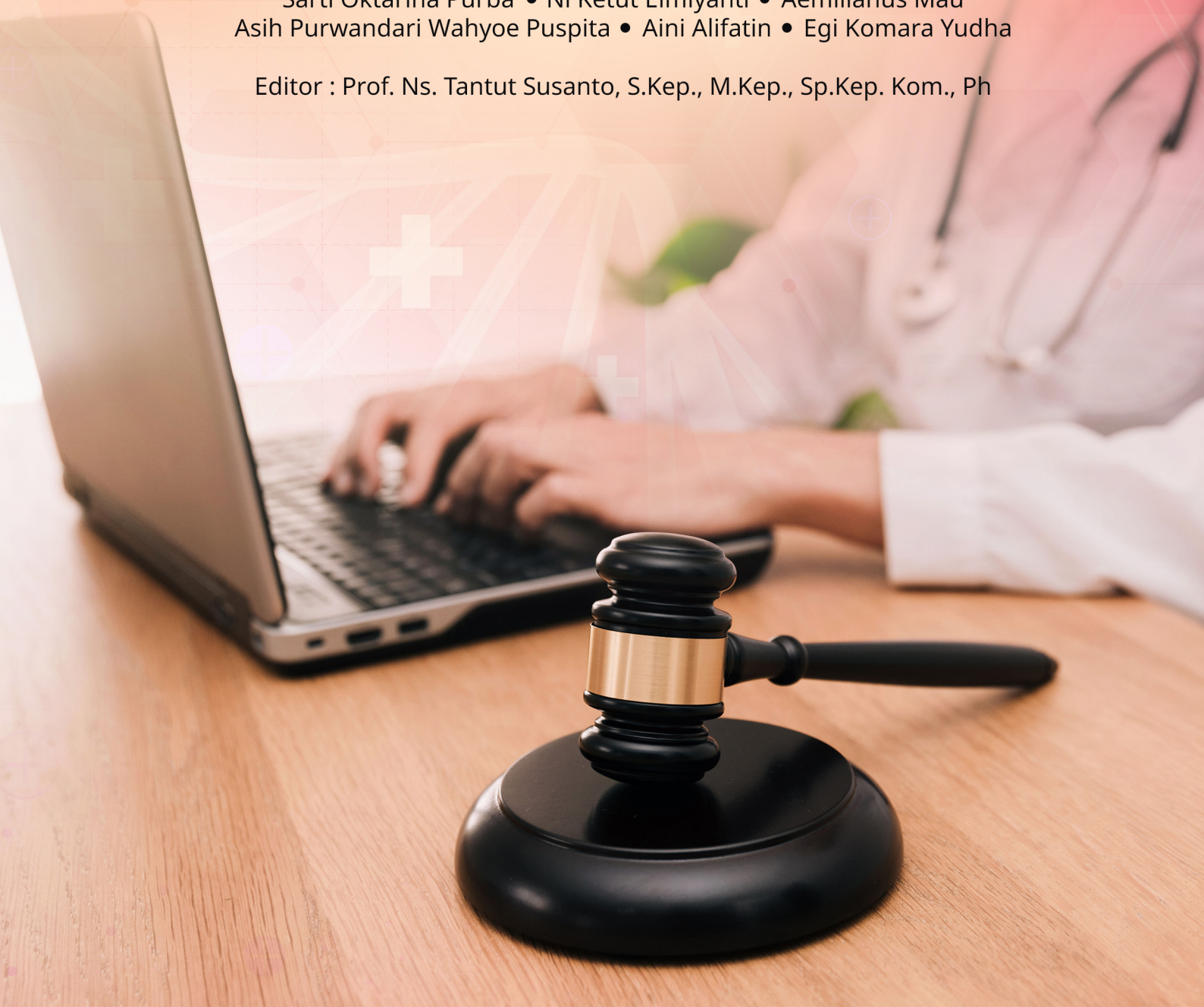


Buku Ajar
**ETIK DAN HUKUM
KEPERAWATAN**

Sarti Oktarina Purba • Ni Ketut Elmiyanti • Aemilianus Mau
Asih Purwandari Wahyoe Puspita • Aini Alifatin • Egi Komara Yudha

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph



Buku Ajar : Etik dan Hukum Keperawatan

Penulis:

Ns. Sarti Oktarina Purba, S.Kep., M.Kep.

Ni Ketut Elmiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Egi Komara Yudha, S.Kp., MM., M.Pd.

Editor :

Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph

Buku Ajar:

Etik dan Hukum Keperawatan

Penulis:

Ns. Sarti Oktarina Purba, S.Kep., M.Kep.

Ni Ketut Elmiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Egi Komara Yudha, S.Kp., MM., M.Pd.

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-04-0

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya "Buku Ajar Etik dan Hukum Keperawatan" ini dengan baik.

Profesi keperawatan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perawat dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai landasan moral, etika, dan hukum kesehatan. Pemahaman ini sangat krusial sebagai kompas moral dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, profesional, dan berpusat pada pasien, sekaligus sebagai perisai pelindung dari potensi risiko hukum. Oleh karena itu, buku ajar ini hadir sebagai literatur utama yang komprehensif, aplikatif, dan berwawasan luas bagi kalangan akademisi, praktisi kesehatan di tatanan klinis, maupun pembaca umum yang menaruh minat pada dinamika hukum keperawatan.

Materi di dalam buku ini dirancang secara sistematis menjadi sebuah kesatuan gagasan yang utuh dan saling berkesinambungan. Pembahasan diawali dengan pendalaman mengenai aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi sebagai fondasi pertanggungjawaban legal perawat. Selanjutnya, pembaca akan diajak menyelami konsep keselamatan pasien, manajemen risiko, dan pelaporan insiden dari kacamata etik serta hukum. Guna memberikan wawasan perlindungan profesi, buku ini mengupas tuntas isu malpraktik, kelalaian (*negligence*), dan disiplin profesi beserta langkah-langkah strategis pencegahannya. Kajian kemudian diperluas melalui eksplorasi berbagai dilema etik klinis yang riil terjadi di lapangan, mulai dari keputusan DNR/DNI, perawatan akhir hayat, pengantar perawatan paliatif, hingga penanganan etik pada populasi khusus seperti anak, lansia, pasien jiwa, dan penyandang disabilitas.

Selain berfokus pada ranah pelayanan, karya ini turut memaparkan rambu-rambu etik penelitian keperawatan dan perlindungan subjek penelitian untuk menunjang pengembangan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Pada bagian akhir, seluruh landasan teoretis tersebut dikontekstualisasikan melalui bedah studi kasus etik-hukum dan proses pengambilan keputusan. Bagian ini juga merinci kerangka analisis serta simulasi sidang etik yang disusun untuk mempertajam daya kritis dan kemampuan analitis pembaca dalam menghadapi realitas permasalahan di dunia kesehatan.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

[Nama Institusi/Universitas/Rumah Sakit jika ada], rekan-rekan sejawat, editor, serta pihak penerbit yang telah memfasilitasi lahirnya karya ini.

Sebagai sebuah karya literatur yang dinamis, penulis menyadari bahwa buku ini masih akan terus berkembang seiring dengan pembaruan regulasi kesehatan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan sumbangsih nyata dalam mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang cerdas secara moral, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

BAB 1 ASPEK HUKUM DOKUMENTASI KEPERAWATAN DAN TANGGUNG GUGAT PROFESI	1
A. ASPEK HUKUM DOKUMENTASI KEPERAWATAN DAN TANGGUNG GUGAT PROFESI	5
B. Dokumentasi Keperawatan sebagai Bukti Legal.....	5
C. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Dokumentasi Keperawatan.....	6
D. Prinsip Legal dalam Dokumentasi Keperawatan	7
E. Tanggung Gugat Profesi Keperawatan	9
F. Identifikasi Unsur Tanggung Gugat pada Skenario.....	11
G. Langkah Pencegahan Tanggung Gugat Profesi	11
H. Hubungan Dokumentasi dengan Tanggung Gugat Profesi.....	12
I. RINGKASAN	32
Referensi	36

BAB 2 KESELAMATAN PASIEN, MANAJEMEN RISIKO, DAN PELAPORAN INSIDEN (PERSPEKTIF ETIK–HUKUM)	37
A. Keselamatan Pasien Perspektif Etik-Hukum.....	43
B. Manajemen Risiko Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49
C. Latihan Soal.....	64
D. Rangkuman	67
Glosarium	68
Referensi	69

BAB 3 MALPRAKTIK, KELALAIAN (NEGLIGENCE), DAN DISIPLIN PROFESI: KONSEP DAN PENCEGAHAN	70
A. PENDAHULUAN.....	73
B. MALPRAKTIK DALAM KEPERAWATAN.....	74
C. KELALAIAN (NEGLIGENCE)	80
D. DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN	82
E. STRATEGI PENCEGAHAN MALPRAKTIK DAN KELALAIAN	84
F. RINGKASAN	84
Referensi	90

BAB 4 ISU ETIK KLINIS: DNR/DNI, AKHIR HAYAT, DAN PERAWATAN PALIATIF (PENGANTAR)	91
A. Teori Dasar	94
B. Dinamika Keputusan DNR dan DNI	95
C. Filosofi Perawatan Paliatif	95
D. Empat Pilar Prinsip Etik Bioetika	95
E. Peran Strategis Perawat sebagai Advokat	96
Referensi	112

BAB 5 ISU ETIK PADA POPULASI KHUSUS: ANAK, LANSIA, JIWA, DAN DISABILITAS	113
A. Pendahuluan	116
B. Kerangka Analisis Etik dalam Populasi Khusus	117
C. Alur Pengambilan Keputusan Etik dalam Praktik Keperawatan (McNee, 2021)	122
D. Issue etik pada kelompok khusus (Anak, lansia, gangguan mental dan disabilitas)	124
E. Ringkasan Bab	152
Referensi	154

BAB 6 ETIK PENELITIAN KEPERAWATAN DAN PERLINDUNGAN SUBJEK PENELITIAN	157
A. Pendahuluan	160
B. Landasan Filosofis dan Teori Etik Penelitian	161
C. Prinsip Etik Penelitian pada Subjek Manusia	162
D. Informed Consent dalam Penelitian Keperawatan	162
E. Perlindungan Privasi, Kerahasiaan, dan Keamanan Data	163
F. Komite Etik Penelitian dan Ethical Clearance	164
G. Isu Etik dan Hukum dalam Penelitian Keperawatan	164
H. Analisis Kasus Etik Penelitian	165
I. Implikasi Praktik dan Pengambilan Keputusan Etik	166
J. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus	167
K. Profesionalisme dan Akuntabilitas Peneliti Keperawatan	180
L. Ringkasan bab	185
Referensi	187

BAB 7 STUDI KASUS ETIK-HUKUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN: KERANGKA ANALISIS DAN SIMULASI SIDANG ETIK	190
A. Teori Dasar	194
B. Kasus Hukum dalam Keperawatan	197
C. Kerangka Hukum Praktik Keperawatan di Indonesia	198
D. Pengambilan Keputusan Etis-Hukum dan Kerangka Analisisnya	200
E. Model Pengambilan Keputusan Etik	202
F. Deliberasi Etik dalam Pengambilan Keputusan Klinis	205

G. Tahapan Prosedural dalam Pengambilan Keputusan Etik	205
H. Rangkuman Materi	259
Glosarium	260
Referensi	264
Profil Penulis.....	267

BAB 1

ASPEK HUKUM DOKUMENTASI KEPERAWATAN DAN TANGGUNG GUGAT PROFESI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik-hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi	1.1 Menyusun dokumentasi keperawatan yang memenuhi prinsip legal (akurasi, kronologi, koreksi benar).	1.2 Mengidentifikasi unsur tanggung gugat profesi pada skenario dan langkah pencegahannya.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-3

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit
CPMK-6	Mini RCA/analisis insiden + presentasi singkat	Skor ketepatan klasifikasi risiko, kualitas rencana pencegahan berbasis akar masalah, dan keterukuran indikator audit.	15	RCA mini; slide/handout ringkas

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik-hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik/standar pada vignette				konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	$\leq 60\%$ elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	$> 90\%$ terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

A. ASPEK HUKUM DOKUMENTASI KEPERAWATAN DAN TANGGUNG GUGAT PROFESI

Pengertian Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan catatan tertulis maupun elektronik yang memuat seluruh proses asuhan keperawatan secara sistematis dan berkesinambungan. Catatan tersebut menggambarkan kondisi pasien, intervensi yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh selama pelayanan berlangsung (Potter & Perry, 2021). Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan sekaligus bukti hukum atas tindakan yang diberikan kepada pasien (Kozier & Erb, 2020).

Dokumentasi keperawatan menjadi bagian penting dalam praktik profesional karena tidak hanya mendukung kontinuitas pelayanan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat. Setiap tindakan yang dilakukan perawat harus dicatat secara akurat dan sistematis karena dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab serta tanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai aspek hukum dokumentasi dan tanggung gugat profesi sangat diperlukan, baik bagi mahasiswa keperawatan maupun perawat praktik klinik.

Kesalahan dalam dokumentasi, seperti pencatatan yang tidak lengkap, tidak kronologis, atau koreksi yang tidak sesuai prosedur, dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kurangnya pemahaman terhadap unsur tanggung gugat profesi juga meningkatkan risiko tuntutan hukum terhadap perawat. Dengan demikian, dokumentasi yang baik menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.

B. Dokumentasi Keperawatan sebagai Bukti Legal

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti tertulis mengenai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Catatan yang lengkap dan akurat dapat menjamin kesinambungan pelayanan serta melindungi perawat dari potensi tuntutan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas dokumentasi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan memberikan perlindungan hukum bagi perawat (Hariyati et al., 2018). Penggunaan sistem dokumentasi elektronik juga dilaporkan mampu meningkatkan kelengkapan dan aspek legal dokumentasi.

Selain sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, dokumentasi keperawatan juga berfungsi sebagai indikator mutu pelayanan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan dokumentasi yang tidak lengkap dan tidak sesuai standar, sehingga meningkatkan risiko kesalahan klinis serta tuntutan hukum terhadap perawat (Kamil et al., 2018). Dokumentasi mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi tindakan keperawatan. Ketepatan dan kelengkapan pencatatan sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien, meskipun dokumentasi sering dianggap sebagai beban kerja tambahan bagi perawat (Ivziku et al., 2022).

C. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Dokumentasi Keperawatan

Kualitas dokumentasi keperawatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi kerja maupun kompetensi perawat. Beban kerja yang tinggi sering kali menyebabkan perawat harus membagi perhatian antara tindakan langsung kepada pasien dan kegiatan pencatatan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan dokumentasi tidak dilakukan secara lengkap atau tertunda. Selain itu, keterbatasan waktu selama dinas, terutama pada unit dengan jumlah pasien yang banyak, juga menjadi kendala dalam menyusun dokumentasi yang sistematis dan rinci. Kurangnya pemahaman mengenai standar dokumentasi keperawatan turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pencatatan, karena perawat mungkin belum sepenuhnya memahami komponen yang harus dicatat serta cara penulisan yang sesuai dengan prinsip legal (Susiana et al., 2019).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan terkait dokumentasi keperawatan. Pelatihan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan perawat tidak mengikuti perkembangan standar dokumentasi terbaru, baik dari sisi klinis maupun aspek hukum. Akibatnya, pencatatan yang dilakukan menjadi tidak konsisten, kurang terstruktur, dan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi. Supervisi yang kurang optimal dari manajemen keperawatan juga dapat memperburuk kondisi ini, karena tidak adanya evaluasi berkala terhadap kualitas dokumentasi yang dibuat oleh perawat.

Di Indonesia, dokumentasi keperawatan berbasis kertas masih banyak digunakan dalam praktik pelayanan kesehatan. Sistem manual ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti risiko kehilangan dokumen, kerusakan fisik, serta kesulitan dalam menelusuri kembali data pasien secara cepat. Selain itu, pencatatan manual lebih rentan terhadap kesalahan penulisan, penggunaan singkatan yang tidak baku, serta masalah keterbacaan tulisan. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi

akurasi data dan berpotensi melemahkan kekuatan dokumentasi sebagai bukti hukum.

Sebaliknya, dokumentasi elektronik dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan aspek legal dokumentasi keperawatan. Sistem elektronik biasanya dilengkapi dengan fitur pengingat otomatis yang membantu perawat mengisi komponen dokumentasi secara lengkap. Selain itu, adanya validasi data dapat meminimalkan kesalahan input, seperti kesalahan waktu, identitas pasien, atau dosis obat. Fitur audit trail juga memungkinkan penelusuran siapa yang melakukan perubahan data dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Hal ini meningkatkan transparansi serta memperkuat posisi dokumentasi sebagai bukti hukum dalam pelayanan kesehatan (Ernawati & Permaida, 2025).

D. Prinsip Legal dalam Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan harus memenuhi prinsip legal yaitu akurasi, kronologi, dan koreksi yang benar. Menurut Guido (2014), dokumentasi yang tidak akurat dapat dianggap sebagai kelalaian profesional. Kesalahan dokumentasi seperti tidak mencantumkan waktu, tidak menandatangani catatan, atau penggunaan singkatan yang tidak baku dapat melemahkan posisi hukum perawat. Penelitian oleh Setiani (2018) menunjukkan bahwa dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan perawat dianggap tidak melakukan tindakan meskipun tindakan tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, dokumentasi harus dilakukan segera setelah tindakan dan sesuai standar praktik keperawatan.

Menurut pedoman dari *American Nurses Association*, dokumentasi harus mencerminkan proses keperawatan secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan standar dokumentasi yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia antara lain:

1. Prinsip Akurasi (*Accuracy*)

Prinsip akurasi menekankan bahwa informasi yang dicatat dalam dokumentasi keperawatan harus menggambarkan kondisi pasien secara nyata dan sesuai fakta. Data yang ditulis harus berasal dari hasil pengkajian, observasi, serta tindakan yang benar-benar dilakukan, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif perawat. Dokumentasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Misalnya, apabila perawat menuliskan bahwa kondisi pasien baik, padahal pasien masih mengeluh nyeri, maka catatan tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Dokumentasi yang akurat juga mencakup

penulisan waktu secara tepat, pencantuman dosis obat yang benar, penggunaan identitas pasien yang sesuai, serta pencatatan hasil observasi secara objektif.

2. Prinsip Kelengkapan (*Completeness*)

Dokumentasi keperawatan harus mencakup seluruh tahapan proses asuhan keperawatan secara menyeluruh, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Kelengkapan pencatatan sangat penting karena tindakan yang tidak terdokumentasi dapat dianggap tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, setiap intervensi keperawatan perlu dicatat secara sistematis agar dapat menjadi bukti pelayanan yang telah diberikan. Komponen yang harus dicantumkan meliputi data pengkajian, diagnosis keperawatan, rencana tindakan, implementasi, serta evaluasi. Dokumentasi yang lengkap mendukung kesinambungan pelayanan, memperlancar komunikasi antar tenaga kesehatan, serta memperkuat tanggung jawab profesional perawat.

3. Prinsip Kronologis (*Chronological Order*)

Pencatatan dalam dokumentasi keperawatan harus dilakukan sesuai urutan waktu kejadian. Penulisan secara kronologis memudahkan penelusuran proses pelayanan yang diberikan kepada pasien. Setiap kegiatan, mulai dari pengkajian, tindakan, pemberian obat, hingga evaluasi, perlu dicatat dengan waktu yang jelas. Penyusunan kronologis membantu menggambarkan alur pelayanan secara sistematis dan sangat penting dalam pembuktian hukum apabila terjadi masalah dalam pelayanan kesehatan.

4. Prinsip Objektivitas (*Objectivity*)

Dokumentasi keperawatan harus didasarkan pada data objektif yang diperoleh melalui pengamatan langsung maupun pernyataan pasien. Perawat perlu mencatat apa yang dilihat, didengar, dan dilaporkan pasien tanpa menambahkan opini pribadi. Penggunaan bahasa subjektif dapat menimbulkan bias serta mengurangi kekuatan dokumentasi sebagai bukti hukum. Oleh karena itu, pencatatan harus menggunakan istilah yang faktual dan dapat diukur, sehingga menggambarkan kondisi pasien secara jelas.

5. Prinsip Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Pencatatan dokumentasi harus dilakukan segera setelah tindakan keperawatan diberikan. Penundaan dalam pencatatan dapat meningkatkan risiko kesalahan informasi akibat lupa atau ketidaktepatan data. Dokumentasi yang dilakukan tepat waktu membantu menjaga kontinuitas pelayanan serta mencegah keraguan terhadap keabsahan data. Selain itu, pencatatan yang terlambat dapat menimbulkan dugaan manipulasi informasi dalam proses hukum.

6. Prinsip Keterbacaan (*Legibility*)

Dokumentasi harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Tulisan yang sulit dibaca dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, pencatatan sebaiknya menggunakan format standar, tulisan yang rapi, serta menghindari penggunaan singkatan yang tidak baku. Keterbacaan juga berkaitan dengan penggunaan media tulis yang permanen agar informasi tidak mudah berubah.

7. Prinsip Koreksi yang Benar (*Proper Correction*)

Kesalahan dalam dokumentasi harus diperbaiki sesuai prosedur yang berlaku. Perubahan tidak boleh dilakukan dengan cara menghapus atau menggunakan cairan koreksi karena dapat merusak keaslian dokumen. Cara yang tepat adalah dengan mencoret satu garis pada bagian yang salah, menuliskan informasi yang benar, kemudian memberikan paraf serta mencantumkan tanggal koreksi. Prosedur ini bertujuan menjaga integritas dokumen sebagai bukti hukum.

8. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Dokumentasi keperawatan berisi informasi pribadi pasien yang bersifat rahasia. Perawat berkewajiban menjaga kerahasiaan data tersebut sesuai dengan etika profesi dan ketentuan hukum. Informasi pasien hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan, pasien yang bersangkutan, atau pihak lain yang memiliki izin resmi. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta melanggar hak pasien.

9. Prinsip Akuntabilitas

Setiap pencatatan dalam dokumentasi keperawatan harus mencantumkan identitas perawat yang melakukan tindakan. Pencantuman nama, tanda tangan, dan waktu pencatatan menunjukkan bahwa perawat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Prinsip akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum.

E. Tanggung Gugat Profesi Keperawatan

Tanggung gugat profesi merupakan kewajiban perawat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diberikan kepada pasien secara hukum. Konsep ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus siap mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaian apabila menimbulkan kerugian pada pasien (Guido, 2014). Dalam tanggung gugat profesi terdapat empat unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu *duty*, *breach of duty*, *causation*, dan *damage*.

1. *Duty* (Kewajiban)

Duty merupakan kewajiban perawat untuk memberikan asuhan keperawatan sesuai standar praktik profesi, prosedur operasional, serta kode etik keperawatan. Kewajiban tersebut muncul karena adanya hubungan profesional antara perawat dan pasien dalam pelayanan kesehatan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2017). Perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian, menentukan intervensi, serta mengevaluasi kondisi pasien sesuai kebutuhan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai standar, maka perawat dapat menghadapi risiko tuntutan hukum (Kozier et al., 2018). Contoh: Perawat harus melakukan identifikasi pasien sebelum memberikan obat.

2. *Breach of Duty* (Pelanggaran Kewajiban)

Breach of duty terjadi apabila perawat tidak menjalankan kewajiban sesuai standar praktik yang berlaku. Pelanggaran dapat berupa tindakan yang tidak tepat maupun tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (American Nurses Association, 2015). Contoh pelanggaran meliputi tidak memverifikasi identitas pasien, tidak mendokumentasikan tindakan keperawatan, atau tidak memantau kondisi pasien sesuai prosedur. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar munculnya tanggung gugat profesi (Potter & Perry, 2021).

3. *Causation* (Hubungan Sebab Akibat)

Causation merupakan adanya hubungan langsung antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian yang dialami pasien. Unsur ini berperan penting dalam menentukan apakah perawat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Potter & Perry, 2021). Jika hubungan sebab akibat antara tindakan perawat dan cedera pasien tidak dapat dibuktikan, maka tanggung gugat profesi sulit ditetapkan. Oleh karena itu, analisis kronologi kejadian menjadi bagian penting dalam penilaian kasus hukum keperawatan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2017). Contoh: Pasien menerima obat yang salah karena identifikasi tidak dilakukan.

4. *Damage* (Kerugian)

Merupakan kerugian yang dialami pasien akibat tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian tersebut dapat berupa cedera fisik, gangguan psikologis, maupun kerugian finansial (Kozier et al., 2018). Kerugian harus nyata dan dapat dibuktikan secara medis. Tanpa adanya kerugian, unsur tanggung gugat profesi biasanya tidak dapat dibuktikan secara hukum (American Nurses Association, 2015). Contoh: Pasien mengalami reaksi alergi setelah menerima obat yang tidak sesuai.

Penelitian Rahman (2020) menunjukkan bahwa perawat yang melakukan tindakan di luar kewenangan memiliki risiko lebih besar menghadapi tuntutan

hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batas kompetensi serta kewenangan perawat dalam praktik klinik.

F. Identifikasi Unsur Tanggung Gugat pada Skenario

Dalam praktik keperawatan, identifikasi unsur tanggung gugat dilakukan melalui analisis kejadian secara sistematis dengan mengacu pada empat unsur utama. Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian profesional dalam pemberian asuhan keperawatan (American Nurses Association, 2015).

Contoh skenario: Seorang perawat tidak menaikkan pagar tempat tidur pada pasien yang memiliki risiko jatuh, kemudian pasien tersebut terjatuh dan mengalami fraktur. Kejadian ini menunjukkan bahwa perawat memiliki kewajiban menjaga keselamatan pasien, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan cedera pada pasien (Kozier et al., 2018).

Pada kasus tersebut terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan perawat yang tidak menaikkan pagar tempat tidur dengan cedera yang dialami pasien. Dengan demikian, unsur tanggung gugat profesi dapat dinyatakan terpenuhi (Potter & Perry, 2021).

G. Langkah Pencegahan Tanggung Gugat Profesi

Pencegahan tanggung gugat profesi dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan standar praktik dan prosedur operasional yang berlaku. Penerapan standar tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan dari kemungkinan risiko hukum (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2017). Dokumentasi yang lengkap dan akurat menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah tanggung gugat profesi. Dokumentasi berperan sebagai bukti bahwa perawat telah melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan (Potter & Perry, 2021).

Selain itu, verifikasi identitas pasien sebelum melakukan tindakan merupakan langkah pencegahan utama untuk menghindari kesalahan pelayanan. Prosedur ini termasuk dalam prinsip keselamatan pasien yang wajib diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan tindakan. Komunikasi yang baik dapat menjamin kesinambungan asuhan serta meningkatkan keselamatan pasien (American Nurses Association, 2015).

Pencegahan tanggung gugat profesi dapat dilakukan melalui penerapan standar praktik keperawatan. Dokumentasi yang lengkap menjadi bukti bahwa perawat telah melaksanakan tindakan sesuai prosedur. Selain itu, verifikasi identitas pasien, komunikasi efektif, serta edukasi kepada pasien dan keluarga juga merupakan langkah penting dalam mencegah risiko hukum (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

H. Hubungan Dokumentasi dengan Tanggung Gugat Profesi

Dokumentasi keperawatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tanggung gugat profesi dalam praktik pelayanan kesehatan. Banyak penelitian telah membuktikan tentang hal ini. Dibawah ini ada beberapa jurnal terkait Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi:

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Materi
1	Purwandari (2022)	Nursing documentation in accredited hospital	Dokumentasi harus akurat, lengkap, dan tepat waktu	Prinsip legal dokumentasi
2	Bolado (2023)	Documentation practice and associated factors among nurses	Dokumentasi menjadi sumber informasi klinis dan bukti hukum	Tanggung gugat profesi
3	Status of Nursing Documentation Types in Indonesia (2023)	Status dokumentasi keperawatan di Indonesia	Dokumentasi penting untuk akuntabilitas dan keselamatan pasien	Prinsip akurasi & kronologi
4	Almotairi (2024)	Nursing documentation as a foundation of safe, ethical, and legal care	Dokumentasi sebagai perlindungan hukum tenaga kesehatan	Aspek hukum dokumentasi
5	Analisis aspek etika dan	Ethical and legal issues in medical records	Ketidakakuratan dan keterlambatan	Risiko tanggung gugat

	hukum rekam medis (2024)		meningkatkan risiko hukum	
6	Factors Hindering Nursing Care Documentation (2025)	Faktor penghambat dokumentasi	Beban kerja tinggi mempengaruhi kualitas dokumentasi	Pencegahan kesalahan dokumentasi
7	Maulana (2025)	Enhancing nursing documentation through incident reporting	Dokumentasi akurat meningkatkan keselamatan pasien	Tanggung jawab profesional
8	Improving Nursing Documentation Quality (2025)	Peningkatan kualitas dokumentasi	Supervisi dan standar meningkatkan kualitas catatan	Pencegahan risiko hukum
9	Governance, accountability and professional regulation (2025)	Akuntabilitas profesional	Dokumentasi sebagai bagian regulasi profesi	Tanggung gugat profesi

Catatan keperawatan yang lengkap dan akurat dapat menunjukkan bahwa perawat telah melaksanakan asuhan sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai tindakan yang dilakukan, respon pasien, serta evaluasi hasil pelayanan. Sebaliknya, dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menimbulkan anggapan bahwa tindakan keperawatan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai prosedur. Kondisi ini dapat memperkuat dugaan adanya kelalaian profesional apabila terjadi masalah dalam pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan berkaitan dengan dokumentasi yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan pencatatan dapat menyulitkan pembuktian bahwa perawat telah memberikan pelayanan sesuai standar. Selain itu, dokumentasi yang tidak sistematis juga dapat menghambat komunikasi antar tenaga kesehatan sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan

keputusan klinis. Kesalahan tersebut berpotensi berdampak pada keselamatan pasien serta meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi.

Sebaliknya, dokumentasi yang baik dan terstruktur dapat membantu menurunkan risiko kesalahan medis karena setiap informasi mengenai kondisi pasien tercatat dengan jelas. Dokumentasi yang lengkap juga mendukung kesinambungan asuhan, mempermudah evaluasi tindakan, serta meningkatkan koordinasi antar anggota tim kesehatan. Dengan demikian, kualitas dokumentasi keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Bolado, 2023).

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Contoh Kasus 1:

Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis Diabetes Mellitus. Pada pukul 08.00 pasien mengeluh pusing dan lemas. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dan diperoleh hasil 60 mg/dL. Selanjutnya, perawat segera memberikan minuman manis dan melaporkan kondisi tersebut kepada dokter jaga. Setelah sekitar 30 menit, kondisi pasien dilaporkan membaik. Namun, perawat baru mendokumentasikan kejadian tersebut pada pukul 11.00 dan tidak mencantumkan waktu kejadian secara rinci. Catatan yang ditulis hanya berbunyi: "Pasien sempat lemas, sudah ditangani, kondisi membaik". Beberapa jam kemudian, keluarga pasien mempertanyakan tindakan yang telah diberikan karena mereka tidak mengetahui secara jelas penanganan yang dilakukan.

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil guna menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi permasalahan dokumentasi yang terdapat pada kasus tersebut.
 2. Prinsip legal dokumentasi apa saja yang belum terpenuhi?
 3. Risiko hukum apa yang mungkin dihadapi oleh perawat?
 4. Bagaimana dokumentasi yang seharusnya dituliskan pada kasus tersebut?
 5. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang?
- Setelah diskusi selesai, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas.

Contoh Kasus 2:

Seorang pasien perempuan berusia 62 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosis pasca operasi fraktur femur hari ke-2. Pada pukul 09.15 pasien mengeluh nyeri hebat pada luka operasi dengan skala nyeri 8/10. Perawat kemudian melakukan pengkajian, memeriksa tanda vital (TD 150/90 mmHg, Nadi 98 x/menit, RR 24 x/menit), dan memberikan analgetik sesuai instruksi dokter. Setelah pemberian obat, perawat membantu pasien mengatur posisi nyaman dan mengajarkan teknik napas dalam. Sekitar 20 menit kemudian pasien menyatakan nyeri berkurang menjadi skala 3/10. Namun, perawat baru menuliskan dokumentasi pada akhir shift pukul 14.00 tanpa mencatat waktu pemberian obat, skala nyeri sebelum dan sesudah intervensi, serta tidak mencantumkan respon pasien secara jelas. Catatan yang ditulis hanya: "Pasien mengeluh nyeri, sudah diberikan obat, kondisi lebih baik." Pada sore hari,

dokter visite menanyakan respon pasien terhadap terapi nyeri, tetapi informasi tersebut tidak tersedia secara lengkap dalam catatan keperawatan.

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil guna menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi permasalahan dokumentasi pada kasus di atas.
2. Prinsip legal dokumentasi apa saja yang tidak terpenuhi?
3. Apa dampak klinis yang dapat terjadi akibat dokumentasi yang tidak lengkap tersebut?
4. Bagaimana contoh dokumentasi yang seharusnya ditulis oleh perawat?
5. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan?

Setelah diskusi selesai, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Role Play Simulasi Dokumentasi Keperawatan

Simulasi/skill lab Dokumentasi Keperawatan

Fokus :Urutan tindakan keperawatan + komunikasi profesional + dokumentasi sesuai prinsip legal

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi
- Penekanan pada integrasi antara tindakan klinik dan dokumentasi legal
- Simulasi menekankan keselamatan pasien dan tanggung gugat profesi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check konsep aspek hukum dokumentasi + analisis mini-case tanggung gugat profesi
Shows How	OSCE simulasi dokumentasi keperawatan sesuai prinsip legal
Does	Observasi praktik dokumentasi keperawatan pada studi kasus klinik / praktik laboratorium

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items

Mahasiswa dinyatakan **tidak kompeten** jika salah satu tidak dilakukan:

- ☐ Tidak mencatat waktu kejadian
- ☐ Tidak mencatat hasil pengkajian
- ☐ Tidak menuliskan tindakan yang dilakukan
- ☐ Tidak mencatat respon pasien
- ☐ Dokumentasi tidak kronologis
- ☐ Tidak mencantumkan identitas perawat
- ☐ Menggunakan bahasa subjektif

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Akurasi data	Data lengkap, sesuai kondisi pasien, tanpa kesalahan	Data cukup lengkap, ada kesalahan kecil	Data kurang lengkap, beberapa tidak sesuai	Data tidak akurat / tidak relevan
Kronologis	Urutan waktu sangat jelas dan runtut	Urutan waktu jelas namun kurang rinci	Urutan kurang runtut	Tidak kronologis
Kelengkapan dokumentasi	Memuat pengkajian, tindakan, respon, waktu, identitas	Satu komponen kurang	Dua komponen kurang	Tidak lengkap
Objektivitas bahasa	Semua menggunakan data objektif	Ada sedikit bahasa subjektif	Banyak bahasa subjektif	Dominan opini pribadi
Ketepatan waktu pencatatan	Dicatat segera setelah tindakan	Sedikit terlambat	Terlambat	Tidak sesuai waktu
Akuntabilitas	Nama, tanda tangan, waktu lengkap	Satu komponen kurang	Dua komponen kurang	Tidak ada identitas
Keterbacaan	Sangat jelas dan mudah dibaca	Cukup jelas	Sulit dibaca	Tidak terbaca

Skor maksimal dapat dihitung:

- Jumlah kriteria: 7
- Skor maksimal: 28

- Kategori:
 - 24–28 = Sangat Baik
 - 19–23 = Baik
 - 14–18 = Cukup
 - <14 = Perlu perbaikan

DOPS (Does)

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Dokumentasi Keperawatan sesuai prinsip legal
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan dokumentasi keperawatan sesuai prinsip legal dan tanggung gugat profesi setelah terjadi perubahan kondisi pasien.
5	Kompetensi	1. Komunikasi profesional 2. Pengkajian fokus 3. Dokumentasi keperawatan 4. Implementasi tindakan 5. Evaluasi 6. Tanggung gugat profesi
6	Kategori	1. Legal etik keperawatan 2. Keselamatan pasien 3. Dokumentasi keperawatan 4. Profesionalisme 5. Komunikasi klinik
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis hipertensi. Pada pukul 09.00 pasien melaporkan keluhan sakit kepala disertai rasa pusing. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 180/100 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan frekuensi napas 22 kali per menit. Perawat kemudian melaksanakan intervensi sesuai instruksi dokter, memposisikan pasien dalam posisi semifowler,

No.	Komponen	Isi
		serta melakukan pemantauan ulang. Setelah sekitar 30 menit, kondisi pasien menunjukkan perbaikan. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada klien standar. 2. Tuliskan dokumentasi keperawatan secara kronologis pada lembar jawab. 3. Gunakan bahasa objektif dalam dokumentasi. 4. Cantumkan waktu kejadian dan identitas perawat. 5. Jelaskan secara singkat tindakan yang dilakukan kepada pasien.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis hipertensi. Pada pukul 09.00 pasien mengeluh sakit kepala dan pusing. Hasil pengkajian: tekanan darah 180/100 mmHg, nadi 90 x/menit, RR 22 x/menit. Perawat melakukan intervensi sesuai instruksi dokter, mengatur posisi semifowler, dan melakukan observasi ulang. Setelah 30 menit kondisi pasien membaik. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi keluhan pasien dan hasil pengkajian. 2. Menilai ketepatan dokumentasi kronologis (waktu, tindakan, respon). 3. Menilai penggunaan bahasa objektif dalam dokumentasi. 4. Menilai kelengkapan dokumentasi (pengkajian, tindakan, evaluasi). 5. Menilai pencantuman identitas perawat (nama/tanda tangan). 6. Menilai perilaku profesional peserta selama simulasi. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain instruksi yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas pasien: laki-laki usia 58 tahun. 2. Keluhan utama: sakit kepala dan pusing sejak pagi. 3. Pasien tampak cemas dan memegang kepala.

No.	Komponen	Isi
		4. Bila ditanya riwayat: pasien memiliki riwayat hipertensi. 5. Bila ditanya keluhan lain: pasien mengatakan sedikit mual. 6. Bila ditanya aktivitas: pasien sedang berbaring di tempat tidur. 7. Respon setelah tindakan: pasien mengatakan sakit kepala berkurang. 8. Klien standar duduk/berbaring sesuai skenario.
10	Setting station	Tempat: Ruang Rawat Penyakit Dalam Tata letak: 1. Tempat tidur pasien 2. Klien standar 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Kursi peserta 6. Troli alat 7. Wastafel / handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	9 Peralatan: 1. Handrub / hand sanitizer 2. Lembar dokumentasi keperawatan 3. Pulpen 4. Tensimeter (simulasi) 5. Stetoskop 6. Jam dinding 7. Lembar jawaban peserta Peran laboran: • Menyiapkan lembar dokumentasi • Merapikan alat setelah setiap peserta • Memastikan station siap digunakan
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Potter & Perry (2021) Fundamentals of Nursing.

SOP DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan keperawatan				
2	Menyiapkan format dokumentasi				
3	Menyiapkan alat tulis/perangkat				
4	Menjamin kerahasiaan data pasien				
5	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
6	Memberi salam terapeutik				
7	Menyebutkan nama dan peran perawat				
8	Mengidentifikasi pasien				
9	Menjelaskan tujuan pendokumentasian				
10	Menjaga privasi pasien				
C	Tahap Kerja				
11	Mendokumentasikan pengkajian				
12	Mencatat tanda vital				

13	Menulis diagnosis keperawatan				
14	Menulis rencana tindakan				
15	Mencatat implementasi				
16	Mencatat respons pasien				
17	Menulis evaluasi				
18	Menulis secara kronologis				
19	Menggunakan bahasa objektif				
20	Mencantumkan tanggal dan jam				
21	Mencantumkan tanda tangan perawat				
D	Tahap Terminasi				
22	Mengevaluasi kelengkapan dokumentasi				
23	Mengakhiri kegiatan				
E	Tahap Dokumentasi				
24	Mencatat seluruh proses asuhan				
F	Penampilan Profesional				
25	Teliti, akurat, sistematis				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: DOKUMENTASI KEPERAWATAN SESUAI PRINSIP LEGAL

I. Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian fokus	Mengidentifikasi keluhan pasien, hasil pemeriksaan, dan perubahan kondisi pasien					1	
2	Dokumentasi keperawatan	Menuliskan dokumentasi kronologis (pengkajian, tindakan, respon)					3	
3	Prinsip legal dokumentasi	Akurasi, objektivitas, ketepatan waktu, kelengkapan, akuntabilitas					4	
4	Tanggung gugat profesi	Menunjukkan dokumentasi sebagai bukti tindakan profesional					1	
5	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: DOKUMENTASI KEPERAWATAN SESUAI PRINSIP LEGAL

I. Rubrik

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan pasien, hasil pemeriksaan, dan perubahan kondisi yang perlu didokumentasikan					1	
2	Dokumentasi keperawatan	Menuliskan dokumentasi kronologis (pengkajian, tindakan, respon pasien) secara jelas					2	
3	Prinsip legal dokumentasi	Menuliskan dokumentasi dengan akurat, objektif, lengkap, mencantumkan waktu dan identitas					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian data yang perlu didokumentasikan, atau data yang dikumpulkan tidak relevan dengan kondisi pasien.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya sebagian kecil data yang digali, tidak sistematis, dan belum mampu	Melakukan pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting yang perlu didokumentasikan, namun masih ada data yang	Melakukan pengkajian secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi kondisi pasien, tindakan keperawatan, respon pasien, perubahan kondisi, serta mampu

		menentukan data penting untuk dokumentasi.	terlewat atau interpretasi belum lengkap.	menentukan data yang harus didokumentasikan secara tepat.
2. Dokumentasi dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menuliskan dokumentasi keperawatan atau dokumentasi tidak sesuai dengan data kasus.	Menuliskan dokumentasi tetapi tidak kronologis, tidak lengkap, dan tidak sesuai standar.	Menuliskan dokumentasi cukup kronologis dan cukup sesuai, namun masih kurang lengkap atau kurang sistematis.	Menuliskan dokumentasi secara kronologis, lengkap, sistematis, dan sesuai dengan data serta rencana keperawatan yang relevan.
3. Prinsip legal dokumentasi	Tidak menerapkan prinsip legal dokumentasi, data tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak mencantumkan identitas.	Menerapkan sebagian kecil prinsip legal, dokumentasi masih subjektif, tidak lengkap, dan waktu pencatatan tidak jelas.	Menerapkan sebagian besar prinsip legal seperti objektif, cukup lengkap, dan mencantumkan waktu, namun masih ada kekurangan kecil.	Menerapkan prinsip legal secara lengkap meliputi akurasi, objektivitas, kronologis, kelengkapan, keterbacaan, ketepatan waktu, serta mencantumkan nama dan tanda tangan secara jelas.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak menjaga kerahasiaan, tidak teliti, dan	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, komunikasi kurang	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik, menjaga kerahasiaan dan komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, menjaga kerahasiaan

	tidak bertanggung jawab terhadap dokumentasi.	jelas, dan belum menjaga kerahasiaan dengan baik.	cukup jelas, namun masih kurang sistematis.	pasien, komunikasi terapeutik baik, teliti, sistematis, bertanggung jawab, serta memahami tanggung gugat profesi dalam dokumentasi.
--	---	---	---	---

III. Keterangan Skor

Skor Keterangan

- 0 Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
- 1 Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
- 2 Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
- 3 Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada dokumentasi asuhan keperawatan pasien di ruangan praktik
- Mahasiswa menuliskan dokumentasi keperawatan sesuai kondisi pasien nyata
- Fokus pada penerapan prinsip legal dokumentasi dan tanggung gugat profesi
- Checklist observasi + umpan balik singkat dari pembimbing klinik
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk Penulis

- Dari simulasi → praktik nyata
- Menilai performa mahasiswa dalam situasi klinik sebenarnya
- Bukti performa sesungguhnya terkait tanggung gugat profesi
- Mendukung penilaian level **Does** pada Piramida Miller

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Pada Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Dokumentasi Keperawatan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa di lahan praktik dalam situasi nyata.	Pembimbing klinik mengamati secara langsung mahasiswa saat menuliskan dokumentasi asuhan keperawatan pasien setelah melakukan tindakan keperawatan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip legal dokumentasi dan tanggung gugat profesi secara nyata di klinik.	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya mendokumentasikan kondisi pasien, tindakan yang dilakukan, respon pasien, serta mencantumkan waktu dan identitas secara benar.
Kasus klinik	Kasus diambil dari kondisi nyata pasien yang membutuhkan dokumentasi keperawatan.	Pasien mengalami nyeri pasca tindakan injeksi. Mahasiswa melakukan pengkajian nyeri, intervensi nonfarmakologis, lalu mendokumentasikan hasil tindakan dan respon pasien.

Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan dokumentasi keperawatan setelah melakukan tindakan klinik.	Mahasiswa mencatat waktu tindakan, kondisi pasien sebelum tindakan, tindakan yang dilakukan, respon pasien, serta menandatangani dokumentasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi kelengkapan, akurasi, objektivitas, kronologis, keterbacaan, ketepatan waktu, dan identitas penulis.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menulis secara objektif, tidak menggunakan opini pribadi, mencatat kronologis tindakan, dan mencantumkan nama serta waktu.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas dokumentasi sebagai bukti tanggung gugat profesi.	Pembimbing memperhatikan apakah dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti legal dan menggambarkan kondisi pasien secara akurat.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi secara singkat dan spesifik.	Pembimbing menyampaikan bahwa dokumentasi mahasiswa sudah kronologis tetapi perlu memperbaiki kelengkapan waktu dan tanda tangan.
Keputusan penilaian	Digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa di lahan praktik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika dokumentasi lengkap dan legal; supervisi jika masih perlu arahan; remedial jika dokumentasi tidak sesuai standar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik performa mahasiswa pada level does.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan nyata dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat dokumentasi keperawatan
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk Penulis

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 1 Portofolio pada Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Dokumentasi Keperawatan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu menulis dokumentasi keperawatan sesuai prinsip legal dan memperbaikinya setelah mendapat umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dokumentasi dari awal praktik hingga mampu menulis dokumentasi yang lengkap dan legal.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bukti keterampilan di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE berisi hasil simulasi dokumentasi legal, DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa menulis dokumentasi pasien.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus yang pernah ditangani mahasiswa beserta dokumentasi penting.	Mahasiswa menuliskan kondisi pasien, tindakan keperawatan, respon pasien, dan evaluasi secara kronologis.
Refleksi patient safety	Refleksi tentang risiko keselamatan pasien terkait dokumentasi.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya mencatat waktu tindakan, respon pasien, dan mencegah kesalahan pencatatan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik pembimbing sebagai dasar perbaikan kompetensi.	CI menilai dokumentasi sudah kronologis tetapi perlu memperbaiki kelengkapan tanda tangan dan waktu.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan menilai konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa dokumentasi kasus yang menunjukkan konsistensi penerapan prinsip legal.

Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa pada berbagai kesempatan praktik.	Hasil OSCE, DOPS, dan dokumentasi kasus menunjukkan mahasiswa konsisten menulis dokumentasi lengkap dan objektif.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran berbasis performa nyata.	Portofolio menunjukkan mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan secara legal dan bertanggung gugat.

Tabel 1. 2 Case Report pada Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Dokumentasi Keperawatan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien yang mendapatkan tindakan keperawatan dan memerlukan dokumentasi legal.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengkajian, dokumentasi, tindakan, dan evaluasi secara sistematis.	Mahasiswa menjelaskan kondisi pasien, tindakan keperawatan, serta dokumentasi yang dibuat sesuai prinsip legal.
Isi laporan	Meliputi identitas singkat pasien, data subjektif-objektif, masalah, tindakan, dokumentasi, dan evaluasi.	Mahasiswa menuliskan kondisi pasien, tindakan keperawatan, respon pasien, serta dokumentasi kronologis lengkap dengan waktu.
Fokus penilaian	Ketepatan dokumentasi, kelengkapan data, kronologis pencatatan, dan penerapan prinsip legal.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menulis dokumentasi objektif, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan keterampilan dokumentasi legal.	Mahasiswa belajar pentingnya mencatat waktu, respon pasien, dan identitas penulis dalam dokumentasi.

Makna dalam OBE	Bukti kemampuan mahasiswa menerapkan teori dalam praktik nyata.	Case report menunjukkan mahasiswa mampu membuat dokumentasi keperawatan yang legal dan bertanggung gugat.
-----------------	---	---

Tabel 1. 3 Refleksi Patient Safety pada Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Dokumentasi Keperawatan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien terkait dokumentasi.	Mahasiswa merefleksikan bahwa dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan tindakan atau miskomunikasi antar tenaga kesehatan.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa dokumentasi yang benar merupakan bagian dari keselamatan pasien.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan mencatat waktu tindakan atau respon pasien dapat berdampak pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah dokumentasi tidak lengkap, tidak kronologis, dan tidak mencantumkan identitas.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa mengenali situasi dokumentasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko berupa salah komunikasi, duplikasi tindakan, keterlambatan intervensi, dan kesalahan informasi kondisi pasien.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya mencatat segera setelah tindakan, menulis objektif, mencantumkan waktu, dan menandatangani dokumentasi.

Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menyadari bahwa dokumentasi akurat dan lengkap merupakan tanggung jawab profesional.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan tanggung jawab klinik mahasiswa.	Mahasiswa mampu mengevaluasi risiko dokumentasi dan meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan.

I. RINGKASAN

Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Bab ini menekankan pentingnya dokumentasi keperawatan dikerjakan dengan benar. Dokumentasi keperawatan adalah catatan tertulis maupun elektronik yang berisi seluruh proses asuhan keperawatan secara sistematis dan berkesinambungan. Dokumentasi berperan sebagai media komunikasi antar tenaga kesehatan, indikator kualitas pelayanan, serta bukti hukum atas tindakan yang diberikan kepada pasien. Pencatatan yang lengkap dan akurat dapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat, sedangkan dokumentasi yang tidak lengkap berpotensi dianggap sebagai tindakan yang tidak pernah dilakukan. Sebagai bukti legal, dokumentasi harus memuat kondisi pasien, intervensi yang dilakukan, serta hasil tindakan secara jelas. Dokumentasi yang baik membantu menjaga kesinambungan pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, dan memperkuat posisi hukum perawat. Sebaliknya, dokumentasi yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kesalahan klinis dan tuntutan hukum. Mutu dokumentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan, supervisi yang belum optimal, serta penggunaan sistem manual. Dokumentasi berbasis elektronik dinilai lebih efektif karena dilengkapi fitur pengingat, validasi data, dan audit trail yang mendukung aspek legal.

Dokumentasi keperawatan harus memenuhi prinsip-prinsip legal, meliputi akurasi, kelengkapan, kronologis, objektivitas, ketepatan waktu, keterbacaan, koreksi yang benar, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Prinsip akurasi mengharuskan data sesuai dengan kondisi nyata pasien, sedangkan kelengkapan mencakup seluruh tahapan proses keperawatan. Prinsip kronologis menuntut pencatatan berdasarkan urutan waktu, objektivitas menekankan penggunaan data faktual, dan ketepatan waktu mengharuskan pencatatan segera setelah tindakan dilakukan. Selain itu, dokumentasi harus mudah dibaca, kesalahan diperbaiki sesuai prosedur,

kerahasiaan pasien dijaga, serta setiap catatan mencantumkan identitas perawat sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Tanggung gugat profesi merupakan kewajiban perawat untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan secara hukum. Terdapat empat unsur utama dalam tanggung gugat profesi, yaitu *duty* (kewajiban), *breach of duty* (pelanggaran kewajiban), *causation* (hubungan sebab akibat), dan *damage* (kerugian). Keempat unsur tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan adanya tanggung gugat profesi.

Upaya pencegahan tanggung gugat profesi dapat dilakukan dengan menerapkan standar praktik keperawatan, melakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat, memastikan identifikasi pasien, menjaga komunikasi yang efektif, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Dokumentasi memiliki hubungan erat dengan tanggung gugat profesi karena menjadi bukti bahwa asuhan keperawatan telah diberikan sesuai prosedur. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat memperkuat dugaan kelalaian, sedangkan dokumentasi yang sistematis dan jelas dapat meningkatkan keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Tabel 1. 4 Red Flags & Eskalasi: Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Red flags	Makna klinis/legal	Tindakan eskalasi
Dokumentasi tidak ditulis segera setelah tindakan	Risiko lupa data penting dan kesalahan informasi	Segera lengkapi dokumentasi dan laporkan kepada pembimbing
Data tidak objektif (menggunakan opini)	Dokumentasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum	Perbaiki dengan data faktual dan klarifikasi kondisi pasien
Tidak mencantumkan waktu tindakan	Kronologi perawatan tidak jelas	Tambahkan waktu sesuai kejadian dan konfirmasi ke tim
Tidak ada tanda tangan/nama perawat	Tidak jelas penanggung jawab tindakan	Lengkapi identitas penulis dokumentasi
Dokumentasi tidak kronologis	Risiko salah interpretasi kondisi pasien	Susun ulang pencatatan sesuai urutan kejadian

Menghapus catatan tanpa prosedur	Berpotensi pelanggaran hukum	Lakukan koreksi sesuai prosedur (coret satu garis, paraf)
Singkatan tidak baku	Potensi salah komunikasi	Gunakan istilah standar dan jelas
Data penting tidak dicatat	Risiko kesalahan tindakan lanjutan	Segera tambahkan data yang terlewat
Dokumentasi tidak terbaca	Informasi tidak dapat digunakan tim kesehatan	Tulis ulang dengan jelas dan rapi
Tidak mendokumentasikan respon pasien	Evaluasi tindakan tidak dapat dinilai	Tambahkan respon pasien setelah tindakan

Form Checklist

Bab Aspek Hukum Dokumentasi Keperawatan dan Tanggung Gugat Profesi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

N o	Pernyataan	Suda h	Belu m	Catata n
1	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip legal dokumentasi keperawatan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menulis dokumentasi segera setelah tindakan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menulis data objektif dan akurat	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menyusun dokumentasi secara kronologis	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mencantumkan waktu pencatatan	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mencantumkan nama dan tanda tangan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menulis respon pasien setelah tindakan	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan koreksi dokumentasi dengan benar	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjaga kerahasiaan data pasien	☐	☐	_____

10	Saya sudah bisa menghindari singkatan yang tidak baku	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mendokumentasikan perubahan kondisi pasien	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu eskalasi dokumentasi	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa memahami tanggung gugat profesi	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menulis dokumentasi yang terbaca dan sistematis	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional dalam dokumentasi	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- American Nurses Association. (2015). *Nursing: Scope and standards of practice* (3rd ed.). American Nurses Association.
- Bolado, G. N. (2023). Documentation practice and associated factors among nurses. *BMC Nursing*.
- Ernawati, & Permaida. (2025). Dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dan aspek legal. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 28(1), 45–52.
- Guido, G. W. (2014). *Legal and ethical issues in nursing* (6th ed.). Pearson.
- Hariyati, R. T. S., Yetti, K., & Afifah, E. (2018). Improvement legal aspects and completeness of documentation using electronic nursing record. *International Journal of Nursing and Health Services*, 1(2), 1–7.
- Ivziku, D., et al. (2022). Nursing documentation workload and patient safety. *Journal of Nursing Management*, 30(3), 560–567.
- Kamil, H., Rachmah, R., & Wardani, E. (2018). What is the problem with nursing documentation? Perspective of Indonesian nurses. *Nurse Media Journal of Nursing*, 8(2), 95–104.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Standar keselamatan pasien rumah sakit*. Kemenkes RI.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2020). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (10th ed.). Pearson.
- Nursalam. (2017). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (5th ed.). Salemba Medika.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar praktik keperawatan Indonesia*. PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Pratiwi. (2021). Dokumentasi keperawatan dan risiko tuntutan hukum. *Jurnal Keperawatan Klinis*, 4(2), 112–118.
- Rahman. (2020). Tanggung gugat profesi perawat dalam praktik klinik. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(1), 23–31.
- Setiani. (2018). Kelengkapan dokumentasi keperawatan sebagai bukti legal. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(3), 170–178.
- Susiana, E., et al. (2019). Factors related to nursing documentation completeness. *Jurnal Keperawatan*, 10(1), 45–53.

BAB 2

KESELAMATAN PASIEN, MANAJEMEN RISIKO, DAN PELAPORAN INSIDEN (PERSPEKTIF ETIK–HUKUM)

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Keselamatan Pasien, Manajemen Risiko, dan Pelaporan Insiden (Perspektif Etik–Hukum)	2.1 Mengidentifikasi risiko keselamatan dan menetapkan prioritas mitigasi berbasis tingkat risiko.	2.2 Menyusun pelaporan insiden yang memenuhi aspek etik–hukum dan kebutuhan pembelajaran sistem.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-2

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit
CPMK-6	Mini RCA/analisis insiden + presentasi singkat	Skor ketepatan klasifikasi risiko, kualitas rencana pencegahan berbasis akar masalah, dan keterukuran indikator audit.	15	RCA mini; slide/handout ringkas

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik/standar pada vignette				konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Pendahuluan

Rumah sakit bisa saja mengalami kesalahan atau kecelakaan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk menjaga keamanan pasien, harus diambil langkah-langkah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan pasien adalah hak dasar yang diatur dalam UU no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus menempatkan keselamatan jiwa pasien sebagai prioritas utama. Karena tingkat kekompleksan dalam layanan kesehatan saat ini, risiko terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP), seperti Insiden Hampir Cedera (IHC) sampai Insiden Sentinel, menjadi tantangan nyata bagi para petugas kesehatan dan lembaga perawatan medis.

Manajemen risiko bukan hanya tugas administratif biasa, tetapi cara yang aktif untuk mengidentifikasi potensi masalah yang bisa muncul sebelum dampaknya terjadi menjadi lebih buruk. Buku ini mengingatkan bahwa membangun sistem pengelolaan risiko yang baik di rumah sakit sangat penting untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan dan mengurangi kerugian, baik untuk pasien maupun lembaga tersebut. Tantangan utama dalam menjaga keselamatan pasien sering kali terjadi karena kurangnya kepatuhan dalam melaporkan kejadian, yang dipicu oleh rasa takut menghadapi sanksi atau budaya menyalahkan. Pelaporan IKP bertujuan agar kita bisa belajar dan menghindari kesalahan yang sama terjadi lagi di masa depan.

Dari sudut pandang etika, prinsip non-maleficence berarti tenaga kesehatan harus bertindak dengan hati-hati agar tidak merugikan pasien. Secara hukum, memahami aspek yuridis normatif sangat penting untuk melindungi hak praktisi dan memastikan keadilan bagi pasien ketika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa dalam pelayanan kesehatan.

Buku Ajar Keselamatan Pasien, Manajemen Risiko, Dan Pelaporan Insiden (Perspektif Etik-Hukum) ini bertujuan memberikan panduan yang lengkap bagi mahasiswa, akademisi, dan para praktisi di bidang kesehatan. Isi buku ini membahas konsep dasar serta standar keselamatan pasien menurut PMK Nomor 11 Tahun 2017, cara menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif di tempat pelayanan kesehatan, serta prosedur pelaporan insiden yang sesuai dengan standar akreditasi nasional.

Bab ini membahas mengenai perlindungan pasien, pengelolaan risiko, serta pelaporan kejadian, dari segi etika dan hukum. Bagian ini bertujuan agar mahasiswa memahami dengan baik teori dan penerapannya dalam hal melindungi pasien, mengelola risiko, serta melaporkan kejadian yang terjadi, dari segi etika dan hukum.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, bagian ini juga memberikan formulir laporan insiden internal kepada tim keselamatan pasien di rumah sakit.

Tujuan Intruksional Khusus:

Usai menyelesaikan proses belajar, diharapkan para peserta didik mampu:

1. Mahasiswa dapat menguraikan mengenai perlindungan pasien dari sudut pandang etika dan hukum.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengelolaan risiko dari sudut pandang etika dan hukum.
3. Mahasiswa dapat menerangkan mengenai pelaporan kejadian dari sudut pandang etika dan hukum.
4. Mahasiswa dapat menerapkan perlindungan pasien, manajemen risiko, laporan kejadian, serta metode untuk mencegah kelalaian atau malpraktik dalam praktik keperawatan dari perspektif etika dan hukum.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa dapat menerapkan konsep keselamatan pasien, manajemen risiko, pencatatan insiden, serta mencegah kelalaian atau malpraktik dalam praktik keperawatan.
2. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip keselamatan pasien, manajemen risiko, dokumentasi insiden, serta mencegah kelalaian atau malpraktik dan disiplin profesional yang sesuai dengan standar.
3. Mahasiswa dapat menerapkan aspek hukum dalam dokumentasi keperawatan dan tanggung jawab profesi melalui pencatatan yang tepat, menyeluruh, dan dapat diperiksa.
4. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip etika dan kerangka analisis etika untuk pengambilan keputusan dalam konteks klinis, termasuk masalah akhir hayat dan kelompok khusus.
5. Mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi risiko keselamatan dan menentukan prioritas untuk pengurangan risiko berdasarkan tingkat bahaya yang ada.
6. Mahasiswa dapat menyusun laporan insiden yang memenuhi unsur etika dan hukum serta memenuhi kebutuhan pembelajaran sistem.

Uraian Materi

Rincian subjek yang akan dibahas dalam bagian ini meliputi Perlindungan Pasien dari Perspektif Etika-Hukum yang didasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2023; KMK No 1596 Tahun 2024, PMK No 11 Tahun 2017; KMK No 1596 Tahun 2024, serta Kode Etik Keperawatan PPNI. Pengelolaan Risiko Layanan Kesehatan. Sistem Pelaporan dan Analisis Insiden berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2017 dan KMK Nomor 1596 Tahun 2024. Struktur Bab ini meliputi pengantar, tujuan pengajaran

dan hasil pembelajaran, materi yang dibagi menjadi beberapa sub-Bab, dan formulir Laporan Insiden Internal kepada Tim KP di Rumah Sakit.

A. Keselamatan Pasien Perspektif Etik-Hukum

1. Definisi

Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam perawatan pasien. Sistem ini meliputi evaluasi risiko, identifikasi serta pengelolaan potensi risiko yang dapat dialami oleh pasien, pelaporan dan analisis insiden yang terjadi, kemampuan untuk belajar dari insiden tersebut dan tindak lanjutnya, serta penerapan solusi untuk mengurangi risiko dan mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan, baik itu karena melakukan tindakan yang salah atau tidak melaksanakan tindakan yang seharusnya dilakukan. (pasal 1 poin 1 PMK No.11 Tahun 2017)

2. Undang-undang Kesehatan No 17 tahun 2023; KMK No. 1595 Tahun 2024

a. Pasal 4 Setiap Orang berhak:

- (c). mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau untuk mencapai tingkat kesehatan yang terbaik;
- (d). mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- (h). memiliki hak untuk menerima atau menolak sebagian atau semua Tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan dan memahami informasi menyeluruh tentang tindakan tersebut;
- (k). Mendapatkan perlindungan dari potensi risiko kesehatan.

b. Pasal 115

- ayat (6) Pelayanan dari transfusi darah dilaksanakan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan para donor, yang menerima, serta tenaga medis dan kesehatan, yang dijalankan sesuai dengan prosedur standar transfusi darah.

c. Pasal 173 ayat 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan:

- (b). untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan memprioritaskan keselamatan Pasien;
- (g). untuk menyusun pedoman prosedur operasional berdasarkan standar Pelayanan Kesehatan.

d. Pasal 176

- Ayat (1) Penyedia layanan kesehatan harus menjalankan protokol keselamatan bagi pasien.

- Ayat (2) Protokol keselamatan pasien dilaksanakan melalui penentuan dan pengendalian risiko, pengkajian dan pelaporan, serta pemecahan masalah untuk mencegah dan menangani insiden yang mengancam keselamatan pasien.
- e. Pasal 178
- Ayat (1) Setiap Sarana Layanan Kesehatan diwajibkan untuk melakukan perbaikan kualitas Layanan Kesehatan secara terus-menerus, baik dari dalam maupun luar.
 - Ayat (2) Perbaikan kualitas Layanan Kesehatan dari dalam, yang disebut dalam ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pengukuran dan penyampaian indikator kualitas; b. Pelaporan kejadian keselamatan Pasien; dan c. Pengelolaan risiko.
 - Ayat (3) Perbaikan kualitas Layanan Kesehatan dari luar, seperti yang diatur dalam ayat (1), dilakukan melalui: a. pendaftaran; b. izin; dan c. akreditasi.
- f. Pasal 189 ayat 1 Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
- (b). menawarkan layanan medis yang aman, berkualitas tinggi, adil dan efektif dengan mengutamakan kebutuhan pasien yang sesuai pada standar pelayanan di rumah sakit;
 - (g). merancang, menerapkan, serta memelihara standar kualitas dalam layanan kesehatan di rumah sakit sebagai dasar dalam merawat pasien;
 - (l). Menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai hak serta tanggung jawab pasien;
 - (m). menghargai dan menjaga hak-hak pasien;
3. PMK no 11 tahun 2017; KMK No. 1596 Tahun 2024
- a. Pasal 2
- Pengaturan tentang Keselamatan Pasien memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas layanan di fasilitas kesehatan dengan cara menerapkan manajemen risiko di setiap sisi layanan yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan.
- b. Pasal 5 ayat 2 a Standar Keselamatan Pasien
- 1) hak dari pasien
 - 2) pembelajaran untuk pasien serta untuk anggota keluarga
 - 3) Keamanan Pasien dalam pelayanan yang berkelanjutan
 - 4) Mengimplementasikan pendekatan untuk meningkatkan kinerja, melakukan evaluasi, dan meningkatkan keselamatan untuk pasien
 - 5) Peran pemimpin dalam mendukung Keamanan Pasien
 - 6) Pelatihan untuk staf mengenai Keamanan Pasien

- 7) Komunikasi menjadi aspek yang krusial bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.
- c. Pasal 5 ayat 2 b Sasaran Keselamatan Pasien
 - 1) Ketepatan dalam mengenal pasien
 - 2) Meningkatkan komunikasi yang efisien
 - 3) Meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan penggunaan obat
 - 4) Menjamin prosedur, lokasi, dan pasien yang benar selama operasi
 - 5) Mengurangi peluang infeksi yang berkaitan dengan layanan kesehatan
 - 6) Menghindari risiko cedera disebabkan oleh jatuh (JCI, 2026)
 - d. pasal 5 ayat 2 c Tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien
 - 1) Meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya Keselamatan terhadap Pasien;
 - 2) Mengarahkan dan memberikan dukungan kepada tim
 - 3) Menyatukan aktivitas pengelolaan yang risiko
 - 4) Menciptakan sistem dari pelaporan
 - 5) Mengikutsertakan pasien dan menjaga alur komunikasi
 - 6) Meneliti dan menyebarkan pengalaman mengenai Keselamatan pada Pasien
 - 7) Menangani luka dengan menerapkan sistem Keselamatan terhadap Pasien.
4. Budaya Keselamatan:
- Cara membangun lingkungan kerja yang terbuka tanpa budaya saling menyalahkan (*just culture*) dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
- a. PMK no 11 tahun 2017 Pasal 11
 - 1) Ayat (1) Standar pelatihan bagi staf mengenai Keselamatan Pasien mencakup kegiatan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan serta menjaga kemampuan staf, sekaligus mendukung pendekatan lintas disiplin dalam pelayanan kesehatan kepada pasien.
 - 2) Ayat (2) Kriteria untuk standar pelatihan staf mengenai Keselamatan Pasien memiliki:
 - Setiap tempat pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan orientasi bagi pegawai baru yang mencakup isu Keselamatan Pasien sesuai dengan tugas mereka;
 - Setiap tempat pelayanan kesehatan diharuskan untuk memasukkan isu Keselamatan Pasien dalam semua aktivitas pelatihan/magang dan memberikan panduan yang terperinci mengenai pelaporan Insiden; dan

- Setiap tempat pelayanan kesehatan wajib melakukan pelatihan mengenai kerja sama tim untuk mendukung pendekatan multidisiplin dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada pasien..

b. KMK No HK.01.07/MENKES/1596/2024

Direktur mengimplementasikan Program Budaya Keselamatan di rumah sakit yang mencakup:

- 1) Tindakan yang memberikan layanan secara aman dan berkelanjutan untuk mencegah kesalahan dalam layanan yang berisiko tinggi.
- 2) Sikap di mana setiap orang diperbolehkan untuk melaporkan kesalahan dan insiden tanpa rasa takut akan sanksi atau kritikan serta diperlakukan dengan adil (budaya yang sepatutnya).
- 3) Kerjasama tim dan koordinasi untuk menghadapi masalah mengenai keselamatan pasien.
- 4) Dukungan dari manajemen rumah sakit kepada staf, seperti dalam penjadwalan kerja, penyelenggaraan pelatihan, metode aman untuk melaporkan masalah, dan usaha lain untuk menangani isu keselamatan.
- 5) Identifikasi dan pengakuan terhadap isu yang timbul dari perilaku tidak pantas (perilaku sembrono).
- 6) Evaluasi budaya secara teratur menggunakan metode seperti diskusi kelompok fokus (FGD), wawancara dengan karyawan, serta analisis data.
- 7) Memfasilitasi kolaborasi dan merancang sistem untuk membangun budaya perilaku yang aman.
- 8) Tanggapan terhadap perilaku yang tidak diperkenankan di semua tingkatan staf di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, klinis dan non-klinis, dokter praktik mandiri, wakil pemilik, dan anggota Dewan pengawas.

c. Kep Dirjen Yankes Nomor-43463-Tahun-2024

Pimpinan unit layanan kesehatan menetapkan program budaya keselamatan pasien dalam fasilitas kesehatan yang terdiri dari:

- 1) Tingkah laku yang menawarkan layanan dengan aman secara teratur untuk menghindari kesalahan dalam pelayanan kesehatan. terutama pada kelompok populasi dan layanan yang berisiko tinggi.
- 2) Perilaku individu yang bisa melaporkan kesalahan dan insiden tanpa rasa ketakutan akan konsekuensi, teguran, dan sanksi yang tidak sesuai, serta diterima secara adil (budaya yang adil).

Semua pihak yang terlibat di layanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya keselamatan bagi pasien dengan berbagai pendekatan. Saat ini, masih ada beberapa fasilitas kesehatan yang menerapkan budaya saling menyalahkan ketika ada kesalahan yang terjadi (budaya

menyalahkan), yang pada gilirannya menghalangi terciptanya budaya keselamatan pasien. Oleh karena itu, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menerapkan perlakuan yang adil (budaya yang adil) ketika kesalahan terjadi. Ada kalanya staf tidak seharusnya disalahkan atas kesalahan, contohnya dalam situasi:

- 1) Komunikasi yang tidak baik antara pasien dan pegawai.
- 2) Dibutuhkan keputusan yang segera.
- 3) Kurangnya jumlah pegawai dalam layanan pasien.

Di sisi lain, terdapat kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawabannya ketika pegawai dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak diinginkan (perilaku ceroboh), contohnya:

- 1) Enggan mencuci tangan.
- 2) Tidak melakukan penundaan (*time-out*) sebelum prosedur bedah.
- 3) Tidak memberikan tanda pada tempat operasi..

5. Kode Etik Keperawatan (PPNI, 2019)

- a. Perawatan Pasien: (3) Tugas utama dari seorang perawat adalah untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang memerlukan perawatan kesehatan. (4) Setiap perawat wajib untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, kecuali jika diwajibkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Keperawatan dan Praktek: (1) Seorang perawat perlu terus-menerus belajar untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan di bidang keperawatan. (2) Perawat selalu berusaha mempertahankan standar pelayanan keperawatan yang tinggi, didukung oleh integritas profesional dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien.

6. Memberikan Asuhan Keperawatan Sesuai Standar Dan Etika Profesi Serta Kebutuhan Pasien (Rumahorba et al, 2025)

a. Standar Pelayanan Keperawatan

- Kualitas Pelayanan

Keperawatan. Perawat perlu menyediakan perawatan yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, mencakup penilaian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi perawatan terhadap pasien.

- Keamanan Pasien.

Perawat harus memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilaksanakan dengan aman guna menghindari cedera atau komplikasi bagi pasien.

- Kualitas dan Efisiensi.
Perawatan yang dilakukan harus berhasil dalam mencapai hasil kesehatan yang diharapkan, dan dilakukan dengan cara yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- b. Standar Prosedur Operasional (SPO)
- Prosedur Keperawatan.
Tahapan yang perlu diikuti dalam prosedur keperawatan spesifik, seperti membersihkan pasien, memberikan medikasi, merawat luka, atau melakukan tindakan darurat.
 - Protokol Keamanan.
Prosedur yang memastikan keselamatan bagi pasien dan tenaga medis, termasuk penerapan alat pelindung dan langkah-langkah pencegahan infeksi.
 - Prosedur Administratif.
Tahapan dalam pencatatan dan pelaporan, memastikan bahwa setiap informasi medis tercatat dengan tepat dan menyeluruh.
- c. Etika Profesi
- Kerahasiaan.
Memastikan segala informasi mengenai pasien tetap rahasia dan tidak mengungkapkannya tanpa izin yang valid.
 - Otonomi Pasien.
Menghargai hak pasien untuk menentukan pilihan mengenai perawatan diri mereka.
 - Keadilan.
Menyediakan perawatan yang setara dan tanpa diskriminasi bagi semua pasien.
 - Beneficence dan Non-maleficence.
Bertindak demi kebaikan pasien serta menghindari tindakan yang bisa berbahaya bagi mereka.
- d. Kebutuhan Pasien
- Asesmen Kebutuhan.
Melakukan evaluasi lengkap tentang keadaan pasien guna menentukan kebutuhan perawatan yang khusus.
 - Perencanaan.
Membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan keperluan unik pasien tersebut.

- Pelaksanaan dan Evaluasi.
Menerapkan rencana perawatan dan secara berkelanjutan mengawasi serta menilai hasilnya untuk memastikan kebutuhan pasien dapat terpenuhi.

B. Manajemen Risiko Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Kep DirJen Yankes Nomor Hk. 02. 02/D/47104/2024

a. Elemen Penilaian TKRS 13 Manajemen Risiko 1) Standar TKRS 14:

1) Program manajemen risiko yang terintegrasi diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian dalam lingkungan rumah sakit. Berbagai jenis risiko yang perlu diidentifikasi mencakup tetapi tidak terbatas pada risiko:

- Operasional, yang merupakan risiko yang muncul saat rumah sakit memberikan layanan kepada pasien, baik yang berkaitan dengan perawatan klinis maupun non-klinis
- Risiko reputasi (gambaran rumah sakit dari sudut pandang masyarakat)
- Risiko strategis (yang terkait dengan perencanaan dan sasaran strategis rumah sakit)
- Risiko terhadap kepatuhan hukum serta peraturan yang berlaku.

2) Langkah-langkah manajemen risiko yang dilakukan di rumah sakit meliputi:

- Komunikasi dan juga konsultasi.
- Menetapkan konteks.
- Mengidentifikasi risiko berdasarkan kategori yang sudah ditentukan.
- Menganalisis risiko.
- Evaluasi risiko.
- Penanganan risiko.
- Pemantauan risiko.

3) Setiap tahun, program pengelolaan risiko di rumah sakit perlu disusun dengan mengacu pada daftar risiko yang diurutkan berdasarkan prioritas dalam profil risiko yang mencakup:

- Proses pengelolaan risiko
- Integrasi pengelolaan risiko di rumah sakit.
- Laporan mengenai kegiatan program pengelolaan risiko
- Penanganan klaim tuntutan yang mungkin timbul.

b. Penetapan Pengelolaan Risiko: Standar PMKP 11

- Komite atau Tim Penyusun Mutu bertugas mengarahkan pelaksanaan program pengelolaan risiko di fasilitas kesehatan. Komite atau Tim Penyusun Mutu membuat Daftar risiko di tingkat rumah sakit yang

didasarkan pada inventaris risiko yang dikumpulkan oleh setiap unit setiap tahunnya. Dari daftar ini, ditentukan prioritas risiko yang akan dicantumkan dalam profil risiko rumah sakit.

- Ada berbagai metode untuk melakukan analisis risiko dengan pendekatan yang proaktif, termasuk analisis modus kegagalan dan dampaknya (FMEA), analisis kerentanan terhadap bahaya (HVA), dan evaluasi risiko untuk pengendalian infeksi (ICRA). Rumah sakit mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai metode tersebut ke dalam program pengelolaan risiko yang ada. Pihak manajemen rumah sakit akan mendesain ulang proses yang dianggap berisiko tinggi yang telah dianalisis secara proaktif, dengan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dalam proses tersebut. Analisis risiko secara proaktif dilakukan minimal sekali dalam setahun dan hasilnya harus didokumentasikan.

c. Sistem Laporan dan Analisis Insiden (PMK no 11 tahun 2017)

1) Sistem Pelaporan

a) Pasal 18

- Setiap insiden wajib dilaporkan secara internal kepada tim Keselamatan Pasien dalam waktu maksimal 2x24 jam dengan menggunakan format laporan yang tertera dalam Formulir 1.
- Laporan yang disebutkan dalam ayat (1) akan diverifikasi oleh tim Keselamatan Pasien untuk memastikan keabsahan insiden tersebut.
- Setelah laporan diverifikasi sebagaimana diatur dalam ayat (2), tim Keselamatan Pasien melakukan penyelidikan melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen.
- Berdasarkan hasil penyelidikan yang dijelaskan dalam ayat (3), tim Keselamatan Pasien menetapkan tingkat insiden (grading) dan melaksanakan *Root Cause Analysis* (RCA) dengan metode standar untuk mengidentifikasi akar permasalahan
- Tim Keamanan Pasien harus memberikan saran tentang keselamatan pasien kepada pengelola fasilitas kesehatan berdasarkan hasil analisis penyebab utama (Root Cause Analysis/RCA) yang diatur dalam ayat (4).
- Aturan lebih lanjut mengenai analisis penyebab utama (RCA) akan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien.

b) Pasal 19

- Fasilitas kesehatan diwajibkan untuk melaporkan kejadian baik secara online maupun secara tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan

Pasien mengikuti format yang terdapat dalam Formulir 2 dan Formulir 3.

- Laporan mengenai kejadian yang telah diacu sebelumnya harus disampaikan setelah melakukan evaluasi serta mendapatkan saran dan pemecahan masalah dari tim Keselamatan Pasien di tempat tersebut.
- Tujuan dari pelaporan insiden yang disebutkan pada poin sebelumnya adalah untuk mengurangi frekuensi insiden dan memperbaiki sistem guna meningkatkan Keselamatan Pasien, tanpa adanya penilaian terhadap individu (non blaming).
- Laporan insiden yang dimaksud wajib dijamin kerahasiaannya, yang bersifat rahasia, anonim, dan juga tidak diperbolehkan untuk diakses bagi yang tidak memiliki kewenangan.

c) Pasal 20

Setelah mendapatkan informasi terkait Insiden sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19, Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan analisis dan memberikan tanggapan yang berisi rekomendasi untuk Keselamatan dari Pasien guna menghindari terulangnya peristiwa yang serupa di berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di seluruh negara.

2) Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko (KMK No. 1596 Tahun 2024)

Komite atau Tim Pengelola Kualitas akan memberikan laporan tentang pelaksanaan program PMKP kepada Direktur setiap triwulan. Setelah itu, Pimpinan mengirimkan laporan kepada Dewan Pengawas. Rincian dalam laporan mencakup:

- a) Hasil pengolahan data yang mencakup: Pencapaian seluruh indikator kualitas, analisis, validasi, dan perbaikan yang telah dilakukan.
 - b) Sebuah laporan mengenai semua insiden keselamatan pasien yang mencakup jumlah, jenis (kejadian sentinel, KTD, KNC, KTC, KPCS), tipe insiden dan kategori kerugian, tindak lanjut yang dilakukan, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dipertahankan.
- 3) Program peningkatan kualitas dan keselamatan pasien di rumah sakit mencakup (KMK No. 1596 Tahun 2024):
- a) Pengumpulan data tolok ukur kualitas yang mencakup indikator nasional mutu (INM), indikator mutu utama RS (IMP RS) serta tolok ukur mutu utama unit (IMP Unit).
 - b) Mendorong untuk melakukan perbaikan mutu dan juga mempertahankan peningkatan yang berkelanjutan.

- c) Jalur klinis digunakan untuk meminimalkan variasi dalam praktik klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol.
 - d) Menilai akibat dari efisiensi dan juga efektivitas dari prioritas perbaikan terhadap aspek finansial dan sumber daya seperti tenaga kerja.
 - e) Penyampaian hasil analisis insiden dari keselamatan pasien.
 - f) Implementasi sasaran dari keselamatan pasien.
 - g) Kontrak klinis dan juga pengelolaan kontrak dilakukan penilaian.
 - h) Pengembangan untuk semua anggota staf sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam program peningkatan kualitas dan keselamatan pasien.
 - i) Menyampaikan hasil dari pengukuran kualitas beserta masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas dan pencapaian data kepada staf.
- 4) Mencatat dan Melaporkan Asuhan Keperawatan yang diberikan (Rumahorba et al, 2025)
- a) Tujuan Pencatatan dan Pelaporan
 - 1. Kesiambungan Perawatan.
Pencatatan asuhan keperawatan memungkinkan setiap anggota tim kesehatan untuk memahami keadaan pasien secara menyeluruh. Informasi ini sangat penting untuk memastikan perawatan berlangsung secara konsisten dan terkoordinasi dengan baik.
 - 2. Dokumentasi Intervensi.
Semua intervensi keperawatan yang dilakukan harus dicatat dengan jelas dan tepat waktu, mencakup pengkajian pasien, diagnosis keperawatan, rencana tindakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.
 - 3. Pemenuhan Persyaratan Hukum dan Administratif.
Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan bukti sah dari perawatan yang diberikan dan dapat digunakan dalam konteks hukum jika dibutuhkan. Selain itu, pencatatan ini juga penting untuk memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.
 - b) Prinsip Pencatatan yang Baik
 - 1. Akurat dan Lengkap.
Semua informasi yang dicatat harus tepat, komprehensif, dan tidak ada yang boleh diabaikan. Kesalahan atau kelalaian dalam proses pencatatan dapat memberikan dampak yang serius terhadap perawatan pasien.

2. Tepat Waktu.

Pencatatan harus dilakukan segera setelah tindakan keperawatan berlangsung untuk menjamin bahwa data yang dicatat Adalah paling terkini dan paling tepat.

3. Objektif dan Jelas.

Catatan harus bersifat objektif, berisi fakta yang dapat diverifikasi, dan ditulis dengan bahasa yang lugas serta dapat dipahami oleh seluruh anggota tim kesehatan.

4. Privasi dan Kerahasiaan.

Data pasien harus tetap dirahasiakan dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Ini bertujuan untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi perlindungan data.

5) Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS (KKPRS, 2015)

Rumah Sakit

LAPORAN INSIDEN (INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 x 24 JAM

No : Ruangan :

MR

Umur : Bulan Tahun

Kelompok : ☐ 0-1 bulan

☐ > 1 bulan - 1 tahun

Umur*

☐ > 1 tahun - 5 tahun

☐ > 5 tahun - 15 tahun

☐ > 15 tahun - 30 tahun

☐ > 30 tahun - 65 tahun

>

☐ > 65 tahun

Jenis : ☐ Laki-laki

☐ Perempuan

kelamin

Penanggung biaya pasien :

☐ Pribadi

☐ Asuransi Swasta

☐ BPJS

☐ lainnya
(sebutkan)

Tanggal : Jam

Masuk RS

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

Tanggal : Jam

2. Insiden :

3. Kronologis Insiden

.....

.....

.....

4. Jenis Insiden* :

☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (*Near miss*)

☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (*Adverse Event*) / Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*)

☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC

- ☐ KPC
5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
- ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
- ☐ Pasien
- ☐ Keluarga / Pendamping pasien
- ☐ Pengunjung
- ☐ Lain-lain.....(sebutkan)
6. Insiden menyangkut pasien :
- ☐ Pasien rawat inap Pasien rawat jalan
- ☐ Pasien UGD
- ☐ Lain-lain (sebutkan)
7. Tempat Insiden
- Lokasi kejadian (sebutkan)
- (Tempat pasien berada)
8. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
- ☐ Anak dan Subspesialisasinya
- ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
- ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
- ☐ THT dan Subspesialisasinya
- ☐ Mata dan Subspesialisasinya
- ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
- ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
- ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain (sebutkan)
9. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
- Unit kerja penyebab (sebutkan)
10. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
- ☐ Kematian
- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ☐ Tidak ada cedera
11. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
-

.....

.....

12. Tindakan dilakukan oleh* :

Tim : terdiri dari :

☐ Dokter

☐ Perawat

☐ Petugas lainnya.....

13. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

☐ Ya ☐ Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....

Pembuat	:	Penerima	:
Laporan	:	Laporan	:
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Terima	:	Tgl Lapor	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU

HIJAU

KUNING

MERAH

NB. * = pilih satu jawaban.

KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN KKPRS

(Patient Safety Incident Report)

- Laporan ini hanya dibuat ketika terjadi insiden yang berkaitan dengan pasien. Laporan ini bersifat rahasia, tidak menyebutkan nama-nama, dan hanya memerlukan informasi tentang insiden, penyebabnya, serta rekomendasi yang diperlukan.
- Untuk mengisi laporan ini, silakan baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Jika ada hal yang tidak jelas, isi berdasarkan pemahaman Anda.
- Isi semua informasi pada Laporan Insiden Keselamatan Pasien secara lengkap. Jangan biarkan kolom kosong agar data dapat dianalisis.
- Kirimkan laporan ini segera ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

KODE RS : (lewat : <http://www.buk.depkes.go.id>)

I. DATA PASIEN

Umur : Bulan Tahun

Kelompok Umur* : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan - 1 tahun
☐ > 1 tahun - 5 tahun ☐ > 5 tahun - 15 tahun
☐ > 15 tahun - 30 tahun ☐ > 30 tahun - 65 tahun
☐ > 65 tahun

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Penanggung biaya :
pasien ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☐ JKN ☐ lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk RS : Jam
.....

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden
Tanggal : Jam
2. Insiden :
3. **Grading Risiko**
4. Kronologis Insiden
.....
.....
.....
5. Jenis Insiden* :
☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (*Near miss*)
☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (*Adverse Event*) / Kejadian
☐ Sentinel (*Sentinel Event*)
☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
6. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
☐ Pasien
☐ Keluarga / Pendamping pasien
☐ Pengunjung
☐ Lain-lain (sebutkan)

7. Insiden terjadi pada* :
 - ☐ Pasien
 - ☐ Lain-lain (sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3 RS.
8. Insiden menyangkut pasien :
 - ☐ Pasien rawat inap D Pasien rawat jalan D Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain (sebutkan)
9. Tempat Insiden

Lokasi kejadian (sebutkan)

(Tempat pasien berada)
10. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
 - ☐ Lain-lain (sebutkan)
11. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden

Unit kerja penyebab (sebutkan)
12. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
 - ☐ Kematian
 - ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
 - ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 - ☐ Cedera Ringan
 - ☐ Tidak ada cedera
13. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :

.....

.....

14. Tindakan dilakukan oleh* :

- ☐ Tim : terdiri dari :
- ☐ Dokter
- ☐ Perawat
- ☐ Petugas lainnya

15. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

- ☐ Ya ☐ Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....

III. TIPE INSIDEN

Insiden :

Tipe Insiden :

Subtipe Insiden :

IV. ANALISA PENYEBAB INSIDEN

Dalam pengisian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)

- a. Faktor Eksternal / di luar RS
- b. Faktor Organisasi dan Manajemen
- c. Faktor Lingkungan kerja
- d. Faktor Tim
- e. Faktor Petugas / Staf
- f. Faktor Tugas
- g. Faktor Pasien
- h. Faktor Komunikasi

V. FAKTOR KONTRIBUTOR, KOMPONEN & SUBKOMPONEN

Faktor kontributor adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya insiden. Penyebab insiden dapat digolongkan berdasarkan penggolongan faktor Kontributor seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Faktor kontributor dapat dipilih lebih dari satu.

1. FAKTOR KONTRIBUTOR EKSTERNAL / DI LUAR RS

Komponen
a. Regulator dan Ekonomi
b. Peraturan & Kebijakan Depkes
c. Peraturan Nasional

d. Hubungan dengan Organisasi lain

2. FAKTOR KONTRIBUTOR ORGANISASI & MANAJEMEN

Komponen	SubKomponen
Organisasi & Manajemen	a. Struktur Organisasi b. Pengawasan c. Jenjang Pengambilan Keputusan
Kebijakan, Standar & Tujuan	a. Tujuan & Misi b. Penyusunan Fungsi Manajemen c. Kontrak Service d. Sumber Keuangan e. Pelayanan Informasi f. Kebijakan diklat g. Prosedur & Kebijakan h. Fasilitas & Perlengkapan i. Manajemen Risiko j. Manajemen K3 k. Quality Improvement
Administrasi	Sistim Administrasi
Budaya Keselamatan	a. Attitude kerja b. Dukungan manajemen oleh seluruh staf
SDM	a. Ketersediaan b. Tingkat Pendidikan & Keterampilan Staf yang berbeda c. Beban Kerja yang optimal
Diklat	Manajemen Training Pelatihan / <i>Refreshing</i>

3. FAKTOR LINGKUNGAN KERJA

Komponen	SubKomponen
Desain dan Bangunan	a. Manajemen Pemeliharaan b. Penilaian Ergonomik c. Fungsionalitas
Lingkungan	a. <i>Housekeeping</i> b. Pengawasan Lingkungan Fisik c. Perpindahan Pasien antar Ruangan

Peralatan / sarana / prasarana	a. Malfungsi Alat b. Ketidakterediaan c. Manajemen Pemeliharaan d. Fungsionalitas e. Desain, Penggunaan & Pemeliharaan peralatan
--------------------------------	--

4. FAKTOR KONTRIBUTOR : TIM

Komponen	SubKomponen
Supervisi & Konsultasi	a. Adanya kemauan staf junior berkomunikasi b. Cepat Tanggap
Konsistensi	a. Kesamaan tugas antar profesi b. Kesamaan tugas antar staf yang setingkat
Kepemimpinan & Tanggung Jawab	a. Kepemimpinan Efektif b. <i>Job Desc</i> Jelas
Respon terhadap Insiden	Dukungan <i>peers</i> setelah insiden

5. FAKTOR KONTRIBUTOR : PETUGAS

Komponen	SubKomponen
Kompetensi	a. Verifikasi Kualifikasi b. Verifikasi Pengetahuan & Keterampilan
Stressor Fisik dan Mental	a. Motivasi b. Stresor Mental: efek beban kerja = beban mental c. Stresor Fisik: Efek beban kerja = Gangguan Fisik

6. FAKTOR KONTRIBUTOR : TUGAS

Komponen	SubKomponen
Ketersediaan SOP	a. Prosedur Peninjauan & Revisi SPO b. Ketersediaan SPO c. Kualitas Informasi d. Prosedur Investigasi
Ketersediaan & akurasi hasil test	a. Test Tidak Dilakukan b. Ketidakesesuaian antara interpretasi hasil test

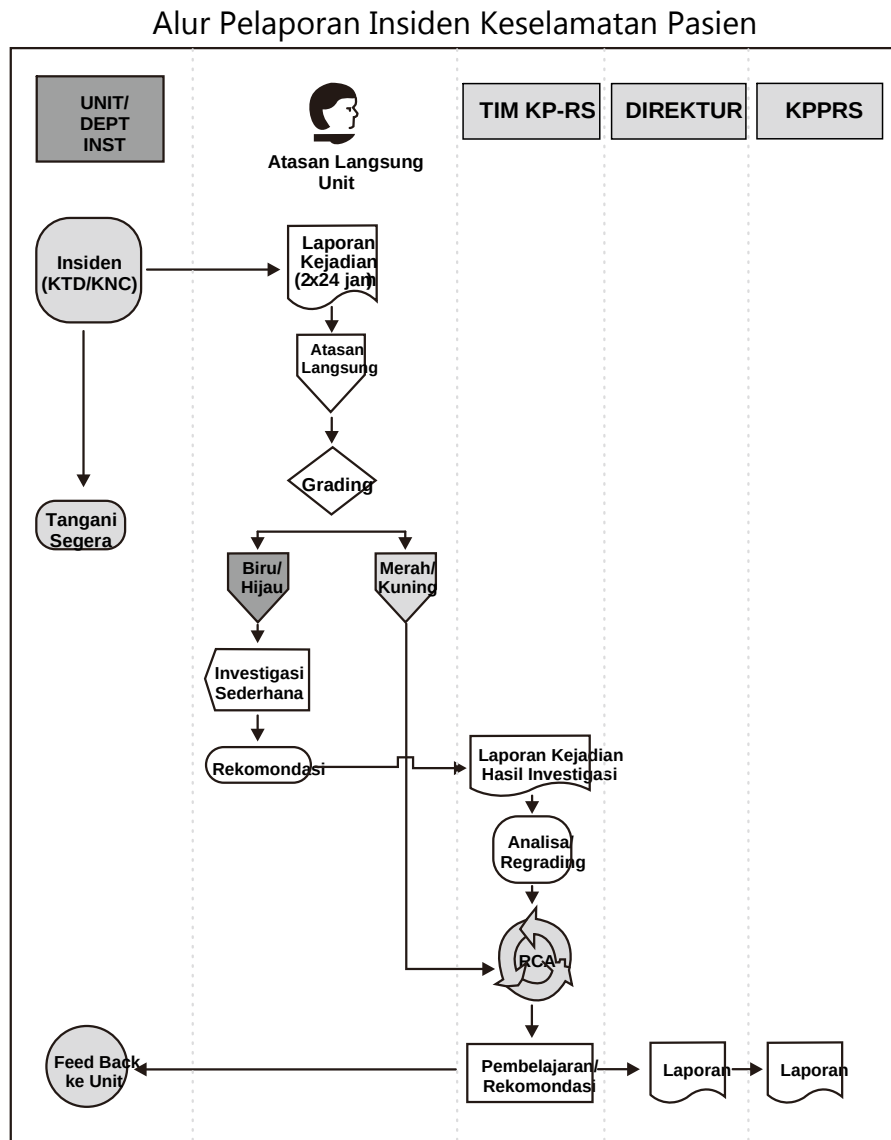
Faktor Penunjang dalam validasi alat medis	a. Ketersediaan, penggunaan, reliabilitas b. Kalibrasi
Desain Tugas	Penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai SPO

7. FAKTOR KONTRIBUTOR : PASIEN

Komponen	SubKomponen
Kondisi	Penyakit yang kompleks, berat, multikomplikasi
Personal	a. Kepribadian b. Bahasa c. Kondisi Sosial d. Keluarga
Pengobatan	Mengetahui risiko yang berhubungan dengan pengobatan
Riwayat	a. Riwayat Medis b. Riwayat Kepribadian c. Riwayat Emosi
Hubungan Staf dan Pasien	Hubungan yang baik

8. FAKTOR KONTRIBUTOR KOMUNIKASI

Komunikasi Verbal	a. Komunikasi antar staf junior dan senior b. Komunikasi antar Profesi c. Komunikasi antar Staf dan Pasien d. Komunikasi antar Unit Departemen
Komunikasi Tertulis	Ketidaklengkapan Informasi



Gambar 2. 1 Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

C. Latihan Soal

1. Faktor pendukung merupakan elemen yang menyebabkan terjadinya insiden. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor pendukung tugas adalah:
 - A. Prosedur Evaluasi dan Perubahan SPO
 - B. Ketersediaan SPO
 - C. Mutu Informasi
 - D. Prosedur Penyelidikan
 - E. Semua benar

2. Yang tidak termasuk dalam Faktor pendukung organisasi dan manajemen, elemen SDM adalah:
 - A. Ketersediaan
 - B. Sikap kerja
 - C. Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Staf yang berbeda
 - D. Beban Kerja yang ideal
 - E. Semua benar
3. Dalam proses pelaporan Insiden Keselamatan pasien dengan grading Biru/hijau, langkah apa yang harus diambil?
 - A. Penyelidikan sederhana
 - B. Laporan peristiwa hasil penyelidikan
 - C. Analisa Regrading
 - D. ICRA
 - E. Semua benar
4. Laporan internal Kejadian KTD/KNC maksimal dilakukan :
 - A. 1x24 jam
 - B. 2x24 jam
 - C. 3x 24 jam
 - D. Sewaktu diperlukan
 - E. 1 minggu
5. Etika Profesi mencakup :
 - A. Kerahasiaan
 - B. Otonomi Pasien
 - C. Keadilan
 - D. Beneficence dan Non-maleficence
 - E. Semua benar

Kunci jawaban

1. E
2. B
3. A
4. B
5. E

Esay

1. Mencatat dan Melaporkan Asuhan Keperawatan yang diberikan memiliki Prinsip Pencatatan yang Baik, sebutkan:

Jawaban :

- a. Akurat dan Lengkap.
- b. Tepat Waktu.
- c. Objektif dan Jelas.
- d. Privasi dan Kerahasiaan

2. Rencana pengelolaan risiko di rumah sakit perlu dibuat setiap tahun berdasarkan daftar risiko yang diurutkan menurut prioritas dalam profil risiko yang mencakup hal-hal berikut?

Jawaban :

- a. Tahapan pengelolaan risiko
- b. Penyatuan manajemen risiko di fasilitas kesehatan.
- c. Dokumen laporan aktivitas program pengelolaan risiko
- d. Administrasi klaim yang mungkin menyebabkan tuntutan hukum

3. Pada Elemen Penilaian TKRS 13 Manajemen Risiko 1) Standar TKRS 14 bahwa Proses manajemen risiko yang diterapkan dalam rumah sakit mencakup:

Jawaban :

- a. Komunikasi dan konsultasi.
- b. Menentukan konteks.
- c. Identifikasi risiko sesuai dengan kategori risiko
- d. Analisis risiko.
- e. Evaluasi risiko.
- f. Penanganan risiko.
- g. Pemantauan risiko

4. Pada Kep Dirjen Yankes Nomor-43463-Tahun-2024 Bahwa Pimpinan unit layanan kesehatan menetapkan program budaya keselamatan pasien dalam fasilitas kesehatan yang mencakup apa saja?

Jawaban

- a. Perilaku memberikan layanan yang aman secara konsisten untuk mencegah kesalahan dalam pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok populasi dan layanan yang berisiko tinggi.

- b. Perilaku individu yang bisa melaporkan kesalahan dan insiden tanpa rasa ketakutan akan konsekuensi, teguran, dan sanksi yang tidak sesuai, serta diterima secara adil (budaya yang adil).

5. Sebutkan Tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien

Jawaban

- a. Membangun pemahaman tentang pentingnya Keselamatan Pasien;
- b. Memimpin serta membantu tim
- c. Memadukan kegiatan pengelolaan risiko
- d. Menciptakan sistem pelaporan
- e. Melibatkan serta berkomunikasi dengan pasien
- f. Belajar dan membagikan pengalaman terkait Keselamatan Pasien
- g. Menanggulangi cedera melalui penerapan sistem Keselamatan Pasien

D. Rangkuman

Pelayanan kesehatan harus didasarkan pada peraturan nasional seperti KMK Nomor 1596 Tahun 2024 serta kode etik profesi. Tanggung Jawab Hukum: Tenaga medis mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sekaligus Prinsip Etik yang menekankan keselamatan pasien (non-maleficence) dan bertindak demi kebaikan pasien (beneficence).

Keselamatan pasien dapat didefinisikan sebagai suatu cara di mana institusi layanan kesehatan (seperti rumah sakit) membangun suasana yang lebih aman untuk pasien. Cara ini mencakup: penilaian terhadap risiko serta pengenalan potensi bahaya, penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko, dan enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP): keakuratan dalam mengenali pasien, komunikasi yang efisien, keamanan dalam penggunaan obat-obatan yang memiliki risiko tinggi, jaminan terhadap lokasi atau prosedur bedah, pengurangan potensi infeksi, dan pencegahan jatuhnya pasien.

Manajemen Risiko dalam Layanan Kesehatan bertujuan untuk mengendalikan ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan guna mencegah terjadinya cedera. Fokus utamanya adalah: Identifikasi Risiko dan Pengelolaan Risiko. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan instrumen pembelajaran untuk mencegah terulangnya insiden yang serupa. Jenis insiden yang harus dilaporkan mencakup: KTD, KNC, KTC, KPC, dan Kejadian Sentinel.

Glosarium

FGD	: Kelompok Fokus Diskusi
FMEA	: <i>Failure Mode Effect Analysis</i> (analisis modus kegagalan dan dampaknya)
HVA	: <i>Hazard Vulnerability Analysis</i>
ICRA	: <i>Infection Control Risk Assessment</i> (pengkajian risiko pengendalian infeksi)
IKP	: Insiden Keselamatan Pasien
IMP	: Indikator Mutu Prioritas
INM	: Indikator Nasional Mutu
KMK	: Keputusan Menteri Kesehatan
KNC	: kejadian nyaris cedera
KTD	: Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
KNC	: Kejaidan Nyaris Cedera
KTC	: Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan atau near-miss)
KPCS	: Kondisi Potensial Cedera Signifikan
KP	: Keselamatan Pasien
PMK	: Peraturan Mentri kesehatan
PMKP	: Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
PPK	: Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan
RCA	: <i>Root Cause Analysis</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPO	: Standar Prosedur Operasional
TKRS	: Tata Kelola Rumah Sakit

Referensi

- Herkutanto (2014). Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit
- Joint Commission International. (2026). Patient Safety Goals and Clinical Risk Management Standards. JCI Press
- Kep Dirjen Yankes Nomor Hk.02.02/D/47104/2024 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit
- Kep Dirjen Yankes nomor-43463-tahun-2024. pedoman-survei-budaya-keselamatan-pasien
- KMK No HK.01.07/MENKES/1596/2024. Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- Persatuan Perawat Indonesia (2019). Kode Etik Keperawatan Lambang Panji PPNI dan Ikrar Keperawatan
- Permenkes Nomor 11 Tahun 2017. Keselamatan Pasien
- Rumahorba et al, (2025). Etika Keperawatan Dan Hukum kesehatan. Erlangga
- UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Tentang Kesehatan

BAB 3

MALPRAKTIK, KELALAIAN (NEGLIGENCE), DAN DISIPLIN PROFESI: KONSEP DAN PENCEGAHAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab3. Malpraktik, Kelalaian (Negligence), dan Disiplin Profesi: Konsep dan Pencegahan	3.1 Mengidentifikasi faktor sistem dan faktor praktik yang meningkatkan risiko kelalaian pada kasus.	3.2 Menetapkan strategi pencegahan (standar, supervisi, komunikasi, dokumentasi) untuk menurunkan risiko.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-1

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit
CPMK-6	Mini RCA/analisis insiden + presentasi singkat	Skor ketepatan klasifikasi risiko, kualitas rencana pencegahan berbasis akar masalah, dan keterukuran indikator audit.	15	RCA mini; slide/handout ringkas

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan peran profesionalnya, perawat selalu bersinggungan dengan aspek hukum dan disiplin. Praktik keperawatan yang aman tidak hanya menuntut keterampilan klinis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai batasan legal agar terhindar dari gugatan malpraktik dan kelalaian. Bab ini akan membedah secara filosofis dan yuridis mengenai konsep malpraktik, perbedaan mendasarnya dengan kelalaian, serta bagaimana regulasi terbaru dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mengatur tentang disiplin profesi tenaga kesehatan.

B. MALPRAKTIK DALAM KEPERAWATAN

1. Definisi dan Konsep

Secara etimologi, malpraktik berasal dari kata "*male*" yang berarti buruk dan "*practice*" yang berarti praktik. Malpraktik didefinisikan sebagai kegagalan seorang profesional untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian atau cedera bagi pengguna jasa. Dalam tatanan kesehatan, malpraktik dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (*intentional misconduct*), kelalaian (*negligence*), maupun ketidakmampuan (*unskillfulness*) yang tidak beralasan (Sampurno, 2005; Nasrullah, 2019).

Ninik Mariyanti dalam Nasrullah (2019) menjabarkan pengertian malpraktik ke dalam dua spektrum utama:

- a. Arti Umum: Praktik buruk yang tidak memenuhi standar teknis maupun etis profesi.
- b. Arti Khusus: Kegagalan dalam tahapan asuhan, mulai dari penegakan diagnosis yang salah, kesalahan prosedur operasi, hingga kelalaian dalam perawatan pasca-tindakan.

Malpraktik juga didefinisikan sebagai kegagalan profesional untuk memenuhi standar pelayanan yang mengakibatkan kerugian (Soekanto, 2014). Berdasarkan definisi ini, maka malpraktik dibagi menjadi tiga kategori besar:

1) Malpraktik Etik

Fokus pada pelanggaran terhadap kode etik profesi yang telah disepakati oleh organisasi profesi (PPNI). Contoh Kasus: * Seorang perawat mengambil foto pasien yang sedang tidak berdaya di ICU dan mengunggahnya ke media sosial (Instagram Story) dengan caption yang tidak pantas, meskipun identitas pasien ditutup stiker. Ini melanggar prinsip *Confidentiality* dan *Privacy*. Menerima komisi dari apotek tertentu untuk memaksa pasien membeli alat kesehatan di tempat tersebut. Sanksi Oleh MKEK PPNI/Komite Etik RS:

- a) Teguran lisan atau tertulis.
- b) Kewajiban mengikuti pembinaan/pelatihan ulang etika.
- c) Rekomendasi skorsing keanggotaan organisasi profesi

2) Malpraktik Perdata

Kelalaian yang menyebabkan kerugian finansial atau fisik yang menuntut ganti rugi. Fokus pada kerugian (*damages*) yang diderita pasien dan tuntutan ganti rugi berupa materiil/uang. Terjadi ketika perawat tidak melaksanakan kewajiban (*breach of duty*) sehingga menyebabkan kerugian

finansial atau cacat fisik pada pasien. Dasar hukumnya adalah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Contoh Kasus: * Perawat lalai tidak memasang pengaman tempat tidur (*side rail*) pada pasien lansia yang berisiko jatuh. Pasien akhirnya jatuh dan mengalami patah tulang paha (*fraktur femur*). Keluarga menuntut ganti rugi seluruh biaya operasi dan perawatan tambahan selama di rumah sakit. Sanksi Oleh Pengadilan Negeri (Soekanto, 2014):

- a) Kewajiban membayar ganti rugi (restitusi) kepada pasien/keluarga.
- b) Pemulihan nama baik (jika dituntut)

3) Malpraktik Pidana

Tindakan yang memenuhi unsur delik pidana, seperti kecerobohan berat yang menyebabkan kematian. Fokus pada pelanggaran hukum negara yang dianggap merugikan kepentingan umum atau menyebabkan hilangnya nyawa/cacat berat karena kesengajaan atau kealpaan berat. Tindakan yang memenuhi delik pidana dalam KUHP atau UU Kesehatan. Terbagi menjadi *Rechtshulp* (karena kesengajaan) dan *Culpa* (karena kelalaian berat/kecerobohan). Contoh Kasus: * *Culpa* (Kealpaan): Perawat salah memberikan dosis obat suntik (10 kali lipat dari dosis seharusnya) karena tidak melakukan prinsip 7 Benar, yang mengakibatkan pasien meninggal dunia (*Overdosis*). *Intentional* (Kesengajaan): Melakukan tindakan medis di luar kewenangan (misal: melakukan aborsi ilegal atau memberikan suntik mati/eutanasia atas permintaan sendiri). Sanksi oleh Pengadilan Negeri/Pidana (UU No. 17 tahun 2023):

- a) Pidana penjara atau kurungan.
- b) Pidana denda.
- c) Pencabutan hak-hak tertentu (seperti hak menjalankan praktik profesi secara permanen).

2. Klasifikasi Malpraktik

Berdasarkan niat dan landasannya, malpraktik dibedakan menjadi:

- a. Malpraktik Murni: Melakukan tindakan yang secara nyata melanggar undang-undang dan dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah.
- b. Malpraktik Disengaja: Tindakan yang melanggar hukum secara sadar, namun tidak selalu melibatkan unsur kelalaian teknis, melainkan pelanggaran terhadap prosedur legal.
- c. Malpraktik Tidak Sengaja: Terjadi karena faktor kecerobohan atau ketidaktelitian (kelalaian), seperti menelantarkan pasien karena lupa (Nasrullah, 2019).

3. Pembuktian Malpraktik (Teori Vestal)

Untuk menyatakan seorang perawat telah melakukan malpraktik secara hukum, penggugat harus mampu membuktikan empat elemen utama (4D):

- a. *Duty* (Kewajiban): Harus ada hubungan profesional yang melahirkan kewajiban bagi perawat untuk memberikan asuhan berdasarkan standar keperawatan.
- b. *Breach of Duty* (Pelanggaran Kewajiban): Perawat menyimpang dari standar yang seharusnya dilakukan. Contoh: Gagal menjalankan kebijakan rumah sakit yang sudah ditetapkan.
- c. *Injury* (Cedera): Pasien mengalami kerugian fisik, mental, atau emosional yang nyata.
- d. *Proximate Cause* (Sebab Langsung): Harus dibuktikan bahwa cedera tersebut secara langsung disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan perawat (Vestal, 1995; Nasrullah, 2019).

4. Bentuk Malpraktik yang Sering Terjadi

Beberapa situasi kritis yang berisiko tinggi menimbulkan malpraktik antara lain (Kozier et al., 2018):

- a. Kesalahan Administrasi Obat: Kegagalan membaca label, kesalahan hitung dosis, atau kesalahan rute pemberian.
- b. Pengabaian Keluhan Pasien: Gagal melakukan observasi terhadap perubahan tanda vital yang dikeluhkan pasien.
- c. Kesalahan Identifikasi: Terjadi pada lingkungan kerja yang sangat sibuk, mengakibatkan tertukarnya tindakan antar pasien.
- d. Benda Asing Tertinggal: Kelalaian di ruang operasi di mana alat kesehatan tertinggal di tubuh pasien akibat kurangnya koordinasi tim.

5. Sanksi hukum dan etik malpraktik

Berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, disiplin profesi berada di bawah wewenang MDTK yang merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Tabel 3. 1 Perbandingan Penegakan Hukum & Disiplin

Aspek	Etik	Disiplin	Hukum (Perdata/Pidana)
Norma	Kode Etik Profesi	Standar Profesi & SOP	UU / Peraturan Negara
Lembaga	MKEK PPNI	MDTK (KTKI)	Pengadilan / Kepolisian

Aspek	Etik	Disiplin	Hukum (Perdata/Pidana)
Tujuan	Menjaga martabat profesi	Menjaga mutu pelayanan	Menegakkan keadilan/ketertiban
Sanksi Utama	Sanksi Moral/Organisasi	Pencabutan STR/SIP sementara/tetap	Penjara atau Ganti Rugi

Tabel 3. 2 Sanksi Pelanggaran Etik, Perdata, Pidana

Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus Klinis	Sanksi / Konsekuensi
Malpraktik Etik	Perawat menceritakan kondisi penyakit pasien (HIV/Kanker) kepada teman sejawat di kantin tanpa kepentingan medis.	Teguran lisan/tertulis, kewajiban pembinaan etika oleh Komite Keperawatan/MKEK PPNI.
Malpraktik Perdata	Perawat lalai memantau tetesan infus pada pasien anak (kelebihan cairan/infiltrasi) yang menyebabkan luka permanen. Keluarga menuntut biaya operasi perbaikan.	Ganti rugi materiil (uang) kepada pasien sesuai putusan pengadilan atau kesepakatan mediasi.
Malpraktik Pidana	Perawat memberikan suntikan obat yang salah (tertukar dengan pasien lain) karena tidak cek gelang identitas, sehingga pasien meninggal dunia.	Pidana penjara, denda, dan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) secara permanen.

6. Doktrin Hukum dalam Malpraktik Keperawatan

Dalam persidangan malpraktik medik, terdapat dua doktrin utama yang sering digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum:

a. Res Ipsa Loquitur (The Thing Speaks for Itself)

Doktrin ini berarti "fakta yang berbicara sendiri". Dalam doktrin ini, penggugat tidak perlu membuktikan kelalaian perawat secara detail karena fakta kejadiannya sudah cukup untuk menunjukkan adanya kelalaian. Syarat Penerapan: 1. Peristiwa tersebut secara normal tidak akan terjadi tanpa adanya kelalaian. 2. Instrumen atau penyebab cedera berada dalam kendali penuh

perawat/tim medis. 3. Pasien tidak berkontribusi terhadap cedera tersebut. Contoh: Ketinggalannya kain kasa atau alat bedah di dalam tubuh pasien pasca-operasi. Fakta adanya benda asing sudah cukup membuktikan terjadinya kelalaian (Guwandi, 2007).

b. Vicarious Liability / Respondent Superior

Doktrin ini menyatakan bahwa atasan (Rumah Sakit atau Dokter Penanggung Jawab) bertanggung jawab atas tindakan bawahan (perawat) yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Prinsip: Jika perawat melakukan kelalaian saat menjalankan tugas sesuai SOP rumah sakit, maka rumah sakit turut digugat untuk membayar ganti rugi (Soekanto, 2014). Pengecualian: Jika perawat melakukan tindakan di luar wewenang atau melanggar instruksi tegas atasan, maka tanggung jawab dapat beralih sepenuhnya kepada individu perawat.

Studi Kasus Nasional: Bahan Diskusi Kelas

Kasus 1: Kelalaian Pemberian Obat (Kasus Viral "Salah Suntik")

Di sebuah rumah sakit daerah, seorang perawat dilaporkan karena diduga salah memberikan dosis obat suntik kepada pasien anak, yang menyebabkan pasien mengalami kejang hebat dan penurunan kesadaran. Kasus ini viral karena keluarga mengunggah video protes di media sosial. **Poin Diskusi:** Analisis apakah perawat telah melakukan *Double Check*? Bagaimana peran dokumentasi dalam membela diri dari tuduhan viral?

Kasus 2: Pelanggaran Privasi Pasien (Kasus Nakes & Konten Media Sosial) Seorang perawat mengunggah konten video mengenai pemasangan kateter pada pasien pria di media sosial dengan narasi yang dianggap melecehkan privasi pasien. Kasus ini memicu kemarahan publik dan berujung pada sanksi disiplin berat. **Poin Diskusi:** Identifikasi jenis pelanggaran etik dan sanksi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.

Prosedur Root Cause Analysis (RCA) & Pelaporan Insiden

Untuk mencegah pengulangan kesalahan, perawat wajib memahami alur pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) sebagai berikut (Kozier et al., 2018):

- 1) Identifikasi Insiden: Segera kenali jika terjadi Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), atau Kejadian Sentinel.
- 2) Pelaporan (*Reporting*): Isi formulir laporan insiden dalam waktu maksimal 2x24 jam. Laporan bersifat rahasia dan tidak bertujuan menyalahkan individu (*Non-blaming culture*).
- 3) Analisis Penyebab (RCA):
 - a) *Gathering Data*: Kumpulkan bukti rekam medis dan wawancara saksi.

- b) *Mapping*: Petakan kronologi kejadian.
- c) *Identify Root Cause*: Gunakan metode "5 Whys" (bertanya "mengapa" sebanyak 5 kali) hingga ditemukan akar masalah (misal: SOP tidak jelas atau kelelahan kerja).
- 4) Rencana Tindak Lanjut: Mengubah SOP atau melakukan pelatihan ulang bagi staf.

Informed Consent sebagai Perisai Hukum (The Shield)

Informed Consent bukan sekadar lembar tanda tangan, melainkan proses komunikasi yang legal.

1) Fungsi Pelindung

Jika di kemudian hari terjadi risiko medis yang sudah dijelaskan sebelumnya (misal: alergi obat yang tidak diketahui atau perdarahan pasca-tindakan), perawat terlindungi secara hukum karena pasien telah menerima risiko tersebut secara sadar (*Assumption of Risk*).

2) Syarat Keabsahan sebagai Perisai:

- a) Informasi Lengkap: Mencakup diagnosis, tujuan, risiko, komplikasi, dan alternatif tindakan.
- b) Kompetensi: Pasien dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan.
- c) Sukarela: Tanpa paksaan dari pihak manapun.

3) Dokumentasi

Perawat sebagai saksi harus memastikan proses pemberian informasi dilakukan oleh dokter dan mendokumentasikan respon pasien dalam catatan keperawatan (Mendri & Prayogi, 2017).

c. Mitigasi Masalah (Langkah Pencegahan Sistemik)

Mitigasi adalah upaya proaktif untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Perawat/mahasiswa harus memahami bahwa "mencegah lebih baik daripada mengadili". Beberapa langkah pencegahan menurut Guwanti (2007) dan Mendri (2017) Adalah:

1) Mitigasi Individual (*Self-Protection*)

- a) Penerapan Prinsip "*Check and Re-check*": Melakukan *double-check* untuk obat-obatan berisiko tinggi (*high alert*) bersama rekan sejawat.
- b) Komunikasi SBAR & *Write-Back*: Saat menerima instruksi verbal dari dokter melalui telepon, perawat wajib menulis, membacakan kembali, dan meminta konfirmasi (*Tulis-Baca-Konfirmasi*).
- c) Mengenali Batas Kompetensi: Berani menolak melakukan tindakan medis yang di luar kewenangannya (Delegasi Medis) jika tidak ada surat penugasan klinis yang jelas.

2) Mitigasi Administrasi & Legal

a) *Informed Consent* yang Berkualitas

Memastikan pasien menandatangani persetujuan bukan sekadar formalitas, melainkan setelah benar-benar paham risiko tindakan.

b) Dokumentasi *Real-Time*

Mencatat setiap respon pasien segera setelah tindakan dilakukan (Prinsip: *Not documented = Not done*).

c) Incident Reporting (Pelaporan Insiden)

Melaporkan Kejadian Nyaris Cedera (KNC) ke Komite Keselamatan Pasien tanpa rasa takut dipersalahkan (*No-blame culture*) agar sistem dapat diperbaiki

C. KELALAIAN (NEGLIGENCE)

1. Pengertian Kelalaian

Berbeda dengan malpraktik yang sering kali diasosiasikan dengan pelanggaran standar profesional yang disengaja atau ketidakmampuan (*unskillfulness*), kelalaian adalah jenis malpraktik yang bersifat tidak sengaja (*unintentional tort*). Kelalaian adalah bentuk kegagalan seseorang untuk berperilaku dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana dalam situasi serupa. Dalam keperawatan, kelalaian terjadi jika perawat melakukan asuhan di bawah standar minimum yang ditetapkan (Mendri & Prayogi, 2017).

Menurut Guwandi (2007), kelalaian adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang lain yang hati-hati dalam situasi yang sama, atau sebaliknya, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks keperawatan, kelalaian terjadi ketika perawat gagal menerapkan standar asuhan yang seharusnya dapat mencegah cedera pada pasien.

Perbedaan utama kelalaian dengan malpraktik terletak pada aspek profesionalitasnya. Malpraktik adalah kelalaian yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas profesionalnya. Sedangkan kelalaian bisa dilakukan oleh siapa saja (non-profesional), seperti pengemudi kendaraan bermotor.

2. Bentuk-Bentuk Kelalaian

Menurut Sampurno (2005), kelalaian dalam pelayanan kesehatan dibagi menjadi:

- a. *Malfeasance*: Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak layak sama sekali (misal: melakukan tindakan medis tanpa indikasi).

- b. *Misfeasance*: Memilih tindakan yang benar, namun melaksanakannya dengan prosedur yang salah.
 - c. *Nonfeasance*: Sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan kewajibannya (misal: tidak memasang pagar tempat tidur pada pasien berisiko jatuh).
3. Penyebab kelalaian (Faktor Risiko)
- Akar masalah kelalaian sering kali bersifat multifaktorial, antara lain:
- a. Faktor Individu: Kelelahan (*burnout*), kurangnya pengetahuan terbaru, atau masalah kesehatan mental.
 - b. Faktor Sistem: Kurangnya jumlah staf (*understaffed*), peralatan medis yang tidak terkalibrasi, atau SOP yang ambigu.
 - c. Faktor Komunikasi: Kesalahan dalam serah terima pasien (*handover*) atau instruksi verbal yang tidak jelas.
4. Doktrin Hukum: Pertanggungjawaban Kelalaian
- Dalam menilai sebuah kelalaian di pengadilan, dua doktrin ini menjadi rujukan utama:
- a. Res Ipsa Loquitur (Fakta yang Berbicara Sendiri)
Doktrin ini digunakan jika bukti kelalaian sangat nyata sehingga tidak memerlukan saksi ahli untuk membuktikannya. *Kutipan*: "Jika kain kasa tertinggal di perut pasien pasca-operasi, maka perawat/tim bedah dianggap lalai karena instrumen tersebut berada dalam kendali mereka" (Guwandi, 2007).
 - b. Respondent Superior (Tanggung Jawab Atasan)
Berdasarkan doktrin ini, institusi (Rumah Sakit) bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan perawat selama mereka bekerja dalam lingkup tugasnya (Soekanto, 2014).
5. Sanksi Hukum, Etik, Dan Disiplin
- Sesuai dengan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, perawat yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi berlapis:
- a. Sanksi Etik: Teguran hingga pencabutan hak anggota oleh PPNI/Komite Etik.
 - b. Sanksi Perdata: Kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian fisik/materiil yang diderita pasien.
 - c. Sanksi Disiplin (MDTK): Pembekuan atau pencabutan STR/SIP untuk jangka waktu tertentu.
 - d. Sanksi Pidana: Jika kealpaan menyebabkan cacat berat atau kematian (Pasal 359 & 360 KUHP).

6. Upaya Mitigasi Dan Pencegahan (Risk Management)

Untuk meminimalisir risiko, perawat harus menerapkan strategi berikut (Kozier et al., 2018):

- a. Informed Consent sebagai Perisai (Shield): Menjelaskan risiko secara detail sebelum tindakan dilakukan. Jika risiko yang telah dijelaskan benar-benar terjadi, perawat terlindungi secara hukum karena pasien telah menerima risiko tersebut secara sadar.
- b. Prosedur Root Cause Analysis (RCA): Jika terjadi insiden, perawat tidak boleh menutupi kesalahan. Gunakan langkah RCA:
 - 1) Identifikasi kejadian.
 - 2) Analisis penyebab (metode "5 Whys").
 - 3) Rancang perbaikan sistem agar tidak terulang (Pencegahan Sistemik).
- c. Dokumentasi Legal: Mencatat setiap tindakan secara objektif, tepat waktu, dan lengkap. Dalam hukum, *"Apa yang tidak dicatat dianggap tidak dilakukan"*.

Studi Kasus Nasional (Bahan Diskusi)

Kasus: Tertukarnya Bayi di Rumah Sakit (Bogor, 2023) Kasus ini viral karena kelalaian perawat dalam memasang label identitas bayi. Akibatnya, dua keluarga merawat anak yang salah selama setahun.

- a. **Analisis Doktrin:** Kasus ini dapat menggunakan doktrin *Res Ipsa Loquitur* karena kesalahan identitas tidak mungkin terjadi tanpa kelalaian prosedur.
- b. **Sanksi:** Perawat dikenakan sanksi disiplin berat dan RS bertanggung jawab secara perdata (Respondent Superior).

D. DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

1. Pengertian Disiplin Profesi

Disiplin profesi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik profesi. Berbeda dengan etik yang bersumber pada moral, disiplin profesi bersumber pada Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SOP).

Menurut UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, setiap tenaga kesehatan wajib menjaga disiplin profesi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pelanggaran disiplin profesi adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan yang dapat bersifat teknis medis atau administratif profesi.

2. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Salah satu perubahan besar dalam regulasi terbaru adalah pembentukan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). MDTK adalah lembaga yang berwenang menegakkan disiplin profesi tenaga kesehatan.

- a. Kedudukan: MDTK merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).
- b. Fungsi: Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan (termasuk perawat).

3. Kriteria Pelanggaran Disiplin

Seorang perawat dapat dinyatakan melanggar disiplin profesi jika (Nasrullah, 2019; UU No. 17/2023):

- a. Melakukan praktik dengan tidak kompeten.
- b. Tugas dikerjakan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, atau SOP.
- c. Membiarkan pasien dalam keadaan bahaya padahal ia mampu menolong.
- d. Menjalankan praktik dalam kondisi kesehatan fisik atau mental yang terganggu (misal: di bawah pengaruh obat/alkohol).
- e. Penyalahgunaan kewenangan atau melakukan tindakan di luar kompetensi tanpa mandat/delegasi yang sah.

4. Sanksi Disiplin Profesi

Sanksi disiplin bertujuan untuk membina tenaga kesehatan agar kembali ke koridor praktik yang benar, bukan semata-mata untuk menghukum. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MDTK meliputi:

- a. Peringatan Tertulis: Teguran resmi untuk pelanggaran ringan.
- b. Kewajiban Mengikuti Pendidikan/Pelatihan: Dilakukan di institusi pendidikan kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk (remedial pendidikan).
- c. Non-aktif STR/SIP: Penonaktifan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik untuk jangka waktu tertentu.
- d. Pencabutan STR/SIP: Sanksi terberat berupa pencabutan izin praktik secara permanen atau dalam jangka waktu lama untuk pelanggaran disiplin berat.

5. Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin (Mitigasi)

Untuk menghindari sanksi disiplin, perawat harus menerapkan langkah-langkah berikut:

- a. Compliance (Kepatuhan): Selalu memperbarui pengetahuan tentang SOP terbaru di unit kerja. Jangan melakukan tindakan hanya berdasarkan "kebiasaan" jika tidak ada dasar proseduralnya.

- b. Self-Awareness: Memahami batasan diri. Jika merasa tidak kompeten atau belum pernah mendapat pelatihan untuk alat/tindakan tertentu, wajib melapor kepada atasan untuk supervisi.
- c. Laporan Insiden (RCA): Menggunakan sistem pelaporan insiden secara jujur untuk memperbaiki sistem di rumah sakit, sehingga kesalahan teknis tidak berubah menjadi pelanggaran disiplin berulang.
- d. Credentialing: Memastikan seluruh dokumen legal (STR dan SIP) selalu dalam masa aktif. Praktik tanpa izin yang aktif adalah pelanggaran disiplin dan hukum yang berat.

E. STRATEGI PENCEGAHAN MALPRAKTIK DAN KELALAIAN

Untuk meminimalisir risiko hukum, perawat harus menerapkan langkah-langkah preventif berikut:

1. Kepatuhan pada SOP: Selalu bekerja berdasarkan standar prosedur operasional yang terbaru.
2. Dokumentasi yang Akurat: "Apa yang tidak dicatat berarti tidak dilakukan." Dokumentasi adalah bukti legal terkuat perawat di pengadilan.
3. Komunikasi Terapeutik: Membangun hubungan baik dengan pasien dan keluarga untuk mencegah kesalahpahaman.
4. Pendidikan Berkelanjutan: Terus memperbarui ilmu pengetahuan agar tetap kompeten (*Knowledge as a shield*).

F. RINGKASAN

1. Hakikat Malpraktik Keperawatan Malpraktik adalah kegagalan profesional dalam memenuhi standar asuhan yang berlaku, baik karena ketidakmampuan (*unskillfulness*), tindakan disengaja, maupun kelalaian. Malpraktik terbagi menjadi tiga ranah hukum:
 - a. Etik: Pelanggaran kode etik profesi (Sanksi: Organisasi Profesi/MKEK).
 - b. Perdata: Kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil/fisik (Sanksi: Ganti rugi/Restitusi).
 - c. Pidana: Pelanggaran hukum negara/kecerobohan berat yang menyebabkan cacat atau kematian (Sanksi: Penjara/Denda).
2. Kelalaian (Negligence) dan Unsur 4D Kelalaian adalah bentuk malpraktik yang tidak disengaja. Seorang perawat hanya dapat dinyatakan lalai secara hukum jika memenuhi empat unsur kumulatif (4D):
 - a. Duty: Adanya kewajiban profesional terhadap pasien.
 - b. Dereliction of Duty: Pelanggaran atau kegagalan bekerja sesuai SOP.

- c. Direct Cause: Pelanggaran tersebut merupakan penyebab langsung cedera.
 - d. Damage: Adanya kerugian nyata (fisik atau materiil) pada pasien.
3. Doktrin Hukum dalam Praktik Keperawatan
- a. *Res Ipsa Loquitur*: Fakta yang berbicara sendiri (kelalaian yang sangat nyata, misal: alat bedah tertinggal).
 - b. *Respondent Superior*: Atasan atau rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan bawahan selama dalam lingkup tugas.
4. Disiplin Profesi dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Disiplin profesi adalah ketaatan pada aturan penerapan keilmuan. Penegakan disiplin kini berada di bawah Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang merupakan bagian dari KTKI. Sanksi disiplin bersifat membina, mulai dari peringatan, kewajiban pendidikan ulang, hingga pencabutan STR/SIP.
5. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Pencegahan malpraktik dilakukan melalui sistem manajemen risiko:
- a. *Informed Consent*: Sebagai "perisai hukum" yang memastikan pasien memahami dan menerima risiko tindakan secara sadar.
 - b. *Root Cause Analysis (RCA)*: Prosedur evaluasi insiden dengan metode "5 Whys" untuk menemukan akar masalah sistemik agar kesalahan tidak terulang.
 - c. Dokumentasi Legal: Bukti terkuat di pengadilan (Not documented = Not done).
 - d. Komunikasi Efektif: Menggunakan teknik SBAR untuk mencegah kesalahan informasi

AKTIVITAS BELAJAR TERSTRUKTUR

Aktivitas 1: Analisis Kasus Malpraktik

Skenario: Seorang perawat senior di ruang bedah membiarkan mahasiswa praktik melakukan pemasangan kateter tanpa supervisi. Terjadi perlukaan pada saluran kemih pasien (trauma uretra) karena mahasiswa tersebut memaksa memasukkan kateter yang tidak sesuai ukuran.

Pertanyaan untuk Mahasiswa (Tugas 12 Halaman):

1. Gunakan analisis **4D** untuk menentukan apakah ini kelalaian perawat senior atau mahasiswa?
2. Identifikasi jenis pelanggaran (Etik/Perdata/Pidana) yang mungkin timbul.
3. Rancanglah 3 langkah **mitigasi** agar kejadian serupa tidak terulang di unit tersebut.

Rubrik Penilaian (Format OBE)

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Analisis 4D	Mampu membedakan Duty, Dereliction, Cause, Damage dengan sangat akurat.	Mampu menjelaskan 4D namun kurang tajam di bagian "Direct Cause".	Hanya menjelaskan 2-3 unsur.	Tidak memahami konsep 4D.
Mitigasi Masalah	Memberikan solusi sistemik (SOP, Edukasi, Dokumentasi).	Memberikan solusi praktis namun tidak sistemik.	Solusi bersifat umum/normatif saja.	Tidak memberikan solusi.

Aktivitas 2: Analisis Insiden Mini (Mini-RCA) & Presentasi

Judul Tugas: Analisis Akar Masalah pada Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). **Metode:** *Case-Based Learning & Small Group Discussion*.

Skenario Kasus untuk Mahasiswa

Kasus: "Salah Identitas di Ruang Perawatan"

Di sebuah bangsal perawatan dewasa yang sangat sibuk (rasio perawat dan pasien 1:15), Perawat B membawa obat injeksi antibiotik untuk Pasien Tn. X di Kamar 302. Karena terburu-buru dan terdistraksi oleh keluhan pasien lain di lorong, Perawat B langsung masuk ke Kamar 302 dan menyuntikkan obat tersebut ke pasien di bed sebelah Tn. X, yaitu Tn. Y, tanpa mengecek gelang identitas atau menanyakan nama.

Beruntung, Tn. Y tidak memiliki riwayat alergi antibiotik tersebut. Namun, 15 menit kemudian Tn. Y mengeluh pusing dan mual. Setelah dicek, ternyata Tn. Y seharusnya tidak mendapatkan obat tersebut. Insiden ini dikategorikan sebagai Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) ringan.

Struktur Laporan & Presentasi (Instruksi Mahasiswa)

Mahasiswa diminta menyusun laporan singkat dan materi presentasi (3-5 slide) yang mencakup:

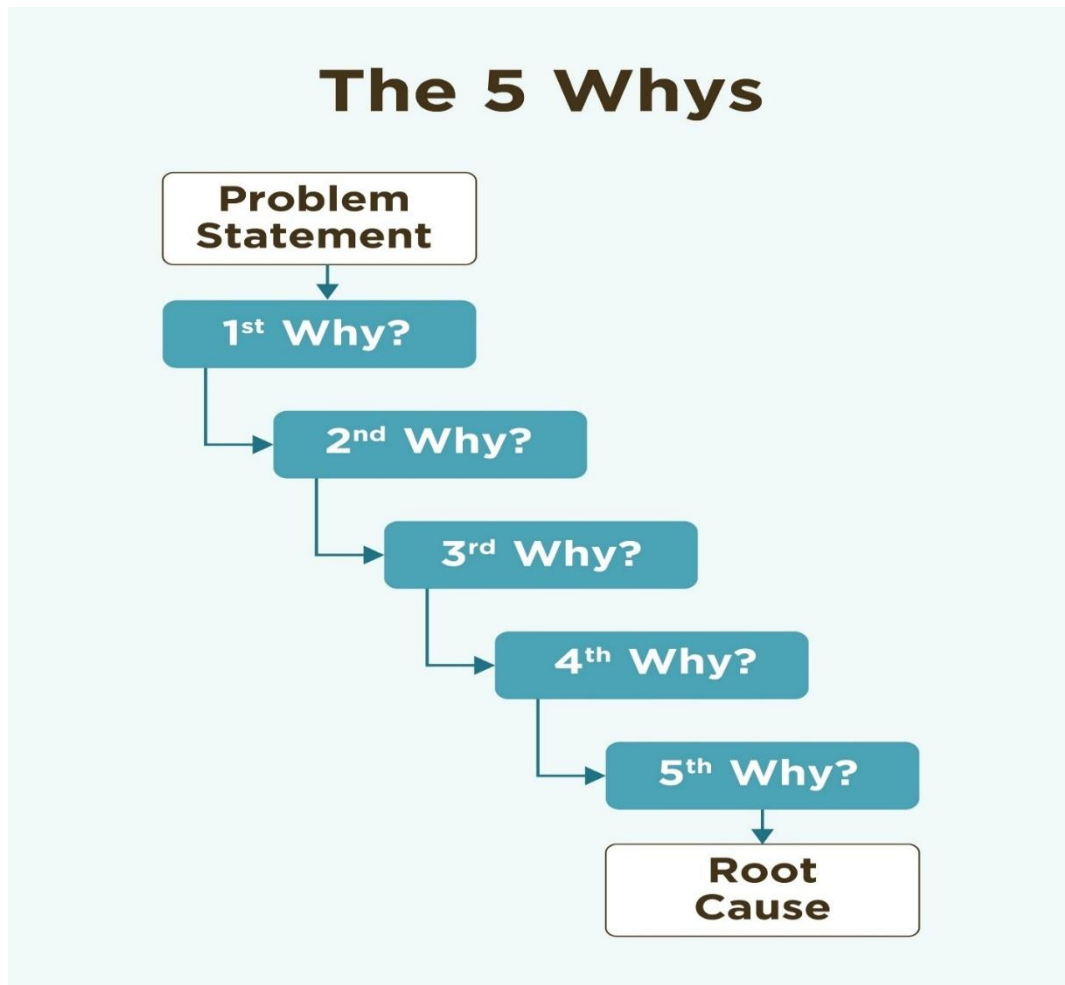
1. Klasifikasi Risiko: Tentukan jenis insiden (KNC/KTD/Sentinel) dan dampak risikonya.
2. Analisis Akar Masalah (Metode *5 Whys*): Cari penyebab terdalam (apakah faktor individu, kelelahan, atau kegagalan sistem/SOP).
3. Rencana Pencegahan (Mitigasi): Susun langkah konkret agar tidak terulang.
4. Indikator Audit: Buat parameter terukur untuk memantau keberhasilan pencegahan tersebut di masa depan.

Rubrik Penilaian CPMK-6

Indikator Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Ketepatan Klasifikasi Risiko	Salah menentukan jenis insiden; prioritas mitigasi keliru atau tidak ada.	Klasifikasi insiden cukup tepat; namun prioritas mitigasi kurang jelas/logis.	Klasifikasi insiden tepat; prioritas mitigasi jelas berdasarkan dampak.	Klasifikasi sangat tepat; prioritas tajam berbasis matriks dampak-probabilitas.
Kualitas Rencana Pencegahan (RCA)	Rencana pencegahan bersifat umum (normatif) dan tidak menyentuh akar masalah.	Rencana pencegahan ada, namun hubungan dengan hasil RCA kurang kuat.	Rencana pencegahan spesifik dan menjawab akar masalah yang ditemukan.	Rencana sangat spesifik; berbasis RCA yang mendalam & mencakup perubahan sistem.
Keterukuran Indikator Audit	Indikator tidak ada atau tidak dapat diukur (<i>unmeasurable</i>).	Indikator ada tetapi bersifat subjektif dan sulit dipantau.	Indikator spesifik, terukur (misal: %)	Indikator komprehensif (ada baseline, target, dan cara ukur yang jelas).

Indikator Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			kepatuhan), dan relevan.	

Jawaban latihan



Struktur laporan:

1. Klasifikasi: KTD Ringan (Pasien mendapatkan obat yang salah namun tidak terjadi cedera permanen).
2. Analisis 5 Whys: * Mengapa salah suntik? Karena tidak cek gelang.
 - a. Mengapa tidak cek gelang? Karena terburu-buru dan terdistraksi.
 - b. Mengapa terburu-buru? Karena beban kerja tinggi (1:15).
 - c. Mengapa beban kerja tinggi? Karena tidak ada regulasi *staffing* yang ketat di unit tersebut (Akar Masalah Sistem).

3. Mitigasi: Penerapan *Barcode Scanning* untuk identitas pasien dan re-edukasi prinsip 7 Benar pemberian obat.
4. Indikator Audit: "100% perawat melakukan verifikasi identitas menggunakan minimal 2 identitas sebelum pemberian obat, diaudit setiap bulan melalui observasi langsung."

Referensi

- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. J., Frandsen, G., Buck, M., Ferguson, L., Yiu, L., & Stamler, L. L. (2018). Fundamentals of Canadian Nursing. In *The Fundamentals of Canadian Nursing: Concepts, process, and practice*. United States of America: Pearson Canada Inc. All rights reserved.
- Guwandi, J. (2007). *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: FKUI
- omite Keperawatan. (2017). *Buku Standar Kode Etik Keperawatan Tahun 2017-2020*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat RS Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.
- Komite Keperawatan RSUD dr. Sayidiman Magetan. (2023). *Sub Komite Etik dan Disiplin*. diakses dari <https://sites.google.com/view/komkeprsd/sub-etik-disiplin>.
- Mendri, N. K., & Prayogi, A. S. (2017). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Baru Press.
- Nasrullah, D. (2019). *Etika Keperawatan*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- PPNI. (2017). *Kode Etik Perawat Indonesia*. Jakarta: DPP PPNI
- Riskika, S., Harun, B., et al. (2022). *Nursing Ethics*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Kedudukan Otopsi Klinis dalam Hukum Medik*. Jakarta: UI Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

BAB 4

ISU ETIK KLINIS: DNR/DNI, AKHIR HAYAT, DAN PERAWATAN PALIATIF (PENGANTAR)

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Isu Etik Klinis: DNR/DNI, Akhir Hayat, dan Perawatan Paliatif (Pengantar)	4.1 Mengidentifikasi isu etik utama pada keputusan akhir hayat dan preferensi perawatan.	4.2 Menyusun keputusan yang selaras dengan nilai pasien/keluarga, keselamatan, dan komunikasi tim secara terstruktur.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario
CPMK-7	Proyek studi kasus + etik penelitian (review protokol)	Skor kualitas rekomendasi kasus (argumentasi, opsi, tindak lanjut) dan kepatuhan komponen perlindungan subjek (rubrik).	15	Laporan proyek; lembar review etik

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. Teori Dasar

Isu etik dalam keperawatan kritis dan paliatif bukan sekadar perdebatan teori, melainkan realitas klinis yang melibatkan keputusan hidup dan mati yang kompleks. Perawat memiliki peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim medis, terutama saat pasien berada dalam kondisi terminal atau kehilangan kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri.

B. Dinamika Keputusan DNR dan DNI

Keputusan untuk tidak melakukan tindakan agresif sering kali menjadi titik paling emosional dalam perawatan pasien.

1. DNR (Do Not Resuscitate): Sebuah instruksi medis yang spesifik agar tim penolong tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) jika pasien mengalami henti napas atau henti jantung. Penting untuk ditekankan bahwa DNR bukan berarti penghentian seluruh perawatan; pasien tetap mendapatkan asuhan keperawatan dan medis lainnya untuk kenyamanan dan manajemen gejala.
2. DNI (Do Not Intubate): Instruksi yang melarang pemasangan pipa endotrakeal (intubasi) dan penggunaan mesin ventilator, meskipun pasien mengalami gagal napas. Keputusan ini sering diambil oleh pasien dengan penyakit paru kronis stadium akhir atau kondisi terminal lainnya yang ingin menghindari ketergantungan pada alat bantu napas.

Penentuan status ini sangat penting karena akan menjadi panduan bagi perawat dalam menentukan tindakan segera saat kondisi klinis memburuk.

C. Filosofi Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga melalui pencegahan dan peniadaan penderitaan.

Prinsip Utama: Paliatif tidak bertujuan mempercepat atau menunda kematian, tetapi menganggap kematian sebagai proses yang normal dan berusaha agar pasien dapat menjalaninya dengan martabat.

Fokus asuhan meliputi:

1. Manajemen Gejala: Pengendalian nyeri, sesak napas, mual, dan keluhan fisik lainnya secara agresif.
2. Dukungan Psikososial: Membantu pasien dan keluarga menghadapi kecemasan dan duka.
3. Pendekatan Holistik: Mengintegrasikan aspek spiritual dan nilai-nilai budaya dalam asuhan keperawatan.

D. Empat Pilar Prinsip Etik Bioetika

Dalam menghadapi dilema akhir hayat, perawat harus menggunakan kerangka kerja etik untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor profesional dan moral.

Prinsip Etik	Penjelasan dalam Konteks Akhir Hayat
Autonomy (Otonomi)	Menghormati hak pasien untuk menentukan pilihannya sendiri, termasuk hak menolak pengobatan melalui Advanced Directives atau wasiat medis.
Beneficence (Berbuat Baik)	Kewajiban perawat untuk memberikan tindakan yang memberikan manfaat maksimal bagi pasien, seperti memastikan manajemen nyeri yang adekuat.
Non-maleficence (Tidak Merugikan)	Kewajiban untuk tidak menambah penderitaan pasien. Misalnya, tidak memaksakan tindakan invasif yang hanya memperpanjang proses sakaratul maut tanpa memberikan kesembuhan.
Justice (Keadilan)	Memastikan setiap pasien mendapatkan akses yang sama terhadap perawatan paliatif dan sumber daya kesehatan tanpa diskriminasi, terlepas dari status DNR-nya.

E. Peran Strategis Perawat sebagai Advokat

Perawat wajib melakukan pengkajian dini terhadap nilai-nilai dan preferensi pasien sebelum krisis terjadi. Edukasi kepada keluarga menjadi kunci utama agar mereka memahami konsekuensi dari setiap pilihan medis yang diambil. Jika ditemukan adanya ketidaksepakatan yang tajam atau tanda bahaya dalam pengambilan keputusan, perawat harus segera melakukan eskalasi kepada komite etik rumah sakit atau preceptor. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten merupakan bukti bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dikuasai secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa profesional yang berpusat pada keselamatan dan martabat pasien.

Aktivitas 1 — Knows How

Metode: Mini-case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dilema etik kompleks, memposisikan diri sebagai advokat pasien, dan merancang strategi komunikasi dalam menghadapi konflik keputusan akhir hayat.

Skenario Klinis

Seorang kakek berusia 78 tahun dengan diagnosis Kanker Paru Stadium IV dirawat di unit perawatan intensif karena mengalami sesak napas berat (dyspnea). Meskipun kondisi fisiknya lemah, pasien berada dalam kondisi sadar penuh dan kompeten secara mental.

Dalam diskusi pribadi dengan perawat, pasien menyatakan dengan tegas: "Saya sudah lelah dan siap pergi dengan tenang. Tolong, jangan pasang alat bantu napas atau memompa dada saya jika jantung saya berhenti." Namun, saat kondisi pasien mulai menurun (desaturasi), anak sulungnya mendatangi nurse station dan bersikeras dengan nada tinggi: "Lakukan segala tindakan yang ada! Lakukan RJP dan pasang intubasi jika perlu. Saya tidak mau kehilangan ayah saya sekarang!"

Pertanyaan Diskusi

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil (4-5 orang) untuk membedah kasus di atas dengan menjawab poin-poin berikut:

1. Identifikasi Dilema Etik: Autonomy vs. Beneficence
 - a. Analisis Prinsip Otonomi: Jelaskan mengapa keinginan pasien yang kompeten harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan medis.
 - b. Analisis Pandangan Keluarga: Identifikasi mengapa anak sulung merasa tindakan agresif (RJP/Intubasi) adalah bentuk beneficence (berbuat baik), dan bagaimana hal ini berisiko menjadi maleficence (merugikan) bagi pasien terminal.
 - c. Dilema: Bagaimana perawat menyeimbangkan penghormatan terhadap hak pasien dengan kewajiban menjaga hubungan baik dengan keluarga yang sedang berduka/stres?.
2. Peran Perawat sebagai Advokat Pasien
 - a. Tentukan langkah konkret perawat untuk memastikan bahwa keinginan asli pasien tetap terlindungi meskipun ada tekanan dari pihak keluarga.
 - b. Bagaimana cara perawat mendokumentasikan pernyataan pasien secara legal agar dapat menjadi landasan bagi tim medis dalam bertindak?
3. Strategi Komunikasi Terapeutik dan Mediasi
 - a. Susunlah tahapan komunikasi menggunakan pendekatan Family Meeting untuk menengahi perbedaan pendapat ini.

- b. Tuliskan contoh kalimat empati yang dapat digunakan perawat untuk memvalidasi ketakutan anak pasien tanpa menjanjikan tindakan medis yang bertentangan dengan wasiat ayahnya.
 - c. Jelaskan peran "mendengarkan aktif" dalam mengeksplorasi alasan di balik paksaan anggota keluarga tersebut.
4. Analisis Konsekuensi Hukum dan Etik Profesional
- a. Apa konsekuensi hukum (malpraktik/pelanggaran hak asasi) jika tim medis mengabaikan penolakan tindakan (Informed Refusal) dari pasien yang kompeten dan tetap melakukan intubasi?
 - b. Diskusikan dampak psikologis bagi pasien (trauma/penderitaan yang tidak perlu) dan dampak moral bagi perawat jika instruksi DNR/DNI yang diinginkan pasien tidak dipatuhi.

Instruksi Presentasi

Setiap kelompok diminta untuk:

1. Menunjuk satu juru bicara untuk memaparkan hasil analisis.
2. Melakukan role-play singkat (3 menit) mengenai cara perawat berbicara kepada anak sulung tersebut di depan kelas.
3. Menyerahkan ringkasan hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis kepada dosen pengampu.

Catatan untuk Mahasiswa:

Ingatlah bahwa dalam keperawatan paliatif, keberhasilan kita tidak diukur dari seberapa lama kita mempertahankan detak jantung pasien, tetapi dari seberapa baik kita menjaga martabat dan ketenangan mereka di akhir hayat.

Aktivitas 2 — Shows How: Simulasi Skill Lab

Fokus: Teknik Menyampaikan Berita Buruk dan Diskusi Advanced Care Planning (ACP)

Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mendemonstrasikan kemampuan komunikasi pada situasi kritis.

Skenario Simulasi:

Seorang anggota keluarga (diperankan oleh Standardized Patient) sedang menunggu di luar ICU. Pasien (ayahnya) mengalami gagal napas akibat PPOK stadium akhir dan kanker paru. Dokter telah menyatakan prognosinya sangat buruk (poor prognosis). Tugas mahasiswa adalah menyampaikan kondisi terkini dan memulai diskusi mengenai pembatasan tindakan (DNR/DNI).

Kriteria Penilaian (Critical Items - WAJIB LULUS):

1. Privasi: Membawa keluarga ke ruangan khusus (bukan di selasar umum).
2. Empati: Menggunakan sentuhan terapeutik (jika budaya memungkinkan) dan memberikan jeda waktu bagi keluarga untuk menangis atau bereaksi.
3. Objektivitas: Menjelaskan bahwa DNR bukan berarti menelantarkan pasien, melainkan fokus pada kenyamanan (comfort care).
4. Eskalasi: Mengenali tanda konflik (misal: keluarga marah besar atau menyalahkan tim medis) dan menyatakan perlunya keterlibatan Komite Etik.

Template Soal OSCE Keperawatan

Judul Station : Komunikasi Edukatif Mengenai Perawatan Akhir Hayat dan DNR

Waktu : 13 Menit

No	Komponen	Deskripsi Detail
1	Tujuan	Mahasiswa mampu melakukan negosiasi etik dan edukasi paliatif secara empati.
2	Skenario	Pasien (Ny. A, 65 th) dengan Gagal Ginjal Terminal dan Penurunan Kesadaran (GCS 7). Keluarga (Anaknya) tampak cemas dan bertanya "Kenapa tidak dipasang mesin napas saja agar Ibu bangun?"
3	Tugas	1. Kaji pemahaman keluarga tentang penyakit pasien. 2. Jelaskan konsep perawatan paliatif (kualitas hidup vs kuantitas hidup). 3. Diskusikan status DNR dengan bahasa yang tidak menghakimi.
4	Instruksi Penguji	Skor 3: Komunikasi lancar, menggunakan teknik SPIKES, menunjukkan empati tinggi. Skor 2: Penjelasan medis benar namun kurang menunjukkan empati. Skor 1: Menggunakan jargon medis yang membingungkan keluarga. Skor 0: Memaksa keluarga menandatangani form DNR tanpa penjelasan.

SOP Komunikasi Diskusi Akhir Hayat (DNR/DNI)

1. Tahap Pra-interaksi

Tinjau rekam medis: Pastikan diagnosis medis sudah tegak dan prognosis telah didiskusikan oleh tim dokter.

Evaluasi kapasitas mental pasien: Jika pasien tidak kompeten, identifikasi siapa pembuat keputusan pengganti (Surrogate Decision Maker).

2. Tahap Orientasi

Salam terapeutik dan perkenalan diri.

Validasi perasaan keluarga: "Bagaimana perasaan Bapak/Ibu melihat kondisi Ayah hari ini?"

Sampaikan tujuan pertemuan: Membahas rencana perawatan ke depan agar sesuai dengan keinginan pasien.

3. Tahap Kerja (Menggunakan Protokol SPIKES)

- S (Setting): Atur tempat duduk yang nyaman dan matikan distraksi (HP/TV).
- P (Perception): Tanya apa yang mereka tahu: "Sejauh ini, apa yang dokter sampaikan tentang kondisi Ayah?"
- I (Invitation): Minta izin: "Bolehkah saya menyampaikan informasi mengenai rencana tindakan jika terjadi kondisi kritis?"
- K (Knowledge): Sampaikan informasi dalam potongan kecil: "Kondisi paru Ayah sudah sangat lemah, penggunaan mesin napas mungkin tidak akan memperbaiki penyakit dasarnya, justru bisa menambah nyeri."
- E (Empathy): Respon emosi keluarga: "Saya mengerti ini sangat berat bagi Bapak/Ibu."
- S (Strategy & Summary): Jelaskan DNR: "DNR artinya jika jantung berhenti, kita tidak akan memompa dadanya, tapi kita tetap berikan obat nyeri dan perawatan terbaik agar beliau tidak sesak."

4. Tahap Terminasi

Evaluasi pemahaman keluarga.

Tawarkan dukungan spiritual/kerohanian.

Kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya.

5. Dokumentasi

Catat siapa saja yang hadir dalam diskusi.

Dokumentasikan keputusan akhir (DNR/Full Code) di lembar instruksi medis yang legal.

Penerapan DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Metode : Observasi Langsung di Ruang Rawat.

Fokus Observasi:

- Aspek Psikomotor: Mahasiswa melakukan perawatan mulut (mouth care) atau memposisikan pasien terminal dengan sangat lembut.
- Aspek Afektif: Ketenangan mahasiswa saat menghadapi pasien yang sedang dalam fase active dying (napas tidak teratur/ngorok).
- Komunikasi: Cara mahasiswa menjelaskan pada keluarga tentang perubahan fisik yang terjadi menjelang kematian tanpa menimbulkan kepanikan.

Portofolio & Refleksi

Refleksi Patient Safety:

Mahasiswa wajib menuliskan dalam logbook: "Mengapa kesalahan identifikasi status DNR dapat dianggap sebagai 'Near Miss' atau 'KTD' dalam keselamatan pasien?" (Analisis tentang risiko tindakan invasif yang tidak diinginkan/medikalisasi kematian).

Case Report:

Mahasiswa memaparkan satu kasus dilema etik: Misalnya, pasien ingin DNR tetapi anak-anaknya berbeda pendapat (ada yang setuju, ada yang tidak). Mahasiswa mendeskripsikan perannya dalam proses mediasi tersebut.

Ringkasan Bab

"Caring When You Cannot Cure"

Bab ini menekankan bahwa saat kesembuhan (cure) tidak lagi memungkinkan, peran perawat bergeser sepenuhnya pada asuhan (care). Inti dari isu etik DNR/DNI bukanlah tentang "menyerah", melainkan tentang memberikan penghormatan terakhir bagi martabat manusia dengan membiarkan proses alamiah terjadi tanpa penderitaan yang sia-sia akibat intervensi medis yang agresif.

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis/Etik	Tindakan Eskalasi
Keluarga meminta menyembunyikan diagnosis dari pasien (Collusion)	Pelanggaran hak Autonomy pasien.	Edukasi keluarga tentang hak pasien, libatkan tim paliatif untuk mediasi.
Konflik antar saudara kandung terkait harta/warisan saat pasien kritis	Keputusan medis terdistorsi kepentingan pribadi keluarga.	Lapor Kepala Ruang & minta pertemuan formal dengan Komite Etik/Legal RS.
Adanya permintaan Eutanasia (mempercepat kematian)	Bertentangan dengan hukum di Indonesia & kode etik keperawatan.	Jelaskan batasan legal, alihkan fokus ke manajemen nyeri yang adekuat.

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Berilah tanda (v) pada kemampuan yang telah Anda kuasai:

- [] Saya mampu membedakan DNR (henti jantung) dan DNI (henti napas) secara klinis.
- [] Saya mampu menggunakan protokol SPIKES dalam menyampaikan berita buruk.
- [] Saya memahami aspek legal formulir persetujuan/penolakan tindakan di Indonesia.
- [] Saya bisa melakukan perawatan kenyamanan (manajemen gejala) pada pasien akhir hayat.
- [] Saya tahu kapan harus menghubungi Komite Etik jika terjadi kebuntuan keputusan.

Saran Pengembangan: Materi ini dapat dilengkapi dengan QR Code yang terhubung ke video contoh simulasi komunikasi DNR yang benar dan yang salah agar mahasiswa memiliki gambaran visual.

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN 1

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Komunikasi Etik dan Edukasi Perawatan Akhir Hayat (DNR/DNI)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi terapeutik, edukasi prinsip paliatif, dan fasilitasi diskusi pengambilan keputusan etik (DNR/DNI) secara empati.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian (Nilai dan Harapan) 3. Implementasi (Teknik SPIKES) 4. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Psikososial 3. Legal Etis
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien (Ny. A, 65 tahun) dirawat dengan Gagal Ginjal Terminal dan kanker stadium lanjut dengan penurunan kesadaran (GCS 7). Kondisi fisik semakin menurun. Keluarga (anak pasien) tampak sangat cemas dan bersikeras agar ibunya "dipasang alat

		bantu apa pun agar tetap hidup." Dokter telah menjelaskan prognosis buruk kepada keluarga. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian nilai dan harapan keluarga terkait kondisi pasien saat ini. 2. Berikan edukasi mengenai tujuan perawatan paliatif (fokus kualitas hidup). 3. Fasilitasi diskusi mengenai status DNR/DNI menggunakan pendekatan empati.
8	Instruksi untuk penguji	TUGAS: (Sesuai tugas peserta) INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan pengkajian: Apakah peserta menanyakan apa yang dipahami keluarga tentang kondisi pasien dan apa harapan mereka 2. Menilai edukasi: Apakah peserta mampu menjelaskan bahwa perawatan paliatif fokus pada kenyamanan, bukan mengabaikan pasien. 3. Menilai teknik komunikasi (SPIKES): - Setting: Menjaga privasi/ketenangan. - Empathy: Menunjukkan respon empati saat keluarga menangis/cemas. - Knowledge: Menjelaskan DNR secara objektif (fokus pada kenyamanan, bukan menghentikan perawatan). 4. Menilai perilaku profesional: Memperkenalkan diri, menjaga martabat pasien, dan tidak memaksa keputusan. 5. Critical Items (Wajib Lulus): Menjaga privasi dan menunjukkan empati yang konsisten.
9	Instruksi untuk klien standar	IDENTITAS: Anak kandung pasien (L/P, usia bebas).PERAN: Tampak cemas, sesekali menyeka air mata.REAKSI: Awalnya bersikeras minta ventilator ("Dokter tolong lakukan apa saja!"). Jika peserta menjelaskan dengan kasar/jargon, KS tetap tidak terima. Jika peserta menunjukkan empati dan menjelaskan DNR dengan fokus kenyamanan, KS mulai mempertimbangkan dan terlihat lebih tenang. HARAPAN: Ingin ibunya tidak menderita, namun takut merasa "berdosa" jika tidak melakukan tindakan agresif.

10	Setting station	Ruang Diskusi Keluarga / Ruang Rawat: - Tempat tidur pasien dengan manekin. - Kursi untuk KS dan peserta (posisi sejajar). - Meja penguji (terpisah). - Fasilitas kebersihan tangan (Handrub).
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Kursi untuk peserta dan KS 2. manekin (sebagai pasien di tempat tidur) 3. lembar informasi/leaflet edukasi DNR/Paliatif 4. Lembar catatan medis singkat. 5. Contoh formulir DNR/DNI. 6. Tissue (untuk KS). 7. Handrub.
12	Referensi	1. Kode Etik Keperawatan Indonesia (PPNI). 2. Protokol SPIKES untuk penyampaian berita buruk. 3. UU Kesehatan terkait hak pasien dan perawatan paliatif.

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN 2

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Komunikasi Etik dan Edukasi Perawatan Paliatif (DNR/DNI)
3	Waktu	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi terapeutik terkait isu etik akhir hayat, memberikan edukasi mengenai konsep DNR/DNI, serta menunjukkan empati dan perilaku profesional pada keluarga pasien paliatif.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling; 2. Pengkajian (psikososial); 3. Perilaku profesional (Etik).
6	Kategori	Psikososial / Etik Legal
7	Instruksi Peserta	SKENARIO KLINIK:Seorang laki-laki (65 tahun) dengan Kanker Paru Stadium IV dirawat di ruang intermediate. Kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran (GCS 9) dan gagal napas. Dokter telah menjelaskan bahwa prognosis pasien sangat buruk (terminal). Istri

		pasien tampak menangis dan bingung saat ditanya mengenai tindakan resusitasi jika terjadi henti jantung. TUGAS: 1. Lakukan komunikasi terapeutik untuk menggali pemahaman keluarga mengenai kondisi pasien. 2. Berikan edukasi mengenai konsep Do Not Resuscitate (DNR) dan Do Not Intubate (DNI) secara tepat dan empiris. 3. Jelaskan prinsip perawatan paliatif (fokus pada kenyamanan) kepada istri pasien. 4. Tunjukkan perilaku profesional dan empati selama interaksi.
8	Instruksi Penguji	SKENARIO KLINIK: (Sama dengan di atas) INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam membuka komunikasi dengan empati (teknik breaking bad news dasar). 2. Menilai ketepatan penjelasan DNR (tidak melakukan RJP) dan DNI (tidak memasang alat bantu napas/ventilator). 3. Menilai kemampuan peserta menjelaskan bahwa DNR bukan berarti "menelantarkan", melainkan beralih ke fokus kenyamanan (paliatif). 4. Menilai cara peserta merespons tangisan/kesedihan istri pasien (validasi perasaan). 5. Monitor perilaku profesional (menjaga privasi dan ketenangan).
9	Instruksi Klien Standar (KS)	Identitas: Istri pasien (Ny. S, 60 tahun). Peran: Tampak sedih, mata sembab, memegang tisu. Sering bertanya "Apakah suami saya akan tersiksa jika dipasang alat?" atau "Apakah kalau saya tanda tangan DNR berarti saya menyerah?". Respons: Jika peserta menjelaskan dengan kasar/terlalu medis, KS harus tampak makin bingung. Jika peserta empati, KS mulai tenang dan mencoba memahami.
10	Setting Station	Ruang Keluarga / Samping tempat tidur pasien (Tenang).
11	Peralatan	Kursi untuk peserta dan KS, tisu, manekin (sebagai pasien di tempat tidur), lembar informasi/leaflet edukasi DNR/Paliatif.
12	Referensi	Kode Etik Keperawatan Indonesia, UU Kesehatan terkait Autonomi Pasien, Pedoman Perawatan Paliatif Kemenkes.

RUBRIK PENILAIAN OSCE

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Komunikasi & Edukasi Etik (DNR/DNI)	Tidak memberikan edukasi atau informasi salah (menyesatkan).	Menjelaskan DNR/DNI secara medis saja, tanpa memperhatikan kesiapan mental keluarga.	Menjelaskan DNR/DNI dengan cukup jelas, namun kurang menekankan pada aspek martabat pasien (dignity).	Menjelaskan konsep DNR/DNI secara tepat, jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menekankan pada penghormatan terhadap fase akhir hayat.
2. Perawatan Paliatif	Tidak menjelaskan konsep paliatif.	Hanya menyebutkan paliatif adalah "pasrah".	Menjelaskan paliatif sebagai fokus pada manajemen kualitas hidup, nyeri, namun belum menyentuh aspek psikospiritual.	Menjelaskan paliatif secara komprehensif: fokus pada kualitas hidup, manajemen nyeri/gejala, dan dukungan emosional keluarga.
3. Perilaku Profesional & Empati	Tidak menunjukkan empati, mengabaikan kesedihan keluarga.	Menunjukkan empati sekilas namun terkesan terburu-buru.	Menunjukkan empati dan komunikasi terapeutik yang cukup baik.	Menunjukkan sikap empati yang dalam, memberikan ruang bagi keluarga untuk berduka, menjaga privasi, dan bersikap tenang.

Saran Penggunaan:

Template ini difokuskan pada aspek komunikasi karena isu DNR dan Paliatif dalam keperawatan lebih ditekankan pada peran perawat sebagai advokat dan edukator etik, bukan sekadar tindakan teknis. Semoga membantu persiapan ujian Anda!

SOP DISKUSI AKHIR HAYAT (DNR/DNI)

No	Kegiatan/Tahapan
A	Tahap Orientasi
1	Menyampaikan salam, perkenalan diri, dan memastikan privasi (pintu ditutup).
2	Menanyakan kesiapan emosional keluarga untuk berdiskusi.
B	Tahap Kerja (Teknik SPIKES)
3	Perception: Menanyakan sejauh mana keluarga memahami kondisi pasien ("Apa yang Bapak pahami tentang penyakit Ibu saat ini?").
4	Invitation: Meminta izin untuk mendiskusikan rencana perawatan ke depan.
5	Knowledge: Menjelaskan kondisi terminal pasien dengan bahasa sederhana tanpa jargon medis.
6	Empathy: Memberikan respon saat keluarga emosional (memberi tissue/jeda waktu).
7	Strategy/DNR Discussion: Menjelaskan konsep DNR sebagai upaya memberikan kematian yang bermartabat dan fokus pada manajemen nyeri/nyaman.
8	Mengklarifikasi bahwa DNR bukan berarti "menelantarkan" atau "menghentikan semua asuhan".
C	Tahap Terminasi & Profesionalisme
9	Menyimpulkan hasil diskusi dan menawarkan dukungan kerohanian/spiritual.
10	Menunjukkan sikap tenang, tidak menghakimi, dan menghargai martabat pasien selama tindakan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERAWATAN PALIATIF DAN AKHIR HAYAT

1. Pengertian

Pendekatan asuhan keperawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan fisik, psikososial, dan spiritual.

2. Tujuan

- Mengurangi nyeri dan gejala fisik lainnya (sesak napas, mual, cemas).
- Memberikan dukungan psikososial dan spiritual bagi pasien dan keluarga.
- Menghargai otonomi pasien dalam pengambilan keputusan akhir hayat.

3. Persiapan Alat

Alat pelindung diri (Masker, Sarung tangan).

Instrumen pengkajian nyeri (VAS/NRS/CPOT).

- Alat perawatan kebersihan diri (perawatan mulut, lotion kulit).
- Lembar dokumentasi/Rekam medis.
- Media edukasi (Leaflet/Flipchart mengenai perawatan di rumah).

4. Prosedur Kerja

Tahap	Tindakan
Pra-Interaksi	1. Verifikasi program perawatan pasien (termasuk status DNR jika ada). 2. Siapkan mental dan empati perawat.
Orientasi	1. Berikan salam terapeutik dan identifikasi pasien. 2. Jelaskan tujuan pertemuan (fokus pada kenyamanan pasien). 3. Jaga privasi dan ciptakan lingkungan yang tenang.
Kerja (Fisik)	1. Manajemen Nyeri: Kaji skala nyeri secara komprehensif (PQRST). Berikan teknik non-farmakologis (distraksi, relaksasi, atau posisi nyaman). 2. Higiene: Lakukan perawatan mulut (<i>mouth care</i>) dan kulit untuk mencegah luka tekan. 3. Nutrisi/Hidrasi: Berikan makan/minum sesuai toleransi, jangan memaksa jika pasien menolak.
Kerja (Psikososial)	4. Komunikasi Terapeutik: Gunakan teknik mendengar aktif (<i>active listening</i>). Biarkan pasien/keluarga mengekspresikan ketakutan mereka. 5. Dukungan Spiritual: Fasilitasi kebutuhan ibadah sesuai keyakinan pasien.

Tahap	Tindakan
Terminasi	1. Evaluasi respon subjektif pasien (tingkat kenyamanan). 2. Sampaikan rencana tindak lanjut. 3. Akhiri dengan sikap yang hangat dan suportif.
Dokumentasi	Catat skala nyeri, respon keluarga, dan keputusan-keputusan penting yang diambil.

RUBRIK PENILAIAN PERAWATAN PALIATIF

Nama Mahasiswa:

Tanggal Ujian:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Skor (0-3)	Nilai (Bobot x Skor)
I	Aspek Kognitif & Persiapan			
1	Mampu menjelaskan tujuan perawatan paliatif dengan tepat.	10%		
2	Persiapan alat dan pengecekan status etik (DNR/DNI) pasien.	5%		
II	Aspek Psikomotor (Keterampilan)			
3	Ketepatan melakukan pengkajian nyeri dan gejala fisik lainnya.	15%		
4	Keterampilan memberikan perawatan kenyamanan (posisi/higiene).	15%		
5	Kemampuan memfasilitasi kebutuhan spiritual/psikososial.	15%		
III	Aspek Afektif (Sikap Profesional)			
6	Empati: Menunjukkan sikap tenang, lembut, dan menghargai martabat pasien.	20%		
7	Komunikasi: Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menghakimi.	10%		
IV	Dokumentasi & Evaluasi			
8	Mencatat respon pasien secara akurat dan rencana asuhan selanjutnya.	10%		
TOTAL		100%		

Keterangan Skor:

3 (Sangat Baik): Melakukan tindakan dengan sempurna, sistematis, dan menunjukkan empati yang sangat tinggi.

2 (Cukup): Melakukan tindakan dengan benar namun kurang sistematis atau komunikasi kurang maksimal.

1 (Kurang): Melakukan tindakan dengan banyak bimbingan atau mengabaikan aspek kenyamanan pasien.

0 (Gagal): Tidak melakukan tindakan sama sekali atau melakukan tindakan yang membahayakan/tidak etis.

Batas Kelulusan: minimal 75% dari total nilai.

Catatan Penguji:

.....
.....

Tanda Tangan Penguji:

(.....)

Referensi

- American Nurses Association. (2021). Nursing Care and Do-not-resuscitate (DNR) and Allow-a-natural-death (AND) Decisions. ANA Position Statement.
- Baile, W. F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E. A., & Kudelka, A. P. (2000). SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news: Application to the patient with cancer. *The Oncologist*, 5(4), 302–311. <https://doi.org/10.1634/theoncologist.5-4-302> (Referensi wajib untuk SOP komunikasi SPIKES).
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press. (Referensi utama untuk prinsip Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, dan Justice).
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2022). *Nursing Ethics: Across the Curriculum and Into Practice* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Chochinov, H. M. (2012). *Dignity Therapy: Final Words for Final Days*. Columbia University Press. (Sangat relevan untuk intervensi psikososial di akhir hayat).
- Ferrell, B. R., & Paice, J. A. (Eds.). (2019). *Oxford Textbook of Palliative Nursing* (5th ed.). Oxford University Press.
- International Council of Nurses. (2021). *The ICN Code of Ethics for Nurses*. ICN.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Matzo, M., & Sherman, D. W. (2018). *Palliative Care Nursing: Quality Care to the End of Life* (5th ed.). Springer Publishing Company.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Bakuan Upaya Reanimasi.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

BAB 5

ISU ETIK PADA POPULASI KHUSUS: ANAK, LANSIA, JIWA, DAN DISABILITAS.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Isu Etik pada Populasi Khusus: Anak, Lansia, Jiwa, dan Disabilitas	5.1 Menentukan penyesuaian pertimbangan kapasitas, persetujuan, dan perlindungan kelompok rentan.	5.2 Menetapkan strategi advokasi dan pencegahan diskriminasi dalam layanan pada populasi khusus.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-4

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario
CPMK-4	Tugas audit privasi & etika digital (worksheet)	Skor identifikasi titik risiko kebocoran data dan kelengkapan kontrol akses/mitigasi yang operasional.	10	Worksheet audit; rencana mitigasi

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. Pendahuluan

Isu etik dalam praktik keperawatan tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas relasi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan. Kompleksitas ini semakin meningkat pada populasi khusus karena adanya keterbatasan kapasitas, ketergantungan, serta potensi ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, etik bukan sekadar refleksi moral, tetapi menjadi bagian inheren dari praktik klinis sehari-hari.

Secara konseptual, etik klinis merupakan cabang bioetik yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam konteks pelayanan pasien. Etik klinis tidak hanya menjawab pertanyaan “apa yang benar”, tetapi juga “apa yang harus dilakukan dalam situasi nyata yang kompleks dan sering ambigu”. Dalam praktik, keputusan

klinis tidak hanya ditentukan oleh bukti ilmiah, tetapi juga nilai, preferensi pasien, norma sosial, dan kerangka hukum (Varkey, 2021).

Pendekatan bioetik modern banyak dipengaruhi oleh kerangka principlism yang diperkenalkan oleh Beauchamp dan Childress, yang mengemukakan empat prinsip utama: *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai teori moral yang komprehensif, melainkan sebagai panduan praktis untuk menganalisis masalah etik dalam berbagai konteks (Takala, 2001).

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam populasi khusus tidak selalu bersifat langsung. Dalam banyak situasi, terjadi ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip etik serta pendekatan analisis yang mampu menangkap kompleksitas situasi klinis.

B. Kerangka Analisis Etik dalam Populasi Khusus

1. Landasan Filosofis Etik Klinis

Etik klinis tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan prinsip moral dalam praktik kesehatan, tetapi merupakan hasil integrasi antara filsafat moral dan praktik klinis. Dalam perkembangannya, etik klinis justru muncul dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara teori moral dan realitas praktik klinis yang kompleks, ambigu, dan sarat konflik nilai. Pendekatan ini menuntut tenaga kesehatan tidak hanya memahami prinsip etik, tetapi juga memiliki kemampuan penalaran filosofis dalam menghadapi situasi klinis yang ambigu. Oleh karena itu, etik klinis pada dasarnya merupakan praktik filosofis yang hidup di dalam konteks klinis.

Dalam perspektif ini, tenaga kesehatan termasuk perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan medis, tetapi juga sebagai agen moral yang terlibat dalam proses refleksi, interpretasi, dan pengambilan keputusan etik. Dalam perspektif ini, praktik klinis ideal menuntut integrasi antara kemampuan teknis dan kemampuan filosofis, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan dapat dipertanggungjawabkan (Bertino, 2021).

Lebih lanjut, praktik etik klinis tidak berdiri di atas teori moral tunggal, tetapi berakar pada apa yang disebut sebagai *common morality*, yaitu seperangkat nilai moral yang secara implisit diakui dalam praktik pelayanan kesehatan. Nilai-nilai ini mencerminkan konsensus bahwa pasien harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, bukan sekadar objek intervensi medis. Dengan demikian,

prinsip-prinsip bioetik tidak muncul sebagai konstruk abstrak, tetapi sebagai refleksi dari praktik moral yang telah berkembang dalam sejarah pelayanan kesehatan (Bertino, 2021).

2. Prinsip Etik Dasar

Pendekatan principlism merupakan kerangka yang paling luas digunakan dalam bioetik klinis karena memberikan struktur analisis yang praktis tanpa mengikat pada satu teori moral tertentu. Empat prinsip utama dalam bioetik *autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice* merupakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan dalam analisis etik klinis. Namun, prinsip-prinsip ini tidak bersifat absolut, melainkan harus dipahami sebagai prinsip *prima facie* yang dapat saling berkonflik dalam praktik. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan interpretasi kontekstual dan penalaran moral yang mendalam (Takala, 2001).

Dalam perspektif ini, prinsip seperti *otonomy* dan *beneficence* tidak hanya dipahami sebagai konstruksi teoritis, tetapi sebagai refleksi dari praktik moral kolektif dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, penerapan prinsip etik dalam praktik klinis tidak dapat dilepaskan dari konteks profesional dan sosial tempat prinsip tersebut digunakan. Pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori etik dan praktik klinis sehari-hari, serta memperkuat legitimasi keputusan yang diambil dalam situasi dilema etik (Bertino, 2021).

a. *Autonomy* (Otonomi)

Prinsip otonomi merujuk pada hak individu untuk menentukan pilihan terkait dirinya sendiri berdasarkan nilai, keyakinan, dan preferensi yang dimilikinya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip ini menjadi dasar utama bagi konsep *informed consent*, yaitu persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan informasi yang memadai.

Namun, otonomi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai “kebebasan memilih”. Dalam literatur bioetik, otonomi mensyaratkan adanya kapasitas pengambilan keputusan (*decision-making capacity*), yang mencakup kemampuan memahami informasi, mengevaluasi konsekuensi, serta mengkomunikasikan pilihan secara konsisten (Vaughn, 2023). Tanpa kapasitas ini, keputusan yang diambil tidak dapat dianggap sebagai ekspresi otonomi yang valid. Selain kapasitas, otonomi juga menuntut adanya kebebasan dari paksaan (*voluntariness*). Dalam praktik, tekanan dari keluarga, tenaga kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi keputusan pasien, sehingga menunjukkan bahwa otonomi bersifat kontekstual, bukan semata-mata individual.

Dalam perspektif filosofis, otonomi berkaitan dengan konsep *personhood*, di mana individu dipandang sebagai agen moral yang memiliki tujuan dan makna hidup yang unik. Oleh karena itu, penghormatan terhadap otonomi tidak hanya berarti memberikan pilihan atau memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memastikan bahwa individu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk membuat keputusan secara bermakna, yang memerlukan kompetensi etik tenaga kesehatan (Bertino, 2021).

Pada praktik klinis, khususnya dalam pelaksanaan *informed consent* sebagai implementasi utama otonomi, sering kali belum berjalan optimal. Kegagalan dalam *informed consent* tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi kerap berkaitan dengan kurangnya kesadaran etik dan keterbatasan penalaran moral tenaga kesehatan. Dalam praktik keperawatan, prinsip otonomi juga melandasi kewajiban menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) dan kejujuran (*truth-telling*), karena keduanya berkaitan langsung dengan hak pasien untuk mengetahui serta mengontrol informasi tentang dirinya (Varkey, 2021).

Namun demikian, otonomi dalam praktik klinis selalu berada dalam konteks relasional. Keputusan pasien sering dipengaruhi oleh tenaga kesehatan, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan, sehingga otonomi dapat menjadi semu apabila pasien secara formal diberikan pilihan, tetapi secara substantif tidak memiliki kapasitas atau kebebasan untuk menentukan keputusan. Tantangan ini semakin nyata pada populasi dengan kapasitas terbatas, seperti anak, lansia dengan demensia, atau pasien dengan gangguan jiwa. Dalam kondisi tersebut, otonomi tidak dihilangkan, tetapi dimodifikasi melalui mekanisme seperti *surrogate decision-making* atau *supported decision-making*, guna tetap menghormati hak individu dalam batas kapasitas yang dimiliki.

b. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Prinsip *beneficence* menekankan kewajiban untuk memberikan manfaat terbaik bagi pasien, mengacu pada kewajiban tenaga kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Prinsip ini menjadi dasar dari tindakan terapeutik dan mencerminkan tanggung jawab profesional untuk meningkatkan kesejahteraan pasien.

Namun, konsep "kepentingan terbaik" tidak selalu bersifat objektif. Perspektif tenaga kesehatan dapat berbeda dengan nilai pasien, sehingga menimbulkan potensi konflik. Dalam kondisi ini, *beneficence* dapat berkembang menjadi *paternalism*, yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar kebaikan tetapi mengabaikan preferensi pasien (Vaughn, 2023).

Dalam beberapa situasi, *paternalism* dapat dibenarkan, terutama ketika pasien tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan. Namun, dalam konteks pasien yang kompeten, *paternalism* harus dibatasi karena dapat melanggar prinsip otonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara *beneficence* dan *autonomy* menjadi kunci dalam praktik etik klinis (Vaughn, 2023).

Dalam konteks ini, *beneficence* harus dipahami secara seimbang dengan prinsip otonomi, sehingga tindakan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat secara klinis, tetapi juga selaras dengan nilai pasien.

c. *Non-maleficence* (Tidak Membahayakan)

Prinsip *non-maleficence* menekankan kewajiban untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam praktik klinis, prinsip ini diwujudkan melalui evaluasi risiko dan manfaat dari setiap intervensi.

Penting untuk dipahami bahwa kerugian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mencakup aspek psikologis, sosial, dan moral. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan dampak luas dari tindakan yang dilakukan (Varkey, 2021).

Konflik antara *beneficence* dan *non-maleficence* sering muncul ketika suatu tindakan memiliki potensi manfaat sekaligus risiko. Dalam situasi ini, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan sebanding dengan risiko yang mungkin terjadi, yang didasarkan pada kondisi pasien dan konteks klinis.

d. *Justice* (Keadilan)

Prinsip keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya dan perlakuan yang adil dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks sistem kesehatan yang terbatas, prinsip ini menjadi semakin penting.

Keadilan tidak hanya berarti kesamaan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi individu. Oleh karena itu, pendekatan *equity* sering digunakan untuk memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan (Vaughn, 2023).

Dalam praktik keperawatan, prinsip keadilan menuntut perawat untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan, termasuk diskriminasi dan hambatan akses terhadap layanan kesehatan.

3. Pendekatan Analisis Etik Klinis

Prinsip etik memberikan dasar normatif, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang sistematis.

a. Four Box Method

Pendekatan *four box method* membagi analisis etik ke dalam empat domain: indikasi medis, preferensi pasien, kualitas hidup, dan faktor kontekstual. Indikasi medis mencakup diagnosis, prognosis, serta tujuan terapi, yang berkaitan dengan prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*. Preferensi pasien berfokus pada keinginan dan pilihan pasien, yang mencerminkan prinsip otonomi.

Kualitas hidup menilai dampak intervensi terhadap kehidupan pasien secara keseluruhan, termasuk aspek subjektif. Sementara itu, faktor kontekstual mencakup aspek sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi keputusan. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan mengorganisasi informasi secara sistematis dan mengidentifikasi konflik etik secara lebih jelas (Schildmann, Gordon, & Vollmann, 2010).

b. Model Pengambilan Keputusan Etik

Model pengambilan keputusan etik dalam keperawatan menekankan proses yang sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis prinsip, eksplorasi alternatif, hingga evaluasi keputusan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan etik bukan proses intuitif, melainkan memerlukan penalaran yang terstruktur dan reflektif. Integrasi antara teori dan praktik menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Yeo, Moorhouse, Khan, & Rodney, 2020).

c. Proses dialektis dilemma etik

Pendekatan berbasis prinsip sering memberikan kesan bahwa keputusan etik dapat dicapai melalui penerapan aturan yang sistematis. Namun dalam praktik, dilema etik justru muncul karena konflik antar prinsip yang tidak dapat diselesaikan secara mekanis.

Dilema etik jarang memiliki jawaban yang sederhana, sehingga diperlukan dialog antara berbagai pihak yang terlibat. Proses dialektis, yaitu proses pertukaran argumentasi antara nilai-nilai yang berbeda, atau antara nilai-nilai yang saling bertentangan. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan etik tidak hanya dihasilkan melalui penerapan prinsip, tetapi melalui proses negosiasi nilai yang mempertimbangkan perspektif pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan (Bertino, 2021).

Bertino (2021), menekankan bahwa proses ini menuntut kemampuan argumentasi moral, dimana tenaga kesehatan harus mampu:

- 1) mengidentifikasi konflik nilai
- 2) menyusun justifikasi

3) mempertahankan keputusan secara rasional

Dengan demikian, etik klinis bukan sekadar “apa yang benar”, tetapi “bagaimana kita sampai pada keputusan tersebut”. Dengan demikian, etik klinis merupakan proses dinamis yang melibatkan refleksi dan komunikasi.

d. Moral Reasoning dalam Bioetik

Penalaran moral merupakan kemampuan untuk menyusun dan mengevaluasi argumen etik. Dalam bioetik, argumen harus didasarkan pada premis yang valid dan relevan. Namun, proses ini sering dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti *confirmation bias* dan *motivated reasoning*, yang dapat mengganggu objektivitas. Oleh karena itu, refleksi kritis menjadi bagian penting dalam analisis etik (Vaughn, 2023).

4. Konsep Kerentanan (*Vulnerability*)

Konsep kerentanan memperluas pemahaman bioetik dengan menekankan bahwa tidak semua individu memiliki kapasitas dan posisi yang sama dalam sistem kesehatan. Kerentanan bersifat multidimensional, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan struktural.

Pendekatan ini mengkritik pandangan bioetik klasik yang terlalu menekankan otonomi individual, dan menggantikannya dengan konsep *relational autonomy*, yang melihat individu sebagai bagian dari jaringan relasi sosial (Takala, 2001).

Dalam praktik, kerentanan berkaitan dengan potensi *coercion* dan *paternalism*, yang dapat membatasi kebebasan individu dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan etik tidak hanya berfokus pada penghormatan otonomi, tetapi juga pada perlindungan, pemberdayaan, dan advokasi.

Model praktik keperawatan modern menekankan integrasi antara kompetensi klinis, *profesionalisme*, dan *caring* sebagai inti pelayanan, yang memungkinkan pendekatan etik yang lebih holistik (Varkey, 2021).

C. Alur Pengambilan Keputusan Etik dalam Praktik Keperawatan (McNee, 2021)

Pengambilan keputusan etik dalam praktik keperawatan merupakan proses reflektif, sistematis, dan kontekstual yang mengintegrasikan pertimbangan klinis, moral, serta hukum. Dalam praktik nyata, dilema etik jarang memiliki solusi tunggal yang jelas, sehingga diperlukan pendekatan yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep bahwa pengambilan keputusan etik merupakan proses *problem solving* yang melibatkan identifikasi masalah, analisis

nilai, serta evaluasi konsekuensi tindakan. Dalam konteks Indonesia, proses ini harus berjalan selaras dengan regulasi hukum yang mengatur hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, serta standar praktik profesional.

1. Identifikasi Dilema Etik

Menentukan apakah situasi mengandung konflik nilai moral (bukan sekadar masalah klinis), dengan mengenali adanya pertentangan prinsip seperti *autonomy*, *beneficence*, atau *non-maleficence*.

2. Pengkajian Klinis dan Kapasitas

Mengumpulkan data medis dan menilai kemampuan pasien dalam memahami serta mengambil keputusan, karena kapasitas menentukan validitas persetujuan.

3. Analisis Prinsip Etik

Menganalisis situasi menggunakan prinsip bioetik utama untuk mengidentifikasi konflik nilai dan mempertimbangkan keseimbangan antar prinsip.

4. Analisis Hukum dan Regulasi

Menilai kesesuaian tindakan dengan peraturan yang berlaku, termasuk validitas informed consent dan kewenangan pengambilan keputusan.

Setiap keputusan etik dalam praktik keperawatan harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Di Indonesia, beberapa regulasi yang relevan meliputi:

- a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- c. Permenkes No. 290 Tahun 2008 (Informed Consent)
- d. Kode Etik Keperawatan Indonesia

5. Identifikasi Alternatif Tindakan

Mengembangkan berbagai pilihan tindakan yang memungkinkan, beserta analisis risiko, manfaat, dan konsekuensi etik masing-masing.

6. Deliberasi dan Pengambilan Keputusan

Melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan dalam proses diskusi untuk menentukan keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan klinis.

7. Implementasi Keputusan

Melaksanakan keputusan dengan tetap menjaga martabat pasien, komunikasi terapeutik, dan keselamatan.

8. Evaluasi dan Refleksi Etik

Menilai hasil keputusan dari aspek klinis dan etik sebagai dasar perbaikan praktik di masa depan.

D. Issue etik pada kelompok khusus (Anak, lansia, gangguan mental dan disabilitas).

1. Isu Etik pada Anak dalam Praktik Keperawatan.

Populasi anak menempati posisi unik dalam analisis etik klinis karena tidak sepenuhnya dapat diposisikan sebagai agen otonom, tetapi juga tidak dapat direduksi menjadi objek keputusan orang dewasa. Kondisi ini menciptakan ruang etik yang kompleks, di mana penerapan prinsip bioetik klasik; *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* sebagaimana dirumuskan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, menjadi tidak memadai jika digunakan secara langsung tanpa adaptasi.

Pendekatan *principlism* cenderung menempatkan *autonomy* sebagai prinsip sentral. Namun dalam konteks anak, *autonomy* bersifat terbatas dan berkembang (*developing autonomy*), sehingga tidak dapat menjadi dasar tunggal dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan lain, khususnya pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dan *ethics of care*.

Pendekatan berbasis hak, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, menempatkan *best interests of the child* sebagai prinsip utama, sekaligus mengakui hak anak untuk didengar dan dilibatkan sesuai tingkat kematangannya (United Nations General Assembly, 2002). Berbeda dengan *principlism* yang berfokus pada keseimbangan prinsip, pendekatan ini memberikan kerangka normatif yang lebih tegas dalam memprioritaskan perlindungan anak.

Sementara itu, *ethics of care* mengkritik pendekatan prinsip yang dianggap terlalu abstrak dan kurang sensitif terhadap konteks relasional. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan etik pada anak tidak dapat dilepaskan dari relasi ketergantungan, empati, dan tanggung jawab moral antara anak, orang tua, dan tenaga kesehatan. Dalam konteks ini, kerentanan anak bukan sekadar kondisi yang harus dilindungi, tetapi menjadi dasar moral dalam menentukan tindakan yang tepat.

Dengan demikian, analisis etik dalam keperawatan anak tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan, melainkan memerlukan integrasi antara:

- a. *principlism* (kerangka analitik)
- b. *rights-based approach* (kerangka normatif)
- c. *ethics of care* (kerangka relasional)

Integrasi ini menjadi landasan dalam memahami berbagai dilema etik pada anak, khususnya yang berkaitan dengan otonomi, konflik keputusan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

a. Otonomi Anak, Assent, dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu isu etik utama dalam keperawatan anak adalah keterbatasan otonomi. Berbeda dengan pasien dewasa, anak umumnya tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan *informed consent*, sehingga keputusan medis biasanya diambil oleh orang tua atau wali.

Namun, pendekatan etik modern tidak lagi memandang anak sebagai pihak pasif. Konsep *assent* dikembangkan untuk mengakomodasi keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. *Assent* merupakan proses komunikasi yang memungkinkan anak memahami kondisi, menerima penjelasan, dan mengekspresikan preferensinya.

Literatur menunjukkan bahwa meskipun anak belum memiliki kompetensi penuh, mereka memiliki kapasitas bertahap untuk memahami informasi dan terlibat dalam keputusan. Oleh karena itu, mengabaikan suara anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabatnya (Knauss, 2019).

Konvensi Hak Anak juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk:

- 1) menyatakan pendapat
- 2) memperoleh informasi
- 3) dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi dirinya (UNICEF, 2019; United Nations General Assembly, 2002).

Dengan demikian, otonomi dalam konteks anak bersifat *graduated autonomy*, yaitu berkembang secara bertahap dan tidak bersifat absolut. Partisipasi anak tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan, terutama dalam situasi risiko tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep otonomi dalam pediatrik tidak dapat dipahami secara individualistik sebagaimana dalam *principlism* klasik, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka relasional dan perkembangan.

b. Konflik Keputusan: Orang Tua, Anak, dan Tenaga Kesehatan

Dalam praktik klinis, konflik sering muncul ketika keputusan orang tua tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak atau rekomendasi tenaga kesehatan. Konflik ini mencakup:

- 1) penolakan tindakan medis
- 2) penghentian terapi
- 3) keputusan perawatan akhir hayat
- 4) penolakan vaksinasi

Secara etik, orang tua memiliki hak sebagai *surrogate decision-maker*, tetapi hak ini tidak bersifat tanpa batas. Prinsip *best interest of the child* menjadi batas utama dalam pengambilan keputusan.

Ketika keputusan orang tua berpotensi menimbulkan kerugian serius, tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk melakukan intervensi demi melindungi anak, bahkan hingga melibatkan mekanisme hukum (Manoharam. B, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip autonomy orang tua dibatasi oleh prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* terhadap anak.

Dalam konteks vaksinasi, konflik juga melibatkan kepentingan kesehatan masyarakat. Prinsip *beneficence* mendukung imunisasi, sementara autonomy orang tua dapat mendorong penolakan. Namun, pendekatan berbasis hak anak menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan kesehatan optimal.

Konsep *Gillick competence* menunjukkan bahwa anak di bawah 16 tahun dapat dianggap kompeten untuk mengambil keputusan medis jika memiliki pemahaman yang cukup (NSPCC, 2018). Namun demikian, baik keputusan anak maupun orang tua dapat dikesampingkan apabila terdapat risiko serius terhadap keselamatan anak.

Dengan demikian, konflik keputusan dalam pediatrik mencerminkan ketegangan antara autonomy, perlindungan berbasis hak, dan tanggung jawab relasional, yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan prinsip semata

c. Kerentanan Anak dan Pendekatan *Ethics of Care*

Pendekatan *principlism* memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas etik pada anak, sehingga perlu diperkaya dengan *ethics of care*. Pendekatan ini menekankan pentingnya relasi, empati, dan tanggung jawab terhadap individu yang rentan.

Kerentanan anak bersifat mendasar (*inherent vulnerability*), sehingga membutuhkan perlindungan yang berkelanjutan (Rich, 2023). Dalam konteks ini, hubungan antara anak, orang tua, dan tenaga kesehatan menjadi pusat pertimbangan etik.

Perawat memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan pasien, sehingga mampu memahami kebutuhan anak secara holistik. Keputusan etik tidak hanya berbasis prinsip, tetapi juga pada relasi interpersonal yang melibatkan empati, kepercayaan, dan tanggung jawab moral.

d. Isu Etik Klinis Spesifik pada Anak

1) Penolakan Tindakan Medis (*Refusal of Treatment*)

Penolakan dapat berasal dari orang tua maupun anak. Secara etik, keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara *autonomy* dan prinsip *beneficence* serta *non-maleficence*. Dalam kondisi risiko serius, intervensi untuk melindungi anak dapat dibenarkan (United Nations General Assembly, 2002).

2) Vaksinasi dan Konflik Keputusan

Vaksinasi mencerminkan konflik antara kepentingan individu dan kesehatan masyarakat. Anak memiliki hak atas perlindungan kesehatan, sehingga keputusan orang tua tidak boleh mengabaikan hak tersebut.

3) End-of-Life Care pada Anak

Keputusan terkait perawatan akhir hayat harus mempertimbangkan manfaat dan beban intervensi, serta kualitas hidup anak. Kompleksitas meningkat karena keterbatasan pemahaman anak dan tekanan emosional orang tua (Beauchamp & Childress, 2019).

4) Child Abuse dan Kewajiban Proteksi

Dalam kasus kekerasan, prinsip *confidentiality* dapat berbenturan dengan kewajiban pelaporan. Namun, perlindungan anak harus diutamakan (NSPCC, 2018; United Nations General Assembly, 2002).

5) Kerahasiaan dan Hak Privasi Anak

Anak yang memiliki kapasitas berhak atas kerahasiaan informasi medisnya. Namun, hak ini dapat dibatasi jika terdapat risiko serius terhadap keselamatan ((RSCP), 2020; NSPCC, 2018).

6) Truth-Telling dan Non-Disclosure

Permintaan orang tua untuk tidak mengungkapkan kondisi kepada anak menimbulkan konflik moral. Keterbukaan mendukung perkembangan otonomi dan kepercayaan, tetapi harus disesuaikan dengan kesiapan psikologis anak (El Ali, O'Neill, & Gillam, 2025).

e. Isu Etik dalam Penelitian pada Anak

Anak merupakan kelompok rentan dalam penelitian kesehatan, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Pedoman CIOMS menegaskan bahwa penelitian harus memiliki nilai ilmiah yang jelas serta risiko minimal (CIOMS-WHO, 2016).

Persetujuan harus diperoleh dari orang tua atau wali, serta *assent* dari anak jika memungkinkan. Pedoman nasional juga menekankan prinsip menghormati, melindungi, dan berlaku adil terhadap subjek penelitian (Kemenkes-RI, 2021).

Isu etik utama meliputi:

- 1) validitas informed consent
- 2) potensi eksploitasi
- 3) distribusi manfaat dan beban penelitian

f. Analisis Kasus Etik pada Anak dalam Praktik Klinis

Pendekatan berbasis kasus (*case-based analysis*) merupakan metode penting dalam etik klinis karena memungkinkan integrasi antara prinsip, konteks, dan realitas praktik. Pada populasi anak, pendekatan ini menjadi semakin penting karena konflik etik sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui teori, tetapi membutuhkan penilaian kontekstual yang mendalam.

1) Kasus Anak Leukemia yang Menolak Kemoterapi

Seorang anak usia 14 tahun didiagnosis leukemia dan direkomendasikan menjalani kemoterapi dengan prognosis yang cukup baik jika terapi dijalankan. Namun, anak tersebut menolak pengobatan karena takut terhadap efek samping dan penderitaan yang akan dialami. Orang tua mendukung keputusan dokter dan ingin terapi tetap dilakukan.

Situasi ini menghadirkan konflik antara *emerging autonomy* anak dan prinsip *beneficence*. Secara perkembangan, anak usia remaja awal sering kali telah memiliki kapasitas untuk memahami kondisi dasar penyakit, tetapi belum tentu mampu mengevaluasi konsekuensi jangka panjang secara utuh. Oleh karena itu, pertanyaan utama bukan hanya apakah anak dapat menyatakan pilihan, tetapi apakah ia memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang sepenuhnya rasional.

Dalam kerangka Gillick *competence*, anak dapat dianggap kompeten jika mampu memahami sifat, tujuan, risiko, dan konsekuensi dari tindakan medis (NSPCC, 2018). Namun, bahkan jika anak dinilai kompeten, penolakannya terhadap terapi yang bersifat menyelamatkan jiwa dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaiknya.

Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar utama dalam situasi ini. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan (United Nations General Assembly, 2002). Dalam kasus ini, keberhasilan terapi dan peluang hidup jangka panjang menjadi argumen kuat untuk melanjutkan pengobatan.

Namun demikian, pendekatan etik yang tepat tidak hanya memaksakan terapi, tetapi juga melibatkan anak dalam proses komunikasi yang empatik. Penolakan anak sering kali bukan bentuk keputusan rasional,

tetapi refleksi dari ketakutan, kurangnya pemahaman, atau pengalaman negatif terhadap prosedur medis.

Dengan demikian, solusi etik tidak hanya terletak pada keputusan akhir, tetapi pada proses:

- a) eksplorasi alasan penolakan
- b) pemberian informasi yang sesuai usia
- c) dukungan psikologis
- d) keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan secara bertahap

Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara proteksi dan pemberdayaan, bukan dominasi salah satu prinsip.

2) Kasus Penolakan Transfusi Darah oleh Orang Tua

Seorang anak mengalami kondisi anemia berat yang membutuhkan transfusi darah segera. Namun, orang tua menolak tindakan tersebut karena keyakinan agama. Kondisi anak berisiko mengancam nyawa jika tidak segera ditangani.

Kasus ini merupakan contoh klasik konflik antara *parental authority* dan hak anak untuk hidup dan sehat. Secara hukum dan etik, orang tua memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi anaknya, tetapi hak tersebut tidak bersifat absolut.

Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraannya (United Nations General Assembly, 2002). Dalam konteks ini, penolakan orang tua yang berpotensi membahayakan kehidupan anak dapat dianggap melanggar prinsip *non-maleficence*.

Dari perspektif bioetik, prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* memiliki prioritas yang lebih kuat dalam situasi risiko kematian. Beauchamp dan Childress menekankan bahwa keputusan medis harus didasarkan pada keseimbangan manfaat dan beban, dimana tindakan yang secara jelas menyelamatkan nyawa memiliki justifikasi moral yang kuat (Beauchamp & Childress, 2019).

Dalam praktik, tenaga kesehatan sering menghadapi dilema antara menghormati keyakinan keluarga dan kewajiban profesional untuk menyelamatkan pasien. Dalam banyak yurisdiksi, kondisi seperti ini memungkinkan intervensi hukum untuk melindungi anak, termasuk melalui perintah pengadilan.

Namun demikian, pendekatan etik yang sensitif tetap diperlukan. Dialog dengan keluarga, penghormatan terhadap nilai mereka, serta

komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting dari proses. Intervensi koersif sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya komunikasi dilakukan.

3) Kasus Anak dengan Gangguan Jiwa dan Penggunaan Restrain

Seorang anak usia 12 tahun dengan gangguan perilaku berat menunjukkan agitasi ekstrem di ruang perawatan, termasuk perilaku agresif terhadap diri sendiri dan orang lain. Upaya de-eskalasi verbal tidak berhasil, dan tim kesehatan mempertimbangkan penggunaan restrain fisik untuk mencegah cedera lebih lanjut.

Situasi ini menghadirkan konflik etik yang tajam antara prinsip *non-maleficence*, *beneficence*, dan *autonomy*. Di satu sisi, restrain dapat mencegah cedera serius dan melindungi keselamatan pasien serta orang di sekitarnya. Namun, di sisi lain, restrain merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis, pelanggaran martabat, serta risiko cedera fisik.

Dalam konteks anak, kompleksitas meningkat karena keterbatasan kapasitas pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Anak dalam kondisi gangguan jiwa akut sering kali tidak mampu menilai konsekuensi perilakunya, sehingga intervensi protektif menjadi lebih dapat dibenarkan. Namun, justifikasi ini tidak boleh mengabaikan prinsip bahwa setiap tindakan harus proporsional dan merupakan pilihan terakhir.

Pendekatan etik modern menegaskan bahwa penggunaan restrain hanya dapat dibenarkan jika memenuhi beberapa kondisi:

- a) terdapat risiko nyata dan segera terhadap keselamatan
- b) intervensi non-restriktif telah diupayakan dan gagal
- c) tindakan dilakukan dalam durasi sesingkat mungkin
- d) disertai pemantauan ketat dan evaluasi berkala

Prinsip ini sejalan dengan pendekatan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi (United Nations General Assembly, 2002).

Namun demikian, restrain tidak boleh dipahami semata sebagai tindakan teknis, melainkan sebagai keputusan etik yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus, penggunaan restrain dapat mencerminkan kegagalan sistem dalam menyediakan pendekatan yang lebih humanis, seperti lingkungan terapeutik yang aman, dukungan psikologis, atau intervensi berbasis relasi.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pengalaman subjektif anak. Anak yang mengalami restrain dapat merasakan ketakutan, kehilangan kontrol, atau bahkan trauma, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setelah tindakan dilakukan, diperlukan proses *debriefing* dan pemulihan hubungan terapeutik.

Dari perspektif bioetik, situasi ini mencerminkan bentuk paternalism yang terbatas (*limited paternalism*), dimana intervensi dilakukan bukan untuk mengontrol, tetapi untuk melindungi individu yang tidak memiliki kapasitas penuh. Beauchamp dan Childress menekankan bahwa tindakan seperti ini hanya dapat dibenarkan jika bertujuan mencegah bahaya yang signifikan dan tidak ada alternatif yang lebih ringan (Beauchamp & Childress, 2019).

g. Implikasi Praktik dan Peran Advokasi Perawat pada Anak

Kasus etik pada anak menuntut perawat tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis seperti komunikasi terapeutik, negosiasi konflik, advokasi, dan kolaborasi interprofesional. Perawat berada pada posisi strategis dalam menjembatani konflik antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, sehingga etik tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi terwujud dalam praktik caring yang konkret. Dalam setiap tindakan, perawat harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar diperlukan, dilakukan secara manusiawi, dan tetap menjaga martabat anak.

Selain itu, perawat memiliki peran sentral sebagai advokat yang bertanggung jawab melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan anak. Peran ini mencakup memastikan kepentingan terbaik anak, memfasilitasi komunikasi antara anak, keluarga, dan tim kesehatan, mengidentifikasi potensi pelanggaran etik, serta memperjuangkan hak anak dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam situasi konflik antara orang tua dan kepentingan anak, kemampuan analisis etik dan komunikasi menjadi kompetensi kunci dalam praktik keperawatan anak.

2. Issue etik pada lansia dalam praktek keperawatan

Populasi lansia menghadirkan kompleksitas etik yang berbeda dari kelompok lain karena berada pada persimpangan antara penurunan kapasitas biologis, meningkatnya ketergantungan, serta potensi marginalisasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Berbeda dengan anak yang otonominya belum berkembang, pada lansia justru sering terjadi erosi otonomi, baik akibat kondisi medis seperti demensia maupun akibat konstruksi sosial yang menempatkan lansia sebagai kelompok "kurang produktif".

Literatur menunjukkan bahwa isu etik pada lansia tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan klinis, tetapi juga dengan bagaimana sistem kesehatan memperlakukan mereka secara adil dan bermartabat. Prinsip *autonomy*, *dignity*, dan *justice* menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks meningkatnya populasi lansia secara global (Ayati et al., 2024).

Namun, dalam praktik nyata, terdapat kecenderungan terjadinya *ageism* dalam pelayanan kesehatan, yaitu diskriminasi berbasis usia yang memengaruhi kualitas pelayanan. Studi menunjukkan bahwa lansia sering mengalami perlakuan tidak adil, kurangnya hubungan terapeutik yang bermakna, serta pengabaian kebutuhan individual dalam pelayanan kesehatan (Zendehtalab, Vanaki, & Memarian, 2023).

a. Otonomi vs Kapasitas (Autonomy vs Decision-Making Capacity)

Salah satu isu paling fundamental dalam etik lansia adalah ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi dan penurunan kapasitas pengambilan keputusan.

Berbeda dengan anak, lansia pada dasarnya memiliki otonomi penuh sebagai individu dewasa. Namun, kondisi seperti demensia, delirium, atau gangguan kognitif lainnya dapat mengganggu kemampuan mereka dalam memahami informasi dan membuat keputusan rasional. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik klinis, tenaga kesehatan sering menghadapi kesulitan dalam:

- 1) menentukan kapasitas pasien
- 2) memperoleh *informed consent* yang valid
- 3) menyeimbangkan antara *autonomy* dan keselamatan pasien (Alodhialah, Almutairi, & Almutairi, 2024)

Masalah etik muncul ketika:

- 1) pasien menolak tindakan yang secara medis diperlukan
- 2) atau menyetujui tindakan tanpa pemahaman yang memadai

Dalam konteks ini, *autonomy* tidak dapat dipahami sebagai konsep absolut. Varkey menegaskan bahwa *autonomy* dalam praktik klinis selalu terkait dengan kapasitas, dan ketika kapasitas terganggu, diperlukan pendekatan substitusi melalui *surrogate decision-making* (Varkey, 2021).

Namun, penting untuk dibedakan antara:

- 1) *loss of capacity* → ketidakmampuan aktual
- 2) *assumed incapacity* → asumsi berdasarkan usia

Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat menyebabkan pelanggaran etik serius, termasuk pengabaian hak pasien.

b. Kasus: Lansia dengan Demensia Menolak Perawatan

Seorang pasien lansia dengan demensia sedang mengalami infeksi serius, tetapi menolak pemberian antibiotik karena tidak memahami kondisinya. Keluarga meminta agar perawatan tetap dilakukan.

Situasi ini mencerminkan konflik antara:

- 1) *autonomy* (yang telah menurun)
- 2) *beneficence* dan *non-maleficence*

Dalam kondisi ini, penilaian kapasitas menjadi kunci. Jika pasien dinyatakan tidak memiliki kapasitas, maka keputusan dapat diambil oleh surrogate berdasarkan prinsip *best interest*.

Namun, dilema muncul karena:

- 1) pasien tetap menunjukkan preferensi (meskipun tidak rasional)
- 2) tindakan medis dapat dianggap melanggar kebebasan individu

Pendekatan etik modern menyarankan penggunaan *supported decision-making*, yaitu membantu pasien memahami informasi sejauh mungkin sebelum mengambil alih keputusan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan Bertino yang menekankan bahwa etik klinis bukan sekadar hasil akhir, tetapi proses *deliberative* yang mempertimbangkan konteks dan nilai pasien (Bertino, 2021).

c. Multimorbiditas dan Polypharmacy

Lansia sering mengalami ***multimorbiditas***, yaitu kondisi dengan beberapa penyakit kronis yang memerlukan terapi kompleks. Hal ini sering diikuti dengan *polypharmacy* (penggunaan banyak obat), yang meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping.

Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini tidak hanya menjadi masalah klinis, tetapi juga masalah etik, karena:

- 1) risiko harm meningkat
- 2) kualitas hidup dapat menurun
- 3) keputusan terapi menjadi semakin kompleks (Alodhialah et al., 2024)

Dilema etik muncul ketika:

- 1) terapi yang diberikan memperpanjang hidup tetapi menurunkan kualitas hidup
- 2) penghentian terapi dianggap sebagai “membiarkan pasien meninggal”

Dalam konteks ini, prinsip *beneficence* harus ditafsirkan ulang, tidak hanya sebagai memperpanjang hidup, tetapi sebagai meningkatkan kualitas hidup.

d. Kasus: Over-Treatment vs Quality of Life

Seorang lansia dengan gagal jantung kronis dan penyakit ginjal stadium akhir terus mendapatkan intervensi agresif di ICU. Secara klinis, prognosis sangat buruk, namun keluarga meminta semua tindakan tetap dilakukan.

Kasus ini mencerminkan konflik klasik antara:

- 1) *life prolongation vs quality of life*
- 2) *medical futility vs family expectation*

Dalam literatur etik, tindakan yang tidak lagi memberikan manfaat signifikan disebut sebagai ***futile treatment***. Vaughn menjelaskan bahwa intervensi semacam ini dapat menjadi tidak etis jika hanya memperpanjang penderitaan tanpa memberikan manfaat nyata (Vaughn, 2023).

Namun, menentukan "*futility*" bukan hal sederhana, karena:

- 1) bersifat subjektif
- 2) dipengaruhi oleh nilai pasien dan keluarga

Dalam konteks ini, keputusan etik harus melibatkan:

- 1) komunikasi terbuka dengan keluarga
- 2) penjelasan realistis tentang prognosis
- 3) pertimbangan nilai dan preferensi pasien

e. Long-Term Care dan Martabat Lansia

Perawatan jangka panjang (*long-term care*) menjadi area yang sangat rentan terhadap masalah etik, terutama terkait dengan martabat (*dignity*) dan integritas lansia.

Penelitian menunjukkan bahwa lansia dalam fasilitas perawatan jangka panjang sering mengalami:

- 1) kurangnya penghormatan terhadap privasi
- 2) kurangnya perawatan individual
- 3) isolasi sosial dan kesepian (Teeri, Leino-Kilpi, & Valimaki, 2006)

Masalah ini menunjukkan bahwa etik tidak hanya berkaitan dengan keputusan klinis besar, tetapi juga praktik sehari-hari yang tampak sederhana, seperti:

- 1) cara berkomunikasi
- 2) cara memberikan perawatan personal
- 3) cara melibatkan pasien dalam aktivitas

Dalam konteks ini, *dignity* bukan konsep abstrak, tetapi sesuatu yang diwujudkan dalam interaksi sehari-hari.

f. Kasus: *Neglect* dalam Perawatan Lansia

Seorang lansia di fasilitas perawatan mengalami penurunan kondisi karena kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar, seperti nutrisi dan

kebersihan. Tidak ada tindakan yang secara eksplisit “membahayakan”, tetapi terjadi pengabaian (*neglect*).

Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik tidak selalu berbentuk tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa kelalaian.

Prinsip *non-maleficence* dalam konteks ini harus diperluas:

- 1) bukan hanya “tidak menyakiti”
- 2) tetapi juga “tidak membiarkan pasien mengalami kerugian”

Selain itu, *justice* juga menjadi relevan karena lansia sering mengalami ketidakadilan dalam distribusi perhatian dan sumber daya.

g. *Ageism* dan Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan

Isu lain yang semakin mendapat perhatian adalah *age-based discrimination (ageism)* dalam pelayanan kesehatan.

Literatur menunjukkan bahwa lansia sering:

- 1) tidak diprioritaskan dalam akses layanan
- 2) dianggap kurang layak menerima intervensi tertentu
- 3) mengalami stereotip negatif dalam praktik klinis (Zendehtalab et al., 2023)

Hal ini bertentangan dengan prinsip *justice* yang menuntut distribusi layanan kesehatan secara adil tanpa diskriminasi.

Dalam konteks ini, etik klinis tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena menyangkut bagaimana sistem kesehatan memperlakukan kelompok lansia secara keseluruhan.

h. Peran Perawat dalam Etik Lansia

Kode etik keperawatan menegaskan bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk:

- 1) menghormati martabat manusia
- 2) melindungi kelompok rentan
- 3) memberikan pelayanan tanpa diskriminasi (ICN, 2021)

Dalam konteks lansia, peran ini menjadi semakin penting karena:

- 1) lansia sering mengalami penurunan kapasitas
- 2) sering berada dalam posisi ketergantungan
- 3) berisiko mengalami marginalisasi

Perawat tidak hanya berperan sebagai caregiver, tetapi juga sebagai:

- 1) advokat
- 2) mediator konflik
- 3) penjaga martabat pasien

3. Isu Etik pada Klien dengan Gangguan Mental dalam Praktik Keperawatan

Isu etik pada klien dengan gangguan mental memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan gangguan pada fungsi kognitif, emosi, persepsi, dan

perilaku yang secara langsung memengaruhi kapasitas individu dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan populasi anak yang mengalami perkembangan kapasitas, atau lansia yang mengalami penurunan kapasitas, pada gangguan mental kapasitas bersifat fluktuatif, situasional, dan sering kali tidak stabil.

Kondisi ini menempatkan tenaga kesehatan pada dilema etik yang khas, terutama dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap *autonomy* dan kewajiban untuk melindungi pasien serta orang lain dari potensi bahaya. Dalam banyak kasus, intervensi yang dilakukan, seperti rawat paksa, restrain, atau pengobatan tanpa persetujuan, dapat dipandang sebagai pelanggaran otonomi, tetapi sekaligus dibenarkan dalam kerangka perlindungan (*protective ethics*).

Secara konseptual, dilema etik dalam gangguan mental sering muncul karena adanya ketegangan antara:

- 1) *self-determination vs protection*
- 2) *confidentiality vs safety*
- 3) *care vs control*

a. Kapasitas, Kompetensi, dan *Autonomy* yang Fluktuatif

Kapasitas pengambilan keputusan pada klien gangguan mental tidak dapat dinilai secara statis. Individu dengan gangguan jiwa dapat:

- 1) memiliki kapasitas pada satu waktu
- 2) kehilangan kapasitas pada waktu lain
- 3) kompeten untuk satu jenis keputusan, tetapi tidak untuk yang lain

Hal ini berbeda dengan pendekatan *simplistik* yang menganggap semua pasien gangguan jiwa tidak kompeten.

Literatur etik kinis menekankan bahwa kapasitas mencakup kemampuan untuk:

- 1) memahami informasi
- 2) menimbang konsekuensi
- 3) membuat pilihan rasional
- 4) mengkomunikasikan keputusan

Ketika salah satu komponen ini terganggu, validitas *autonomy* menjadi dipertanyakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa gangguan mental tidak otomatis menghilangkan *autonomy*. Kesalahan dalam mengasumsikan ketidakmampuan (*assumed incapacity*) dapat menyebabkan pelanggaran hak pasien, sebagaimana juga terjadi pada lansia (Alodhialah et al., 2024).

b. Kasus: Pasien Skizofrenia Menolak Pengobatan

Seorang pasien dengan skizofrenia mengalami episode psikotik akut, menunjukkan halusinasi dan waham, serta menolak pengobatan karena meyakini bahwa dirinya tidak sakit.

Kasus ini mencerminkan konflik klasik antara:

- 1) *autonomy* (penolakan pasien)
- 2) *beneficence & non-maleficence* (kewajiban tenaga kesehatan)

Dalam kondisi ini, pertanyaan utama bukan hanya “apa yang diinginkan pasien”, tetapi: apakah pasien memiliki kapasitas untuk memahami realitas dan konsekuensi keputusan?. Dalam episode psikotik, persepsi realitas terganggu, sehingga keputusan pasien tidak dapat dianggap sebagai ekspresi *autonomy* yang valid. Oleh karena itu, intervensi tanpa persetujuan dapat dibenarkan dalam kerangka:

- 1) *therapeutic necessity*
- 2) *risk prevention*

Namun, pendekatan etik modern menekankan bahwa tindakan tersebut harus:

- 1) bersifat sementara
- 2) dievaluasi secara berkala
- 3) diarahkan untuk memulihkan kapasitas pasien

Dengan demikian, tujuan utama bukan menghilangkan *autonomy*, tetapi mengembalikannya.

c. Involuntary Treatment (Perawatan Paksa)

Perawatan tanpa persetujuan (*involuntary treatment*) merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam etik kesehatan jiwa. Secara umum, tindakan ini dapat dibenarkan jika:

- 1) pasien berisiko membahayakan diri sendiri
- 2) pasien berisiko membahayakan orang lain
- 3) pasien tidak memiliki kapasitas

Namun, tindakan ini juga berisiko:

- 1) melanggar hak asasi
- 2) menimbulkan trauma
- 3) merusak hubungan terapeutik

Dalam praktik, dilema muncul karena:

- 1) batas “bahaya” tidak selalu jelas
- 2) penilaian kapasitas bersifat subjektif
- 3) terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan

Literatur etik menekankan bahwa penggunaan perawatan paksa harus memenuhi prinsip:

- 1) *necessity* (kebutuhan nyata)
- 2) *proportionality* (proporsionalitas tindakan)
- 3) *least restrictive alternative* (alternatif paling minimal restriksi)

d. *Restrain* dan *Seclusion* pada Pasien Gangguan Jiwa

Penggunaan *restrain* dan *seclusion* pada pasien gangguan jiwa sering menjadi sumber konflik etik yang serius. Di satu sisi, melindungi keselamatan pasien dan orang lain, namun di sisi lain:

- 1) membatasi kebebasan
- 2) berpotensi melanggar martabat
- 3) dapat menyebabkan trauma psikologis

Seperti pada kasus anak, *restrain* hanya dapat dibenarkan jika:

- 1) merupakan pilihan terakhir
- 2) terdapat risiko langsung
- 3) dilakukan dalam waktu terbatas

Namun, dalam konteks gangguan jiwa, penggunaan *restrain* sering lebih kompleks karena:

- 1) perilaku agresif dapat berulang
- 2) faktor lingkungan (*overcrowding*, kurang staf) memengaruhi keputusan

Hal ini menunjukkan bahwa *restrain* tidak hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem pelayanan.

e. Kerahasiaan vs Risiko (*Confidentiality vs Duty to Protect*)

Kerahasiaan merupakan prinsip fundamental dalam praktik kesehatan. Namun, pada gangguan mental, prinsip ini sering berbenturan dengan kewajiban untuk melindungi.

Contoh:

- 1) pasien mengungkapkan niat bunuh diri
- 2) pasien mengancam orang lain

Dalam kondisi ini, tenaga kesehatan menghadapi dilema:

- 1) menjaga kerahasiaan
- 2) atau melanggar kerahasiaan demi keselamatan

Literatur etik menunjukkan bahwa dalam situasi risiko serius, kewajiban untuk melindungi dapat mengesampingkan kerahasiaan, terutama jika terdapat ancaman nyata terhadap individu atau masyarakat (Mueller, Hook, & Fleming, 2004).

Namun, pelanggaran kerahasiaan harus:

- 1) berbasis alasan kuat
- 2) dibatasi pada informasi yang relevan
- 3) dilakukan secara proporsional

f. Stigma dan Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

Klien dengan gangguan mental sering menghadapi stigma, baik dalam masyarakat maupun dalam sistem pelayanan kesehatan.

Stigma ini dapat menyebabkan:

- 1) kualitas pelayanan yang lebih rendah
- 2) pengabaian kebutuhan pasien
- 3) pembatasan akses layanan

Fenomena ini serupa dengan *ageism* pada lansia, dimana kelompok tertentu diperlakukan tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu.

Dari perspektif etik, hal ini melanggar prinsip:

- 1) justice
- 2) dignity
- 3) non-discrimination

Pendekatan etik modern menekankan bahwa pasien gangguan jiwa harus diperlakukan sebagai individu dengan hak penuh, bukan sekadar objek kontrol.

g. Kasus: Pasien dengan Risiko Bunuh Diri

Seorang pasien depresi berat mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya, tetapi meminta agar informasi tersebut dirahasiakan.

Kasus ini mencerminkan konflik antara:

- 1) autonomy & confidentiality
- 2) non-maleficence & duty to protect

Dalam situasi ini, prinsip *non-maleficence* memiliki prioritas lebih tinggi karena:

- 1) terdapat risiko kematian
- 2) pasien dalam kondisi vulnerabel

Dengan demikian, intervensi dapat meliputi:

- 1) pelaporan kepada tim kesehatan
- 2) peningkatan pengawasan
- 3) intervensi terapeutik intensif

Namun, penting untuk tetap menjaga hubungan terapeutik agar pasien tidak merasa dikhianati.

h. Peran Perawat dalam Etik Kesehatan Jiwa

Dalam konteks gangguan mental, perawat memiliki peran yang sangat kompleks, yaitu sebagai:

- 1) caregiver
- 2) advokat pasien
- 3) pengelola risiko
- 4) mediator antara pasien, keluarga, dan sistem

Perawat harus mampu:

- 1) menilai kapasitas secara dinamis

- 2) membangun hubungan terapeutik
- 3) mengambil keputusan dalam situasi tidak pasti

Sebagaimana dalam konteks lansia dan populasi lain, perawat berperan sebagai penjaga keseimbangan antara *autonomy* dan *protection*. Isu etik pada gangguan mental menunjukkan bahwa:

- 1) *autonomy* bersifat tidak stabil
- 2) kapasitas bersifat dinamis
- 3) intervensi sering berada di wilayah abu-abu antara ***care dan control***

Pendekatan etik tidak dapat bersifat kaku, tetapi harus; kontekstual, reflektif dan berbasis relasi. Dengan demikian, etik kesehatan jiwa merupakan salah satu area paling kompleks dalam praktik keperawatan, karena menuntut integrasi antara penilaian klinis, sensitivitas etik, dan pertimbangan hukum secara simultan.

4. Isu Etik pada Klien Disabilitas dalam Praktik Keperawatan

Isu etik pada pasien disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan populasi lain karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi klinis, tetapi juga dengan hambatan komunikasi, ketergantungan fungsional, serta faktor sosial dan struktural. Disabilitas tidak semata-mata merupakan kondisi individu, melainkan hasil interaksi antara keterbatasan individu dengan lingkungan yang tidak aksesibel. Dalam konteks ini, dilema etik sering kali muncul bukan karena penyakit itu sendiri, tetapi karena keterbatasan akses terhadap layanan, ketimpangan dalam kualitas pelayanan, serta kegagalan sistem kesehatan dalam mengakomodasi kebutuhan khusus pasien disabilitas.

Dengan demikian, isu etik pada disabilitas lebih banyak berkaitan dengan prinsip keadilan (*justice*), otonomi yang bersifat didukung (*supported autonomy*), serta penghormatan terhadap martabat (*dignity*) dalam kondisi ketergantungan (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019). Ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas praktik keperawatan pada pasien disabilitas.

a. *Autonomy* dalam Konteks Ketergantungan dan Supported Decision-Making

Berbeda dengan gangguan jiwa yang kapasitasnya fluktuatif, pada disabilitas terutama disabilitas intelektual kapasitas individu sering kali bersifat terbatas, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Hal ini menimbulkan pertanyaan etik mendasar mengenai sejauh mana individu mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta sejauh mana intervensi keluarga atau wali dapat dibenarkan.

Literatur menunjukkan bahwa disabilitas tidak secara otomatis menghilangkan kapasitas seseorang. Individu dengan disabilitas tetap memiliki

hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan seharusnya bukan menggantikan keputusan pasien, melainkan mendukung proses pengambilan keputusan melalui konsep *supported decision-making*. Pendekatan ini menekankan bahwa individu dibantu untuk memahami informasi dan mengekspresikan kehendaknya, bukan diambil alih keputusannya.

Namun dalam praktik, tenaga kesehatan masih sering menggunakan pendekatan paternalistik, dimana keputusan langsung dialihkan kepada keluarga tanpa melibatkan pasien. Hal ini menimbulkan konflik antara penghormatan terhadap otonomi dan kewajiban untuk memberikan manfaat (*beneficence*), yang menjadi salah satu dilema utama dalam praktik keperawatan pada disabilitas.

b. Kasus: Pasien Disabilitas Intelektual dan *Informed Consent*

Dalam praktik klinis, isu *informed consent* menjadi sangat kompleks ketika berhadapan dengan pasien disabilitas intelektual. Misalnya, pada pasien dengan disabilitas intelektual ringan yang akan menjalani prosedur medis, keluarga sering kali meminta agar seluruh keputusan diambil oleh mereka tanpa melibatkan pasien.

Situasi ini mencerminkan konflik antara efisiensi pelayanan dan penghormatan terhadap otonomi pasien. Meskipun kapasitas pasien terbatas, hak individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tetap harus dihormati. Oleh karena itu, *informed consent* tetap perlu diupayakan melalui pendekatan komunikasi yang adaptif, seperti penggunaan bahasa sederhana, media visual, serta teknik komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan pasien (Mate, Simon, & Elmadani, 2025).

Masalah etik muncul ketika tenaga kesehatan tidak berusaha menyesuaikan cara komunikasi dan langsung menganggap pasien tidak mampu. Dalam banyak kasus, kegagalan komunikasi justru disalahartikan sebagai ketidakmampuan pasien, sehingga hak pasien untuk berpartisipasi menjadi terabaikan.

c. Hambatan Komunikasi sebagai Masalah Etik

Hambatan komunikasi merupakan isu sentral dalam disabilitas dan berdampak langsung pada *informed consent*, partisipasi pasien, serta hubungan terapeutik. Komunikasi yang tidak adekuat dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, kesalahan terapi, dan pengabaian kebutuhan pasien (Elmadani et al., 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pelayanan kesehatan sering kali gagal menyediakan *accessible communication environment*, baik dari sisi literasi kesehatan, format informasi, maupun interaksi interpersonal (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019). Akibatnya, pasien disabilitas tidak hanya kesulitan memahami informasi medis, tetapi juga kesulitan menyampaikan pengalaman tubuh (*embodied experience*) yang kompleks, seperti nyeri kronis atau kelelahan yang tidak dapat direduksi menjadi parameter klinis sederhana. Kondisi ini berimplikasi etik serius karena mengurangi validitas *informed consent* dan memperlemah posisi pasien sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, praktik komunikasi yang tidak inklusif sering kali memperkuat relasi kuasa yang timpang antara tenaga kesehatan dan pasien. Penggunaan pertanyaan tertutup, keterbatasan waktu, serta asumsi bahwa pasien “tidak mampu memahami” menyebabkan pasien disabilitas terpinggirkan dari proses komunikasi klinis.

Dalam konteks etik, ini adalah pelanggaran terhadap: *autonomy* dan *dignity*, karena pasien tidak diperlakukan sebagai individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang tubuhnya sendiri. Selain itu, hambatan komunikasi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan epistemik.

d. *Overprotection vs Self-Determination*

Pasien disabilitas sering mengalami *overprotection* dari keluarga, tenaga kesehatan, maupun institusi. Bentuknya dapat berupa pembatasan dalam pengambilan keputusan, aktivitas sosial, maupun kontrol yang berlebihan terhadap kehidupan pasien.

Meskipun bertujuan melindungi, pendekatan ini justru dapat menghambat *self-determination*, yang merupakan bagian penting dari kualitas hidup dan hak asasi individu. Dalam praktik, tenaga kesehatan sering berada pada dilema antara memberikan perlindungan dan menghormati kebebasan pasien.

Literatur menunjukkan bahwa perlindungan yang berlebihan dapat menjadi bentuk pelanggaran otonomi, karena mengurangi kesempatan individu untuk berkembang dan mengambil peran aktif dalam kehidupannya (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019).

e. Ketidakadilan Akses dan Diskriminasi (*Justice Issue*)

Ketidakadilan sistemik merupakan isu utama dalam disabilitas. Pasien disabilitas sering mengalami akses layanan yang lebih rendah, kualitas

pelayanan yang kurang optimal, serta angka morbiditas yang lebih tinggi (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019).

Kondisi ini dipengaruhi oleh stigma, fasilitas yang tidak aksesibel, serta kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Diskriminasi juga terjadi dalam pendidikan, praktik klinis, dan penelitian (Cornish & Monson, 2018). Secara etik, hal ini melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Ketidakadilan yang dialami oleh pasien disabilitas juga tidak dapat dilepaskan dari dominasi *medical model of disability*, yang memandang disabilitas semata sebagai masalah individu yang harus diperbaiki. Model ini cenderung mengabaikan faktor sosial, lingkungan, dan kebijakan yang justru berkontribusi besar terhadap pengalaman disabilitas. Akibatnya, pelayanan kesehatan sering berfokus pada “perbaikan fungsi tubuh”, tetapi mengabaikan kebutuhan partisipasi sosial, kualitas hidup, dan pengalaman subjektif pasien.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang pendekatan *social* dan *rights-based model*, yang menempatkan disabilitas sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan. Dalam perspektif ini, masalah etik tidak lagi hanya dilihat sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai kegagalan sistem dalam menyediakan akses yang setara dan lingkungan yang inklusif. Hal ini memperluas cakupan prinsip *justice*, dari sekadar distribusi layanan menjadi upaya aktif untuk menghilangkan hambatan struktural dalam pelayanan kesehatan.

f. *Abuse, Neglect, dan Vulnerabilitas*

Pasien disabilitas memiliki risiko lebih tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian dibandingkan populasi umum (Cornish & Monson, 2018). Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan komunikasi dan ketergantungan pada caregiver.

Dalam praktik, perawat sering menghadapi dilema antara menjaga hubungan dengan keluarga dan kewajiban melindungi pasien. Namun secara etik dan legal, perlindungan pasien harus menjadi prioritas utama.

g. *Restrictive Practice dalam Disabilitas*

Praktik restriktif seperti pembatasan aktivitas, kontrol perilaku, atau penggunaan sedasi sering terjadi pada pasien disabilitas. Meskipun bertujuan menjaga keselamatan, praktik ini sering digunakan untuk kemudahan sistem, bukan kebutuhan pasien (Elmadani et al., 2025).

Hal ini menimbulkan konflik antara keselamatan dan martabat. Oleh karena itu, pendekatan etik menekankan penggunaan *least restrictive alternative* dan *person-centered care*.

h. Peran Keluarga dan Konflik Kepentingan

Keluarga memiliki peran penting sebagai *caregiver* dan pengambil keputusan, tetapi dapat terjadi konflik antara kepentingan keluarga dan kepentingan pasien. Misalnya, pembatasan hak reproduksi atau edukasi seksual pasien berdasarkan nilai budaya tertentu, padahal pasien tetap memiliki hak sebagai individu (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019).

i. Peran Perawat dalam Etik Disabilitas

Perawat memiliki peran strategis sebagai advokat, fasilitator komunikasi, dan penjaga martabat pasien. Praktik keperawatan harus berlandaskan pendekatan berbasis hak (*human rights*), yang menekankan penghormatan terhadap martabat, otonomi, non-diskriminasi, dan partisipasi penuh (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2019).

Implikasinya, perawat harus mendorong pemberdayaan pasien, keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta penggunaan komunikasi yang adaptif. Pendekatan *supported decision-making* menjadi kunci dalam memastikan bahwa keterbatasan kapasitas tidak menjadi alasan untuk menghilangkan hak.

Pendekatan etik pada disabilitas juga perlu berlandaskan pada kerangka *human rights*, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang menekankan penghormatan terhadap martabat, otonomi, non-diskriminasi, dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, perawat tidak hanya bertanggung jawab secara klinis, tetapi juga memiliki peran dalam memastikan bahwa praktik pelayanan tidak mereproduksi ketidakadilan struktural.

Implikasinya, praktik keperawatan harus mengarah pada:

- 1) pemberdayaan pasien (*empowerment*)
- 2) keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan
- 3) penggunaan pendekatan komunikasi yang adaptif dan inklusif

Selain itu, prinsip *supported decision-making* harus diutamakan dibandingkan substitusi keputusan, dengan memberikan dukungan yang memadai agar pasien tetap dapat mengekspresikan kehendaknya. Pendekatan ini menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas bukan alasan untuk menghilangkan hak, melainkan dasar untuk meningkatkan dukungan etik dan profesional.

Isu etik pada disabilitas menunjukkan karakter khas yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial. Dalam konteks ini, otonomi tidak bersifat absolut, melainkan membutuhkan dukungan (*supported autonomy*), sehingga dilema

etik yang muncul umumnya berkisar pada ketegangan antara perlindungan dan pemberdayaan (*protection vs empowerment*), antara perawatan dan kontrol (*care vs control*), serta antara inklusi dan eksklusivitas (*inclusion vs exclusion*). Jika dibandingkan dengan populasi lain, anak menghadapi isu perkembangan kapasitas, lansia mengalami penurunan kapasitas, gangguan jiwa ditandai kapasitas yang fluktuatif, sedangkan disabilitas ditandai kapasitas yang terbatas serta hambatan sistemik. Oleh karena itu, pendekatan etik pada disabilitas menuntut penerapan kerangka berbasis hak (*rights-based approach*), komunikasi yang adaptif, serta upaya mewujudkan keadilan sistemik dalam pelayanan kesehatan.

Isu etik dalam keperawatan pada populasi khusus, anak, lansia, gangguan jiwa, dan disabilitas, menunjukkan bahwa penerapan prinsip bioetik tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik kapasitas, tingkat ketergantungan, serta konteks sosial masing-masing kelompok. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa konsep *autonomy* bersifat dinamis: berkembang pada anak, menurun pada lansia, fluktuatif pada gangguan jiwa, dan terbatas namun tetap ada pada disabilitas. Dalam seluruh konteks tersebut, dilema etik umumnya berpusat pada ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi dan kewajiban perlindungan, yang menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya berpegang pada prinsip, tetapi juga mampu melakukan penilaian kontekstual yang sensitif terhadap kondisi individu.

Lebih lanjut, isu etik pada populasi khusus juga memperlihatkan bahwa praktik keperawatan tidak dapat dilepaskan dari dimensi struktural, seperti ketidakadilan akses, stigma, dan keterbatasan sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai advokat yang memastikan terpenuhinya hak, martabat, dan keadilan bagi kelompok rentan. Pendekatan etik yang diperlukan bukan hanya berbasis prinsip, tetapi juga berbasis relasi dan hak (*rights-based and relational ethics*), dimana keputusan klinis diambil melalui proses deliberatif yang melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan, serta mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, kompetensi etik perawat menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh populasi.

ASESMEN

1. ASESMEN CPMK-2 (UTAMA)

Teknik: Analisis Kasus Etik (Case-Based)

a. Deskripsi Tugas

Mahasiswa menganalisis satu kasus etik pada populasi khusus (anak/lansia/gangguan jiwa/disabilitas), menggunakan:

- 1) prinsip bioetik
- 2) kerangka analisis etik klinis
- 3) pertimbangan kapasitas & perlindungan

b. **Output:** Laporan analisis kasus (1500–2000 kata)

c. Format Laporan (Wajib)

- 1) Identifikasi kasus & fakta klinis
- 2) Identifikasi dilema etik
- 3) Analisis kapasitas & consent
- 4) Analisis prinsip etik (4 prinsip)
- 5) Analisis aspek hukum
- 6) Alternatif tindakan
- 7) Keputusan & justifikasi
- 8) Strategi advokasi & pencegahan diskriminasi

d. Rubrik Penilaian (Skor 0–4 per aspek)

Aspek	0	1	2	3	4
Identifikasi konflik etik	Tidak ada	Tidak tepat	Sebagian	Cukup tepat	Sangat tepat & lengkap
Analisis kapasitas & consent	Tidak ada	Salah	Parsial	Tepat	Komprehensif & kontekstual
Analisis prinsip etik	Tidak ada	Deskriptif	Parsial	Tepat	Mendalam & kritis
Justifikasi keputusan	Tidak ada	Lemah	Kurang logis	Logis	Sangat kuat & berbasis kerangka
Advokasi & anti-diskriminasi	Tidak ada	Umum	Kurang aplikatif	Aplikatif	Strategis & kontekstual

Skor akhir: $(\text{Total skor} / 20) \times 100$

Bobot: 20%

2. ASESMEN CPMK-3 (PENDUKUNG)

Teknik: OSCE (Simulasi Informed Consent / Penolakan)

a. Deskripsi

Mahasiswa melakukan simulasi:

- 1) pemberian informed consent
- 2) menangani penolakan tindakan
- 3) situasi kapasitas tidak adekuat

b. Checklist OSCE (Ya = 1, Tidak = 0)

1) Pembukaan

- a) Memperkenalkan diri & peran
- b) Menjelaskan tujuan komunikasi

2) Pemberian Informasi

- a) Diagnosis/indikasi tindakan
- b) Tujuan tindakan
- c) Risiko & manfaat
- d) Alternatif tindakan
- e) Konsekuensi jika menolak

3) Verifikasi Pemahaman

- a) Menggunakan bahasa sederhana
- b) Mengecek pemahaman pasien

4) Persetujuan / Penolakan

- a) Memberi kesempatan bertanya
- b) Menghormati keputusan
- c) Tidak memaksa

5) Jika Penolakan / Kapasitas Tidak Adekuat

- a) Mengidentifikasi kapasitas
- b) Melibatkan keluarga/surrogate
- c) Menjelaskan risiko secara jelas
- d) Dokumentasi keputusan

6) Komunikasi Etik

- a) Empati
- b) Tidak menghakimi
- c) Menjaga martabat pasien

c. Kriteria Penilaian

- 1) $\geq 80\%$ item terpenuhi $\rightarrow$ Kompeten
- 2) Tidak ada **critical error**:
 - a) tidak menjelaskan risiko
 - b) memaksa pasien

c) mengabaikan kapasitas

d. **Bobot:** 15%

3. ASESMEN CPMK-4 (PENDUKUNG)

Teknik: Audit Privasi & Etika Digital

a. Deskripsi Tugas

Mahasiswa melakukan audit pada skenario layanan (misal: rekam medis, komunikasi digital, dokumentasi).

b. **Output:**

1) Worksheet audit

2) Rencana mitigasi

c. Format Worksheet

1) Identifikasi Risiko

Mahasiswa mengidentifikasi:

a) akses tidak sah

b) kebocoran data

c) penggunaan media tidak aman

d) dokumentasi tidak terlindungi

2) Analisis Risiko

Area	Risiko	Dampak	Tingkat Risiko
------	--------	--------	----------------

3) Rencana Mitigasi

Risiko	Tindakan Mitigasi	Penanggung Jawab	Status
--------	-------------------	------------------	--------

d. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Identifikasi risiko	Sangat terbatas	Cukup	Lengkap	Sangat komprehensif
Analisis dampak	Tidak jelas	Umum	Tepat	Mendalam
Mitigasi	Tidak operasional	Kurang jelas	Aplikatif	Spesifik & realistis

e. **Skor akhir:** $(\text{Total} / 12) \times 100$

f. **Bobot:** 10%

4. REKAP BOBOT ASESMEN

CPMK	Teknik	Bobot
CPMK-2	Analisis kasus	20%
CPMK-3	OSCE	15%
CPMK-4	Audit privasi	10%

5. CONTOH KASUS ETIK

a. Kasus

Seorang pasien laki-laki usia 68 tahun dengan riwayat stroke dan demensia ringan dirawat karena pneumonia berat. Kondisi pasien saat ini mengalami penurunan kesadaran fluktuatif. Dokter merekomendasikan pemasangan ventilator karena terjadi gagal napas.

Saat kondisi sadar, pasien sebelumnya pernah menyatakan kepada perawat bahwa ia tidak ingin "dipasang alat" jika kondisinya memburuk. Namun, tidak ada *advance directive* tertulis.

Keluarga (anak) meminta semua tindakan dilakukan, termasuk ventilator, dengan alasan ingin "berusaha maksimal". Perawat merasa dilema karena:

- ada indikasi keinginan pasien sebelumnya
- keluarga meminta tindakan agresif
- kondisi pasien tidak stabil untuk menilai kapasitas secara optimal

b. KUNCI JAWABAN (*GOLD STANDARD*)

1) Identifikasi Fakta Klinis

- Lansia, stroke + demensia ringan
- Pneumonia berat → gagal napas
- Indikasi medis ventilator
- Kapasitas: fluktuatif (tidak adekuat saat ini)

2) Identifikasi Dilema Etik

Konflik utama:

- *Autonomy* pasien (pernyataan sebelumnya menolak tindakan)
vs
- *Beneficence* (tindakan menyelamatkan hidup)
vs
- Keinginan keluarga (*surrogate decision*)

Tambahan konflik:

- Tidak ada dokumen legal (*advance directive*)
- Ketidakjelasan validitas preferensi pasien

3) Analisis Kapasitas & *Consent*

- Saat ini pasien tidak memiliki kapasitas adekuat
- Keputusan → *surrogate* (keluarga)
- Namun:
 - terdapat ***previous expressed wishes***
 - harus dipertimbangkan sebagai bagian *autonomy*

Prinsip:

- *substituted judgment* → apa yang diinginkan pasien
- *best interest* → jika preferensi tidak jelas

4) Analisis Prinsip Etik

Autonomy

- Tidak aktual (kapasitas terganggu)
- Namun ada *autonomy* sebelumnya (*prior expressed wishes*)

Beneficence

- Ventilator → meningkatkan peluang hidup

Non-maleficence

- Risiko:
 - *prolong suffering*
 - kualitas hidup rendah pasca ICU

Justice

- Tidak dominan, tetapi terkait penggunaan sumber daya ICU

5) Analisis Hukum

- Permenkes 290/2008:
 - pasien tidak kompeten → keluarga sebagai pengambil keputusan
- Namun:
 - preferensi pasien sebelumnya tetap relevan secara etik
- Tidak ada *advance directive* → posisi hukum lemah

6) Alternatif Tindakan

- a) *Full treatment (ventilator)*
- b) *Limited treatment (non-invasive / trial ICU)*
- c) *Palliative approach* (tanpa ventilator)

7) Keputusan Etik (*Gold Standard*)

- a) Pendekatan terbaik:

Shared decision-making dengan keluarga

Menyampaikan:

- kondisi klinis
- prognosis realistis
- kemungkinan kualitas hidup

Mengintegrasikan:

- nilai pasien sebelumnya
- kepentingan terbaik pasien

b) Keputusan yang paling etis:

Trial terapi terbatas (*time-limited trial*) dengan evaluasi berkala, ATAU pendekatan paliatif jika prognosis sangat buruk

Alasan:

- menghormati autonomy sebelumnya
- tidak langsung menolak *beneficence*
- menghindari *overtreatment*

8) Justifikasi

Keputusan ini:

- a) menyeimbangkan *autonomy + beneficence*
- b) mempertimbangkan kapasitas yang tidak adekuat
- c) menghindari tindakan yang berpotensi futile
- d) sesuai pendekatan etik klinis deliberatif

9) Strategi Advokasi & Anti-Diskriminasi

Peran perawat:

- a) memastikan suara pasien (*previous wishes*) dipertimbangkan
- b) mencegah keputusan berbasis tekanan emosional keluarga
- c) memfasilitasi komunikasi tim

Anti-diskriminasi:

- a) tidak mendiskriminasi karena usia (*ageism*)
- b) tidak mengabaikan nilai pasien

6. CATATAN PENILAIAN (UNTUK DOSEN)

Jawaban dianggap **level tinggi (skor 4)** jika:

- a. mampu mengidentifikasi konflik utama (*autonomy vs beneficence*)
- b. memasukkan konsep:
 - kapasitas
 - *substituted judgment*
 - *best interest*
- c. memberikan keputusan tidak ekstrem (tidak hitam-putih)
- d. justifikasi berbasis prinsip, bukan opini

7. VARIASI KASUS (OPSIONAL UNTUK BANK SOAL)

Bisa dimodifikasi menjadi:

- a. anak leukemia menolak terapi
- b. pasien gangguan jiwa menolak obat
- c. pasien disabilitas tidak dilibatkan consent

E. Ringkasan

Bab ini membahas kompleksitas isu etik dalam praktik keperawatan pada populasi khusus, yaitu anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas, yang memiliki karakteristik kerentanan berbeda sehingga memerlukan pendekatan etik yang kontekstual. Penerapan prinsip bioetik, *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, tidak dapat dilakukan secara seragam, karena kapasitas pengambilan keputusan pada setiap kelompok bersifat dinamis: berkembang pada anak, menurun pada lansia, fluktuatif pada gangguan jiwa, serta terbatas namun tetap ada pada disabilitas. Oleh karena itu, pengambilan keputusan etik harus didasarkan pada analisis kapasitas, mekanisme persetujuan (consent/assent), serta perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kerangka analisis etik klinis yang sistematis dan deliberatif.

Lebih lanjut, bab ini menekankan bahwa dilema etik pada populasi khusus umumnya berpusat pada ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi dan kewajiban perlindungan, yang sering muncul dalam situasi seperti penolakan tindakan, perawatan akhir hayat, penggunaan restrain, konflik dengan keluarga, serta keterbatasan komunikasi. Selain aspek individual, isu etik juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti stigma, diskriminasi, dan ketidakadilan akses layanan kesehatan. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis sebagai advokat yang menjamin terpenuhinya hak, martabat, dan keadilan bagi pasien, serta sebagai fasilitator komunikasi dan pengambil keputusan etik yang profesional. Dengan demikian, praktik keperawatan tidak hanya menuntut kompetensi klinis, tetapi juga kompetensi etik dan hukum yang terintegrasi untuk memastikan pelayanan yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh populasi.

Redflag

Tabel 5. 1 Tabel Red Flag Isu Etik pada Populasi Khusus

Populasi	Red Flag (Tanda Peringatan Etik)
Anak	Tidak melibatkan anak dalam <i>assent</i> padahal sudah mampu memahami; keputusan sepenuhnya diambil orang tua tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak; menyembunyikan informasi penting tanpa alasan etik yang jelas.
Lansia	Menganggap semua lansia tidak kompeten tanpa asesmen kapasitas; melakukan tindakan tanpa <i>informed consent</i> yang valid; memberikan terapi agresif tanpa mempertimbangkan kualitas hidup (<i>futile treatment</i>).
Gangguan Jiwa	Menganggap pasien tidak kompeten hanya berdasarkan diagnosis; penggunaan restrain atau perawatan paksa tanpa indikasi jelas; mengabaikan risiko bunuh diri atau membahayakan orang lain.
Disabilitas	Tidak melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan; kegagalan komunikasi yang dianggap sebagai ketidakmampuan pasien; diskriminasi layanan atau pembatasan hak tanpa dasar yang sah.

Referensi

- (RSCP), R. S. C. P. (2020). Multi-Agency Guide for Professionals - Gillick Competency and Fraser Guidelines: Capacity and consent of children.
- Alodhialah, A. M., Almutairi, A. A., & Almutairi, M. (2024). Ethical and Legal Challenges in Caring for Older Adults with Multimorbidities: Best Practices for Nurses. *Healthcare (Switzerland)*, 12(16), 1–17. <http://doi.org/10.3390/healthcare12161585>
- ANA Center for Ethics and Human Rights. (2019). Nurse's Role in Providing Ethically and Developmentally Appropriate Care to People with Intellectual and Developmental Disabilities Statement of ANA Position. Retrieved from www.nursingworld.org
- Ayati, A., Payab, M., Shadman, Z., Shojaei, A., Asadi, M., Sharifi, F., ... Larijani, B. (2024). Ethics and healthcare in the older adult population. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 17(2), 1–17. <http://doi.org/10.18502/jmehm.v17i12.18664>
- Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *American Journal of Bioethics*, 19(11), 9–12. <http://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>
- Bertino, J. T. (2021). *Clinical Ethics for Consultation Practice*. Springer. <http://doi.org/10.1007/978-3-030-90182-0>
- CIOMS-WHO. (2016). *Pedoman Etik Internasional Penelitian kesehatan yang melibatkan manusia*. CIOMS - WHO 2016.
- Cornish, J. A. E., & Monson, S. P. (2018). Ethical issues in working with individuals with disability. In *The Cambridge Handbook of Applied Psychological Ethics* (pp. 285–301). <http://doi.org/10.1017/9781316417287.015>
- El Ali, M., O'Neill, J., & Gillam, L. (2025). How paediatric nurses frame the ethics of non-disclosure directives. *Nursing Ethics*, 32(8), 2639–2655. <http://doi.org/10.1177/09697330251350383>
- Elmadani, M., Simon, K., Mustafa, M., Limungi, G. M., Kiptulon, E. K., Besbes, M., ... Mate, O. (2025). Ethical dimensions in nursing care for individuals with intellectual disabilities. *Nursing Ethics*, 33(1), 156–176. <http://doi.org/10.1177/09697330251366607>
- ICN. (2021). *THE ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES International Council of Nurses. Code of Ethics for Nurses*. Retrieved from https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-06/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web.pdf
- Kemenkes-RI. (2021). *Pedoman dan Standar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan*

- Knauss, L. K. (2019). Ethical and Professional Issues in Assessment. *The Cambridge Handbook of Clinical Assessment and Diagnosis*, 2, 38–48. <http://doi.org/10.1017/9781108235433.004>
- Manoharam, B, P. (2022). Ethical and Legal Issues in Paediatric Nursing. *International Journal of Nursing Education and Research*, 10(1), 80–84. <http://doi.org/10.52711/2454-2660.2022.00018>
- Mate, O., Simon, K., & Elmadani, M. (2025). Ethical and legal challenges in nursing care for individuals with intellectual disabilities. *Kontakt*, 27(1), 1–2. <http://doi.org/10.32725/kont.2025.010>
- McNee, P. (2021). Ethical Issues. In *Nursing Care of Children and Young People with Long-Term Conditions* (pp. 145–170).
- Mueller, paul s, Hook, christopher c, & Fleming, kevin c. (2004). Ethical Issues in Geriatrics: A Guide for Clinicians. *Mayo Foundation for Medical Education and Research*, 79, 554–562.
- NSPCC. Gillick competency and Fraser guidelines Balancing children's rights with the responsibility to keep them safe from harm (2018). Retrieved from <https://dx.doi.org/10.1080/09649068708412165%0Afile:///C:/Users/Jasmine/AppData/Local/Temp/gillick-competency-factsheet.pdf>
- Rich, K. L. (2023). *Infant and Child Nursing Ethics*. Jones & Bartlett Learning, LLC.
- Schildmann, J., Gordon, J., & Vollmann, J. (2010). Clinical Ethics Consultation Theories and Methods, implementation, evaluation. In *Ashgate Publishing Company*.
- Takala, T. (2001). What is wrong with global bioethics? On the limitations of the four principles approach. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 10(1), 72–77. <http://doi.org/10.1017/S0963180101001098>
- Teeri, S., Leino-Kilpi, H., & Valimäki, M. (2006). LONG-TERM NURSING CARE OF ELDERLY PEOPLE: IDENTIFYING ETHICALLY PROBLEMATIC EXPERIENCES AMONG PATIENTS, RELATIVES AND NURSES IN FINLAND. *Nursing Ethics*, 13(2), 28–38. <http://doi.org/10.1191/0969733006ne830oa>
- UNICEF. Convention on the Rights of the Child- The childrens version, Committee on the Rights of the Child. 1–4 (2019). Retrieved from <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- United Nations General Assembly. (2002). Convention on the Rights of the Child. *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28.

<http://doi.org/10.1159/000509119>

Vaughn, L. (2023). *Bioethics Principles, issues and cases-Fifth edition*. Oxford University press.

Yeo, M., Moorhouse, A., Khan, P., & Rodney, P. (2020). *Concepts and Cases in Nursing Ethics*. Broadview press.

Zendehtalab, H., Vanaki, Z., & Memarian, R. (2023). Ethical challenges in caring for healthy older adults: Qualitative perspectives. *Nursing Ethics*, 30(4), 542–555. <http://doi.org/10.1177/09697330221081953>

BAB 6

ETIK PENELITIAN KEPERAWATAN DAN PERLINDUNGAN SUBJEK PENELITIAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Etik Penelitian Keperawatan dan Perlindungan Subjek Penelitian	6.1 Mengidentifikasi risiko penelitian dan langkah perlindungan subjek (kerahasiaan, minimisasi risiko).	6.2 Menilai kelayakan etik protokol sederhana (persetujuan, kerentanan, manfaat–risiko).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-3

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario
CPMK-4	Tugas audit privasi & etika digital (worksheet)	Skor identifikasi titik risiko kebocoran data dan kelengkapan kontrol akses/mitigasi yang operasional.	10	Worksheet audit; rencana mitigasi
CPMK-7	Proyek studi kasus + etik penelitian (review protokol)	Skor kualitas rekomendasi kasus (argumentasi, opsi, tindak lanjut) dan kepatuhan komponen perlindungan subjek (rubrik).	15	Laporan proyek; lembar review etik

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. Pendahuluan

Etik penelitian keperawatan merupakan bagian integral dari praktik profesional yang bertujuan memastikan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga melindungi martabat, hak, dan kesejahteraan subjek penelitian. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penelitian sering melibatkan

manusia sebagai partisipan sehingga berpotensi menimbulkan risiko etik dan hukum apabila tidak dikelola secara tepat (Kemenkes-RI, 2021).

Perawat sebagai peneliti memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin bahwa setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga publikasi, dilakukan sesuai prinsip etik dan regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan standar profesional yang menekankan akuntabilitas, integritas, dan perlindungan terhadap individu yang menerima layanan atau terlibat dalam penelitian (ICN, 2021).

Selain itu, meningkatnya kompleksitas penelitian kesehatan, termasuk penggunaan teknologi digital dan data kesehatan, memperluas potensi risiko etik seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pemahaman etik penelitian menjadi kompetensi esensial bagi perawat dalam menghasilkan praktik berbasis bukti yang aman dan bertanggung jawab (Kemenkes-RI, 2021).

B. Landasan Filosofis dan Teori Etik Penelitian

Etik penelitian keperawatan berakar pada teori moral utama seperti deontologi dan utilitarianisme. Deontologi menekankan kewajiban moral dan penghormatan terhadap hak individu, sedangkan utilitarianisme berfokus pada konsekuensi dan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (Vaughn, 2023).

Selain itu, pendekatan *principlism* yang terdiri dari prinsip *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, menjadi kerangka yang paling banyak digunakan dalam bioetika modern. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam pengambilan keputusan etik (Varkey, 2021).

Autonomy menekankan hak individu untuk membuat keputusan sendiri, yang menjadi dasar *informed consent*. *Beneficence* mengharuskan peneliti memberikan manfaat maksimal, sedangkan *non-maleficence* menuntut untuk menghindari atau meminimalkan risiko. *Justice* berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban penelitian secara adil (Varkey, 2021). Namun, pendekatan empat prinsip ini tidak selalu universal dan dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan global. Kritik terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapannya perlu disesuaikan dengan nilai lokal dan kondisi masyarakat (Takala, 2001).

Selain pendekatan *principlism*, landasan etik penelitian keperawatan juga diperkuat oleh pedoman internasional yang menjadi standar global, salah satunya adalah *Declaration of Helsinki*. Deklarasi ini menegaskan bahwa dalam penelitian yang melibatkan manusia, kesejahteraan, kesehatan, serta martabat subjek penelitian harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Deklarasi Helsinki juga menekankan bahwa penelitian

harus didasarkan pada prinsip ilmiah yang kuat, melalui kajian literatur yang memadai dan pertimbangan risiko–manfaat yang proporsional. Peneliti memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan, privasi, dan hak subjek penelitian sepanjang proses penelitian berlangsung (WMA-DECLARATION-HELSINKI, 2024).

Dengan demikian, dalam konteks penelitian keperawatan, prinsip-prinsip etik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terikat pada standar normatif global yang mengatur praktik penelitian secara universal.

C. Prinsip Etik Penelitian pada Subjek Manusia

Penelitian yang melibatkan manusia harus memenuhi prinsip etik yang menekankan penghormatan terhadap individu, perlindungan dari bahaya, dan keadilan dalam distribusi manfaat. Pedoman internasional seperti CIOMS menegaskan bahwa penelitian harus memiliki nilai ilmiah dan sosial yang jelas sebagai dasar justifikasi etik (CIOMS-WHO, 2016). Selain itu, keseimbangan antara risiko dan manfaat menjadi pertimbangan utama. Penelitian tidak boleh dilakukan apabila risiko yang ditimbulkan melebihi manfaat yang diharapkan, baik bagi individu maupun masyarakat (CIOMS-WHO, 2016). Kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, dan individu dengan keterbatasan kapasitas pengambilan keputusan memerlukan perlindungan tambahan. Hal ini mencakup mekanisme persetujuan khusus dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah eksploitasi (CIOMS-WHO, 2016).

Selain pedoman CIOMS, prinsip etik penelitian juga diperkuat oleh *Declaration of Helsinki* yang menegaskan bahwa kesejahteraan subjek penelitian harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Prinsip ini menempatkan perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, privasi, dan martabat manusia sebagai tanggung jawab utama peneliti (WMA-DECLARATION-HELSINKI, 2024).

Deklarasi ini juga menekankan bahwa penelitian harus didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat dan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang proporsional terhadap manfaat yang diharapkan. Selain itu, kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus karena memiliki risiko lebih besar untuk mengalami eksploitasi dalam penelitian (WMA-DECLARATION-HELSINKI, 2024).

D. *Informed Consent* dalam Penelitian Keperawatan

Informed consent merupakan proses komunikasi yang memastikan bahwa partisipan memahami tujuan, prosedur, risiko, manfaat, serta hak mereka sebelum

menyetujui keterlibatan dalam penelitian. Prinsip ini berakar pada *autonomy* yang menekankan kebebasan individu dalam membuat keputusan (Varkey, 2021).

Komponen utama *informed consent* meliputi pemberian informasi yang memadai, pemahaman oleh partisipan, dan persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu, partisipan memiliki hak untuk menolak atau menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif (Vaughn, 2023).

Pada kelompok rentan, persetujuan dapat melibatkan wali atau perwakilan hukum, namun tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik subjek penelitian. Dalam praktiknya, *informed consent* bukan hanya dokumen administratif, tetapi proses etis yang berkelanjutan (CIOMS-WHO, 2016).

E. Perlindungan Privasi, Kerahasiaan, dan Keamanan Data

Privasi dan kerahasiaan merupakan aspek penting dalam etik penelitian, terutama dalam era digital. Data kesehatan termasuk informasi sensitif yang harus dilindungi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan (Kemenkes-RI, 2021). Kerahasiaan mengharuskan peneliti menjaga identitas dan informasi partisipan, sedangkan privasi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Kedua konsep ini merupakan turunan dari prinsip *autonomy* dan *dignity* (Vaughn, 2023).

CIOMS juga menekankan pentingnya pengelolaan data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data secara etis, terutama dalam penelitian berbasis *digital* dan *big data* (CIOMS-WHO, 2016). Perkembangan teknologi digital, khususnya *artificial intelligence* (AI), telah mengubah lanskap penelitian kesehatan, termasuk penelitian keperawatan. AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, namun sekaligus menghadirkan tantangan etik baru yang tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka etik konvensional (Yu, Lee, & Hwang, 2024).

Sistem AI sering kali mengandalkan data kesehatan dalam jumlah besar, yang meningkatkan risiko kebocoran informasi sensitif serta penyalahgunaan data jika tidak diatur secara ketat. Selain itu, penggunaan data sekunder tanpa persetujuan yang jelas dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *autonomy* (Farhud & Zokaei, 2021).

AI juga berpotensi menimbulkan bias algoritma, terutama jika data yang digunakan tidak merepresentasikan populasi secara adil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hasil penelitian maupun dalam pengambilan keputusan klinis berbasis teknologi (Yuliana, 2025).

Lebih lanjut, kompleksitas sistem AI yang sering bersifat “*black box*” menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Peneliti dan praktisi kesehatan mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana keputusan dihasilkan oleh sistem tersebut, sehingga dapat memengaruhi kualitas *informed consent* dan tanggung jawab profesional (Yu et al., 2024).

WHO menegaskan bahwa penggunaan AI dalam kesehatan harus berlandaskan prinsip etik seperti transparansi, keadilan, keselamatan, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa teknologi tidak memperburuk kesenjangan kesehatan yang sudah ada. Sejalan dengan itu, UNESCO menekankan bahwa pengembangan AI harus berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi dan ketimpangan sosial (UNESCO, 2022).

Dengan demikian, integrasi AI dalam penelitian keperawatan menuntut pendekatan etik yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas.

F. Komite Etik Penelitian dan Ethical Clearance

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) berperan dalam menilai kelayakan etik suatu penelitian sebelum dilaksanakan. Proses ini dikenal sebagai *ethical clearance* dan merupakan persyaratan wajib dalam penelitian yang melibatkan manusia (Kemenkes-RI, 2021).

Penilaian etik mencakup evaluasi risiko–manfaat, perlindungan subjek, metode penelitian, serta kepatuhan terhadap prinsip etik dan regulasi. Review dapat dilakukan melalui mekanisme *full board*, *expedited*, atau *exempted* tergantung tingkat risiko penelitian (Kemenkes-RI, 2021).

Keberadaan komite etik memastikan adanya pengawasan independen dan mencegah potensi pelanggaran etik. Peneliti tetap bertanggung jawab untuk mematuhi persetujuan etik selama penelitian berlangsung (Kemenkes-RI, 2021).

G. Isu Etik dan Hukum dalam Penelitian Keperawatan

Beberapa pelanggaran etik dalam penelitian meliputi *plagiarisme*, fabrikasi data, dan manipulasi hasil penelitian. Praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat berdampak hukum dan merusak integritas ilmiah (Kemenkes-RI, 2021).

Konflik kepentingan juga menjadi isu penting, terutama ketika peneliti memiliki hubungan dengan sponsor atau pihak yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Transparansi menjadi kunci dalam menjaga objektivitas (CIOMS-WHO, 2016).

Eksplorasi subjek penelitian, terutama pada kelompok rentan, merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip justice dan beneficence. Oleh karena itu, pemilihan subjek harus adil dan tidak diskriminatif (CIOMS-WHO, 2016).

Salah satu contoh pelanggaran etik paling signifikan dalam sejarah penelitian kesehatan adalah *Tuskegee Syphilis Study*, di mana partisipan tidak diberikan pengobatan yang seharusnya tersedia. Studi ini menunjukkan kegagalan serius dalam prinsip *informed consent*, *beneficence*, dan *justice* (Ogungbure, 2011).

Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman eksploitasi tersebut memicu trauma historis dan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan, yang masih memengaruhi perilaku masyarakat hingga saat ini (Dolan & Bell, 2024).

Selain itu, upaya pembenaran terhadap penelitian tidak etis seperti dalam kasus Tuskegee menunjukkan bagaimana rasionalisasi moral dapat menutupi pelanggaran etik, bahkan dalam komunitas ilmiah. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan etik yang ketat dan independen dalam penelitian kesehatan (Paul & Brookes, 2015).

H. Analisis Kasus Etik Penelitian

Analisis kasus merupakan pendekatan penting dalam pembelajaran etik, karena membantu mengidentifikasi konflik nilai dan prinsip yang terjadi dalam praktik nyata. Pendekatan ini memungkinkan penerapan teori etik dalam konteks klinis dan penelitian (Yeo, Moorhouse, Khan, & Rodney, 2020).

1. Model analisis etik

Model analisis etik biasanya melibatkan:

- a. Identifikasi masalah etik
- b. Analisis prinsip yang terlibat
- c. Evaluasi alternatif tindakan
- d. Penentuan keputusan dan justifikasi

Pendekatan sistematis ini membantu menghasilkan rekomendasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

2. Studi Kasus: *Tuskegee Syphilis Study* sebagai Pelanggaran Etik Penelitian

Salah satu kasus paling terkenal dalam pelanggaran etik penelitian adalah *Tuskegee Syphilis Study*, yang berlangsung selama beberapa dekade di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, partisipan tidak diberikan pengobatan yang efektif meskipun terapi sudah tersedia, sehingga melanggar prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* secara serius (Ogungbure, 2011).

Selain itu, partisipan tidak diberikan informasi yang memadai mengenai kondisi mereka maupun tujuan penelitian, sehingga prinsip *informed consent* dan *autonomy* tidak terpenuhi. Pemilihan subjek yang berasal dari kelompok rentan juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *justice* (Ogungbure, 2011).

Dampak dari penelitian ini tidak berhenti pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan trauma historis dan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan, yang masih dirasakan oleh generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik dalam penelitian dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat (Dolan & Bell, 2024).

Lebih lanjut, adanya upaya pembenaran terhadap penelitian tersebut menunjukkan bagaimana rasionalisasi dapat digunakan untuk menutupi pelanggaran etik, sehingga menekankan pentingnya sistem pengawasan etik yang independen dan kuat dalam penelitian kesehatan (Paul & Brookes, 2015).

I. Implikasi Praktik dan Pengambilan Keputusan Etik

Pengambilan keputusan etik dalam penelitian memerlukan integrasi antara prinsip etik, regulasi hukum, dan konteks klinis. Konflik antar prinsip, seperti antara *autonomy* dan *beneficence*, sering terjadi dan membutuhkan pertimbangan yang matang (Varkey, 2021).

Model pengambilan keputusan etik berbasis langkah sistematis dapat membantu perawat dalam menghadapi dilema kompleks. Selain itu, perawat memiliki peran sebagai advokat untuk melindungi hak subjek penelitian dan memastikan praktik yang etis.

Dalam konteks penelitian modern, integrasi teknologi seperti AI menuntut penguatan tata kelola etik dan regulasi. Tata kelola ini harus mencakup perlindungan data, transparansi algoritma, serta mekanisme akuntabilitas untuk mencegah kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi (WHO, 2024).

Pendekatan *governance* yang efektif harus mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak individu. Hal ini mencakup penerapan regulasi yang adaptif, pengawasan berbasis risiko, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia (WHO, 2024).

J. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus

Penelitian yang melibatkan kelompok khusus memerlukan perlindungan etik tambahan karena adanya keterbatasan kapasitas, ketergantungan, atau risiko eksploitasi. Pedoman internasional menekankan bahwa kelompok ini tidak boleh dilibatkan kecuali penelitian tersebut relevan dengan kebutuhan mereka dan tidak dapat dilakukan pada populasi lain (CIOMS-WHO, 2016). Beberapa kelompok khusus akan dibahas penyelesaian etik penelitian satu persatu di bawah ini.

1. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus Anak

Penelitian pada anak menghadirkan dilema antara kebutuhan pengembangan ilmu dan perlindungan terhadap individu yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Anak belum mampu memberikan *informed consent* secara mandiri, sehingga persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, disertai dengan **assent** dari anak sesuai tingkat perkembangan kognitifnya (CIOMS-WHO, 2016).

Penelitian pada anak secara etik dikategorikan sebagai penelitian pada kelompok rentan karena keterbatasan kapasitas pengambilan keputusan, ketergantungan pada pihak lain, serta posisi sosial yang relatif subordinat. Kerentanan ini bukan hanya bersifat biologis, tetapi juga sosial dan relasional, di mana anak berada dalam struktur otoritas orang tua dan tenaga kesehatan sehingga potensi eksploitasi menjadi lebih tinggi (Podany, 2017).

Pendekatan etik pada penelitian anak tidak dapat dilepaskan dari pedoman **CIOMS (2016)** yang secara eksplisit memberikan kerangka operasional dalam pengambilan keputusan etik pada kelompok rentan. CIOMS menegaskan bahwa anak hanya boleh dilibatkan dalam penelitian apabila memenuhi dua syarat utama:

- 1) penelitian tersebut tidak dapat dilakukan pada populasi yang mampu memberikan *consent* penuh, dan
- 2) penelitian tersebut memiliki nilai sosial dan relevansi langsung terhadap kebutuhan kesehatan anak.

Dengan demikian, keterlibatan anak bukan sekadar diperbolehkan, tetapi harus dijustifikasi secara etik, bukan karena kemudahan akses atau alasan praktis.

a. Isu dan fenomena etik yang sering terjadi

Salah satu isu utama dalam penelitian pada anak adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan penelitian dan perlindungan subjek. Di satu sisi, penelitian pada anak sangat penting karena anak bukan “miniatur orang dewasa” dan memiliki karakteristik fisiologis serta respons terapi yang berbeda, sehingga data dari populasi dewasa tidak selalu dapat digeneralisasi

(Mcintosh, 2002). Namun di sisi lain, keterbatasan kapasitas anak membuat mereka sangat bergantung pada keputusan orang lain.

Fenomena yang sering terjadi adalah adanya **“silent dissent”**, yaitu ketika anak sebenarnya tidak setuju tetapi tidak mampu menolak karena takut terhadap otoritas orang tua atau tenaga kesehatan. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa anak sering menyembunyikan ketidaknyamanan agar tidak mengecewakan pihak berwenang (Podany, 2017).

Selain itu, terdapat fenomena **therapeutic misconception**, di mana orang tua atau anak menganggap bahwa penelitian pasti memberikan manfaat langsung, padahal tidak semua penelitian bersifat terapeutik. Hal ini dapat menyebabkan persetujuan diberikan tanpa pemahaman yang utuh.

CIOMS melihat kerentanan anak bukan hanya karena usia, tetapi karena:

- 1) keterbatasan kapasitas kognitif
- 2) ketergantungan pada otoritas (orang tua/tenaga kesehatan)
- 3) ketidakmampuan menolak secara bebas

Kondisi ini menciptakan risiko eksploitasi tidak langsung, di mana anak dapat dilibatkan dalam penelitian tanpa benar-benar memiliki pilihan yang bebas. Hal ini memperkuat fenomena **“silent dissent”**, tetapi dalam kerangka CIOMS, hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *voluntariness* dalam *informed consent*.

b. Kesalahan umum dalam praktik penelitian pada anak

Kesalahan paling sering terjadi adalah menganggap bahwa persetujuan orang tua sudah cukup, tanpa melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, prinsip etik modern menegaskan pentingnya **assent anak** sebagai bentuk penghormatan terhadap *autonomy* yang berkembang (Mcintosh, 2002).

Kesalahan lain adalah penggunaan informasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penjelasan penelitian sering disampaikan dalam bahasa medis yang kompleks sehingga anak tidak memahami apa yang akan dialami. Hal ini bertentangan dengan prinsip *respect for persons* dalam (HHS, 1979).

Selain itu, penelitian pada anak sering kali mengadopsi desain penelitian dewasa tanpa modifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko karena tidak mempertimbangkan kondisi biologis dan psikologis anak (Blake, 2023).

Dalam beberapa kasus, terdapat juga konflik kepentingan antara orang tua dan anak. Sejarah menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, orang tua

dapat menyetujui partisipasi anak demi keuntungan tertentu, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan terbaik anak (Podany, 2017).

CIOMS mengidentifikasi beberapa praktik yang sering keliru dalam penelitian anak:

- 1) Over-reliance pada parental consent
→ Menganggap izin orang tua cukup tanpa mempertimbangkan kehendak anak
- 2) Failure to assess risk properly
→ Tidak membedakan antara minimal risk dan more-than-minimal risk
- 3) Inclusion without necessity
→ Anak dilibatkan padahal penelitian bisa dilakukan pada orang dewasa
- 4) Therapeutic misconception tidak dikoreksi
→ Orang tua mengira semua penelitian pasti bermanfaat langsung

Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada prosedur administratif, tetapi pada kegagalan memahami prinsip etik secara substantif.

c. Prinsip perlindungan etik pada anak dalam penelitian

Perlindungan utama dalam penelitian pada anak adalah penerapan **dual consent**, yaitu persetujuan dari orang tua/wali dan assent dari anak. *Assent* bukan sekadar formalitas, tetapi proses aktif yang memastikan anak memahami dan menyetujui partisipasi sesuai kapasitasnya (Mcintosh, 2002).

Selain itu, prinsip **minimal risk** harus menjadi standar utama. Penelitian yang tidak memberikan manfaat langsung hanya dapat dilakukan jika risiko yang ditimbulkan sangat kecil dan sebanding dengan kehidupan sehari-hari anak. Prinsip ini merupakan turunan dari *beneficence* dan *non-maleficence* dalam *Belmont Report* (HHS, 1979).

Peneliti juga harus memastikan bahwa informasi disampaikan dengan pendekatan yang sesuai perkembangan, misalnya menggunakan bahasa sederhana, visual, atau metode komunikasi interaktif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa *assent* benar-benar bermakna, bukan sekadar simbolis.

Selain itu, penolakan anak harus dihormati. Meskipun secara hukum orang tua memiliki otoritas, secara etik penolakan anak merupakan ekspresi *autonomy* yang harus dipertimbangkan secara serius. Mengabaikan penolakan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk *coercion* terselubung.

CIOMS menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui informed consent, tetapi harus mencakup:

- 1) Independent ethical review (KEPK)

- 2) Monitoring selama penelitian berlangsung
- 3) Penghentian penelitian jika risiko meningkat
- 4) Perlindungan khusus untuk kelompok sangat rentan (misalnya anak sakit berat, anak institusional)

Artinya, perlindungan bersifat sistemik, bukan hanya individual.

d. Pengambilan keputusan etik dalam penelitian anak

Pengambilan keputusan dalam penelitian anak harus berlandaskan prinsip *best interest of the child*, yaitu keputusan yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan anak, bukan semata-mata kepentingan ilmiah. Dalam praktiknya, keputusan etik harus mempertimbangkan tiga aspek utama:

- 1) Relevansi penelitian terhadap kebutuhan anak (tidak boleh eksploitasi populasi mudah)
- 2) Proporsionalitas risiko–manfaat
- 3) Partisipasi anak dalam proses keputusan sesuai kapasitasnya

WHO juga menekankan bahwa inklusi kelompok rentan dalam penelitian harus disertai dengan perlindungan tambahan dan justifikasi etik yang kuat, bukan sekadar karena kemudahan akses terhadap populasi tersebut (WHO, 2025). Masalah utama dalam etik penelitian anak bukan hanya pada “izin”, tetapi pada **ketegangan antara proteksi dan partisipasi**:

- 1) Terlalu protektif → anak tidak mendapatkan manfaat penelitian
- 2) Terlalu permisif → anak berisiko dieksploitasi

Karena itu, pendekatan etik modern bergeser dari “melindungi anak dari penelitian” menjadi “melibatkan anak secara aman dan bermakna dalam penelitian”.

CIOMS memberikan kerangka operasional dalam menentukan, apakah penelitian pada anak dapat dilakukan atau tidak, melalui tiga lapisan evaluasi:

- 1) Justifikasi inklusi anak, yaitu:
 - a) Apakah penelitian relevan untuk kondisi anak?
 - b) Apakah tidak bisa dilakukan pada orang dewasa?

Jika tidak terpenuhi → tidak etis melibatkan anak

2) Klasifikasi risiko penelitian

CIOMS membagi menjadi:

- a) Minimal risk → risiko setara aktivitas sehari-hari
- b) Minor increase over minimal risk
- c) More than minimal risk dengan potensi manfaat langsung

Implikasinya adalah:

- a) Tanpa manfaat langsung → hanya boleh sampai minimal risk
- b) Risiko lebih tinggi → harus ada manfaat langsung bagi anak

3) Mekanisme *consent* dan *assent*

- a) Wajib *parental consent*
- b) Wajib *assent* jika anak mampu
- c) Penolakan anak harus dihormati

CIOMS menekankan bahwa *assent* adalah **proses kontinu**, bukan satu kali tanda tangan. Dalam konteks CIOMS, prinsip *best interest of the child* tidak boleh diartikan secara sempit sebagai keputusan orang tua, tetapi harus mempertimbangkan:

- a) perspektif anak (*assent/dissent*)
- b) penilaian profesional (tenaga kesehatan/peneliti)
- c) standar etik global

Dengan demikian, keputusan etik adalah hasil **triangulasi** antara: Orang tua, Anak dan Sistem etik (komite etik + regulasi).

2. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus Lansia

Penelitian pada lansia merupakan area yang semakin penting seiring dengan meningkatnya populasi *aging society* dan prevalensi penyakit kronis serta gangguan kognitif seperti demensia. Namun, kelompok lansia memiliki karakteristik etik yang khas, terutama terkait kapasitas pengambilan keputusan yang fluktuatif, komorbiditas, serta ketergantungan sosial dan medis. Hal ini menjadikan lansia sebagai kelompok rentan yang memerlukan pendekatan etik yang lebih kompleks dibandingkan populasi umum.

Dalam pedoman **CIOMS (2016)**, lansia tidak selalu disebut sebagai kategori tersendiri, tetapi secara substantif masuk dalam kelompok "*persons with impaired capacity to consent*", terutama pada kondisi seperti demensia, delirium, atau gangguan kognitif lainnya. Fokus CIOMS bukan pada usia, tetapi pada kapasitas pengambilan keputusan.

a. Isu dan fenomena etik pada lansia

Isu utama dalam penelitian lansia terletak pada penurunan kapasitas kognitif yang tidak selalu bersifat absolut, tetapi spektral dan dinamis. Banyak lansia masih mampu mengambil keputusan dalam kondisi tertentu, tetapi mengalami kesulitan dalam situasi kompleks atau ketika informasi terlalu abstrak.

Dalam konteks demensia, misalnya, kapasitas untuk memahami dan mengevaluasi informasi sering menurun seiring progresivitas penyakit. Hal ini menimbulkan dilema etik: apakah individu masih dapat memberikan *informed consent* yang valid atau tidak (Chandra, Harbishettar, Sawhney, & Amanullah, 2021).

CIOMS menegaskan bahwa individu dengan keterbatasan kapasitas (termasuk banyak lansia) tidak boleh secara otomatis dikecualikan, tetapi harus ada justifikasi ilmiah dan etik mengapa mereka dilibatkan dan penelitian harus relevan dengan kondisi mereka. Eksklusi lansia dari penelitian justru dianggap melanggar prinsip *justice*, karena mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari *evidence-based care*.

Fenomena lain adalah *overprotection*, di mana lansia sering secara otomatis dianggap tidak kompeten. Ini justru bertentangan dengan prinsip *autonomy* karena menghilangkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, fenomena *underprotection* juga terjadi, ketika lansia dianggap kompeten tanpa evaluasi yang memadai, sehingga berisiko terhadap eksploitasi.

Selain itu, terdapat fenomena *relational dependency*, yaitu ketergantungan lansia pada keluarga atau *caregiver*, yang dapat memengaruhi keputusan partisipasi dalam penelitian. Dalam kondisi tertentu, keputusan yang diambil bukan sepenuhnya mencerminkan kehendak lansia, melainkan hasil tekanan atau pengaruh lingkungan sosial.

b. Kesalahan umum dalam praktik penelitian pada lansia

Kesalahan paling mendasar adalah tidak melakukan *capacity assessment* secara sistematis, melainkan hanya berdasarkan asumsi klinis. Padahal, kapasitas bukan status tetap, tetapi harus dinilai secara spesifik terhadap keputusan tertentu (*decision-specific capacity*).

Dalam praktik klinis dan penelitian, *capacity assessment* mencakup empat kemampuan utama:

- 1) Memahami informasi
- 2) Mengapresiasi konsekuensi
- 3) Menalar (reasoning)
- 4) Mengkomunikasikan pilihan

Keempat komponen ini menjadi dasar dalam berbagai alat *capacity assessment* seperti yang dijelaskan dalam toolkit *capacity assessment* (Scott, 2008).

Kesalahan lain adalah mengabaikan kondisi fluktuatif, terutama pada pasien dengan demensia atau delirium. Dalam banyak kasus, penilaian kapasitas dilakukan hanya sekali, padahal kondisi kognitif dapat berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian sering tidak mempertimbangkan beban partisipasi (*burden*) pada lansia, seperti kelelahan, stres, atau kesulitan mobilitas, yang secara etik termasuk dalam aspek *non-maleficence*.

CIOMS menekankan bahwa, kapasitas harus dinilai *decision-specific*, bukan global. individu dapat kompeten untuk satu keputusan tetapi tidak untuk yang lain. Ini sangat relevan pada lansia dengan *mild cognitive impairment* dan *early dementia*. Artinya, tidak etis jika langsung menganggap lansia tidak kompeten, tanpa *assessment*.

Capacity assessment dalam konteks etik penelitian bukan sekadar kemampuan kognitif, tetapi kemampuan untuk, memahami informasi yang relevan, menilai konsekuensi keputusan dan membuat pilihan yang konsisten. Definisi ini menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap memiliki kapasitas meskipun memiliki gangguan kognitif ringan, selama empat komponen tersebut masih terpenuhi (Scott, 2008).

Namun, literatur menunjukkan bahwa proses *capacity assessment* sangat bervariasi dan belum terstandarisasi secara global, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan etik (Shanker, 2016). Dalam konteks klinis, alat seperti *MacArthur Competence Assessment Tool (MacCAT)* digunakan untuk meningkatkan objektivitas dalam menilai kapasitas, terutama pada kondisi seperti depresi atau gangguan neurokognitif (Wang et al., 2018).

c. Prinsip perlindungan etik pada lansia dalam penelitian

Perlindungan pada lansia harus berangkat dari prinsip *respect for persons* dalam *Belmont Report*, yang menekankan bahwa individu dengan kapasitas terbatas tetap harus dihormati dan dilibatkan sejauh mungkin dalam pengambilan keputusan (Department-of-Health-Education-and-Welfare, 1979).

Dalam praktiknya, hal ini diterjemahkan menjadi:

- 1) *Capacity assessment* wajib sebelum *consent*
- 2) *Supported decision-making* → membantu lansia memahami informasi, bukan langsung menggantikan keputusan
- 3) *Proxy consent (substitute decision-maker)* jika kapasitas tidak adekuat
- 4) Tetap melibatkan lansia dalam proses (assent-like participation)

Dalam penelitian demensia, pendekatan etik modern menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan dan inklusi, karena eksklusi lansia dari penelitian justru dapat menghambat pengembangan intervensi yang relevan bagi mereka (Chandra et al., 2021).

Dalam perlindungan etik, CIOMS menekankan bahwa pada individu tanpa kapasitas penuh, dapat berpartisipasi dalam penelitian dengan ketentuan:

- 1) Penelitian tanpa manfaat langsung → hanya boleh *minimal risk*

- 2) Penelitian dengan manfaat langsung → boleh lebih dari *minimal risk*, dengan justifikasi kuat.

CIOMS mengharuskan adanya, review etik yang lebih ketat, monitoring berkelanjutan dan mekanisme penghentian jika risiko meningkat. Ini sangat relevan pada lansia karena, kondisi dapat berubah cepat dan kapasitas dapat fluktuatif.

d. Pengambilan keputusan etik (*framework* praktis)

Pengambilan keputusan etik pada lansia harus mengikuti tahapan berikut:

- 1) Evaluasi kapasitas, dengan menggunakan pendekatan klinis disertai alat ukur yang tepat, dan bersifat *decision-specific*.
- 2) Jika kapasitas adekuat, Lansia memberikan *informed consent* penuh
- 3) Jika kapasitas parsial, gunakan *supported decision-making* dan libatkan lansia semaksimal mungkin dengan penyederhanaan informasi dan pengulangan penjelasan.
- 4) Jika tidak adekuat, gunakan *proxy decision-maker* dan terapkan prinsip *best interest* dengan tetap melibatkan individu.
- 5) Monitoring berkelanjutan (kapasitas harus dievaluasi ulang/tidak statis). Bahkan jika tidak kompeten, penolakan tetap harus dihormati.

Masalah etik utama pada lansia bukan hanya pada "boleh atau tidak ikut penelitian", tetapi pada bagaimana menjaga keseimbangan antara, melindungi dari risiko (*non-maleficence*) dan menghormati kemandirian (*autonomy*). Pendekatan yang terlalu protektif dapat menghilangkan hak lansia untuk berpartisipasi, sedangkan pendekatan yang terlalu permisif dapat meningkatkan risiko eksploitasi. Karena itu, pendekatan etik modern menekankan, "***autonomy is not lost, but transformed***" (lansia mungkin tidak sepenuhnya independen, tetapi tetap memiliki preferensi yang harus dihormati).

Etik penelitian pada lansia berpusat pada konsep kapasitas yang bersifat dinamis, kontekstual, dan dapat didukung. Oleh karena itu, perlindungan etik tidak boleh hanya berbasis status "kompeten vs tidak kompeten", tetapi harus mempertimbangkan spektrum kemampuan individu serta mekanisme dukungan yang tersedia. Pendekatan ini menandai pergeseran dari model *paternalistik* menuju model partisipatif berbasis dukungan (*supported autonomy*) dalam penelitian keperawatan.

3. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus Gangguan Jiwa (*Mental Health*)

Penelitian pada individu dengan gangguan jiwa merupakan salah satu area paling kompleks dalam etik penelitian, karena melibatkan kombinasi antara fluktuasi kapasitas, potensi *coercion*, serta bias struktural dalam praktik kesehatan

mental. CIOMS menempatkan kelompok ini dalam kategori *persons with impaired decision-making capacity*, tetapi dengan penekanan tambahan pada risiko eksploitasi dan tekanan terselubung.

a. Isu dan fenomena etik yang sering terjadi

Isu paling mendasar adalah fluktuasi kapasitas pengambilan keputusan, terutama pada kondisi seperti psikosis akut, depresi berat, atau mania. Kapasitas dalam kondisi ini tidak bersifat statis, melainkan berubah sesuai fase penyakit, sehingga *informed consent* tidak dapat dianggap valid secara permanen (Wang et al., 2018).

Fenomena kedua adalah *coercion*, baik dalam bentuk formal (*involuntary admission, restraint*) maupun informal (tekanan relasional, ketergantungan layanan). Praktik *coercive* ini masih menjadi bagian dari sistem kesehatan mental global dan sering dianggap sah secara klinis, tetapi tetap menimbulkan persoalan etik serius karena berpotensi melanggar hak asasi manusia (Sashidharan, Mezzina, & Puras, 2019).

Coercion menjadi isu paling khas dalam kelompok ini. Literatur menunjukkan bahwa praktik *coercive* dapat menimbulkan dampak psikologis negatif seperti kehilangan martabat, trauma, dan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan (Jin, Burbach, Greenshaw, & Winkler, 2023).

Secara etik, *coercion* hanya dapat dibenarkan jika:

- 1) ada risiko serius terhadap diri sendiri/orang lain
- 2) tidak ada alternatif lain
- 3) bersifat proporsional

Namun, bahkan dalam kondisi tersebut, *coercion* tetap dianggap problematik karena dapat melanggar prinsip *autonomy* dan *justice*, terutama jika dipengaruhi oleh bias struktural (Faissner & Braun, 2024). *Coercion* dalam kesehatan mental merupakan fenomena global yang masih melekat dalam praktik klinis, termasuk penggunaan *restrain*, isolasi, dan perawatan paksa (Sashidharan et al., 2019), meskipun secara etik, dapat dibenarkan dalam kondisi ekstrem (bahaya serius), tetapi tetap problematik karena melanggar *autonomy*.

Analisis terbaru menunjukkan bahwa bahkan ketika *coercion* dianggap proporsional, faktor seperti bias struktural (misalnya diskriminasi) dapat membuat praktik tersebut tetap tidak etis (Faissner & Braun, 2024), di mana individu dengan gangguan jiwa lebih sering dianggap tidak kompeten dibandingkan kondisi aktualnya. Bias ini dapat menyebabkan eksklusi tidak adil atau justru inklusi tanpa perlindungan memadai (Faissner & Braun, 2024).

b. Kesalahan umum dalam penelitian pada gangguan mental.

Kesalahan umum yang sering terjadi dalam penelitian pada individu dengan gangguan mental meliputi:

- 1) Tidak melakukan capacity assessment secara spesifik
→ Menggeneralisasi bahwa semua pasien gangguan jiwa tidak kompeten
- 2) Melakukan rekrutmen saat kondisi akut
→ Misalnya saat episode psikotik atau depresi berat
- 3) Mengabaikan coercion terselubung
→ Partisipasi terjadi karena ketergantungan pada layanan kesehatan
- 4) Tidak membedakan antara keputusan klinis dan penelitian
→ Pasien mengira penelitian adalah bagian dari terapi (therapeutic misconception)

Penelitian menunjukkan bahwa gejala psikiatri dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan individu dalam memahami dan mengevaluasi keputusan, sehingga tanpa asesmen yang tepat, consent menjadi tidak valid (Wang et al., 2018).

c. Prinsip perlindungan etik individu dengan gangguan jiwa dalam penelitian

Pada individu dengan gangguan mental, perlindungan tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi tidak bersifat eksploitatif. Prinsip "*best interest*" menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan (CIOMS-WHO, 2016). Pendekatan modern menekankan:

- 1) *Dynamic capacity assessment* (berulang)
- 2) *Trauma-informed care* untuk meminimalkan coercion
- 3) *Supported decision-making*
- 4) Pemisahan tegas antara peran klinisi dan peneliti

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa partisipasi benar-benar sukarela dan tidak dipengaruhi oleh ketergantungan pada layanan kesehatan.

d. Pengambilan keputusan etik (*framework* praktis)

CIOMS memberikan beberapa prinsip kunci:

- 1) *Capacity-based inclusion*, dimana individu hanya dapat memberikan *consent* jika memiliki kapasitas. Kapasitas harus dinilai secara *decision-specific* dan *time-specific*.
- 2) Jika kapasitas tidak adekuat, bisa menggunakan *legally authorized representative (proxy consent)*, namun tetap melibatkan individu (*assent/dissent*). Dalam hal ini, Penolakan tetap harus dihormati, bahkan jika secara hukum dapat diwakilkan.
- 3) Pertimbangan Risiko dan manfaat. Jika penelitian tanpa manfaat langsung
→ individu bisa berpartisipasi hanya minimal risk dalam penelitian. Jika

dengan manfaat langsung → risiko lebih tinggi diperbolehkan dengan justifikasi kuat

CIOMS menekankan bahwa kelompok dengan gangguan jiwa tidak boleh dijadikan “populasi mudah” untuk penelitian karena aksesnya lebih mudah atau karena mereka berada dalam institusi kesehatan. Masalah utama dalam etik penelitian gangguan jiwa bukan hanya kapasitas, tetapi legitimasi keputusan dalam kondisi ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pendekatan etik modern bergeser dari sekadar “*valid consent*” menuju “*authentic voluntariness*”.

4. Etika Penelitian pada Kelompok Khusus Penyandang Disabilitas.

Penelitian pada penyandang disabilitas mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan protektif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Kelompok ini tidak lagi dipandang semata sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam penelitian. CIOMS menekankan bahwa disabilitas tidak identik dengan ketidakmampuan mengambil keputusan, sehingga pendekatan etik harus berbasis kapasitas individual, bukan label diagnosis.

a. Isu dan fenomena etik

Isu utama adalah diskriminasi dan eksklusi sistemik, di mana penyandang disabilitas sering tidak dilibatkan dalam penelitian karena dianggap tidak mampu berpartisipasi. Hal ini justru melanggar prinsip *justice* karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari penelitian.

Fenomena lain adalah *barrier-based exclusion*, yaitu hambatan komunikasi, akses informasi, dan lingkungan yang tidak inklusif, yang membuat partisipasi menjadi sulit meskipun individu sebenarnya mampu. Dalam banyak kasus, keterbatasan bukan berasal dari individu, tetapi dari sistem yang tidak aksesibel. Selain itu, terdapat risiko *epistemic injustice*, di mana pengalaman penyandang disabilitas tidak dianggap valid sebagai sumber pengetahuan dalam penelitian.

b. Kesalahan umum dalam penelitian pada individu dengan disabilitas

Kesalahan umum dalam penelitian pada individu dengan disabilitas masih sering berakar pada asumsi yang keliru, yaitu menganggap bahwa semua bentuk disabilitas identik dengan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Akibatnya, peneliti cenderung mengabaikan kebutuhan aksesibilitas, seperti tidak menyediakan dukungan komunikasi yang memadai, termasuk penggunaan *interpreter* atau *augmentative and alternative communication* (AAC). Selain itu, penyandang disabilitas sering tidak dilibatkan dalam proses perancangan penelitian, sehingga perspektif mereka sebagai

subjek utama justru terpinggirkan. Pendekatan yang digunakan pun kerap bersifat paternalistik, di mana keputusan diambil atas nama “kepentingan terbaik”, tetapi tanpa partisipasi bermakna dari individu yang bersangkutan. Praktik-praktik ini secara jelas bertentangan dengan prinsip inklusi dan keadilan dalam penelitian.

Pedoman CIOMS menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh secara otomatis dianggap tidak mampu memberikan persetujuan. Sebaliknya, kapasitas harus dinilai secara individual dan kontekstual, serta didukung dengan penyediaan *reasonable accommodation* untuk memungkinkan partisipasi yang setara. Dalam banyak kasus, hambatan yang muncul bukan berasal dari keterbatasan individu, melainkan dari lingkungan yang tidak aksesibel, baik secara komunikasi, sistem, maupun desain penelitian itu sendiri.

Sejalan dengan itu, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu dengan hambatan lingkungan, sehingga tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan tersebut berada pada sistem sosial, termasuk dalam konteks penelitian. Konvensi ini juga menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri, serta berhak memperoleh dukungan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan (United Nations General Assembly, 2002).

Dengan demikian, pendekatan etik dalam penelitian harus bergeser dari model substitusi keputusan menuju pendekatan *supported decision-making*, di mana individu tetap menjadi pusat pengambilan keputusan, sementara sistem menyediakan dukungan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara optimal dan bermakna

c. Prinsip Perlindungan etik individu dengan disabilitas dalam penelitian

Pendekatan etik yang tepat meliputi:

- 1) *Accessible informed consent* (format visual, audio, bahasa sederhana)
- 2) *Reasonable accommodation*
- 3) *Co-production* → melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra penelitian

Pendekatan ini meningkatkan validitas etik sekaligus kualitas penelitian karena pengalaman *lived experience* menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah.

d. Pengambilan Keputusan etik dalam penelitian pasien disabilitas

Pengambilan keputusan dalam penelitian pada penyandang disabilitas berlandaskan pada prinsip bahwa disabilitas tidak identik dengan ketidakmampuan mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan etik tidak boleh berbasis asumsi, tetapi harus didasarkan pada penilaian kapasitas

individual serta dukungan yang tersedia. Prinsip ini sejalan dengan pedoman CIOMS yang menekankan bahwa kapasitas harus dinilai secara spesifik terhadap keputusan, serta dengan pendekatan berbasis hak dalam CRPD yang menegaskan hak individu untuk membuat keputusan sendiri dengan dukungan yang sesuai (CIOMS-WHO, 2016).

Pendekatan pengambilan keputusan pada penyandang disabilitas bertumpu pada tiga prinsip utama:

- 1) *Autonomy* yang didukung (*supported autonomy*)
→ individu tetap menjadi pengambil keputusan utama
- 2) *Individual capacity assessment*
→ kapasitas tidak boleh ditentukan berdasarkan label disabilitas
- 3) *Non-discrimination*
→ tidak boleh ada penolakan partisipasi hanya karena disabilitas

Pendekatan ini menandai pergeseran dari model paternalistik menuju model partisipatif berbasis hak.

Kerangka pengambilan Keputusan etik yang ditawarkan CIOMS, diantaranya;

- 1) Jika individu memiliki kapasitas penuh
→ Memberikan *informed consent* secara mandiri
- 2) Jika kapasitas parsial
→ Gunakan *supported decision-making*, meliputi:
 - a) penyederhanaan informasi
 - b) penggunaan media visual/audio
 - c) bantuan komunikasi (AAC, interpreter)Tujuan: meningkatkan pemahaman tanpa menggantikan keputusan
- 3) Jika kapasitas tidak adekuat
→ Gunakan *legally authorized representative (proxy consent)*

Namun:

- a) individu tetap harus dilibatkan sejauh mungkin
- b) ekspresi penolakan (*dissent*) tetap harus dihormati

Catatan CIOMS: perlindungan tidak boleh menghilangkan partisipasi.

- 4) *Supported decision-making* sebagai pendekatan utama

CRPD menekankan bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dalam pengambilan keputusan, bukan digantikan keputusannya (United Nations General Assembly, 2002). Dalam konteks penelitian, *supported decision-making* dapat berupa:

- a) pendampingan oleh keluarga atau fasilitator
- b) penggunaan alat bantu komunikasi

c) pengulangan dan klarifikasi informasi

Pendekatan ini dianggap lebih etis dibandingkan *substituted decision-making*, karena tetap mempertahankan *agency* individu. Terjadi perubahan paradigma utama dari "*protecting vulnerable subjects*" menjadi "*enabling equal participation*". Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya melindungi, tetapi memastikan bahwa penelitian tidak memperkuat eksklusi sosial yang sudah ada.

Keempat kelompok (anak, lansia, gangguan jiwa, disabilitas) menunjukkan bahwa etik penelitian tidak dapat menggunakan pendekatan universal. Setiap kelompok memiliki bentuk kerentanan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan yang spesifik, berbasis kapasitas, konteks, dan hak individu.

K. Profesionalisme dan Akuntabilitas Peneliti Keperawatan

Kode etik profesi perawat menekankan tanggung jawab terhadap pasien, masyarakat, dan profesi, termasuk dalam konteks penelitian. Perawat harus menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap aktivitas ilmiah (ICN, 2021).

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap hasil penelitian, termasuk pelaporan yang jujur dan tidak menyesatkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi keperawatan (ICN, 2021).

Asesmen

1. ASESMEN CPMK 7 (UTAMA)

Proyek Studi Kasus + Review Protokol Etik Penelitian

a. Deskripsi Tugas

Mahasiswa menganalisis satu kasus etik penelitian keperawatan (nyata/hipotetik) dan melakukan **review protokol penelitian** yang disediakan/dibuat sendiri, mencakup aspek perlindungan subjek penelitian.

b. Instrumen Penilaian (Rubrik)

Komponen	Indikator Terukur	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Identifikasi masalah etik	Ketepatan mengidentifikasi konflik etik-hukum	Tidak tepat	Sebagian	Tepat	Sangat komprehensif
Analisis prinsip etik	Penggunaan autonomy, beneficence, dll	Tidak ada	Terbatas	Cukup tepat	Mendalam & kritis
Argumentasi	Logika & dasar ilmiah	Lemah	Kurang kuat	Cukup	Sangat kuat & berbasis eviden
Alternatif solusi	Jumlah & relevansi opsi	Tidak ada	1 opsi	≥2 opsi	Variatif & realistis
Rekomendasi akhir	Kejelasan keputusan	Tidak jelas	Kurang tepat	Tepat	Sangat tepat & aplikatif
Tindak lanjut	Rencana implementasi	Tidak ada	Umum	Spesifik	Operasional & terukur
Perlindungan subjek	Informed consent, risiko, privasi	Tidak lengkap	Sebagian	Lengkap	Sangat lengkap & kritis
Kepatuhan etik	Mengacu CIOMS/Helsinki/KEPK	Tidak ada	Sebagian	Ada	Terintegrasi kuat

Skor akhir = (total/32) × 100

c. Format Produk

- Laporan (10–15 halaman)
- Lembar review etik (template checklist)

d. Template Lembar Review Etik (ringkas)

Komponen	Ya	Tidak	Catatan
Nilai ilmiah & manfaat jelas	☐	☐	
Risiko vs manfaat seimbang	☐	☐	
Informed consent lengkap	☐	☐	
Perlindungan kelompok rentan	☐	☐	
Privasi & kerahasiaan	☐	☐	
Manajemen data	☐	☐	
Persetujuan etik (KEPK)	☐	☐	

2. ASESMEN CPMK 1 (PENDUKUNG)

Ujian Tulis (CBT / Essay Terstruktur)

a. Blueprint Soal

Materi	Indikator	Bentuk	Jumlah
Teori etik	Menjelaskan teori	MCQ	5
Prinsip etik	Identifikasi prinsip	MCQ	5
Kode etik	Aplikasi kode etik	MCQ	5
Kasus (vignette)	Analisis kasus	Essay	2

b. Contoh Soal (MCQ)

Prinsip yang mendasari informed consent adalah:

- A. Justice
- B. Beneficence
- C. Autonomy
- D. Veracity

Kunci: C

Essay (Vignette)

Seorang pasien menolak ikut penelitian karena takut datanya disalahgunakan.

→ Jelaskan prinsip etik yang terlibat dan bagaimana perawat harus merespons.

c. Rubrik Essay

Aspek	Skor 0–2
Identifikasi prinsip	0–2
Argumentasi	0–2
Kesesuaian tindakan	0–2

d. Penilaian

- MCQ: % benar
- Essay: total skor /6 ×100

3. ASESMEN CPMK 3 (PENDUKUNG)

Simulasi OSCE: Informed Consent & Penolakan

a. Skenario

Mahasiswa berperan sebagai perawat yang:

- 1) Menjelaskan informed consent penelitian
- 2) Menghadapi pasien yang menolak

b. Checklist OSCE

Komponen	Ya (1)	Tidak (0)
Menjelaskan tujuan penelitian	☐	☐
Menjelaskan risiko	☐	☐
Menjelaskan manfaat	☐	☐
Menjelaskan hak menolak	☐	☐
Menggunakan bahasa mudah dipahami	☐	☐
Memastikan pemahaman pasien	☐	☐
Menghormati penolakan	☐	☐
Tidak memaksa	☐	☐
Menilai kapasitas pasien	☐	☐

Skor maksimal: 9

c. Kesalahan Kritis (langsung tidak lulus)

- Memaksa pasien
- Tidak menjelaskan risiko
- Mengabaikan penolakan

d. Interpretasi

- ≥80% = Kompeten
- <80% = Perlu remedial

4. ASESMEN CPMK 4 (PENDUKUNG)

Audit Privasi & Etika Digital (Worksheet)

a. Deskripsi Tugas

Mahasiswa mengaudit skenario sistem data kesehatan (misal: rekam medis elektronik / aplikasi telemedicine).

b. Worksheet Audit

Area	Risiko	Dampak	Kontrol Ada	Rekomendasi
Akses data				
Penyimpanan data				
Transfer data				
Penggunaan AI				
Kebocoran data				

c. Rubrik Penilaian

Aspek	Indikator	Skor 1–4
Identifikasi risiko	Jumlah & relevansi	1–4
Analisis dampak	Kedalaman analisis	1–4
Kontrol akses	Kelengkapan	1–4
Mitigasi	Operasional & realistis	1–4

Skor akhir = (total/16) × 100

d. Output

- Worksheet audit
- Rencana mitigasi (1–2 halaman)

e. Distribusi Bobot Total

- CPMK 7: 15%
- CPMK 1: 10%
- CPMK 3: 15%
- CPMK 4: 10%

L. Ringkasan

Bab ini menegaskan bahwa etik penelitian keperawatan merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa seluruh proses penelitian yang melibatkan manusia dilakukan dengan menghormati martabat, hak, serta keselamatan subjek penelitian. Prinsip-prinsip etik seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice menjadi kerangka dasar dalam pengambilan keputusan etik, yang diperkuat oleh pedoman global seperti Belmont Report dan CIOMS. Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam praktik seperti informed consent, perlindungan privasi dan kerahasiaan data, serta kewajiban memperoleh ethical clearance sebelum penelitian dilaksanakan.

Selain aspek konseptual, bab ini juga menyoroti berbagai isu etik dan hukum yang sering muncul dalam penelitian keperawatan, termasuk plagiarisme, konflik kepentingan, eksploitasi subjek, serta pelanggaran terhadap hak partisipan. Analisis kasus, seperti pelanggaran etik dalam sejarah penelitian, menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip etik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu, perawat sebagai peneliti dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan penelitian.

Secara khusus, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas menjadi fokus penting dalam bab ini. Pendekatan etik modern menekankan keseimbangan antara perlindungan dan partisipasi, melalui mekanisme seperti assent, capacity assessment, serta supported decision-making. Dengan demikian, etik penelitian keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menghasilkan penelitian yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab secara ilmiah maupun moral.

Redflag

Kelompok	Red Flag (Tanda Bahaya)	Risiko Etik	Tindakan yang Seharusnya
Anak	Tidak ada assent, hanya consent orang tua	Eksplorasi, pelanggaran autonomy berkembang	Terapkan parental consent + child assent
Anak	Penjelasan tidak sesuai usia	Anak tidak memahami partisipasi	Gunakan bahasa sederhana/visual
Lansia	Tidak dilakukan capacity assessment	Consent tidak valid	Lakukan asesmen kapasitas (decision-specific)
Lansia	Langsung menggunakan proxy tanpa melibatkan lansia	Hilangnya autonomy	Libatkan lansia semaksimal mungkin
Gangguan Jiwa	Rekrutmen saat kondisi akut	Consent tidak sah	Tunda hingga kondisi stabil
Gangguan Jiwa	Ada tekanan/coercion (langsung/tidak langsung)	Pelanggaran voluntariness	Pastikan partisipasi sukarela
Disabilitas	Tidak ada akses komunikasi (AAC/interpreter)	Diskriminasi, eksklusi	Sediakan reasonable accommodation
Disabilitas	Menganggap semua tidak kompeten	Pelanggaran justice	Nilai kapasitas secara individual
Disabilitas	Keputusan sepenuhnya diambil caregiver	Hilangnya agency individu	Gunakan supported decision-making

Referensi

- Blake, K. V. (2023). Ethics Challenges in Pediatric Research. *The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics*, 28(8), 680–686. <http://doi.org/10.5863/1551-6776-28.8.680>
- Chandra, M., Harbishettar, V., Sawhney, H., & Amanullah, S. (2021). Ethical Issues in Dementia Research. *Indian Journal Psychological Medicine*, 43(5). <http://doi.org/10.1177/02537176211022224>
- CIOMS-WHO. (2016). *Pedoman Etik Internasional Penelitian kesehatan yang melibatkan manusia. CIOMS - WHO 2016*.
- Department-of-Health-Education-and-Welfare. The Belmont Report, Harvard Law School Project on Disability (1979).
- Dolan, C. M., & Bell, S. M. (2024). Historical Trauma, Health Care Distrust, and the Legacy of Tuskegee: Implications for Nurse Practitioner Practice and Research. *Journal for Nurse Practitioners*, 20(4), 104910. <http://doi.org/10.1016/j.nurpra.2023.104910>
- Faissner, M., & Braun, E. (2024). The ethics of coercion in mental healthcare : the role of structural racism, 476–481. <http://doi.org/10.1136/jme-2023-108984>
- Farhud, D. D., & Zokaei, S. (2021). Ethical issues of artificial intelligence in medicine and healthcare. *Iranian Journal of Public Health*, 50(11), i–v. <http://doi.org/10.61171/v02.02.62>
- HHS, H.-H.-S. THE BELMONT REPORT Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research (1979).
- ICN. (2021). *THE ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES International Council of Nurses. Code of Ethics for Nurses*. Retrieved from https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-06/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web.pdf
- Jin, J., Burbach, L., Greenshaw, A. J., & Winkler, O. (2023). Commentary : Coercion in Psychiatry: Lessons Learned from Trauma-Informed Care, 6–8. <http://doi.org/10.1177/07067437221125884>
- Kemenkes-RI. (2021). *Pedoman dan Standar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional*.
- Mcintosh, N. (2002). Ethical principles of paediatric research. *Current Paediatrics*, 12, 508–512. <http://doi.org/10.1006/cupe.2002.0265>.
- Ogungbure, A. A. (2011). The Tuskegee Syphilis Study: Some Ethical Reflections. *A Journal of the Philosophical Association of Kenya (PAK) New Series*, 3(2), 75–92. Retrieved from http://www.gmc-uk.org/giuidinace/good_medical_Practice/index.asp

- Paul, C., & Brookes, B. (2015). The rationalization of unethical research: Revisionist accounts of the Tuskegee syphilis study and the New Zealand "unfortunate experiment." *American Journal of Public Health*, 105(10), e12–e19. <http://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302720>
- Podany, A. T. (2017). Ethical Considerations in Pediatric Code of Federal Regulations. In *Research and Study Design in Pediatrics 7*.
- Sashidharan, S. P., Mezzina, R., & Puras, D. (2019). Reducing coercion in mental healthcare. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 28(6), 605–612. <http://doi.org/10.1017/S2045796019000350>
- Scott, D. (2008). Toolkit for Primary Care : Capacity Assessment.
- Shanker, R. rajendra. (2016). A Review of the Literature on Capacity Assessment Tools within Mental Health Practice. *Joint Center for Bioethics*.
- Takala, T. (2001). What is wrong with global bioethics? On the limitations of the four principles approach. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 10(1), 72–77. <http://doi.org/10.1017/S0963180101001098>
- UNESCO. Recommendation on The Ethics of Artificial Intelligence, UNESCO 225–248 (2022). <http://doi.org/10.7551/mitpress/14102.003.0010>
- United Nations General Assembly. (2002). Convention on the Rights of the Child. *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <http://doi.org/10.1159/000509119>
- Vaughn, L. (2023). *Bioethics Principles, issues and cases-Fifth edition*. Oxford University press.
- Wang, Y., Wang, S., Ungvari, G., Yu, X., Ng, C., & Xiang, Y. (2018). The assessment of decision-making competence in patients with depression using the MacArthur Competence Assessment Tools : A systematic review. In *Perspectives in Psychiatric Care*, (Vol. 54, pp. 206–211). <http://doi.org/https://doi.org/10.1111/ppc.12224>.
- WHO. (2024). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.
- WHO. (2025). *WHO guidance on the ethics of health research priority setting. WHO guidance on the ethics of health research priority setting*.
- WMA-DECLARATION-HELSINKI. WMA DECLARATION OF HELSINKI WMA DECLARATION OF HELSINKI – ETHICAL PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS, World Medical Association (WMA) 1–7 (2024).
- Yeo, M., Moorhouse, A., Khan, P., & Rodney, P. (2020). *Concepts and Cases in Nursing*

Ethics. Broadview press.

- Yu, S., Lee, S., & Hwang, H. (2024). The ethics of using artificial intelligence in medical research. *Kosin Medical Journal*, 39(4), 229–237.
<http://doi.org/10.7180/kmj.24.140>
- Yuliana. (2025). The Ethical Aspects of Applying Artificial Intelligence in the Healthcare System. *LogicLink*, 2(1), 18–26.
<http://doi.org/10.28918/logiclink.v2i1.10710>

BAB 7

STUDI KASUS ETIK-HUKUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN: KERANGKA ANALISIS DAN SIMULASI SIDANG ETIK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

I. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Studi Kasus Etik–Hukum dan Pengambilan Keputusan: Kerangka Analisis dan Simulasi Sidang Etik	7.1 Menyusun analisis kasus etik–hukum menggunakan kerangka terstruktur dan bukti relevan.	7.2 Menyajikan argumen profesional dan rekomendasi tindak lanjut dalam simulasi sidang etik.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5

J. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit
CPMK-6	Mini RCA/analisis insiden + presentasi singkat	Skor ketepatan klasifikasi risiko, kualitas rencana pencegahan berbasis akar masalah, dan keterukuran indikator audit.	15	RCA mini; slide/handout ringkas
CPMK-7	Proyek studi kasus + etik penelitian (review protokol)	Skor kualitas rekomendasi kasus (argumentasi, opsi, tindak lanjut) dan kepatuhan komponen perlindungan subjek (rubrik).	15	Laporan proyek; lembar review etik

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak-probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

A. Teori Dasar

Dalam literatur akademik, kasus etik tidak dipandang sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai sebuah kondisi "kebuntuan moral". Berikut adalah beberapa definisi kunci dari para pakar:

1. Tom L. Beauchamp dan James F. Childress (2019) Dalam buku monumental mereka, *Principles of Biomedical Ethics*, kedua pakar ini mendefinisikan dilema atau kasus etik sebagai situasi dengan alasan moral yang sama kuatnya untuk melakukan dua tindakan yang saling eksklusif (tidak bisa dilakukan bersamaan). Memilih salah satu tindakan berarti melanggar prinsip moral yang lain. Mereka menekankan bahwa kasus etik terjadi pada titik temu antara empat prinsip utama: otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*.
2. Andrew Jameton (2018) Jameton memberikan definisi yang sangat relevan bagi praktisi klinis. Ia membedakan kasus etik ke dalam tiga level:
 - a. Ketidakpastian Moral: Saat praktisi tidak yakin prinsip etik mana yang harus diterapkan.
 - b. Dilema Moral: Saat dua atau lebih prinsip etik berbenturan.
 - c. Distres Moral: Saat praktisi mengetahui tindakan yang benar secara etik, namun terhalang oleh aturan institusi atau kendala hukum untuk melakukannya. Bagi Jameton, sebuah situasi menjadi "kasus etik" ketika integritas moral seorang profesional diuji oleh keterbatasan sistem.
3. Sara T. Fry dan Robert M. Veatch (2020) Dalam perspektif keperawatan dan kesehatan umum, Fry dan Veatch mendefinisikan kasus etik sebagai sebuah masalah yang melibatkan pertanyaan nilai (*value inquiry*) yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengumpulan data klinis atau fakta empiris. Kasus etik memerlukan analisis mendalam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia yang sering kali melampaui apa yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SPO).
4. Lawrence Kohlberg (Dalam Rest et al., 2020) Dari sudut pandang psikologi moral yang sering dikutip dalam buku etika, Kohlberg memandang kasus etik sebagai sarana pengujian "penalaran moral". Sebuah kasus dikategorikan sebagai masalah etik jika ia menuntut individu untuk beralih dari sekadar kepatuhan pada aturan (tahap konvensional) menuju pertimbangan prinsip-prinsip etika universal (tahap pascakonvensional).

Tabel 7. 1 Intisari dan Fokus Utama Definisi Kasus Etik Menurut Beberapa Ahli

Nama Ahli	Intisari Definisi	Fokus Utama
Beauchamp & Childress	Benturan antar prinsip moral yang setara.	Prinsip Bioetika
Andrew Jameton	Ketidakberdayaan moral menghadapi sistem.	Distres Moral Praktisi
Fry & Veatch	Konflik nilai yang tidak bisa dijawab dengan data medis.	Tanggung Jawab Profesi
Lawrence Kohlberg	Ujian penalaran moral individu.	Perkembangan Kognitif Moral

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus etik merupakan situasi yang menimbulkan pertanyaan mengenai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan nilai moral, norma sosial, serta prinsip etika yang berlaku. Kasus etik biasanya muncul ketika individu atau kelompok dihadapkan pada pilihan yang melibatkan konflik nilai atau kepentingan moral sehingga memerlukan pertimbangan etis dalam menentukan tindakan yang paling tepat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kasus etik sering berkaitan dengan keputusan yang memengaruhi keselamatan, martabat, hak, dan kesejahteraan pasien sehingga tenaga kesehatan perlu menggunakan kerangka etika profesional dalam proses pengambilan keputusan (Butts & Rich, 2023).

Dalam praktik keperawatan, kasus etik merujuk pada situasi klinis yang memunculkan konflik nilai moral sehingga perawat dihadapkan pada beberapa pilihan tindakan yang masing-masing memiliki implikasi etis. Situasi ini tidak selalu memiliki satu jawaban yang benar secara absolut, sehingga memerlukan analisis yang cermat dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, standar profesi, serta tanggung jawab moral terhadap pasien. Oleh karena itu, permasalahan etik dalam keperawatan sering berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai “apa yang seharusnya dilakukan” oleh tenaga kesehatan agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip etika profesi dan tujuan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan pasien (Berman et al., 2022; Butts & Rich, 2023).

Beberapa ahli memberikan definisi yang memperkuat pemahaman mengenai kasus etik dalam keperawatan. Janie B. Butts dan Karen L. Rich menjelaskan bahwa dilema etik dalam keperawatan terjadi ketika seorang tenaga kesehatan harus memilih di antara dua atau lebih tindakan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral dan tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas dari pertimbangan etis. Sementara itu, Tom L. Beauchamp dan James F. Childress menegaskan bahwa

pengambilan keputusan etik dalam pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip bioetika yang menjadi kerangka normatif dalam praktik klinis modern (Beauchamp & Childress, 2019).

Menurut Audrey Berman dalam buku *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing*, konflik etik dalam pelayanan kesehatan sering berkaitan dengan pertentangan antara prinsip-prinsip dasar bioetika yang menjadi landasan pengambilan keputusan profesional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Autonomy (Otonomi)

Prinsip otonomi menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan mengenai kesehatan dan kehidupannya sendiri setelah memperoleh informasi yang lengkap dan jelas. Tenaga kesehatan berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan memadai agar pasien dapat menentukan pilihan secara sadar dan bebas dari paksaan (Beauchamp & Childress, 2019).

Contoh:

Seorang pasien dengan penyakit kronis menolak tindakan operasi yang direkomendasikan dokter. Dalam situasi ini, perawat perlu menghormati keputusan pasien setelah memastikan bahwa pasien telah memperoleh informasi yang cukup mengenai manfaat, risiko, serta alternatif terapi yang tersedia.

2. Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip beneficence mengharuskan tenaga kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien dengan memberikan intervensi yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien (Butts & Rich, 2023).

Contoh:

Perawat memberikan edukasi kesehatan kepada pasien hipertensi mengenai pentingnya kepatuhan minum obat, pengaturan pola makan rendah garam, serta aktivitas fisik teratur guna mencegah komplikasi seperti stroke atau penyakit jantung.

3. Non-maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip non-maleficence menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, cedera, atau memperburuk kondisi pasien. Prinsip ini sering dirumuskan dalam ungkapan "*do no harm*" atau tidak menimbulkan kerugian bagi pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

Contoh:

Sebelum memberikan obat kepada pasien, perawat melakukan prosedur keselamatan seperti memverifikasi identitas pasien, memeriksa dosis obat, serta

memastikan tidak ada riwayat alergi terhadap obat tersebut guna mencegah kesalahan pemberian obat.

4. Justice (Keadilan)

Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi sumber daya kesehatan secara adil serta pemberian pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Setiap pasien memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan medisnya (Butts & Rich, 2023).

Contoh:

Dalam kondisi keterbatasan tempat tidur di ruang perawatan intensif, tenaga kesehatan perlu menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan medis, bukan berdasarkan status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang budaya pasien.

Selain berlandaskan prinsip bioetika universal, praktik keperawatan di Indonesia juga dipandu oleh nilai profesional yang tercantum dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. Kode etik tersebut menegaskan bahwa perawat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan yang menghormati martabat manusia, menjaga kerahasiaan pasien, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan keperawatan. Dengan memahami konsep kasus etik serta prinsip bioetika tersebut, perawat dapat melakukan analisis yang lebih sistematis ketika menghadapi permasalahan etik di lingkungan pelayanan kesehatan. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan yang tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan hukum.

B. Kasus Hukum dalam Keperawatan

Teori Dasar

Berbeda dengan kasus etik yang lebih berkaitan dengan konflik nilai moral, kasus hukum dalam keperawatan memiliki karakter yang lebih formal, objektif, dan mengikat secara hukum. Kasus hukum muncul ketika tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan, termasuk perawat, dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien, keluarga pasien, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah tidak lagi hanya melalui pertimbangan moral atau diskusi etik, tetapi melalui mekanisme hukum yang melibatkan aturan, prosedur pembuktian, serta sanksi yang ditetapkan oleh negara.

Dalam kajian hukum kesehatan, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dipahami sebagai hubungan hukum profesional yang mengandung hak dan

kewajiban bagi kedua belah pihak. Menurut Haryani (2020), hukum kesehatan berfungsi mengatur hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan secara jelas dan terstruktur. Hubungan ini didasarkan pada prinsip bahwa pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi, sedangkan tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi, standar praktik, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kasus hukum yang melibatkan tenaga keperawatan umumnya berkaitan dengan dua ranah utama, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

1. Aspek Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, kasus hukum keperawatan biasanya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat kelalaian (negligence) yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan apabila mereka merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar profesi atau kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Sebagai contoh, seorang pasien mengalami luka infeksi serius akibat prosedur perawatan luka yang tidak dilakukan sesuai standar sterilitas. Jika terbukti bahwa perawat tidak mengikuti prosedur yang semestinya dan hal tersebut menyebabkan kerugian pada pasien, maka keluarga pasien dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.

2. Aspek Hukum Pidana

Selain aspek perdata, kasus hukum dalam praktik keperawatan juga dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana, terutama apabila tindakan kelalaian tenaga kesehatan menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian pasien. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kealpaan (culpa) yang menimbulkan akibat serius bagi korban. Sebagai ilustrasi, apabila seorang perawat memberikan obat dengan dosis yang sangat tidak sesuai dengan resep dokter karena kelalaian dalam membaca instruksi medis, dan tindakan tersebut menyebabkan pasien mengalami kondisi yang membahayakan jiwa, maka kasus tersebut dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

C. Kerangka Hukum Praktik Keperawatan di Indonesia

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur tenaga kesehatan saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan

sistem kesehatan nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, tanggung jawab tenaga kesehatan, serta standar praktik profesional. Selain itu, praktik keperawatan juga berkaitan dengan standar profesi dan regulasi organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang menetapkan kode etik serta pedoman praktik bagi perawat di Indonesia.

Perkembangan sistem hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya regulasi baru yang mengintegrasikan berbagai aturan sektor kesehatan ke dalam satu kerangka hukum yang lebih komprehensif. Pembaharuan hukum kesehatan nasional terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sering disebut sebagai pendekatan *omnibus law* dalam sektor kesehatan. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai peraturan sebelumnya yang mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk profesi keperawatan.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah penegasan mengenai legalitas praktik tenaga kesehatan. Setiap perawat diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti pengakuan kompetensi profesional, serta Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dasar hukum untuk menjalankan pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan tertentu. Dalam kerangka regulasi terbaru, masa berlaku STR mengalami perubahan menjadi lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya, meskipun tetap memerlukan pemenuhan persyaratan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Perlindungan tersebut diberikan selama tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan profesional yang dilakukan sesuai standar tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila terjadi komplikasi medis yang tidak dapat dihindari.

Sebelum hadirnya regulasi kesehatan terbaru, praktik keperawatan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Meskipun sebagian ketentuannya telah diintegrasikan ke dalam undang-undang kesehatan yang lebih baru, undang-undang ini tetap memiliki nilai penting dalam sejarah perkembangan profesi keperawatan di Indonesia. Menurut kajian yang dikemukakan oleh Mulyadi (2022), regulasi tersebut merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui kewenangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara mandiri. Pengakuan ini memperkuat posisi perawat sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi

husus dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan sekadar pelaksana instruksi medis.

D. Pengambilan Keputusan Etis-Hukum dan Kerangka Analisisnya

Teori Dasar

Pengambilan keputusan merupakan proses yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam lingkup individu maupun organisasi. Setiap tindakan yang dilakukan pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Lebih dari sekadar memilih, pengambilan keputusan mencerminkan proses kognitif yang melibatkan analisis, penilaian, serta pertimbangan terhadap konsekuensi dari setiap pilihan. Secara umum, pengambilan keputusan (*general decision making*) dipahami sebagai proses menentukan satu pilihan tindakan dari beberapa alternatif guna mencapai tujuan tertentu. Proses ini biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kondisi yang sedang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Robbins & Judge (2019) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan respons terhadap suatu masalah yang ditandai oleh adanya kesenjangan antara keadaan aktual dan kondisi ideal, sehingga diperlukan evaluasi berbagai alternatif solusi. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah tindakan spontan, melainkan melalui tahapan sistematis seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis pilihan, hingga penentuan solusi yang dianggap paling tepat.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan umum sering dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan, seperti informasi yang tidak lengkap, tekanan waktu, pengalaman individu, serta dinamika lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan yang dihasilkan tidak selalu sepenuhnya rasional, melainkan berada dalam batas rasionalitas (*bounded rationality*). Oleh karena itu, kualitas keputusan sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola informasi serta memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Berbeda dengan pengambilan keputusan umum yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara efektif, pengambilan keputusan etis (*ethical decision making*) lebih menekankan pada pertimbangan nilai moral. Dalam proses ini, individu tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip kebajikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan standar moral.

Treviño & Nelson (2021) mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai proses mental yang sistematis dalam menilai dampak moral dari suatu tindakan,

dengan mempertimbangkan hak-hak para pemangku kepentingan serta integritas individu sebagai pengambil keputusan. Definisi ini menegaskan bahwa dimensi moral menjadi bagian penting dalam setiap keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik kepentingan atau dilema etika. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan, tenaga medis kerap dihadapkan pada keputusan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga menyangkut hak pasien, keadilan, dan tanggung jawab profesional. Pengambilan keputusan etis biasanya melalui beberapa tahapan, mulai dari mengenali adanya isu moral, mengevaluasi alternatif berdasarkan prinsip etika, hingga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Prinsip-prinsip seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati hak individu), dan *justice* (keadilan) menjadi landasan penting dalam proses ini. Oleh karena itu, pengambilan keputusan etis tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan nilai yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) memiliki karakteristik yang lebih formal dan sistematis. Proses ini dilakukan oleh praktisi hukum dalam menerapkan aturan yang bersifat abstrak ke dalam kasus nyata. Pengambilan keputusan hukum menuntut pemahaman terhadap norma hukum serta kemampuan dalam melakukan penalaran hukum secara logis. Shapiro (2021) menyatakan bahwa pengambilan keputusan hukum merupakan aktivitas interpretatif yang bertujuan menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum, dengan berlandaskan pada sumber hukum formal seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga tidak bersifat subjektif.

Proses pengambilan keputusan hukum meliputi beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi fakta, menafsirkan aturan hukum yang relevan, menghubungkan norma dengan fakta, serta menarik kesimpulan dalam bentuk putusan. Selain itu, preseden atau putusan sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan demikian, tujuan utama dari pengambilan keputusan hukum adalah menciptakan keadilan sekaligus kepastian hukum.

Jika dibandingkan, ketiga jenis pengambilan keputusan tersebut memiliki perbedaan yang jelas. Pengambilan keputusan umum berfokus pada efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan, sehingga cenderung fleksibel dan kontekstual. Pengambilan keputusan etis berlandaskan pada nilai moral dan bertujuan mencapai kebenaran yang dapat diterima secara sosial. Sementara itu, pengambilan keputusan hukum berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan serta pencapaian

keadilan melalui prosedur formal. Meskipun berbeda, ketiganya saling berkaitan dalam praktik. Dalam berbagai bidang, terutama kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, pengambil keputusan perlu mempertimbangkan aspek rasional, etis, dan hukum secara bersamaan. Misalnya, seorang tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan medis harus mempertimbangkan efektivitas tindakan, kesesuaian dengan prinsip etika profesi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiga konsep ini sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi yang kompleks dan penuh dilema. Keputusan yang berkualitas tidak hanya mampu menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Oleh karena itu, integrasi antara aspek rasional, etika, dan hukum menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

E. Model Pengambilan Keputusan Etik

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, pengambilan keputusan etik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi moral, klinis, hukum, dan sosial. Tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada situasi di mana tidak terdapat satu keputusan yang sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Kondisi tersebut muncul karena praktik klinis tidak hanya berfokus pada aspek medis semata, tetapi juga pada hak pasien, nilai profesional tenaga kesehatan, serta keterbatasan sumber daya sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan etik memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis agar keraguan moral yang muncul dapat diubah menjadi keputusan klinis yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional (Varkey, 2021).

Dalam literatur bioetika kontemporer, pengambilan keputusan etik dipahami sebagai proses analitis yang melibatkan identifikasi masalah, evaluasi nilai moral yang relevan, serta pertimbangan konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan. Model pengambilan keputusan etik dikembangkan untuk membantu tenaga kesehatan menavigasi dilema moral yang sering muncul dalam praktik klinis, seperti konflik antara otonomi pasien dan kewajiban profesional tenaga medis, keterbatasan sumber daya kesehatan, maupun perbedaan pandangan antara tenaga medis dan keluarga pasien (Kateb et al., 2025). Dengan menggunakan kerangka analitis yang terstruktur, tenaga kesehatan dapat mengevaluasi berbagai pilihan tindakan secara objektif serta mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang didasarkan pada tekanan emosional atau bias pribadi.

1. Model Enam Langkah Analisis Etik

Salah satu kerangka analisis yang banyak digunakan dalam praktik kesehatan adalah model enam langkah pengambilan keputusan etik yang dikembangkan oleh Purtilo dan Doherty. Model ini memberikan panduan sistematis yang membantu praktisi kesehatan menganalisis permasalahan etik secara bertahap sehingga seluruh aspek moral yang relevan dapat dipertimbangkan secara komprehensif. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses refleksi kritis dalam menghadapi dilema moral yang muncul dalam praktik pelayanan kesehatan (Doherty & Purtilo, 2021). Langkah pertama dalam model ini adalah mengumpulkan informasi yang relevan mengenai kasus yang dihadapi. Informasi tersebut mencakup data medis pasien, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta faktor lingkungan yang dapat memengaruhi keputusan klinis. Ketepatan dan kelengkapan data menjadi dasar penting dalam analisis etik karena keputusan yang diambil tanpa informasi yang memadai berpotensi menghasilkan penilaian yang tidak akurat. Langkah kedua adalah mengidentifikasi jenis permasalahan etik yang muncul. Dalam praktik klinis, konflik moral dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dilema etik, yaitu situasi di mana dua pilihan tindakan sama-sama memiliki nilai moral yang kuat namun tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat mengalami *moral distress*, yaitu kondisi ketika praktisi mengetahui tindakan yang benar secara moral tetapi tidak dapat melaksanakannya karena hambatan institusional atau kebijakan organisasi. Langkah ketiga adalah menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan teori etika yang relevan. Pendekatan utilitarianisme menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar yang dapat dihasilkan bagi jumlah orang terbanyak. Sebaliknya, pendekatan deontologis menekankan kewajiban moral dan prinsip profesional sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan teori etika memungkinkan tenaga kesehatan menilai situasi secara lebih objektif dan sistematis. Langkah keempat adalah mengeksplorasi berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Pada tahap ini, tenaga kesehatan didorong untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat meminimalkan konflik nilai yang terjadi. Dalam beberapa kasus, pendekatan kompromi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan memilih salah satu pilihan secara ekstrem. Langkah kelima adalah melaksanakan tindakan yang dipilih. Keputusan etik harus diterjemahkan ke dalam tindakan klinis yang konkret agar dapat memberikan manfaat nyata bagi pasien. Oleh karena itu, implementasi keputusan menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan etik. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah

diambil. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah keputusan tersebut telah mencapai tujuan moral yang diharapkan serta untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan pada kasus serupa di masa depan. Pendekatan reflektif ini membantu tenaga kesehatan meningkatkan sensitivitas etik serta kualitas praktik profesional mereka (Park, 2021).

2. Model Jonsen's Four-Box dalam Analisis Kasus Etik

Selain model enam langkah, pendekatan lain yang banyak digunakan dalam diskusi etik klinis adalah metode Four-Box yang diperkenalkan oleh Jonsen, Siegler, dan Winslade. Model ini mengorganisasi analisis kasus ke dalam empat dimensi utama, yaitu indikasi medis, preferensi pasien, kualitas hidup, dan faktor kontekstual. Dimensi pertama adalah indikasi medis, yang berkaitan dengan analisis kondisi klinis pasien serta tujuan intervensi medis yang direncanakan. Dalam tahap ini, tenaga kesehatan perlu menilai diagnosis, prognosis, serta kemungkinan manfaat dan risiko dari berbagai pilihan terapi. Analisis ini berkaitan erat dengan prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*, yaitu kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat bagi pasien sekaligus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya. Dimensi kedua adalah preferensi pasien, yang berfokus pada prinsip otonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait perawatan yang diterimanya selama memiliki kapasitas mental dan kompetensi hukum yang memadai. Dalam praktik klinis modern, penghormatan terhadap otonomi pasien diwujudkan melalui proses *shared decision-making*, yaitu pendekatan yang melibatkan pasien secara aktif dalam pengambilan keputusan medis (Elwyn et al., 2020). Dimensi ketiga adalah kualitas hidup, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan medis terhadap kehidupan pasien. Analisis ini meliputi kemungkinan pemulihan fungsi, tingkat penderitaan yang mungkin dialami pasien, serta persepsi pasien mengenai kehidupan yang bermakna. Dalam beberapa kasus, intervensi medis yang secara teknis dapat memperpanjang kehidupan belum tentu meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Dimensi terakhir adalah faktor kontekstual, yang mencakup berbagai kondisi eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor tersebut dapat meliputi aspek hukum, kebijakan institusi, keterbatasan sumber daya kesehatan, serta dampak keputusan terhadap keluarga pasien maupun masyarakat secara luas. Analisis terhadap faktor kontekstual penting untuk memastikan bahwa keputusan klinis tidak hanya tepat secara medis tetapi juga realistis dalam konteks sistem pelayanan kesehatan. Model Four-Box banyak digunakan dalam diskusi komite etik rumah sakit karena kemampuannya menyusun analisis kasus secara sistematis dan komprehensif.

F. Deliberasi Etik dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Selain pendekatan analitis, proses pengambilan keputusan etik juga sering dilakukan melalui metode deliberasi etik. Deliberasi merupakan proses diskusi reflektif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai pemahaman moral bersama mengenai tindakan yang paling tepat dalam suatu kasus klinis. Dalam lingkungan rumah sakit, deliberasi etik biasanya dilakukan melalui forum komite etik yang terdiri dari berbagai profesi, seperti dokter, perawat, ahli hukum kesehatan, serta perwakilan masyarakat. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan setiap kasus dianalisis dari berbagai perspektif sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan seimbang. Menurut Gracia (2020), deliberasi etik yang efektif memerlukan sikap keterbukaan intelektual dari setiap peserta diskusi. Setiap anggota tim harus bersedia mempertimbangkan kembali pandangannya apabila terdapat argumen moral yang lebih kuat. Proses deliberatif semacam ini dapat membantu tenaga kesehatan mencapai konsensus moral sekaligus mengurangi potensi konflik dalam pengambilan keputusan klinis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengambilan keputusan etik yang dilakukan secara kolaboratif antara dokter dan perawat dapat meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Kateb et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama interprofesional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan klinis tidak hanya tepat secara medis tetapi juga sesuai dengan prinsip etika profesi.

G. Tahapan Prosedural dalam Pengambilan Keputusan Etik

Berdasarkan sintesis berbagai model pengambilan keputusan etik, terdapat beberapa tahapan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik klinis maupun dalam forum sidang etik rumah sakit. Tahap pertama adalah mengidentifikasi inti permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, tenaga kesehatan perlu memahami konflik nilai yang mendasari suatu kasus, misalnya konflik antara keinginan keluarga pasien dan rekomendasi medis, atau keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien.

Tahap kedua adalah mengumpulkan fakta klinis dan informasi hukum yang relevan. Seluruh data medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta regulasi kesehatan perlu dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ketiga adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau terdampak oleh keputusan tersebut. Pihak tersebut tidak hanya mencakup pasien

dan keluarga, tetapi juga tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, serta pihak pembiayaan seperti sistem jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, tenaga kesehatan perlu menentukan prinsip etik yang paling relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu, beberapa prinsip etik dapat saling bertentangan sehingga diperlukan prioritas nilai yang sesuai dengan konteks klinis. Misalnya, dalam situasi gawat darurat, prinsip beneficence yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa sering kali menjadi prioritas utama dibandingkan prinsip autonomy.

Tahap keempat adalah mengevaluasi berbagai alternatif tindakan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap pilihan. Pendekatan analisis beban dan manfaat (*burden-benefit analysis*) sering digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya.

Tahap terakhir adalah mengambil keputusan serta mendokumentasikan seluruh proses yang telah dilakukan. Dokumentasi yang baik memiliki peran penting dalam praktik kesehatan karena dapat menjadi bukti bahwa keputusan klinis telah diambil melalui proses analisis etik yang memadai. Dalam perspektif hukum kesehatan, pencatatan yang lengkap juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penggunaan model pengambilan keputusan etik yang sistematis tidak hanya membantu tenaga kesehatan menyelesaikan dilema moral secara rasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, hak pasien, serta tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Kasus:

Ny. S (65 tahun) dirawat di ruang VVIP sebuah Rumah Sakit di Bandung dengan diagnosa Ca Pankreas Stadium IV yang telah bermetastasis ke hati dan paru. Kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran (somnia) dan terpasang alat bantu napas (Ventilator). Anak sulung pasien, yang merupakan penyandang dana utama perawatan, meminta tim perawat dan dokter untuk merahasiakan diagnosa asli dari adik-adiknya dan saudara lainnya dengan alasan "agar tidak membuat kegaduhan keluarga". Ia juga meminta tim medis untuk melakukan tindakan *Full Code* (termasuk RJP jika henti jantung), meskipun tim medis telah menjelaskan bahwa prognosinya sangat buruk (*futile care*). Di sisi lain, perawat menemukan dokumen "Pesan Terakhir" (Advance Directive) yang dibuat Ny. S satu tahun lalu saat masih sehat, yang menyatakan bahwa ia tidak ingin dipasang alat bantu napas atau dilakukan RJP jika penyakitnya sudah tidak tersembuhkan. Namun, anak sulung bersikeras dokumen itu sudah tidak berlaku karena kondisi ibu mereka sekarang berbeda. Perawat merasa tertekan antara memenuhi keinginan keluarga (sebagai mitra perawatan), menghormati hak otonomi pasien yang tertulis, dan menghindari tindakan yang hanya memberikan penderitaan tanpa manfaat klinis (futilitas medis).

Pertanyaan Diskusi

1. Prinsip bioetik mana yang saling berbenturan dalam kasus di atas? Jelaskan mengapa otonomi pasien (melalui *Advance Directive*) berkonfrontasi dengan prinsip *beneficence* versi keluarga.
2. Apakah tindakan *Full Code* pada pasien stadium terminal termasuk pelanggaran prinsip *Non-Maleficence*? Berikan argumentasi Anda.
3. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bagaimana posisi perawat dalam menghadapi instruksi keluarga yang bertentangan dengan wasiat medis pasien?
4. Bagaimana aspek legal mengenai "Persetujuan Tindakan Kedokteran" jika terjadi perbedaan pendapat antara anggota keluarga inti?
5. Jika Anda adalah Perawat Primer (PP) dalam kasus tersebut, langkah advokasi apa yang akan Anda lakukan untuk menjembatani konflik antara anak sulung dan keinginan pasien?
6. Rancanglah sebuah draf komunikasi terapeutik untuk menjelaskan konsep *DNR (Do Not Resuscitate)* kepada keluarga tanpa menghilangkan harapan mereka.

7. Bagaimana Anda mendokumentasikan penolakan tindakan atau keberadaan *Advance Directive* tersebut agar memiliki *legal standing* yang kuat jika suatu saat terjadi tuntutan hukum dari pihak keluarga lain?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Batasan Kewenangan Klinis dalam Praktik Keperawatan

Teori Dasar

Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam hukum kesehatan adalah penentuan batas kewenangan profesional. Ketidakjelasan mengenai kewenangan tindakan klinis dapat menimbulkan konflik tanggung jawab apabila terjadi kesalahan medis atau kerugian pada pasien.

1. Praktik keperawatan mandiri

Dalam lingkup kewenangan profesional, perawat memiliki ruang praktik mandiri dalam memberikan asuhan keperawatan, melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien, serta melakukan tindakan pertolongan darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Praktik mandiri ini mencakup proses pengkajian keperawatan, penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi tindakan, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan. Menurut Yusuf (2021), dalam praktik mandiri tersebut perawat memegang tanggung jawab profesional secara penuh terhadap keputusan klinis yang diambil. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada standar praktik keperawatan dan pertimbangan klinis yang tepat.

2. Mekanisme pelimpahan tindakan medis

Dalam situasi tertentu, perawat juga dapat melakukan tindakan medis yang berada di luar kewenangan mandiri melalui mekanisme pelimpahan wewenang dari dokter. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, pelimpahan ini umumnya dilakukan melalui dua bentuk, yaitu delegasi dan mandat. Pada mekanisme delegasi, dokter tidak hanya menyerahkan pelaksanaan tindakan kepada perawat tetapi juga sebagian tanggung jawab profesional terkait tindakan tersebut. Sebaliknya, dalam mekanisme mandat, dokter tetap memegang tanggung jawab hukum atas tindakan medis yang dilakukan oleh perawat selama tindakan tersebut dilaksanakan sesuai instruksi yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Rustina (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan pemahaman mengenai kedua mekanisme

tersebut sering menjadi faktor yang memicu sengketa medis dalam praktik pelayanan kesehatan.

3. Perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban profesi

Negara memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan sebagai bentuk pengakuan terhadap risiko tinggi yang melekat pada profesi ini. Namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Tenaga kesehatan tetap dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan kesalahan serius atau tindakan yang menyimpang dari standar profesi. Kajian hukum kesehatan yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto dan Herkutanto (2019) menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak berlaku apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) atau tindakan yang disengaja sehingga membahayakan keselamatan pasien. Selain pertanggungjawaban hukum melalui sistem peradilan, perawat juga dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi etik melalui organisasi profesi. Dalam konteks profesi keperawatan, pengawasan etik dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui lembaga yang dikenal sebagai Majelis Kehormatan Etik Keperawatan.

Praktik keperawatan di Indonesia berkembang dalam suatu sistem yang tidak hanya bertumpu pada kompetensi ilmiah dan keterampilan klinis, tetapi juga diatur oleh kerangka hukum yang terus berkembang. Regulasi tersebut memiliki fungsi strategis dalam dua hal sekaligus. Di satu sisi, hukum berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan praktik pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar kompetensi. Di sisi lain, regulasi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya secara mandiri maupun kolaboratif. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, praktik keperawatan dapat berlangsung secara aman, akuntabel, dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku (Haryani, 2020).

Malpraktik dalam Perspektif Hukum

Banyak kasus hukum dalam bidang kesehatan bermuara pada tuduhan malpraktik. Secara umum, malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan profesional yang menyimpang dari standar praktik yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Dalam proses pembuktian malpraktik, biasanya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya kewajiban profesional (*duty of care*): Tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi.
2. Terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*): Tenaga kesehatan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

3. Adanya hubungan sebab-akibat (causal connection): Kerugian yang dialami pasien merupakan akibat langsung dari tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan.
4. Terjadi kerugian nyata pada pasien (damage): Pasien mengalami kerugian berupa cedera, kerugian finansial, atau bahkan kehilangan nyawa.

Sebagai contoh, apabila seorang perawat tidak melakukan pemantauan tanda vital pasien pascaoperasi sesuai jadwal yang ditentukan dan akibatnya kondisi pasien memburuk tanpa terdeteksi secara dini, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban profesional apabila terbukti tidak sesuai dengan standar praktik keperawatan.

Dengan demikian, pemahaman mengenai aspek hukum dalam praktik keperawatan menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan. Pengetahuan tentang hukum kesehatan tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga untuk melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesional secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik PPNI dan Regulasi Praktik Keperawatan

Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, praktik profesional perawat tidak berlangsung secara bebas tanpa aturan. Setiap tindakan keperawatan harus berpedoman pada kerangka normatif yang jelas, baik dari sisi etika profesi maupun dari aspek hukum. Dua instrumen utama yang menjadi dasar praktik tersebut adalah kode etik profesi yang disusun oleh organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Kedua instrumen ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai pedoman bagi perawat dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

1. Kode Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Kode Etik Keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku profesional perawat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik ini berisi prinsip, nilai, dan standar perilaku yang diharapkan dari setiap perawat sebagai anggota profesi keperawatan. Kode etik tidak sekadar berfungsi sebagai kumpulan nasihat atau rekomendasi moral, melainkan merupakan komitmen profesional perawat kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menjaga integritas profesi. Dengan kata lain, kode etik menjadi dasar moral yang membimbing perawat dalam mengambil keputusan ketika menghadapi berbagai

situasi klinis yang kompleks. Secara umum, Kode Etik PPNI (2021) mengatur lima bidang utama tanggung jawab profesional perawat, yaitu:

a. Perawat dan klien

Bagian ini menekankan kewajiban perawat untuk menghormati harkat dan martabat setiap individu yang menerima pelayanan keperawatan. Perawat harus mengakui bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang unik serta berhak memperoleh informasi yang jujur mengenai kondisi kesehatannya. Selain itu, perawat juga berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama memberikan pelayanan.

Contoh:

Perawat yang mengetahui riwayat penyakit sensitif pasien, seperti HIV atau gangguan kesehatan mental, harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak menyebarkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien.

b. Perawat dan praktik keperawatan

Kode etik juga menegaskan bahwa perawat harus senantiasa menjaga kualitas pelayanan keperawatan melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Perawat hanya diperbolehkan menerima tanggung jawab profesional yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

Contoh:

Seorang perawat tidak diperkenankan melakukan tindakan medis tertentu yang berada di luar kompetensi atau tanpa pelatihan yang memadai, karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan pasien.

c. Perawat dan masyarakat

Perawat memiliki tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran ini dapat diwujudkan melalui kegiatan promosi kesehatan, edukasi masyarakat, maupun partisipasi dalam program kesehatan publik.

Contoh:

Perawat yang bekerja di puskesmas dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit menular atau program imunisasi masyarakat.

d. Perawat dan rekan sejawat

Kode etik juga menekankan pentingnya hubungan profesional yang harmonis antara sesama tenaga kesehatan. Perawat diharapkan mampu bekerja secara kolaboratif dengan rekan sejawat serta menjaga integritas profesi dengan mencegah atau melaporkan praktik yang tidak etis.

Contoh:

Apabila seorang perawat mengetahui adanya tindakan yang berpotensi

membahayakan pasien akibat kelalaian rekan kerja, ia memiliki kewajiban moral untuk melaporkan atau menindaklanjuti situasi tersebut secara profesional.

e. Perawat dan profesi

Sebagai bagian dari profesi keperawatan, setiap perawat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan organisasi profesi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian, pendidikan berkelanjutan, maupun partisipasi dalam kegiatan organisasi profesi.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Apabila kode etik mencerminkan dimensi moral dari praktik keperawatan, maka regulasi hukum memberikan legitimasi formal dan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dalam menjalankan profesinya. Salah satu regulasi penting yang secara khusus mengatur praktik keperawatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Meskipun sistem hukum kesehatan nasional saat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan dalam UU Keperawatan tetap menjadi referensi penting dalam memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab profesional perawat.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam regulasi tersebut antara lain:

1. Registrasi dan perizinan praktik

Undang-undang menetapkan bahwa setiap perawat yang melakukan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Kedua dokumen ini menjadi bukti bahwa seorang perawat telah memenuhi standar kompetensi serta memperoleh izin resmi untuk memberikan pelayanan keperawatan. Melakukan praktik tanpa izin yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius.

2. Wewenang dan tanggung jawab profesional

Regulasi ini juga menjelaskan batasan kewenangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Undang-undang membedakan antara tindakan keperawatan yang dilakukan secara mandiri dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan delegasi atau mandat dari dokter. Penjelasan mengenai batas kewenangan ini sangat penting dalam kasus hukum, karena dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau komplikasi medis.

3. Perlindungan hukum bagi perawat

Undang-undang juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perawat yang menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SPO). Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat bekerja secara profesional tanpa takut menghadapi tuntutan hukum selama mereka mengikuti standar yang berlaku.

Hubungan antara **Kode Etik PPNI** dan **UU Keperawatan** membentuk konsep penting yang dikenal sebagai **akuntabilitas profesional**. Dalam praktik keperawatan, setiap keputusan yang diambil oleh perawat perlu dipertimbangkan dari dua dimensi utama, yaitu dimensi hukum dan dimensi etika.

1. Dimensi Legal (Regulasi Hukum): Dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai kewenangan hukum seorang perawat dalam melakukan suatu tindakan. Perawat harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berada dalam lingkup kewenangan profesional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila seorang perawat memberikan obat keras tanpa instruksi atau delegasi dari dokter, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum meskipun tujuannya untuk membantu pasien.
2. Dimensi Etik (Kode Etik Profesi): Dimensi etik berkaitan dengan cara perawat menjalankan tindakan profesional dengan tetap menghormati martabat dan hak pasien. Suatu tindakan mungkin secara hukum diperbolehkan, tetapi dapat dianggap tidak etis apabila dilakukan tanpa empati, komunikasi yang baik, atau tanpa menghormati privasi pasien. Sebagai contoh, seorang perawat mungkin memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu, tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sikap tidak menghargai pasien atau tanpa menjelaskan prosedur terlebih dahulu, maka tindakan tersebut dapat melanggar prinsip etika profesi.

Aktivitas 2 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Pasien dengan penyakit terminal membutuhkan komunikasi terbuka mengenai kondisi kesehatannya. Berdasarkan ketentuan dalam UU Keperawatan, pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi medisnya. Di sisi lain, Kode Etik PPNI juga menegaskan bahwa perawat berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menggunakan informasi tersebut secara bijaksana demi kepentingan pasien.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana perawat dapat menyeimbangkan antara kewajiban memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pasien (sesuai UU Keperawatan) dengan kewajiban menjaga kerahasiaan serta mempertimbangkan kondisi psikologis pasien menurut Kode Etik PPNI?
2. Dalam kondisi pasien terminal, apakah perawat sebaiknya menyampaikan seluruh informasi terkait prognosis secara langsung, atau mempertimbangkan kesiapan emosional pasien? Jelaskan dasar etik dan profesional dari keputusan tersebut.

3. Sejauh mana perawat boleh terlibat dalam membantu pasien memahami dan mengambil keputusan terkait kondisi terminalnya, tanpa melampaui batas kewenangan atau memengaruhi otonomi pasien?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan argumen kelompok Anda dalam bentuk debat terbuka di kelas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa profesionalisme dalam praktik keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan klinis semata, tetapi juga oleh kesadaran terhadap dimensi etika dan hukum yang mengatur profesi tersebut. Seorang perawat profesional harus mampu menjalankan praktiknya dengan mematuhi regulasi pemerintah sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang tercermin dalam kode etik profesi. Dengan memahami dan menerapkan kedua instrumen tersebut, perawat tidak hanya dapat meminimalkan risiko terjadinya sengketa medis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

Dalam praktik pelayanan kesehatan, relasi antara etik dan hukum sering menjadi landasan penting yang memengaruhi bagaimana tenaga kesehatan bersikap serta mengambil keputusan terhadap pasien. Secara konseptual, etika profesi kesehatan berkembang dari konsensus internal komunitas profesi yang berakar pada nilai moral universal, seperti *beneficence* (berbuat baik) dan *non-maleficence* (tidak menimbulkan bahaya). Etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional berdasarkan kesadaran nurani dan komitmen terhadap keluhuran profesi. Notoatmodjo (2018) dalam *Etika dan Hukum Kesehatan* menjelaskan bahwa etika dapat dipahami sebagai bentuk "hukum internal" yang otonom karena kekuatan normatifnya bersumber dari pengakuan profesi serta tanggung jawab moral individu terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan etika, hukum kesehatan merupakan seperangkat norma yang dibentuk oleh negara dan diberlakukan secara formal kepada seluruh warga negara. Karakter hukum bersifat heteronom karena kekuatan mengikatnya berasal dari otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban sosial serta kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.

Perbedaan mendasar antara keduanya juga tercermin dalam standar penilaian terhadap suatu tindakan profesional. Pelanggaran etik biasanya berkaitan dengan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan martabat profesi atau tidak mencerminkan

integritas moral, meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian materiil bagi pasien. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan dalam penilaian etik cenderung bersifat kualitatif, yaitu menilai apakah suatu tindakan tergolong baik atau buruk dalam perspektif moral profesi. Sebaliknya, pelanggaran hukum dinilai berdasarkan norma positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga tolok ukurnya lebih tegas dan bersifat legal formal, yakni apakah suatu tindakan dinilai benar atau salah menurut hukum yang berlaku. Hanafiah dan Amir (2019) dalam *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* menegaskan bahwa hukum pada dasarnya menetapkan batas minimal perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan etika profesi justru menuntut standar moral yang lebih tinggi dari seorang praktisi kesehatan.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada mekanisme penegakan norma. Pelanggaran etik biasanya ditangani oleh lembaga internal profesi, misalnya Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) dalam profesi keperawatan, melalui proses pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk menjaga martabat serta kredibilitas profesi. Sebaliknya, pelanggaran hukum diproses melalui sistem peradilan umum, baik pidana maupun perdata, yang berjalan secara terbuka dan mengikuti prosedur hukum acara yang ketat. Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua mekanisme tersebut tidak selalu berjalan secara terpisah. Penelitian Suhartini et al. (2021) dalam jurnal *Law and Justice* menunjukkan bahwa kasus kelalaian medis sering kali diproses secara paralel dalam ranah etik dan hukum sekaligus, karena tindakan yang sama dapat melanggar standar moral profesi sekaligus aturan hukum yang berlaku.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan pemberian sanksi. Sanksi etik pada dasarnya bersifat pembinaan dan rehabilitatif, karena tujuan utamanya adalah memperbaiki sikap profesional agar kembali selaras dengan nilai moral profesi. Bentuknya dapat berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan keanggotaan profesi. Sebaliknya, sanksi hukum memiliki karakter punitif dan restoratif. Dalam ranah pidana, sanksi diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap negara melalui hukuman atau denda, sedangkan dalam hukum perdata fokus utamanya adalah pemulihan hak pasien melalui mekanisme ganti rugi. Priharjo (2020) dalam *Etika Keperawatan* menegaskan bahwa meskipun memiliki fungsi yang berbeda, etika dan hukum sebenarnya saling melengkapi dalam menjamin perlindungan pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan.

Hubungan antara etik dan hukum juga bersifat dinamis karena banyak norma hukum yang pada awalnya berasal dari prinsip etik profesi. Fenomena ini sering disebut sebagai proses “legalisasi etik”, yaitu ketika nilai moral yang sebelumnya hanya menjadi pedoman profesi kemudian diadopsi ke dalam peraturan hukum formal. Contohnya dapat dilihat pada kewajiban menjaga kerahasiaan medis dan praktik *informed consent*, yang awalnya merupakan norma etik tetapi kemudian dilembagakan dalam

regulasi karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan publik. Widodo dan Handayani (2022) dalam *Jurnal Medika Hukum* menjelaskan bahwa negara cenderung melakukan intervensi terhadap norma etik apabila pelanggaran terhadap norma tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan masyarakat.

Dalam konteks praktik keperawatan sehari-hari, relasi antara etik dan hukum dapat terlihat melalui berbagai situasi klinis. Misalnya, seorang perawat yang berkomunikasi dengan sikap tidak empatik atau menggunakan nada kasar kepada pasien lanjut usia mungkin tidak melanggar hukum selama tindakan keperawatan yang diberikan tetap sesuai standar klinis, tetapi perilaku tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran etik karena bertentangan dengan prinsip *caring*. Sebaliknya, kesalahan dalam pemberian dosis obat akibat kelalaian dalam melakukan identifikasi pasien dapat masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum karena mengandung unsur *negligence* yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik bagi pasien. Dalam hal ini, Simamora (2019) menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip etik sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan awal agar tenaga kesehatan tidak terjatuh dalam persoalan hukum di kemudian hari.

Tabel 7. 2 Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

No	Aspek Perbandingan	Pelanggaran Etik (Ethical Misconduct)	Pelanggaran Hukum (Legal Breach)
1	Sumber Norma	Kode Etik Profesi (misal: Kode Etik PPNI) dan konsensus moral profesi.	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan regulasi negara lainnya.
2	Sifat Keberlakuan	Otonom: Berlaku khusus untuk anggota profesi tertentu.	Heteronom: Berlaku umum bagi seluruh warga negara atau subjek hukum.
3	Tolok Ukur	Baik atau Buruk (<i>Good or Bad</i>) berdasarkan nilai keluhuran budi.	Benar atau Salah (<i>Right or Wrong</i>) berdasarkan hukum positif.

No	Aspek Perbandingan	Pelanggaran Etik (Ethical Misconduct)	Pelanggaran Hukum (Legal Breach)
4	Tujuan Utama	Menjaga martabat, kehormatan, dan integritas moral profesi.	Menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial.
5	Bentuk Pelanggaran	Perilaku tidak pantas, kurang empati, atau mengabaikan janji profesi.	Malpraktik, kelalaian (<i>negligence</i>), atau pelanggaran administrasi/pidana.
6	Institusi Penegak	Majelis Kehormatan Etik (MKEK) atau Komite Keperawatan RS.	Pengadilan Negeri (Ranah Pidana/Perdata) atau PTUN.
7	Sifat Persidangan	Tertutup dan rahasia (untuk menjaga marwah profesi).	Terbuka untuk umum (sesuai asas hukum acara).
8	Bentuk Sanksi	Pembinaan, teguran lisan/tertulis, hingga pencabutan keanggotaan.	Denda, ganti rugi materiil, penjara, atau pencabutan STR/SIP.
9	Penyelesaian	Diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui sidang etik profesi.	Diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi hukum).

Hubungan antara Norma Etik, Norma Hukum, dan Standar Profesi

Dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya di bidang keperawatan, norma etik, norma hukum, dan standar profesi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Ketiganya membentuk suatu sistem normatif yang bekerja secara simultan untuk menjamin kualitas pelayanan sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pasien. Secara konseptual,

hubungan ini dapat dianalogikan sebagai sebuah struktur bangunan: etika berperan sebagai landasan moral yang menopang sikap profesional, standar profesi berfungsi sebagai kerangka teknis yang mengarahkan praktik klinis, sedangkan hukum menjadi perangkat pengatur yang memberikan batasan sekaligus perlindungan agar praktik pelayanan kesehatan tetap berada dalam koridor keselamatan publik. Melalui keterpaduan ini, praktik keperawatan tidak hanya berorientasi pada ketepatan tindakan klinis, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hubungan tersebut, standar profesi menempati posisi penting sebagai penghubung operasional antara nilai moral dan ketentuan hukum. Standar profesi yang meliputi standar kompetensi, standar praktik keperawatan, seperti Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) serta Standar Prosedur Operasional (SPO), berfungsi menerjemahkan prinsip-prinsip etik ke dalam langkah-langkah tindakan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Simamora (2019) dalam *Buku Ajar Etika Keperawatan* menjelaskan bahwa standar profesi merupakan bentuk konkret dari kewajiban moral profesi yang dirumuskan dalam prosedur tindakan klinis yang terukur dan dapat dievaluasi. Dengan mengikuti standar tersebut, seorang perawat pada dasarnya telah menjalankan prinsip etik seperti *beneficence* (memberikan manfaat bagi pasien) serta *non-maleficence* (menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya). Selain itu, kepatuhan terhadap standar profesi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam konteks sengketa medis, standar profesi sering menjadi acuan utama dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau masih berada dalam batas praktik profesional yang wajar.

Keterkaitan antara etika, standar profesi, dan hukum juga menunjukkan sifat yang dinamis melalui proses institusionalisasi norma. Banyak ketentuan yang pada awalnya hanya berupa pedoman etik atau standar profesional kemudian diadopsi menjadi aturan hukum formal oleh negara. Salah satu contohnya adalah kewajiban melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif dan mendokumentasikan setiap tindakan asuhan secara sistematis. Praktik tersebut pada awalnya merupakan tuntutan profesional dan moral dalam praktik keperawatan, tetapi kini telah dilembagakan dalam berbagai regulasi kesehatan, termasuk dalam undang-undang yang mengatur praktik keperawatan. Widodo dan Handayani (2022) dalam *Jurnal Medika Hukum* menyatakan bahwa standar profesi sering dijadikan tolok ukur oleh sistem hukum untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan (*culpa*) dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, standar profesi tidak hanya berfungsi sebagai panduan praktik,

tetapi juga sebagai parameter hukum dalam menilai tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.

Pemahaman terhadap hubungan triadik antara norma etik, norma hukum, dan standar profesi memiliki implikasi penting bagi kualitas praktik keperawatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2022) menunjukkan bahwa perawat yang memahami keterkaitan ketiga unsur tersebut cenderung menunjukkan kinerja klinis yang lebih konsisten dan bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya bekerja berdasarkan kepatuhan terhadap aturan hukum semata, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berintegritas. Dalam kerangka ini, etika berperan sebagai sumber motivasi internal yang membentuk komitmen moral perawat, standar profesi menyediakan panduan teknis yang memastikan kualitas tindakan klinis, sedangkan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang menjamin akuntabilitas praktik pelayanan kesehatan. Ketiganya, dengan demikian, membentuk sistem yang saling melengkapi dalam menjaga profesionalisme dan keselamatan pasien.

Tabel 7. 3 Hubungan Triadik Norma Etik, Standar Profesi, dan Norma Hukum

Unsur	Fungsi Utama	Sifat Hubungan	Konsekuensi Pelanggaran
Norma Etik	Menentukan arah moral dan nilai-nilai luhur profesi.	Memberikan jiwa/ruh bagi standar profesi dan hukum.	Sanksi moral, beban hati nurani, dan sanksi organisasi.
Standar Profesi	Memberikan panduan teknis dan kompetensi operasional.	Menjadi tolok ukur nyata dalam menilai etis/tidaknya tindakan.	Penurunan kredibilitas profesi dan bukti awal kelalaian hukum.
Norma Hukum	Memberikan batasan minimal dan kepastian perlindungan.	Menjamin bahwa standar profesi ditaati demi keselamatan publik.	Sanksi pidana, perdata (ganti rugi), atau administratif (cabut izin).

Prinsip Etik dalam Analisis Kasus

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, perawat sering menghadapi situasi klinis yang kompleks dan menuntut pengambilan keputusan yang tidak hanya tepat secara ilmiah, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Prinsip-prinsip bioetik menjadi kerangka konseptual yang membantu tenaga kesehatan mengevaluasi berbagai dilema moral yang muncul dalam praktik klinis. Beauchamp dan Childress melalui pendekatan *principlism* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis dalam pelayanan kesehatan berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Dalam perkembangan praktik keperawatan, dua prinsip tambahan yaitu *veracity* dan *fidelity* juga sering digunakan untuk memperkuat dimensi komunikasi serta komitmen profesional tenaga kesehatan (Varkey, 2021).

Prinsip bioetik modern menyediakan bahasa yang seragam bagi tenaga kesehatan untuk mendiskusikan dilema moral. Berdasarkan pemikiran Simamora (2019) dalam *Buku Ajar Etika Keperawatan*, terdapat enam pilar utama yang menjadi standar emas dalam analisis kasus:

1. **Autonomy (Otonomi):** Prinsip ini menghormati hak pasien sebagai individu yang memiliki kedaulatan penuh untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri. Dalam keperawatan, otonomi mewujudkan dalam pelaksanaan *Informed Consent*. Perawat berperan sebagai advokat yang memastikan pasien menerima informasi yang cukup dan jujur sebelum memberikan persetujuan, tanpa adanya paksaan atau manipulasi informasi.
2. **Beneficence (Berbuat Baik):** Kewajiban moral ini menuntut perawat untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Tindakan ini melampaui sekadar menjalankan tugas; ia mencakup upaya preventif dan promotif demi kesejahteraan holistik pasien. Menurut Hanafiah & Amir (2019), *beneficence* harus selalu diseimbangkan dengan otonomi agar tidak terjebak dalam perilaku paternalisme (memaksa kebaikan menurut pandangan perawat saja).
3. **Non-maleficence (Tidak Merugikan):** Prinsip ini merupakan turunan dari sumpah *Primum non nocere*, yang menekankan bahwa hal pertama yang harus dipastikan adalah tidak mencederai pasien. Dalam analisis kasus, perawat harus menimbang risiko dari setiap intervensi. Jika suatu tindakan medis memiliki efek samping, maka manfaatnya harus jauh lebih besar daripada potensi bahaya yang ditimbulkan.
4. **Justice (Keadilan):** Keadilan dalam bioetik merujuk pada distribusi sumber daya kesehatan yang merata dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Perawat dituntut untuk memberikan asuhan berdasarkan kebutuhan klinis pasien, bukan berdasarkan status sosial, suku, agama, atau kemampuan finansial.

5. Veracity (Kejujuran): Kejujuran adalah fondasi dari hubungan saling percaya (*trust*) antara perawat dan pasien. Menyampaikan kebenaran mengenai kondisi medis, risiko prosedur, hingga kesalahan medis (*medical error*) adalah keharusan etis. Ketidakjujuran, meskipun tujuannya "melindungi" perasaan pasien, sering kali berujung pada pelanggaran hak pasien untuk mengetahui realitas kesehatannya.
6. Fidelity (Kesetiaan/Komitmen Profesional): Prinsip ini menekankan pada ketaatan perawat terhadap janji dan komitmen profesionalnya. Hal ini mencakup menjaga rahasia pasien, menepati janji kunjungan, serta tetap setia pada standar asuhan meskipun dalam situasi yang menekan. Priharjo (2020) menyebutkan bahwa *fidelity* adalah lem yang merekatkan hubungan perawat-pasien dalam jangka panjang.

Dilema Etik dalam Praktik Keperawatan

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dilema etika dalam praktik keperawatan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi medis, keterbatasan sumber daya kesehatan, serta meningkatnya tuntutan terhadap keselamatan pasien. Studi oleh Epstein et al. (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% perawat rumah sakit pernah mengalami dilema etika terkait konflik antara kepentingan pasien dan kebijakan institusi kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan analisis bioetik dalam praktik profesional perawat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Whitehead et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan kerangka analisis etika seperti *Four Box Method* mampu membantu tenaga kesehatan melakukan evaluasi sistematis terhadap kasus klinis dengan mempertimbangkan empat dimensi utama yaitu indikasi medis, preferensi pasien, kualitas hidup, dan faktor kontekstual. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pendidikan kesehatan dan praktik klinis untuk membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan yang seimbang antara aspek medis, etika, dan hukum.

Profesionalisme bukan hanya tentang keahlian teknis (*skill*), melainkan integrasi antara kompetensi, tanggung jawab sosial, dan etika kerja. Nilai-nilai profesionalisme keperawatan mencakup altruisme (mengutamakan kepentingan orang lain), integritas, dan akuntabilitas. Penelitian oleh Hidayat et al. (2022) dalam *Journal of Health Science and Prevention* menunjukkan bahwa profesionalisme perawat berkorelasi positif dengan keselamatan pasien. Profesionalisme menuntut perawat untuk berani mengambil keputusan mandiri yang berbasis bukti (*evidence-based*) sambil tetap menjunjung tinggi kode etik yang berlaku.

Salah satu tantangan paling berat dalam praktik keperawatan modern adalah *moral distress*. Kondisi ini terjadi ketika seorang perawat mengetahui tindakan etis yang "benar" untuk dilakukan, namun merasa tidak berdaya atau terhambat oleh kendala institusional, kebijakan rumah sakit, atau struktur kekuasaan medis untuk

melaksanakannya. Menurut studi oleh Suhartini et al. (2021), *moral distress* yang berkepanjangan dapat memicu kelelahan emosional (*burnout*) dan penurunan kualitas asuhan. Contoh nyata adalah ketika seorang perawat merasa bahwa melanjutkan terapi agresif pada pasien terminal hanya akan memperpanjang penderitaan (melanggar *non-maleficence*), namun ia dipaksa oleh kebijakan rumah sakit atau permintaan keluarga untuk tetap melakukannya. Ketegangan antara suara hati nurani dan tekanan eksternal inilah yang menjadi inti dari distres moral.

Contoh kasus dan analisis bioetik dalam praktik keperawatan tersaji pada Tabel 7.4.

Tabel 7. 4 Contoh Kasus Bioetik dalam Praktik Keperawatan

Kasus	Vignette	Autonomy	Beneficence	Non-maleficence	Justice
Unit Perawatan Intensif atau ICU merupakan salah satu lingkungan klinis yang paling sering menghadapi dilema etika bagi perawat. Pasien yang dirawat di ICU umumnya berada	Seorang pasien dengan gagal napas berat berada dalam kondisi koma dan bergantung pada ventilator mekanik. Tim medis menilai bahwa kemungkinan pemulihan pasien sangat kecil. Namun, keluarga pasien meminta agar semua terapi tetap dilanjutkan.	Pasien tidak mampu menyampaikan preferensi sehingga keputusan diwakili oleh keluarga.	Tim medis berusaha memberikan terapi terbaik bagi pasien.	Terapi agresif yang berkelanjutan berpotensi memperpanjang penderitaan pasien.	Penggunaan sumber daya ICU yang terbatas harus dipertimbangkan.

dalam kondisi kritis sehingga memerlukan intervensi medis yang kompleks dan seringkali melibatkan keputusan mengenai keberlanjutan terapi. Penelitian oleh Prentice et al. (2021) menunjukkan bahwa dilema etika yang paling sering dialami perawat ICU berkaitan dengan keputusan untuk melanjutkan atau					
--	--	--	--	--	--

menghent ikan terapi penunjan g hidup (<i>life- sustaining treatment</i>) . Penelitian oleh McAndre w et al. (2022) menunjuk kan bahwa konflik seperti ini sering memicu moral distress pada perawat ICU karena mereka merasa tindakan yang dilakukan tidak selalu selaras dengan kepenting an terbaik pasien.					
---	--	--	--	--	--

Perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal. Dalam konteks ini, dilema etika sering muncul terkait keputusan mengenai penghentian terapi kuratif dan fokus pada perawatan suportif. Penelitian oleh Hui et al. (2023) menunjukkan bahwa komunikasi	Seorang pasien kanker stadium akhir mengalami nyeri hebat dan kondisi fisiknya semakin menurun. Dokter merekomendasikan perawatan paliatif dan menghentikan terapi kemoterapi yang sudah tidak efektif. Namun keluarga pasien tetap meminta terapi agresif.	Keputusan pasien mengenai perawatan akhir hidup harus dihormati.	Perawatan paliatif bertujuan meningkatkan kenyamanan pasien.	Terapi agresif dapat meningkatkan penderitaan tanpa manfaat signifikan.	Penggunaan terapi yang tidak efektif dapat mengurangi akses pasien lain terhadap sumber daya kesehatan. Penelitian oleh Robinson et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi empatik antara perawat dan keluarga pasien dapat membantu menyelesaikan konflik etika dalam perawatan paliatif.
---	---	--	--	---	--

si antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan etis pada perawatan paliatif.					
Praktik keperawatan pada pasien anak menghadapi tantangan etika tersendiri karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan medis. Penelitian	Seorang anak dengan leukemia membutuhkan transfusi darah untuk mempertahankan hidupnya. Namun orang tua menolak tindakan tersebut karena alasan kepercayaan agama.	Hak orang tua untuk mengambil keputusan bagi anak.	Transfusi darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa anak.	Penolakan transfusi dapat membahayakan pasien.	Negara memiliki kewajiban melindungi hak anak untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Penelitian oleh Unguru et al. (2020) menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini tenaga kesehatan dapat melibatkan komite etik rumah sakit

oleh Coyne et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik pediatrik sering terjadi konflik antara kepentingan terbaik anak (<i>best interest of the child</i>) dan keputusan orang tua.					atau sistem hukum untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.
--	--	--	--	--	--

Tabel 7. 5 Contoh Pelanggaran/Dilema dalam Penerapan Prinsip Bioetik

Prinsip	Definisi Operasional	Contoh Pelanggaran/Dilema
Autonomy	Menghargai keputusan mandiri pasien.	Memasang NGT pada pasien sadar tanpa izin.
Beneficence	Melakukan tindakan untuk kebaikan pasien.	Melakukan mobilisasi dini pasca operasi demi pemulihan.
Non-maleficence	Menghindari cedera atau bahaya.	Mengabaikan sisi tempat tidur yang terbuka pada pasien risiko jatuh.

Prinsip	Definisi Operasional	Contoh Pelanggaran/Dilema
Justice	Alokasi sumber daya yang adil.	Mengutamakan pasien VIP dibandingkan pasien BPJS dengan kondisi lebih kritis.
Veracity	Menyampaikan informasi yang benar.	Menyembunyikan kesalahan dosis obat dari pasien dan dokter.
Fidelity	Menepati janji dan kerahasiaan.	Menceritakan riwayat penyakit pasien di kantin rumah sakit.

Integrasi Aspek Hukum

Dalam diskursus hukum kesehatan modern, etika dan hukum sering dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam praktik pelayanan medis. Etika memberikan pedoman normatif mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan hukum menentukan batasan formal mengenai tindakan yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh sistem hukum. Dengan kata lain, etika berorientasi pada standar moral profesional, sedangkan hukum menyediakan mekanisme regulatif yang memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan klinis yang etis harus selalu mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara moral tetapi juga memiliki legitimasi yuridis (Varkey, 2021; Dunn, 2024). Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, tenaga kesehatan sering menghadapi situasi yang menuntut integrasi antara pertimbangan etik dan kepatuhan terhadap hukum kesehatan.

Keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan etik tanpa memperhatikan regulasi hukum dapat menimbulkan risiko tuntutan pidana maupun perdata. Sebaliknya, keputusan yang semata-mata berorientasi pada aspek hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etik berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, integrasi antara etika dan hukum menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan klinis yang profesional dan bertanggung jawab (O'Mathúna, 2022). Langkah pertama dalam mengintegrasikan aspek hukum ke dalam pengambilan keputusan etik adalah mengidentifikasi regulasi yang relevan dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan perlu memahami hierarki regulasi yang mengatur praktik pelayanan kesehatan, mulai dari

undang-undang nasional hingga kebijakan internal institusi pelayanan kesehatan. Pada tingkat makro, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, serta standar pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini memperkuat perlindungan terhadap hak pasien, termasuk hak untuk memperoleh informasi medis dan hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan medis (Fatkhullah, 2026). Selain itu, terdapat berbagai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur aspek teknis dalam praktik medis, seperti regulasi mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*), pengelolaan rekam medis, serta standar pelayanan kesehatan. Regulasi ini memberikan panduan operasional bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat institusi, fasilitas pelayanan kesehatan biasanya memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berfungsi sebagai pedoman internal bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. SPO membantu memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi dan kebijakan institusi. Penelitian mengenai praktik *informed consent* di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman tenaga kesehatan terhadap regulasi hukum sangat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis (Hanif, 2023; Dewi & Christianto, 2023).

Analisis Potensi Konsekuensi Hukum

Setiap keputusan klinis yang diambil oleh tenaga kesehatan memiliki potensi konsekuensi hukum. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan etik, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan kemungkinan dampak hukum dari tindakan medis yang dilakukan. Dalam hukum kesehatan, konsekuensi tersebut dapat muncul dalam tiga ranah utama, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Ranah pidana berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur kelalaian (*culpa*) dalam tindakan medis yang menyebabkan kerugian serius bagi pasien, seperti kecacatan atau kematian. Dalam situasi tertentu, tindakan medis yang dilakukan secara lalai dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana maupun regulasi kesehatan. Ranah perdata berkaitan dengan kemungkinan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pasien atau keluarga pasien. Gugatan ini biasanya didasarkan pada konsep wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila tindakan tenaga kesehatan dianggap menimbulkan kerugian bagi pasien. Ranah administratif berkaitan dengan sanksi disiplin yang dapat diberikan oleh otoritas kesehatan atau organisasi profesi, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP), sanksi profesi, atau penurunan status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam literatur hukum kesehatan, analisis terhadap potensi konsekuensi hukum tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan tenaga kesehatan. Sebaliknya, pemahaman terhadap

konsekuensi hukum bertujuan memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan agar dapat mengambil keputusan klinis secara profesional dan bertanggung jawab (Pont et al., 2025).

Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Dalam praktik pelayanan kesehatan, terutama dalam pengambilan keputusan kolektif seperti sidang komite etik rumah sakit, prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting. Hukum kesehatan mengenal beberapa konsep tanggung jawab yang berkaitan dengan praktik medis.

1. *Personal liability*, yaitu tanggung jawab individual yang melekat pada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis secara langsung. Dalam konsep ini, tenaga kesehatan bertanggung jawab atas keputusan klinis yang diambil berdasarkan kompetensi profesionalnya.
2. *Vicarious liability*, yaitu tanggung jawab institusi terhadap tindakan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungannya. Dalam konteks rumah sakit, institusi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien akibat tindakan tenaga kesehatan yang bekerja di dalam organisasi tersebut.
3. Akuntabilitas profesional, yaitu kewajiban tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang diambil kepada organisasi profesinya. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui lembaga etik profesi seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau Majelis Kehormatan Etik Keperawatan.

Penelitian mengenai pengambilan keputusan etik dalam praktik keperawatan menunjukkan bahwa akuntabilitas profesional merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa keputusan klinis diambil secara transparan dan sesuai dengan standar profesi (Chen et al., 2025).

Dokumentasi sebagai Bukti Hukum

Dalam praktik hukum kesehatan, dokumentasi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis. Terdapat prinsip hukum yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak didokumentasikan secara tertulis dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, dokumentasi yang akurat dan sistematis merupakan bagian integral dari praktik profesional tenaga kesehatan. Dokumentasi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun institusi pelayanan kesehatan. Rekam medis, catatan tindakan medis, serta dokumentasi hasil diskusi komite etik dapat menjadi alat bukti utama dalam proses persidangan. Konsep ***informed consent*** merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang memiliki nilai hukum penting dalam praktik pelayanan kesehatan. Persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh informasi yang memadai tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap prinsip otonomi pasien, tetapi juga berfungsi

sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Firma, 2025). Selain itu, dokumentasi yang baik mencerminkan transparansi proses pengambilan keputusan klinis. Catatan mengenai alasan etik dan pertimbangan hukum di balik suatu tindakan medis dapat menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil melalui proses deliberasi yang rasional dan profesional.

Dalam praktik klinis, integrasi antara model analisis etik dan pertimbangan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar moral dan legal yang kuat. Dalam **Model Enam Langkah Analisis Etik**, aspek hukum biasanya dianalisis pada tahap identifikasi masalah serta pada tahap evaluasi dan dokumentasi keputusan. Sementara itu, dalam **Model Four-Box**, dimensi hukum sering muncul dalam komponen faktor kontekstual yang mencakup regulasi kesehatan, kebijakan institusi, serta potensi risiko hukum dari suatu tindakan medis. Dengan demikian, integrasi antara analisis etik dan pertimbangan hukum memungkinkan tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis yang tidak hanya sesuai dengan prinsip bioetika seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, tetapi juga sejalan dengan regulasi hukum yang berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan (Dunn, 2024). Tanpa dokumentasi yang memadai dan kejelasan tanggung jawab, bahkan keputusan etik yang paling baik sekalipun dapat menjadi rentan ketika diuji dalam proses hukum. Oleh karena itu, setiap proses analisis etik dalam pelayanan kesehatan idealnya diakhiri dengan dokumentasi resmi yang merangkum fakta klinis, dasar hukum, serta pertimbangan etik yang melandasi keputusan tersebut.

Dinamika pelayanan kesehatan modern saat ini berkembang dalam lanskap yang semakin kompleks dan menuntut efisiensi tinggi dalam setiap aspek pelayanan. Institusi kesehatan tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif, tetapi juga harus menjamin keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar profesi, serta kesesuaian dengan regulasi hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, tuntutan efisiensi ini kerap kali berbenturan dengan batasan kewenangan klinis yang telah ditetapkan secara etik dan legal. Ketegangan ini menjadi semakin nyata ketika terjadi ketidakjelasan dalam pendelegasian tindakan medis kepada tenaga keperawatan, yang tidak lagi sekadar menjadi persoalan administratif, melainkan berkembang menjadi isu multidimensional yang menyentuh prinsip etik *beneficence*, *non-maleficence*, serta aspek legalitas formal dalam praktik pelayanan kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019; Nursalam, 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan yang dinamis, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan. Pada kondisi tertentu, khususnya dalam situasi kegawatdaruratan, tenaga keperawatan berada di garis depan dalam merespons perubahan kondisi pasien. Hal ini menciptakan dilema antara kewajiban moral untuk segera bertindak demi

keselamatan pasien dan kewajiban profesional untuk tetap berada dalam batas kompetensi yang dimiliki. Dilema ini memperlihatkan adanya “area abu-abu” dalam praktik klinis yang berpotensi menimbulkan konflik etik dan konsekuensi hukum apabila tidak dikelola dengan baik (Potter et al., 2021).

Fenomena ini sangat terlihat di unit-unit dengan tingkat urgensi tinggi seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU). Di unit tersebut, perawat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan awal dalam kondisi kritis. Dalam banyak kasus, perawat menerima instruksi lisan dari dokter untuk melakukan tindakan tertentu, bahkan ketika tindakan tersebut berada di luar lingkup praktik mandiri mereka. Kondisi ini sering kali diperburuk oleh keterbatasan jumlah tenaga medis, beban kerja yang tinggi, serta tekanan waktu yang mendesak, sehingga mendorong terjadinya deviasi dari standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan (Kemenkes RI, 2022).

Aktivitas 3 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang pasien perempuan, Ny. S (45 tahun), dirawat di Bangsal Penyakit Dalam dengan diagnosis gagal ginjal kronis. Pada kondisi awal, pasien berada dalam keadaan stabil, namun pada pukul 02.00 WIB terjadi perburukan kondisi secara tiba-tiba yang ditandai dengan sesak napas berat dan penurunan kesadaran. Dalam situasi tersebut, Perawat A yang bertugas segera mengambil langkah dengan menghubungi dokter jaga untuk mendapatkan instruksi medis. Namun, karena dokter jaga sedang menangani pasien lain di IGD, ia memberikan instruksi secara lisan kepada perawat untuk melakukan pemasangan kateter vena sentral (central venous catheter/CVC).

Pertanyaan Diskusi:

1. Dalam situasi kegawatdaruratan, apakah tindakan perawat yang menerima dan berpotensi melaksanakan instruksi pemasangan CVC secara lisan dari dokter dapat dibenarkan secara etik dan hukum? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip kewenangan praktik keperawatan.
2. Bagaimana seharusnya perawat menyikapi instruksi medis yang diberikan secara lisan dalam kondisi darurat, terutama untuk tindakan invasif seperti pemasangan CVC? Apa risiko hukum dan keselamatan pasien yang mungkin timbul?
3. Dalam kasus ini, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh perawat untuk menjamin keselamatan pasien tanpa melanggar batas kompetensi dan kewenangannya?

4. Bagaimana perawat menyeimbangkan prinsip **beneficence (berbuat baik)** dan **non-maleficence (tidak merugikan)** ketika harus bertindak cepat, tetapi dihadapkan pada keterbatasan instruksi yang tidak ideal?
5. Jika terjadi komplikasi akibat tindakan yang dilakukan berdasarkan instruksi lisan tersebut, siapa yang bertanggung jawab secara hukum: perawat, dokter, atau institusi? Jelaskan dasar argumentasinya.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Kaitkan jawaban Anda dengan:
 - a. UU Keperawatan
 - b. Standar Praktik Keperawatan
 - c. Kode Etik PPNI
 - d. Prinsip patient safety (WHO / nasional)
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Secara klinis dan regulatif, pemasangan CVC merupakan tindakan invasif yang memerlukan keterampilan khusus dan hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi tertentu, biasanya dokter spesialis atau tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan khusus (WHO, 2021). Dalam kondisi tekanan tinggi, Perawat A menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, terdapat dorongan kuat untuk segera bertindak demi menyelamatkan pasien, terlebih dengan adanya instruksi langsung dari dokter. Di sisi lain, terdapat kesadaran bahwa tindakan tersebut berada di luar kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya. Namun, faktor pengalaman observasional sebelumnya, rasa tanggung jawab, serta tekanan situasi darurat akhirnya mendorong perawat untuk mengambil keputusan melakukan tindakan tersebut secara mandiri tanpa supervisi.

Keputusan tersebut membawa konsekuensi serius. Selama prosedur berlangsung, terjadi komplikasi berupa pneumotoraks akibat kesalahan dalam teknik penusukan. Pneumotoraks merupakan kondisi medis yang berbahaya karena dapat menyebabkan kolaps paru dan gangguan pernapasan yang signifikan. Dalam kasus ini, kondisi pasien memburuk secara drastis dalam waktu singkat setelah tindakan dilakukan, menunjukkan adanya kegagalan dalam pelaksanaan prosedur yang berisiko tinggi tersebut. Dari sisi pengalaman subjektif, keluarga pasien menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait tindakan yang akan dilakukan, termasuk risiko yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip informed consent, yang merupakan bagian penting dalam praktik pelayanan kesehatan yang menghormati hak pasien. Sementara itu, Perawat A mengakui bahwa dirinya berada dalam tekanan situasi darurat dan merasa harus segera bertindak berdasarkan instruksi

dokter. Secara objektif, rekam medis menunjukkan tidak adanya dokumentasi informed consent yang sah untuk tindakan invasif seperti pemasangan CVC.

Selain itu, hasil pemeriksaan radiologi pasca tindakan menunjukkan adanya pneumotoraks pada paru kanan, yang menguatkan adanya komplikasi akibat prosedur yang tidak dilakukan sesuai standar. Fakta ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem dokumentasi dan kepatuhan terhadap SOP yang seharusnya menjadi bagian integral dari praktik pelayanan kesehatan (Joint Commission International, 2020). Kasus ini memunculkan konflik etik yang mendalam, terutama antara prinsip beneficence dan non-maleficence. Prinsip beneficence menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk berbuat baik dan memberikan manfaat bagi pasien, sedangkan prinsip non-maleficence menekankan kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya. Dalam kasus ini, niat awal perawat untuk membantu pasien merupakan manifestasi dari beneficence, namun tindakan yang dilakukan justru melanggar non-maleficence karena menimbulkan risiko dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi pasien (Beauchamp & Childress, 2019). Selain itu, prinsip autonomy juga tidak terpenuhi. Pasien dan keluarga tidak diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan terkait tindakan yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat sekalipun, penghormatan terhadap hak pasien tetap harus dijaga, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mengancam nyawa dan tidak memungkinkan adanya persetujuan (Gillon, 2018).

Dari perspektif hukum, kasus ini berpotensi dikategorikan sebagai kelalaian (negligence) atau bahkan malpraktik. Berdasarkan regulasi di Indonesia, tenaga kesehatan hanya diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangannya dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, namun tetap harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Dalam kasus ini, pemasangan CVC tidak termasuk dalam tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat umum, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kompetensi. Selain itu, terdapat potensi liabilitas perdata, di mana pasien atau keluarga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan yang tidak sesuai standar. Rumah sakit sebagai institusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan sistem yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut. Dari sisi administratif, ketiadaan dokumentasi pendelegasian yang sah juga merupakan pelanggaran terhadap standar akreditasi rumah sakit (KARS, 2022).

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan reflektif yang penting dalam praktik pelayanan kesehatan. Apakah urgensi klinis dapat dijadikan justifikasi untuk melanggar batas kompetensi? Bagaimana seharusnya tenaga kesehatan menyeimbangkan antara loyalitas terhadap instruksi dokter dan kepatuhan

terhadap standar hukum dan etik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa praktik pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan moral dan hukum. Analisis sistematis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kegagalan sistem pendelegasian (*delegation failure*), bukan semata-mata kesalahan individu. Instruksi lisan untuk tindakan berisiko tinggi tanpa supervisi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip keselamatan pasien. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur pendelegasian tindakan medis (ANA, 2021). Dari sisi etik, perawat memiliki kewajiban untuk menjaga standar profesi dan menolak tindakan yang berada di luar kompetensinya. Dalam kasus ini, tindakan Perawat A dapat dilihat sebagai bentuk *overconfidence* yang dipengaruhi oleh tekanan situasi. Sementara itu, dari sisi hukum, regulasi di Indonesia membedakan antara pendelegasian mandat dan delegatif, yang masing-masing memiliki implikasi tanggung jawab yang berbeda. Namun, tidak semua tindakan dapat didelegasikan, terutama tindakan invasif berisiko tinggi seperti pemasangan CVC.

Sebagai alternatif solusi, terdapat beberapa langkah yang seharusnya dapat dilakukan. Pertama, penerapan protokol eskalasi yang jelas, di mana perawat dapat menghubungi dokter lain atau supervisor keperawatan ketika dokter jaga tidak tersedia. Kedua, fokus pada tindakan suportif yang berada dalam kewenangan perawat, seperti pemberian oksigen atau ventilasi manual menggunakan bag-mask. Ketiga, penguatan sistem komunikasi dan dokumentasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh lagi, institusi kesehatan perlu memperkuat budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, audit klinis, serta pengembangan sistem pelaporan insiden yang tidak bersifat menyalahkan (*no blame culture*). Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat belajar dari kesalahan tanpa takut terhadap sanksi yang tidak proporsional (WHO, 2021).

Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait, di mana kesalahan tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kegagalan sistem. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang mencakup aspek etik, hukum, dan manajerial sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dengan memperjelas batas kewenangan, memperkuat sistem pendelegasian, serta meningkatkan kesadaran etik dan hukum tenaga kesehatan, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa yang akan datang.

Aktivitas 4 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang pasien laki-laki, Tn. R (68 tahun), dirawat di unit ICU dengan diagnosis stroke hemoragik berat disertai penurunan kesadaran (GCS 6). Pasien telah menggunakan ventilator mekanik selama lima hari. Berdasarkan riwayat yang disampaikan keluarga, sebelumnya pasien pernah menyatakan tidak menghendaki tindakan resusitasi agresif apabila peluang pemulihannya sangat kecil. Memasuki hari keenam, kondisi pasien menunjukkan penurunan signifikan dengan tanda-tanda kegagalan multi organ. Dokter penanggung jawab kemudian menginformasikan rencana tindakan lanjutan berupa pemasangan akses vena sentral tambahan serta kemungkinan dilakukan resusitasi apabila terjadi henti jantung. Namun, muncul perbedaan pendapat di antara anggota keluarga: anak pertama cenderung menolak tindakan lanjutan dan memilih pendekatan paliatif, sementara anak kedua menginginkan seluruh intervensi medis tetap dilakukan.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana seharusnya perawat bersikap ketika terdapat perbedaan pendapat antar anggota keluarga terkait tindakan lanjutan, sementara pasien sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk tidak dilakukan resusitasi agresif?
2. Bagaimana perawat menerapkan prinsip autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam menentukan pendekatan yang tepat antara perawatan paliatif dan intervensi agresif pada kondisi pasien tersebut?
3. Sejauh mana perawat dapat berperan sebagai advokat pasien dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap menghormati keinginan pasien, meskipun terjadi konflik dalam keluarga?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan argumen kelompok Anda dalam bentuk debat terbuka di kelas.

Analisis Langkah demi Langkah

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengenali bahwa kasus ini melibatkan berbagai dimensi sekaligus, mulai dari aspek klinis hingga persoalan etik, hukum, dan komunikasi. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama, namun tidak boleh mengabaikan hak pasien dan keluarganya. Selanjutnya, perawat harus memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah. Karena pasien tidak sadar, maka keputusan berada pada keluarga, namun tetap harus melalui kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi. Langkah berikutnya, perawat perlu bersikap profesional dengan tidak melaksanakan instruksi medis yang belum memiliki landasan hukum yang kuat, terutama untuk

tindakan invasif yang berisiko tinggi. Selain itu, menjaga kerahasiaan informasi pasien menjadi kewajiban penting. Informasi hanya boleh diberikan kepada pihak yang berhak dan sesuai dengan kesepakatan keluarga.

Dalam konteks pengambilan keputusan akhir kehidupan (end-of-life decision), perawat memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara tim medis dan keluarga agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kualitas hidup pasien.

Secara etik, kasus ini berkaitan dengan beberapa prinsip utama:

1. Autonomy, yaitu penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan tindakan medis, yang dalam kondisi ini diwakili oleh keluarga.
2. Beneficence, yaitu upaya memberikan manfaat terbaik bagi pasien.
3. Non-maleficence, yaitu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya.
4. Confidentiality, yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien.

Dari sisi hukum, terdapat beberapa aspek yang relevan:

1. Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) merupakan syarat wajib sebelum tindakan dilakukan.
2. Penolakan tindakan medis harus dihormati apabila disampaikan secara sah.
3. Pendelegasian tindakan harus sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Tindakan yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau malpraktik.
5. Kerahasiaan pasien dilindungi oleh regulasi dan kode etik profesi.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menginisiasi diskusi keluarga yang difasilitasi oleh tim medis untuk mencapai kesepakatan bersama terkait rencana perawatan.
2. Menunda tindakan invasif hingga persetujuan yang jelas dan terdokumentasi diperoleh.
3. Mempertimbangkan pendekatan paliatif apabila kondisi pasien tidak menunjukkan harapan pemulihan yang signifikan.
4. Melibatkan komite etik rumah sakit apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara internal.
5. Menyampaikan informasi medis secara selektif kepada pihak yang berwenang guna menjaga kerahasiaan pasien.

Dalam situasi ini, perawat sebaiknya:

1. Bekerja sesuai dengan batas kompetensi dan menolak tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Mengutamakan komunikasi yang empatik untuk membantu keluarga memahami kondisi pasien secara objektif.

3. Mendokumentasikan seluruh tindakan dan komunikasi sebagai bentuk akuntabilitas profesional.
4. Berperan sebagai advokat pasien dengan memastikan keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan terbaik pasien.
5. Menjaga profesionalisme dengan tetap berpegang pada prinsip etik dan ketentuan hukum, meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Simulasi Sidang Etik

Teori Dasar

Kusnanto (2022) mendefinisikan simulasi sidang etik sebagai metode pembelajaran eksperiensial yang merekonstruksi proses pemeriksaan formal pelanggaran kode etik keperawatan. Tujuannya bukan sekadar memahami prosedur, melainkan untuk menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme. Dalam pandangannya, simulasi ini berfungsi sebagai jembatan antara teori etika (seperti *beneficence* dan *justice*) dengan praktik klinis nyata yang sering kali penuh dengan dilema. Sementara itu, Haryanto (2021) memandang simulasi sidang etik sebagai instrumen pengawasan internal (self-regulation) dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia. Ia mendefinisikannya sebagai latihan prosedural yang menyerupai peradilan (*quasi-judicial*) untuk membuktikan ada atau tidaknya malpraktik etik. Definisi ini menekankan pada aspek struktur organisasi, di mana tenaga kesehatan belajar mengenai peran majelis etik, pembuktian melalui saksi, dan perumusan putusan yang bersifat membina. Menurut Berman, Snyder, & Frandsen (2021), simulasi sidang etik sering disebut sebagai *Ethics Case Deliberation Simulation*. Mereka mendefinisikannya sebagai proses refleksi kritis kelompok yang terstruktur untuk menganalisis konflik moral. Fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan komunikasi terapeutik dan advokasi pasien saat seorang praktisi dihadapkan pada tuntutan hukum atau aduan pelanggaran privasi. Simulasi sidang etik juga didefinisikan sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif, dengan mensimulasikan persidangan, praktisi kesehatan dapat memahami batasan kewenangan delegatif dan mandat (Suryani, 2020). Hal ini menitikberatkan pada aspek legalistik, dan simulasi menjadi sarana untuk memitigasi risiko hukum sebelum sengketa tersebut masuk ke ranah peradilan perdata atau pidana.

Perbedaan Sidang Etik dan Sidang Hukum

Masih sering terjadi kesalahpahaman antara sidang etik dan proses hukum formal. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. Sidang etik berlandaskan pada kode etik profesi dan bertujuan menjaga martabat serta perilaku profesional. Sanksi yang diberikan umumnya bersifat pembinaan, seperti teguran atau

kewajiban mengikuti pelatihan. Sebaliknya, sidang hukum berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bertujuan menegakkan keadilan serta ketertiban umum. Sanksinya bersifat yudisial, seperti denda, pidana penjara, atau ganti rugi. Selain itu, sidang etik dijalankan oleh sesama profesi (majelis etik), sementara sidang hukum dipimpin oleh hakim di pengadilan. Dengan demikian, sifat sidang etik lebih mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan, sedangkan sidang hukum bersifat represif dan penegakan hukum.

Tabel 7. 6 Perbedaan Sidang Etik dan Sidang Hukum

Dimensi Perbedaan	Sidang Etik	Sidang Hukum (Pidana/Perdata)
Landasan	Kode Etik Profesi	Undang-Undang / Hukum Positif
Tujuan	Menjaga martabat dan perilaku profesi	Menegakkan keadilan dan ketertiban umum
Sanksi	Teguran, kewajiban pelatihan, hingga pencabutan rekomendasi izin praktik	Denda, kurungan penjara, atau ganti rugi materiil
Pelaksana	Teman sejawat (Majelis Etik)	Hakim di Pengadilan Negeri
Sifat	Pembinaan dan rehabilitasi	Yudisial dan punisi

Sidang etik keperawatan merupakan forum formal yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, seperti PPNI di Indonesia, atau oleh Komite Etik dan Hukum di rumah sakit, dengan tujuan untuk menelaah, memeriksa, serta memutus dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Keperawatan. Berbeda dengan mekanisme peradilan umum yang berfokus pada aspek hukum positif, sidang etik lebih menekankan dimensi moral, tanggung jawab profesional, serta upaya pemulihan citra profesi (Haryanto, 2021).

Fungsi Pembinaan dan Penegakan Kode Etik

Fungsi utama sidang etik tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan lebih pada pembinaan profesional. Penegakan kode etik bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan integritas profesi. Menurut Kusnanto (2022), terdapat beberapa tujuan utama dalam penegakan kode etik, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat, dengan memastikan bahwa pasien menerima pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan berlandaskan nilai moral yang tinggi.
2. Perlindungan profesi, guna mencegah menurunnya kepercayaan publik akibat tindakan individu yang tidak sesuai standar.
3. Penguatan otonomi profesi, yang menunjukkan bahwa keperawatan memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengawasi anggotanya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal.

Struktur Sidang Etik

Agar proses sidang berjalan objektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan struktur organisasi yang jelas. Komposisi dalam sidang etik umumnya melibatkan beberapa unsur berikut:

1. Majelis Etik, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah ganjil. Mereka biasanya merupakan perawat senior atau ahli yang memiliki integritas tinggi serta pemahaman mendalam mengenai etik dan hukum kesehatan (Suryani, 2020).
2. Terlapor, yaitu perawat yang diduga melakukan pelanggaran etik, yang memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan klarifikasi.
3. Pelapor, pihak yang mengajukan aduan, yang dapat berasal dari pasien, keluarga, tenaga kesehatan lain, atau manajemen rumah sakit.
4. Saksi, individu yang memiliki pengetahuan langsung terkait kejadian dan memberikan keterangan untuk memperkuat pembuktian.
5. Notulen, yang bertugas mendokumentasikan seluruh jalannya persidangan secara sistematis sebagai bagian dari administrasi resmi.

Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan secara adil dan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan fakta.

Alur Simulasi Sidang Etik

Proses sidang etik harus mengikuti tahapan yang sistematis guna menjamin prinsip keadilan dan transparansi. Dalam simulasi sidang etik, alur yang digunakan umumnya mencakup:

1. Pembukaan sidang, di mana ketua majelis menyatakan sidang dimulai, menjelaskan sifat sidang yang tertutup untuk menjaga kerahasiaan, serta memperkenalkan anggota majelis.

2. Pembacaan laporan, yaitu penyampaian kronologi dugaan pelanggaran oleh pelapor atau sekretaris.
3. Pemeriksaan saksi, yang dilakukan untuk memperoleh fakta secara objektif melalui proses tanya jawab.
4. Klarifikasi terlapor, di mana terlapor diberikan kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
5. Rapat tertutup majelis, yaitu proses deliberasi untuk menilai kesesuaian fakta dengan ketentuan kode etik.
6. Pembacaan putusan, yang memuat hasil penilaian serta rekomendasi tindakan yang harus dijalankan.

Alur ini mencerminkan prinsip *due process* yang menekankan keadilan prosedural dalam setiap tahapan.

Contoh Simulasi Sidang (Role Play)

Tema Kasus

Pelanggaran kerahasiaan pasien melalui unggahan foto di media sosial tanpa izin.

Peran yang Terlibat

- Ketua Majelis (KM)
- Terlapor: Perawat B (PB)
- Pelapor: Keluarga Pasien (KP)
- Saksi: Rekan sejawat (S)

1. Cuplikan Dialog

(KM): "Sidang Majelis Etik Keperawatan pada hari ini dinyatakan dibuka dan bersifat tertutup."

(KM): "Saudara Perawat B, apakah siap mengikuti persidangan?"

(PB): "Siap, Ketua."

(KM): "Silakan pelapor menyampaikan aduan."

(KP): "Kami merasa dirugikan karena foto ibu kami diunggah di media sosial tanpa izin."

(KM): "Saksi, apakah Anda mengetahui hal tersebut?"

(S): "Benar, saya melihat unggahan itu dan sempat mengingatkan."

(KM): "Terlapor, silakan memberikan klarifikasi."

(PB): "Saya mengakui kesalahan dan tidak bermaksud melanggar privasi."

Dialog ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kesempatan yang adil bagi semua pihak.

2. Ringkasan Berita Acara

Sidang mencatat bahwa terlapor mengunggah foto pasien tanpa menjaga anonimitas, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan

pasien sebagaimana diatur dalam kode etik. Terlapor juga menunjukkan sikap kooperatif dengan mengakui kesalahan.

3. Putusan Etik

Majelis menetapkan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik tingkat sedang. Rekomendasi yang diberikan meliputi teguran tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan etik dan literasi digital, serta permintaan maaf kepada keluarga pasien.

4. Analisis Akademik dan Refleksi

Simulasi sidang etik merupakan metode pembelajaran berbasis pengalaman yang efektif dalam membangun sensitivitas etik pada tenaga keperawatan. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga belajar menerapkan prinsip etik dalam situasi nyata. Dalam perspektif hukum kesehatan, pelanggaran terhadap privasi pasien tidak hanya berdampak pada aspek etik, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan medis (Hendrick, 2022). Oleh karena itu, penanganan melalui sidang etik menjadi langkah awal untuk mencegah eskalasi ke ranah hukum yang lebih luas. Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam praktik keperawatan. Kemudahan berbagi informasi di media sosial dapat menjadi risiko apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etik yang kuat. Prinsip fidelity, yaitu komitmen untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan pasien, harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap situasi, termasuk di ruang digital. Penegakan kode etik yang konsisten tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kolektif bagi profesi. Dengan demikian, lingkungan kerja yang aman, profesional, dan bermartabat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan (Berman et al., 2021).

Pendalaman Konseptual Sidang Etik Keperawatan dalam Praktik Profesional

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, sidang etik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen refleksi kolektif bagi profesi keperawatan. Kompleksitas kasus yang dihadapi perawat saat ini tidak lagi terbatas pada persoalan klinis semata, melainkan melibatkan dimensi sosial, budaya, teknologi, hingga hukum yang saling berkelindan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sidang etik perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari sistem tata kelola profesional (professional governance). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses sidang etik mampu menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan pembelajaran.

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan tidak seharusnya berorientasi pada "mencari kesalahan individu" semata, melainkan juga mengidentifikasi faktor sistemik yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Misalnya, tekanan kerja

yang tinggi, kurangnya supervisi, atau minimnya pemahaman terhadap etik digital dapat menjadi faktor yang memengaruhi perilaku tenaga kesehatan. Dengan demikian, sidang etik berfungsi sebagai ruang evaluasi menyeluruh, bukan sekadar forum penjatuhan sanksi. Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa pelanggaran etik dalam keperawatan sering kali terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena adanya kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan praktik. Dalam konteks ini, konsep moral distress menjadi relevan. Moral distress terjadi ketika perawat mengetahui tindakan yang benar secara etik, tetapi tidak mampu melaksanakannya karena tekanan eksternal, seperti instruksi atasan atau keterbatasan sistem. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran etik.

Dalam simulasi sidang etik, aspek komunikasi menjadi elemen yang sangat krusial. Kemampuan majelis etik dalam menggali informasi secara objektif sangat bergantung pada teknik komunikasi yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya bersifat klarifikatif, tetapi juga eksploratif, sehingga mampu mengungkap konteks di balik suatu tindakan. Di sisi lain, terlapor juga perlu diberikan ruang yang aman untuk menyampaikan perspektifnya tanpa rasa terintimidasi. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan prosedural sekaligus mendorong keterbukaan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah dokumentasi. Setiap proses dalam sidang etik harus terdokumentasi secara sistematis dan akurat, karena dokumen tersebut dapat menjadi rujukan apabila kasus berkembang ke ranah hukum. Dokumentasi yang baik juga mencerminkan profesionalisme institusi dalam menangani pelanggaran etik. Oleh karena itu, peran notulen tidak sekadar administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas proses.

Dalam konteks pengambilan keputusan, majelis etik dihadapkan pada tantangan untuk menilai tindakan berdasarkan standar etik yang bersifat normatif, namun harus diterapkan pada situasi yang sering kali ambigu. Di sinilah diperlukan kemampuan penalaran etik (*ethical reasoning*) yang kuat. Majelis tidak hanya menilai apakah suatu tindakan melanggar aturan, tetapi juga mempertimbangkan niat, konteks, serta dampak dari tindakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan keputusan yang dihasilkan lebih proporsional dan adil. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membawa implikasi besar terhadap praktik keperawatan, khususnya terkait kerahasiaan pasien. Era digital telah mengaburkan batas antara ruang profesional dan ruang pribadi. Banyak tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menyadari bahwa aktivitas di media sosial tetap berada dalam lingkup tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi baru yang harus dimiliki oleh perawat. Sidang etik dalam konteks ini juga berperan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko etik di dunia digital.

Dari sudut pandang pendidikan, simulasi sidang etik memiliki nilai pedagogis yang tinggi. Metode ini memungkinkan mahasiswa atau praktisi untuk mengalami secara langsung dinamika pengambilan keputusan etik, sehingga pembelajaran tidak bersifat abstrak. Melalui simulasi, peserta dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Hal ini sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman. Lebih jauh lagi, sidang etik juga memiliki peran dalam membangun budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). Ketika pelanggaran etik ditangani secara transparan dan edukatif, hal ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya standar profesional. Sebaliknya, jika pelanggaran ditutupi atau ditangani secara represif, maka hal tersebut dapat menciptakan budaya takut yang justru menghambat pelaporan insiden. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam sidang etik harus mampu menyeimbangkan antara akuntabilitas dan pembelajaran.

Dalam praktiknya, hasil sidang etik tidak hanya berdampak pada individu terlapor, tetapi juga pada institusi secara keseluruhan. Rekomendasi yang dihasilkan sering kali mencakup perbaikan sistem, seperti revisi SOP, peningkatan pelatihan, atau penguatan supervisi. Hal ini menunjukkan bahwa sidang etik memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan aspek psikologis bagi perawat yang menjadi terlapor. Proses sidang etik dapat menjadi pengalaman yang menegangkan dan berpotensi menimbulkan stres. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus tetap menjunjung tinggi prinsip *human dignity*, di mana terlapor diperlakukan secara adil dan tidak dipermalukan. Pendekatan yang suportif akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan pendekatan yang bersifat menghukum semata. Refleksi dari keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa integritas profesi keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sidang etik menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara standar profesional dan dinamika praktik di lapangan.

Dengan demikian, penguatan sistem sidang etik perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan profesi keperawatan ke depan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas majelis etik, pengembangan panduan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta integrasi pendidikan etik dalam kurikulum keperawatan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pembelajaran, sidang etik tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun profesionalisme yang berintegritas tinggi.

Dokumentasi Klinis dan Aspek Legal Forensik dalam Praktik Kesehatan

Dunia pelayanan kesehatan modern mengalami transformasi yang sangat signifikan, tidak hanya dalam aspek teknologi dan intervensi klinis, tetapi juga dalam tata kelola informasi dan pertanggungjawaban profesional. Dalam konteks ini, dokumentasi klinis tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar aktivitas administratif yang bersifat rutin, melainkan sebagai elemen fundamental yang menghubungkan praktik medis dengan aspek etik, hukum, dan keselamatan pasien. Prinsip klasik yang sering dikutip dalam hukum Kesehatan *"What is not written, is not done; what is written, is done"* menjadi refleksi dari pentingnya dokumentasi sebagai representasi dari tindakan medis itu sendiri. Dengan kata lain, rekam medis bukan hanya catatan, tetapi bukti eksistensi tindakan profesional yang dilakukan tenaga kesehatan.

Dalam perkembangan terkini, rekam medis juga dipandang sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan yang memiliki nilai strategis dalam pengambilan keputusan klinis dan kebijakan kesehatan. Transformasi menuju digitalisasi melalui Rekam Medis Elektronik (RME) semakin mempertegas posisi dokumentasi sebagai komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern (Rosady et al., 2023).

Dokumentasi Klinis sebagai Pilar Praktik Profesional

Dalam praktik sehari-hari, tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada tekanan waktu, kompleksitas kasus, serta tuntutan administratif yang tinggi. Namun demikian, kualitas dokumentasi tidak boleh dikompromikan. Dokumentasi klinis merupakan refleksi langsung dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sebuah rekam medis yang disusun dengan baik menunjukkan adanya proses berpikir klinis yang sistematis, pengambilan keputusan yang rasional, serta pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan standar profesi. Prinsip dasar pencatatan yang dikenal dengan konsep FACT (*Factual, Accurate, Complete, and Timely*) menjadi standar emas dalam praktik dokumentasi medis. Prinsip ini tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan.

Aspek faktual dan objektivitas menuntut tenaga kesehatan untuk mencatat berdasarkan fakta yang terobservasi, bukan interpretasi subjektif. Hal ini penting karena rekam medis dapat menjadi dokumen yang ditelaah oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Selanjutnya, akurasi berkaitan erat dengan penggunaan terminologi medis yang baku dan sistem klasifikasi internasional. Implementasi sistem seperti ICD dalam dokumentasi medis menunjukkan bahwa rekam medis kini tidak hanya berfungsi secara klinis, tetapi juga administratif dan legal (Setiawan, 2022). Kelengkapan dokumentasi menjadi aspek yang sangat krusial. Rekam medis harus mencerminkan keseluruhan proses pelayanan kesehatan. Kekosongan data dapat menjadi celah hukum yang berpotensi merugikan tenaga kesehatan dalam proses pembuktian (Febriyanti, 2025). Terakhir, ketepatan waktu dalam pencatatan

menjadi indikator integritas data. Dokumentasi yang dilakukan secara real-time akan meningkatkan keandalan informasi serta mengurangi risiko distorsi memori.

Dimensi Hukum Dokumentasi Medis

Secara yuridis, dokumentasi medis memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Rekam medis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah dalam proses peradilan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa dokumen rekam medis secara fisik merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien (Komala, 2024). Ketentuan ini memperjelas aspek kepemilikan sekaligus tanggung jawab dalam pengelolaan data medis. Dalam praktik hukum, rekam medis memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat. Nilai pembuktiannya bergantung pada keaslian, integritas, dan konsistensi data yang tercatat. Oleh karena itu, dokumentasi yang lengkap dan sistematis dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, rekam medis juga berkaitan erat dengan hak pasien. Pasien memiliki hak untuk mengakses informasi kesehatannya, sementara tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Keseimbangan antara hak akses dan kerahasiaan ini menjadi salah satu isu penting dalam hukum kesehatan modern (Juwita, 2024).

Tantangan Dokumentasi di Era Digital

Digitalisasi rekam medis melalui RME membawa berbagai keuntungan, seperti efisiensi, aksesibilitas, dan peningkatan akurasi data. Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan dan perlindungan data. Penelitian menunjukkan bahwa RME meningkatkan efisiensi pelayanan dan akurasi data, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi jika tidak disertai sistem keamanan yang memadai. Oleh karena itu, regulasi terbaru seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022 menekankan pentingnya enkripsi dan kontrol akses terhadap data medis (Siregar & Sinaga, 2025). Keunggulan utama sistem digital adalah adanya *audit trail*, yang memungkinkan pelacakan setiap aktivitas dalam sistem. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi manipulasi data. Namun, manipulasi data tetap menjadi ancaman serius. Dalam konteks hukum, manipulasi rekam medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaan data menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.

Lebih jauh, perlindungan data medis juga menjadi bagian dari isu global terkait keamanan informasi kesehatan. Penggunaan teknologi seperti enkripsi dan bahkan blockchain mulai dikembangkan untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data medis (Habib et al., 2023).

Dokumentasi dalam Perspektif Forensik

Dalam konteks forensik, rekam medis memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi utama dalam proses hukum. Rekam medis menjadi dasar dalam penyusunan *Visum et Repertum* (VeR), yang merupakan dokumen medis resmi untuk kepentingan peradilan. Kualitas VeR sangat bergantung pada kualitas dokumentasi awal. Jika pencatatan tidak dilakukan secara detail dan sistematis, maka informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan dapat menghambat proses pembuktian hukum. Dokumentasi forensik menuntut ketelitian yang lebih tinggi, termasuk penggunaan deskripsi luka yang spesifik, diagram tubuh, serta dokumentasi visual. Tenaga medis harus menjaga objektivitas dan tidak memberikan interpretasi hukum dalam pencatatan. Dalam kasus malpraktik, rekam medis menjadi alat utama untuk menilai apakah terjadi pelanggaran standar profesi. Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan standar yang berlaku.

Integrasi Etika, Hukum, dan Praktik Klinis

Dokumentasi klinis berada di persimpangan antara etika, hukum, dan praktik profesional. Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara etis, dokumentasi mencerminkan integritas tenaga kesehatan. Pencatatan yang jujur dan akurat merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap pasien. Secara hukum, dokumentasi menjadi alat perlindungan dan pertanggungjawaban. Rekam medis yang baik dapat memperkuat posisi tenaga kesehatan dalam menghadapi sengketa hukum. Secara klinis, dokumentasi berfungsi sebagai alat komunikasi yang menjamin kesinambungan pelayanan. Informasi yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan koordinasi yang efektif antar tenaga kesehatan.

Anatomi Manipulasi Data: Antara Kelalaian dan Kesengajaan

Dalam hukum kesehatan, manipulasi data tidak selalu berbentuk penghapusan total, tetapi sering kali muncul dalam bentuk yang lebih halus namun tetap berisiko tinggi.

- a. Ex Post Facto Documentation (Pencatatan Susulan yang Tidak Sah): Sering terjadi ketika seorang tenaga kesehatan menyadari adanya efek samping obat yang tidak dicatat, lalu menambahkannya beberapa jam kemudian tanpa keterangan "Late Entry". Secara hukum, jika urutan waktu (*timeline*) dalam rekam medis tidak logis, dokumen tersebut kehilangan kredibilitasnya sebagai alat bukti utama.
- b. Window Dressing: Praktik mempercantik data medis agar terlihat sesuai dengan SOP, padahal kondisi pasien sebenarnya tidak dipantau secara ketat. Misalnya, mencantumkan tanda-tanda vital yang stabil setiap 4 jam secara seragam (*copy-paste* data), padahal pemantauan tidak dilakukan. Di era RME, fitur *copy-paste* adalah "jebakan" yang paling sering digunakan jaksa untuk membuktikan adanya unsur ketidaktelitian.

- c. Penghapusan Jejak Kesalahan (Spoliation of Evidence): Dalam rekam medis manual, penggunaan cairan pengoreksi (*stipo*) atau coretan tebal yang menutupi tulisan asli dianggap sebagai upaya menyembunyikan fakta. Prinsip yang benar adalah mencoret satu garis, memberikan paraf, dan menuliskan koreksinya agar data asli tetap terbaca.

Rekam Medis Elektronik (RME)

Berdasarkan PMK No. 24 Tahun 2022, RME bukan sekadar pemindahan kertas ke layar, melainkan sistem yang memiliki kecerdasan forensik.

1. Metadata sebagai Bukti: Hakim dapat meminta audit metadata. Metadata akan mengungkapkan siapa yang membuka rekam medis pasien, dari komputer mana, berapa lama mereka membacanya, dan bagian mana yang diubah. Jika seorang perawat mengubah catatan asuhan keperawatan *setelah* pasien dinyatakan meninggal atau *setelah* adanya somasi dari pengacara, maka unsur "niat jahat" (*mens rea*) dapat terpenuhi.
2. Interoperabilitas dan Autentikasi: Sesuai standar terbaru, penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi (BSRE) memberikan kepastian hukum bahwa data tersebut tidak dapat disangkal (*non-repudiation*). Artinya, tenaga kesehatan tidak bisa lagi berdalih "itu bukan tulisan saya" atau "id saya dipakai orang lain."

Aspek Legal Forensik: Dokumentasi Luka dan Trauma

Dalam kasus forensik klinik (pasien hidup yang menjadi korban kejahatan), dokumentasi medis berfungsi sebagai pengganti tubuh korban di meja hijau.

1. Prinsip Deskripsi Luka yang Akurat: Seorang praktisi harus menghindari terminologi subjektif. *Contoh Buruk*: "Terdapat luka parah di lengan kanan." *Contoh Legal-Forensik*: "Terdapat luka lecet geser pada lengan bawah sisi luar, koordinat 5 cm dari pergelangan tangan, ukuran 3 cm x 2 cm, warna merah kecokelatan, dasar dermis." Deskripsi yang detail memungkinkan dokter forensik atau hakim untuk menyimpulkan jenis senjata (tumpul/tajam) dan perkiraan waktu kejadian, meskipun luka tersebut sudah sembuh saat persidangan dimulai.
2. Rantai Simpul Bukti (Chain of Custody): Dokumentasi forensik juga mencakup pencatatan serah terima barang bukti fisik, seperti pakaian korban, peluru, atau sampel swab vagina pada kasus kekerasan seksual. Jika perawat mengumpulkan sampel tetapi tidak mencatat siapa yang menerima sampel tersebut di laboratorium (pukul berapa, siapa nama petugasnya), maka bukti tersebut dapat dinyatakan "cacat hukum" dan tidak dapat digunakan di pengadilan.

Strategi Mitigasi Risiko Hukum dalam Dokumentasi

Untuk memastikan dokumentasi tetap menjadi pelindung, beberapa strategi "*High-Reliability*" perlu diterapkan:

1. Gunakan Teknik SOAP/SBAR yang Konsisten: Memberikan struktur yang logis sehingga memudahkan pembacaan kronologis oleh pihak eksternal (audit/hukum).
2. Double Check pada Prosedur Invasif: Pastikan *Informed Consent* tertaut langsung dengan catatan prosedur. Ketiadaan tanda tangan persetujuan pada tindakan berisiko tinggi adalah celah malpraktik yang paling sulit dibela.
3. Catat Komunikasi dengan Keluarga: Sering kali konflik hukum muncul karena miskomunikasi. Mencatat "Telah dilakukan edukasi mengenai risiko operasi kepada istri pasien pukul 14.00, keluarga menyatakan paham dan setuju" adalah bukti perlindungan yang sangat kuat.

Aktivitas 5 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang perawat di unit ICU (Saudara X) mengunggah foto *selfie* di depan pasien yang sedang terpasang ventilator ke *Instagram Story* miliknya. Meskipun wajah pasien disensor dengan stiker, namun nomor rekam medis pada papan informasi di kaki tempat tidur terlihat jelas oleh pengikutnya. Salah satu keluarga pasien yang melihat unggahan tersebut merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak Rumah Sakit dengan tuduhan pelanggaran kerahasiaan dan malpraktik etis. Saudara X berdalih bahwa ia hanya ingin memberikan edukasi mengenai "perjuangan tenaga medis" dan tidak bermaksud memermalukan pasien.

Pertanyaan Diskusi

1. Apakah tindakan Saudara X tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kerahasiaan pasien, meskipun wajah pasien telah disensor? Bagaimana implikasinya jika informasi lain seperti nomor rekam medis masih dapat diidentifikasi?
2. Sejauh mana tenaga keperawatan diperbolehkan menggunakan media sosial untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman kerja tanpa melanggar kode etik profesi dan hukum yang berlaku?
3. Apakah alasan Saudara X yang mengklaim "tidak bermaksud memermalukan pasien" dapat menjadi pembenaran secara etik dan hukum? Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban profesional dalam kasus ini?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Bedah kasus menggunakan prinsip Bioetik (Otonomi vs Beneficence) dan mengaitkannya dengan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 serta Kode Etik Keperawatan Indonesia.

3. Bagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang dengan pembagian peran sebagai berikut: Ketua Komite Etik, Anggota Komite (Pakar Hukum/Etik), Perawat Teradu (Saudara X), Saksi (Rekan Kerja), dan Pendamping/Keluarga Pasien.
4. Susun naskah dan melakukan simulasi persidangan etik selama 15-20 menit, dan lakukan *role play* di depan kelas.
5. Susun laporan Putusan Sidang Etik yang berisi kronologi, analisis pelanggaran, dan rekomendasi sanksi (misal: teguran lisan, tertulis, atau rekomendasi pencabutan kewenangan klinis sementara).
6. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.

Latihan

Pilihan Ganda

1. Dalam konteks keperawatan, dilema etik terjadi ketika...
 - A. Perawat tidak mengetahui prosedur tindakan
 - B. Ada konflik antara dua nilai moral yang sama-sama penting
 - C. Perawat melanggar hukum pidana
 - D. Pasien menolak tindakan medis
 - E. Tidak tersedia alat kesehatan

Jawaban: B

2. Prinsip etik yang berkaitan dengan menghormati hak pasien untuk menentukan pilihannya sendiri adalah...
 - A. Beneficence
 - B. Non-maleficence
 - C. Autonomy
 - D. Justice
 - E. Fidelity

Jawaban: C

3. Contoh pelanggaran aspek hukum dalam praktik keperawatan adalah...
 - A. Tidak empati kepada pasien
 - B. Tidak mengikuti SOP yang berlaku
 - C. Tidak ramah kepada keluarga pasien
 - D. Kurang komunikasi
 - E. Terlambat datang kerja

Jawaban: B

4. Dalam analisis kasus etik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah...

- A. Menentukan keputusan
- B. Mengidentifikasi masalah
- C. Melaksanakan tindakan
- D. Mengevaluasi hasil
- E. Memberi sanksi

Jawaban: B

5. Prinsip “tidak merugikan pasien” dikenal sebagai...

- A. Autonomy
- B. Justice
- C. Fidelity
- D. Non-maleficence
- E. Veracity

Jawaban: D

6. Seorang pasien laki-laki (70 tahun) dengan gagal jantung terminal dirawat di ICU dan menggunakan ventilator. Dalam rekam medis ditemukan Advance Directive yang menyatakan pasien tidak ingin dilakukan resusitasi (DNR). Namun, anak pasien bersikeras meminta tindakan resusitasi penuh jika terjadi henti jantung. Konflik utama dalam kasus tersebut adalah...

- A. Konflik antara hukum dan teknologi
- B. Konflik antara autonomy pasien dan beneficence versi keluarga
- C. Konflik antara perawat dan dokter
- D. Konflik administratif rumah sakit
- E. Konflik biaya perawatan

Jawaban: B

7. Dalam simulasi sidang etik, pihak yang berperan sebagai penilai utama adalah...

- A. Pasien
- B. Keluarga
- C. Tim etik
- D. Perawat pelapor
- E. Dokter

Jawaban: C

8. Salah satu tujuan sidang etik adalah...
- A. Memberikan hukuman pidana
 - B. Menentukan kesalahan administrasi
 - C. Menjaga standar profesi
 - D. Menentukan tarif pelayanan
 - E. Mengganti kerugian pasien

Jawaban: C

9. Seorang pasien perempuan (45 tahun) dengan kanker stadium lanjut menolak kemoterapi karena alasan keyakinan pribadi, meskipun dokter menyatakan terapi masih berpotensi memperpanjang hidup.
Dalam konteks hukum kesehatan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai...
- A. Pelayanan rutin
 - B. Informed consent yang sah
 - C. Pelanggaran hak pasien
 - D. Standar praktik
 - E. Edukasi kesehatan

Jawaban: C

10. Perawat salah memberikan dosis obat karena tidak melakukan pengecekan identitas pasien, sehingga pasien mengalami reaksi serius.
Unsur malpraktik yang paling jelas adalah...
- A. Duty
 - B. Damage
 - C. Breach of duty
 - D. Justice
 - E. Autonomy

Jawaban: C

11. Jika perawat membocorkan rahasia pasien, maka prinsip etik yang dilanggar adalah...
- A. Justice
 - B. Autonomy
 - C. Confidentiality
 - D. Beneficence
 - E. Accountability

Jawaban: C

12. Dalam pengambilan keputusan etik, pendekatan yang mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak orang disebut...

- A. Deontologi
- B. Utilitarianisme
- C. Virtue ethics
- D. Legalistik
- E. Individualistik

Jawaban: B

13. Contoh konflik etik-hukum adalah...

- A. Perawat kelelahan bekerja
- B. Pasien menolak tindakan yang menyelamatkan nyawa
- C. Perawat tidak disiplin
- D. Rumah sakit kekurangan alat
- E. Jadwal kerja padat

Jawaban: B

14. Dalam kerangka analisis etik, siapa saja yang termasuk stakeholder?

- A. Hanya pasien
- B. Hanya tenaga medis
- C. Semua pihak yang terlibat dalam kasus
- D. Hanya keluarga pasien
- E. Hanya manajemen rumah sakit

Jawaban: C

15. Prinsip keadilan dalam keperawatan disebut...

- A. Fidelity
- B. Justice
- C. Veracity
- D. Autonomy
- E. Beneficence

Jawaban: B

16. Seorang pasien dengan penyakit menular serius meminta perawat merahasiakan kondisinya, tetapi penyakit tersebut berpotensi menular ke masyarakat.

Dilema etik utama dalam kasus ini adalah...

- A. Autonomy vs Justice
- B. Beneficence vs Veracity

- C. Confidentiality vs Public safety
- D. Fidelity vs Justice
- E. Non-maleficence vs Autonomy

Jawaban: C

17. Dalam sidang etik, bukti yang digunakan untuk analisis adalah...

- A. Opini pribadi
- B. Perasaan perawat
- C. Data dan fakta kasus
- D. Dugaan pasien
- E. Asumsi tim

Jawaban: C

18. Perbedaan utama antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum adalah...

- A. Etik lebih berat dari hukum
- B. Hukum tidak memiliki sanksi
- C. Etik berkaitan dengan norma profesi, hukum berkaitan dengan aturan negara
- D. Etik tidak penting
- E. Hukum hanya untuk dokter

Jawaban: C

19. Dalam pengambilan keputusan, langkah evaluasi bertujuan untuk...

- A. Menghukum pelaku
- B. Menilai efektivitas keputusan
- C. Mengabaikan hasil
- D. Mengulang tindakan
- E. Menghentikan proses

Jawaban: B

20. Seorang perawat melakukan praktik mandiri tanpa memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.

Tindakan tersebut termasuk...

- A. Pelanggaran etik ringan
- B. Pelanggaran hukum serius
- C. Praktik normal
- D. Tidak masalah jika pasien sembuh
- E. Hanya pelanggaran administratif

Jawaban: B

Esai

1. Kasus: Seorang tenaga kesehatan dihadapkan pada situasi di mana keluarga pasien meminta agar diagnosis penyakit terminal pasien disembunyikan dari pasien dengan alasan agar kondisi psikologis pasien tidak memburuk. Di sisi lain, pasien secara sadar menanyakan kondisi penyakitnya kepada Anda.

Pertanyaan soal:

Susunlah analisis kasus tersebut menggunakan kerangka terstruktur. Identifikasi konflik prinsip etika yang terjadi (misal: *autonomy vs beneficence*), berikan justifikasi keputusan Anda, dan sertakan bukti atau dasar regulasi yang relevan untuk mendukung keputusan tersebut!

Rubrik Assessment:

Aspek yang Dinilai	Deskripsi	Skor Maks
Identifikasi konflik etik	Mampu mengidentifikasi <i>autonomy vs beneficence/non-maleficence</i>	4
Analisis kasus	Penjelasan logis, sistematis, dan kontekstual	4
Justifikasi keputusan	Argumentasi kuat berbasis prinsip etik	4
Dasar hukum/regulasi	Mengacu pada UU/aturan relevan	4
Struktur & kejelasan	Sistematika dan bahasa akademik	4
Total		20

Kunci Jawaban:

Kasus ini mencerminkan dilema etik ketika tenaga kesehatan menghadapi dua kepentingan yang bertentangan, yaitu permintaan keluarga untuk menyembunyikan diagnosis penyakit terminal dan hak pasien yang dalam kondisi sadar untuk mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga menuntut respons profesional yang tepat. Konflik prinsip etik yang muncul meliputi *autonomy*, yaitu hak pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan keputusan atas dirinya sendiri; *beneficence*, yaitu upaya keluarga melindungi pasien dari dampak psikologis; serta *non-maleficence*, yaitu kekhawatiran bahwa keterbukaan informasi dapat memperburuk kondisi pasien, yang merupakan dilema umum dalam praktik klinis. Dalam situasi ini, pasien yang sadar dan kompeten secara etik dan hukum berhak menerima informasi, sehingga menyembunyikan diagnosis tanpa persetujuannya dapat melanggar hak dasar pasien. Namun, penyampaian informasi perlu dilakukan dengan pendekatan komunikasi terapeutik yang empatik, bertahap,

dan disesuaikan dengan kondisi emosional pasien. Oleh karena itu, keputusan yang tepat adalah tetap memberikan informasi kepada pasien dengan mempertimbangkan kesiapan psikologisnya, karena prinsip autonomy memiliki prioritas utama pada pasien kompeten, hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi dalam pelayanan kesehatan, dan penutupan informasi berpotensi merusak hubungan terapeutik serta kepercayaan pasien. Keputusan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pasien berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan hak pasien untuk mendapatkan penjelasan mengenai diagnosis dan tindakan medis, serta Kode Etik Keperawatan Indonesia yang mewajibkan perawat menghormati hak pasien dan memberikan informasi secara profesional.

2. Kasus: Terjadi kesalahan pemberian dosis obat pada pasien di bangsal akibat instruksi lisan yang tidak terverifikasi dengan benar saat terjadi pergantian shift (handover). Insiden ini masuk dalam kategori Kejadian Nyaris Cedera (KNC).

Pertanyaan soal:

Lakukan analisis insiden (Mini RCA) terhadap kasus di atas. Klasifikasikan jenis risikonya, identifikasi akar masalah (misal: faktor komunikasi atau sistem), dan susunlah rencana pencegahan berbasis akar masalah beserta indikator audit untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut!

Rubrik assessment:

Aspek yang Dinilai	Deskripsi	Skor Maks
Klasifikasi risiko	Tepat menentukan level risiko	4
Identifikasi akar masalah	Menemukan faktor utama (komunikasi/sistem)	4
Analisis RCA	Alur sebab-akibat jelas	4
Rencana pencegahan	Solusi spesifik & aplikatif	4
Indikator audit	Terukur & relevan	4
Total		20

Kunci Jawaban:

Kasus ini diklasifikasikan sebagai Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dengan tingkat risiko moderate hingga high, karena meskipun belum menimbulkan cedera, kesalahan dosis obat memiliki potensi besar menyebabkan dampak serius bagi keselamatan pasien. Berdasarkan analisis, akar masalah utama terletak pada kegagalan komunikasi saat handover, khususnya penggunaan instruksi lisan yang tidak diverifikasi dengan benar (*lack of read-back/confirmatory communication*). Selain

itu, terdapat faktor sistem seperti tidak adanya standar baku dalam proses handover, kurangnya penerapan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), serta kemungkinan beban kerja tinggi saat pergantian shift yang meningkatkan risiko miskomunikasi. Berdasarkan akar masalah tersebut, rencana pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menstandarisasi proses handover menggunakan metode SBAR, mewajibkan verifikasi ulang (read-back) untuk setiap instruksi lisan, serta memperkuat kebijakan bahwa instruksi medis harus didokumentasikan secara tertulis atau elektronik sesegera mungkin. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan serta penguatan budaya keselamatan pasien di unit pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan intervensi, indikator audit yang dapat digunakan meliputi: persentase kepatuhan penggunaan SBAR saat handover, persentase dokumentasi instruksi medis yang lengkap dan tervalidasi, serta penurunan jumlah insiden medication error dalam periode tertentu. Dengan pendekatan ini, upaya perbaikan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

3. Kasus: Dalam sebuah simulasi sidang etik, Anda berperan sebagai komite etik yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran prosedur penelitian di mana peneliti tidak memperbarui *Informed Consent* setelah ada perubahan protokol yang menambah risiko efek samping bagi subjek.

Pertanyaan soal:

Sajikan argumen profesional Anda terkait pelanggaran tersebut dilihat dari sudut pandang perlindungan subjek penelitian. Berikan rekomendasi tindak lanjut yang mencakup sanksi, opsi penyelesaian bagi subjek yang terdampak, dan langkah perbaikan sistem penelitian!

Rubrik assessment

Aspek yang Dinilai	Deskripsi	Skor Maks
Identifikasi pelanggaran	Menjelaskan pelanggaran informed consent	4
Argumentasi etik	Mengaitkan dengan prinsip etik penelitian	4
Rekomendasi sanksi	Relevan dan proporsional	4
Perlindungan subjek	Solusi untuk subjek terdampak	4
Perbaikan sistem	Preventif dan berkelanjutan	4
Total		20

Kunci jawaban:

Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan subjek penelitian, khususnya terkait kegagalan peneliti dalam memperbarui *informed consent* setelah terjadi perubahan protokol yang meningkatkan risiko efek samping. Dalam perspektif etik penelitian, tindakan tersebut melanggar prinsip autonomy, karena subjek tidak diberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang sadar (*informed decision*) berdasarkan informasi terbaru, serta prinsip justice, karena subjek tidak memperoleh perlindungan yang adil terhadap risiko tambahan yang muncul. Selain itu, prinsip non-maleficence juga dilanggar karena subjek berpotensi mengalami kerugian tanpa persetujuan yang memadai. Menurut *World Medical Association* dalam Declaration of Helsinki, setiap perubahan signifikan dalam penelitian yang dapat memengaruhi risiko wajib dikomunikasikan kepada subjek dan memerlukan persetujuan ulang. Dari sudut pandang komite etik, pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial karena menyangkut hak dasar dan keselamatan subjek penelitian. Oleh karena itu, rekomendasi tindak lanjut yang perlu diberikan adalah penghentian sementara penelitian sampai dilakukan evaluasi menyeluruh, serta kewajiban bagi peneliti untuk melakukan re-consent (persetujuan ulang) kepada seluruh subjek dengan menjelaskan perubahan risiko secara transparan. Selain itu, perlu dilakukan audit etik terhadap seluruh proses penelitian dan pelaporan kasus kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) sebagai bentuk akuntabilitas. Dari sisi sanksi, komite etik dapat memberikan teguran tertulis hingga pembekuan sementara izin penelitian, tergantung pada tingkat kelalaian dan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal perlindungan subjek yang terdampak, peneliti wajib memberikan kompensasi atau penanganan medis yang diperlukan, serta membuka opsi bagi subjek untuk menarik diri dari penelitian tanpa konsekuensi apa pun. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan subjek yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan individu sebagai prioritas utama. Sebagai langkah perbaikan sistem, institusi penelitian perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan memastikan bahwa setiap perubahan protokol wajib melalui persetujuan ulang dari komite etik sebelum diimplementasikan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi peneliti terkait etika penelitian, penguatan sistem monitoring, serta penggunaan checklist kepatuhan etik dalam setiap tahapan penelitian. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah dan integritas penelitian tetap terjaga.

H. Rangkuman

Bab ini menegaskan bahwa praktik keperawatan merupakan profesi yang tidak hanya menuntut kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan dalam mempertimbangkan aspek etik dan hukum secara bersamaan. Dalam pelayanan kesehatan modern, perawat sering menghadapi dilema akibat benturan nilai antara kepentingan pasien, keluarga, institusi, dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis kasus secara sistematis dengan berlandaskan prinsip bioetika seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, *justice*, *veracity*, dan *fidelity*. Proses pengambilan keputusan etik–hukum dilakukan melalui tahapan terstruktur mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan fakta, analisis konflik nilai, hingga penetapan keputusan dan dokumentasi yang akurat sebagai bentuk akuntabilitas profesional sekaligus perlindungan hukum. Perubahan paradigma menuju *patient-centered care* serta perkembangan teknologi kesehatan semakin memperluas kompleksitas dilema etik, sehingga perawat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, dan keberanian moral dalam praktiknya.

Selain itu, materi ini membahas perbedaan antara kasus etik dan kasus hukum, serta pentingnya memahami kerangka regulasi praktik keperawatan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, kepemilikan STR dan SIP, serta kode etik profesi dari PPNI sebagai pedoman moral. Kasus hukum berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang dapat berujung pada sanksi perdata maupun pidana, termasuk dalam konteks malpraktik yang harus memenuhi unsur *duty*, *breach*, *causality*, dan *damage*. Sementara itu, praktik keperawatan juga mencakup berbagai peran strategis seperti *caregiver*, *educator*, *advocate*, dan *manager* yang harus dijalankan secara profesional sesuai batas kewenangan. Untuk mendukung kompetensi tersebut, pembelajaran melalui studi kasus dan simulasi sidang etik digunakan sebagai metode untuk melatih analisis, argumentasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, integrasi antara etika dan hukum dalam praktik keperawatan bertujuan menjamin keselamatan pasien, menjaga kualitas pelayanan, serta memperkuat integritas profesi.

Glosarium

Advance Directive

Dokumen yang berisi pernyataan kehendak pasien terkait tindakan medis yang diinginkan atau ditolak di masa depan ketika pasien tidak lagi mampu mengambil keputusan.

Akuntabilitas Profesional

Kewajiban tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara etik, hukum, dan profesional.

Autonomy (Otonomi)

Prinsip bioetika yang menekankan hak pasien untuk membuat keputusan secara bebas dan sadar mengenai kesehatannya.

Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip yang mengharuskan tenaga kesehatan bertindak demi kepentingan terbaik pasien.

Breach of Duty

Pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang seharusnya dilakukan sesuai standar praktik.

Ca (Cancer/Kanker)

Istilah medis untuk penyakit kanker yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal.

Casuistry

Pendekatan analisis etik berbasis studi kasus konkret dengan membandingkan kasus serupa untuk menentukan keputusan.

Confidentiality (Kerahasiaan)

Kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga informasi pribadi dan medis pasien.

Causal Relationship (Hubungan Sebab-Akibat)

Keterkaitan langsung antara tindakan tenaga kesehatan dengan kerugian yang dialami pasien.

Damage (Kerugian)

Dampak negatif yang dialami pasien, baik fisik, psikologis, maupun finansial akibat tindakan tenaga kesehatan.

Delegasi

Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat disertai sebagian tanggung jawab profesional.

Dilema Etik

Situasi ketika dua atau lebih prinsip moral bertentangan sehingga sulit menentukan keputusan yang benar.

Distres Moral (Moral Distress)

Kondisi ketika tenaga kesehatan mengetahui tindakan yang benar secara etik, tetapi tidak dapat melaksanakannya karena hambatan tertentu.

DNR (Do Not Resuscitate)

Instruksi medis untuk tidak melakukan tindakan resusitasi jantung paru pada pasien dalam kondisi tertentu.

Duty of Care

Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi.

Etika Keperawatan

Nilai dan norma moral yang menjadi pedoman perilaku profesional perawat dalam praktik.

Four-Box Method

Metode analisis kasus etik yang mencakup: indikasi medis, preferensi pasien, kualitas hidup, dan faktor kontekstual.

Fidelity

Prinsip kesetiaan dan komitmen perawat dalam menjalankan tanggung jawab profesional.

ICU (Intensive Care Unit)

Unit perawatan intensif di rumah sakit untuk pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat.

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah menerima informasi lengkap mengenai tindakan tersebut.

IVF (In Vitro Fertilization)

Teknologi reproduksi berbantu yang dilakukan dengan pembuahan sel telur di luar tubuh.

Justice (Keadilan)

Prinsip yang menekankan distribusi pelayanan kesehatan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Kasus Etik

Masalah yang melibatkan konflik nilai moral dan memerlukan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan.

Kasus Hukum

Masalah yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Kode Etik PPNI

Pedoman moral yang mengatur perilaku profesional perawat di Indonesia.

Malpraktik

Tindakan profesional yang menyimpang dari standar sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien.

Mandat

Pelimpahan tindakan medis dari dokter kepada perawat dengan tanggung jawab tetap pada dokter.

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Keperawatan)

Lembaga di bawah organisasi profesi yang bertugas menangani pelanggaran kode etik keperawatan.

Non-maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip yang menekankan kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya pada pasien.

Patient-Centered Care (PCC)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pengambilan keputusan.

Perlindungan Hukum

Jaminan dari negara bagi tenaga kesehatan selama bekerja sesuai standar profesi dan regulasi.

PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

Organisasi profesi perawat di Indonesia yang berperan dalam pembinaan, pengawasan etik, serta pengembangan profesi keperawatan.

Prinsip Bioetika

Dasar nilai etik dalam pelayanan kesehatan yang meliputi autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice.

Rekam Medis

Dokumen resmi yang mencatat seluruh proses pelayanan kesehatan pasien sebagai bukti klinis dan hukum.

RJP (Resusitasi Jantung Paru)

Tindakan darurat untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernapasan pada pasien yang mengalami henti jantung.

Simulasi Sidang Etik

Metode pembelajaran untuk melatih analisis dan argumentasi dalam kasus pelanggaran etik.

SIP / SIPP (Surat Izin Praktik Perawat)

Izin yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu sesuai kewenangannya.

SOP / SPO (Standar Operasional Prosedur)

Panduan teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan agar sesuai standar profesional.

STR (Surat Tanda Registrasi)

Bukti legal bahwa tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi untuk praktik.

Triase

Proses penentuan prioritas pelayanan berdasarkan tingkat kegawatan pasien.

UU (Undang-Undang)

Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar legal dalam praktik kesehatan.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Regulasi terbaru yang mengatur sistem kesehatan nasional, termasuk praktik tenaga kesehatan dan perlindungan hukum.

UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-undang yang secara khusus mengatur praktik keperawatan, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan perizinan.

Veracity (Kejujuran)

Prinsip yang menuntut tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara jujur kepada pasien.

VVIP (Very Very Important Person)

Kelas pelayanan rumah sakit dengan fasilitas paling lengkap dan eksklusif.

Referensi

- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.
- Austin, W. (2020). Ethical climate and nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2022). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2019). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Coyne, I., et al. (2022). Ethical challenges in pediatric nursing. *Nursing Ethics*.
- Delany, C., Edwards, I., & Fryer, C. (2019). Ethics in health professional practice. *Journal of Clinical Ethics*, 30(2), 121–129.
- Doherty, R. F., & Purtilo, R. B. (2021). *Ethical dimensions in the health professions* (7th ed.). Elsevier.
- Dzeng, E. (2022). Institutional constraints in healthcare ethics. *Social Science & Medicine*.
- Elwyn, G., Frosch, D., & Kobrin, S. (2020). Implementing shared decision-making. *Journal of General Internal Medicine*, 35(2), 603–608.
- Epstein, E., et al. (2022). Moral distress among nurses. *Journal of Nursing Ethics*.
- Fowler, M. D. (2022). *Guide to the code of ethics for nurses: Interpretation and application*. American Nurses Association.
- Gallagher, A. (2023). Ethical competence in nursing. *Nursing Ethics*.
- Grace, P. J., & Uveges, M. (2022). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Gracia, D. (2020). Ethical deliberation in clinical decision-making. *Journal of Medical Ethics*, 46(3), 162–167.
- Guwandi, J. (2021). *Hukum medik dan etika kedokteran*. FKUI.
- Habib, M. A., Alam, K. M. R., & Morimoto, Y. (2023). Secure medical record sharing. *arXiv*.
- Haddad, L. M., & Geiger, R. A. (2023). Nursing ethical considerations. StatPearls Publishing.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2019). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan* (Edisi 5). EGC.

- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2023). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan* (Edisi 6). EGC.
- Haryani, S. (2020). *Etika keperawatan dan hukum kesehatan dalam perspektif praktis*. Rajawali Pers.
- Haryanto, A. (2021). *Hukum kesehatan: Teori dan aplikasinya di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. A., et al. (2022). Kepatuhan kode etik dan mutu pelayanan. *Journal of Health Science and Prevention*, 6(1), 45–53.
- Hui, D., et al. (2023). Palliative care communication. *The Lancet Oncology*.
- Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2019). *Clinical ethics* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Kaihlanen, A. M., et al. (2021). Ethics and nursing care quality. *Journal of Advanced Nursing*.
- Kateb, A. Y., et al. (2025). Ethical decision-making in healthcare. *Journal of Professional Healthcare Ethics*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Standar akreditasi rumah sakit*. Kemenkes RI.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). *Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)*. KARS.
- Kusnanto, H. (2022). *Etika profesi dan hukum keperawatan*. Airlangga University Press.
- Millum, J., & Emanuel, E. J. (2020). Ethics of global health resource allocation. *The Lancet*, 395, 109–112.
- Mulyadi, A. (2022). Tanggung jawab hukum perawat. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1), 15–28.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Etika dan hukum kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Manajemen keperawatan* (6th ed.). Salemba Medika.
- O'Mathúna, D. (2022). Ethical challenges in nursing. *Nursing Ethics*.
- Park, E. J. (2021). Ethical decision-making model. *Nursing Ethics*, 28(4), 512–524.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2021). *Kode etik keperawatan Indonesia*. DPP PPNI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Priharjo, R. (2020). *Etika keperawatan: Konsep dan aplikasi*. Kanisius.
- Prianto, B. (2022). Ethical dilemmas in terminal care. *Journal of Medical Ethics and Health Policy*, 14(2), 112–128.

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Robinson, J., et al. (2021). Family communication in end-of-life care. *Journal of Palliative Medicine*.
- Rushton, C. H. (2018). *Moral resilience*. Oxford University Press.
- Saraswati, R. (2021). Resource scarcity and decision making. *Indonesian Journal of Health Law*, 5(1), 45–60.
- Shapiro, S. J. (2021). *Legality*. Harvard University Press.
- Simamora, R. H. (2019). *Buku ajar etika keperawatan*. Prenada Media.
- Soekanto, S., & Herkutanto. (2019). *Pengantar hukum kesehatan*. Remaja Rosdakarya.
- Sokol, D. K. (2020). Four-box method revisited. *Journal of Medical Ethics*, 46(4), 231–235.
- Suhartini, S., et al. (2021). Integrasi sanksi etik dan hukum. *Law and Justice Journal*, 6(2), 145–160.
- Suryani, L., & Rustina, Y. (2021). *Legalitas dan kompetensi perawat di era global*. Trans Info Media.
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021). *Managing business ethics: Straight talk about how to do it right* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Ulenaers, D., et al. (2021). COVID-19 and ethical decision-making. *Nursing Ethics*.
- Umanailo, M. C. B. (2020). *Unsur-unsur pengambilan keputusan*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7z64n>
- Varkey, B. (2021). Clinical ethics principles. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28.
- Widodo, S., & Handayani, T. (2022). Transformasi norma etik ke hukum. *Jurnal Medika Hukum*, 11(1), 22–35.
- World Health Organization. (2021). *Patient safety incident reporting and learning systems*. WHO.
- Yusuf, M. (2021). Malpraktik keperawatan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1(2), 88–102.
- Yusuf, M., & Rahayu, S. (2021). Medical records in legal disputes. *Asian Journal of Law and Policy*, 3(4), 210–225.

Profil Penulis



Ns. Sarti Oktarina Purba., S.Kep., M.Kep.

Lahir di Pematang Siantar, 03 Oktober 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh S1 Keperawatan pada Program Studi Ners Keperawatan, STIK Sint Carolus tahun 2005-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di STIK Sint Carolus dan lulus tahun 2015-2017. Riwayat pekerjaan di RS PGI Cikini diawali pada tahun 1989 sebagai perawat staf ruang perawatan bedah, sebagai perawat staf di ruang ICU Dewasa, sebagai kepala ruang perawatan bedah, sebagai wakil kepada bidang perawatan, tim *Patient safety*, Ketua Komite Keperawatan, staf direksi PPSDM, Tim akreditasi RS, Tim penelitian, kepala bidang keperawatan, penanggung jawab pokja Asesmen pasien, sebagai anggota tim *Covid-19*, wakil kepala PPSDM. Saat ini penulis sebagai asesor akreditasi rumah sakit, sebagai dosen di STIKes PGI Cikini, sebagai anggota tim perubahan bentuk Akademi menjadi STIKes PGI Cikini, sebagai ketua laboratorium STIKes PGI Cikini, mengampu mata kuliah Kosep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Pelayanan Pastoral, Keperawatan Dasar, Keperawatan Gawat Darurat, Pratik Klinik Keperawatan Dasar. Dan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai staf pengajar, penelitian, publikasi, seminar, pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sartipurba310@gmail.com

Motto: "Meringankan penderitaan adalah karya Ilahi"

Profil Penulis



Ni Ketut Elmiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Tambarana, pada 12 Januari 1987 dan saat ini berdomisi di daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan tinggi ditempuh pada jenjang S1 dan Ners di Fakultas Keperawatan Universitas De La Salle Manado, lulus pada tahun 2010. Selanjutnya Pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Hasanuddin Makassar, lulus pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2010 sebagai staf Program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia jaya dan kemudian diangkat menjadi dosen tetap hingga saat ini. Sebagai dosen, penulis aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang Keperawatan. Pada saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Metodologi Penelitian, Keperawatan Jiwa dan Etika Keperawatan. Selain aktif mengajar, melakukan publikasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga telah menulis 4 (empat) judul buku di bidang keperawatan yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampu.
Motto: "Merawat dengan Hati, Mendidik dengan Ilmu."

Profil Penulis



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep

lahir di Malaka pada 27 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang ditempuh diawali di Akademi Keperawatan Kupang dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) dan Profesi Ners (Ns.) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis kemudian meraih gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada tahun 2023. Karier profesional penulis diawali sebagai perawat sekaligus dosen di Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (PAM-KT) Dili, Timor Timur, pada periode 1996–1998. Sejak bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Keperawatan dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners. Di samping aktivitas akademik, penulis aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, serta anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI). Dalam bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Falsafah dan Teori Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan, Caring, Etika Keperawatan, Metodologi Penelitian, Evidence-Based Nursing, dan Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa pada penyusunan tugas akhir, karya ilmiah, dan penelitian di bidang keperawatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan book chapter di bidang keperawatan, menjadi narasumber dalam seminar, pelatihan, dan workshop ilmiah, serta berperan sebagai reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi pengembangan model praktik keperawatan berbasis caring, etik dan budaya, pendidikan keperawatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian tuberkulosis, mutu dan keselamatan pasien di RS.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aemilianusmau58@gmail.com.

Motto: "Terus Belajar agar Ilmunya Dapat Bermanfaat bagi orang lain"

Profil Penulis



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

adalah seorang dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan profesi Ners, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990. Riwayat pendidikan dimulai dari jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013. pendidikan Magister Keperawatan Manajemen di institusi yang sama dan lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, aktif mengajar sebagai dosen di program studi DIII, S1 Keperawatan, dan prodi Profesi Ners di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI pada tahun 2014 hingga sekarang. Selain ini penulis menjabat sebagai tim pengembangan akademik dan kurikulum program studi Keperawatan dan ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Keperawatan FPOK UPI.

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau mampu berbagai mata kuliah, seperti Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Manajemen Keselamatan Pasien, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Kewirausahaan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, serta Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis telah membuat buku ajar keperawatan dasar, manajemen keperawatan, metodologi keperawatan. buku referensi kesehatan terpadu berbasis Interprofesional.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asihpurwandari@upi.edu atau asihpwp@upi.edu.

Motto: Man jadda wajada" (Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan menemukannya).

Sesulit apapun jalannya, seruit apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya...

Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dekat..

Profil Penulis



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep

Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatan dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Mereka yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."



Egi Komara Yudha, S.Kp., MM., M.Pd.

Lahir di Tasikmalaya, 29 September 1977. Menyelesaikan studi S1 Keperawatan di Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat dan S2 Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan peminatan Sumber Daya Manusia. Saat ini, penulis pernah menjadi dosen serta editor buku Etika dan Hukum Kesehatan. Saat ini, penulis masih aktif menulis buku, artikel penelitian, dan menjadi dosen Keperawatan di Institut Kesehatan Rajawali Bandung.

Motto : Never give up!

Sinopsis

Praktik keperawatan modern tidak hanya menuntut kecakapan klinis yang prima, tetapi juga pemahaman yang komprehensif mengenai landasan moral dan aspek hukum yang mengikat profesi. Buku Ajar *Etik dan Hukum Keperawatan* hadir sebagai panduan utama bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi keperawatan dalam menavigasi kompleksitas dilema moral serta batasan legal dalam tatanan pelayanan kesehatan.

Buku ini disusun secara sistematis mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan terkini, merangkum esensi perlindungan hukum dan integritas profesi melalui tujuh pembahasan utama. Pembaca akan diajak untuk memahami kekuatan dokumentasi keperawatan sebagai tameng hukum dan bentuk tanggung gugat profesi, serta bagaimana manajemen risiko dan pelaporan insiden menjadi pilar utama dalam membangun budaya keselamatan pasien.

Secara lebih tajam, buku ini membedah batas-batas krusial antara malpraktik, kelalaian (*negligence*), dan pelanggaran disiplin, lengkap dengan strategi pencegahannya. Kajian kemudian diperdalam dengan analisis isu-isu etik klinis yang kerap menjadi dilema di lapangan, mulai dari keputusan akhir hayat seperti *Do Not Resuscitate* (DNR), perawatan paliatif, hingga perlakuan etik pada populasi khusus dan rentan seperti anak, lansia, pasien dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Selain praktik klinis, buku ini juga memberikan rambu-rambu esensial dalam pelaksanaan penelitian keperawatan untuk memastikan perlindungan hak subjek penelitian.

Sebagai muara dari seluruh konsep teoritis, buku ini menyajikan kerangka analisis studi kasus etik-hukum yang aplikatif. Dilengkapi dengan panduan pengambilan keputusan klinis dan simulasi sidang etik, buku ini tidak hanya menjadi sumber literatur, tetapi juga sarana berlatih memecahkan kasus-kasus nyata.

Melalui pendekatan teoretis dan praktis, Buku Ajar *Etik dan Hukum Keperawatan* diharapkan mampu mencetak perawat profesional yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga tangguh secara moral, peka terhadap hak asasi pasien, dan taat pada koridor hukum yang berlaku.

Praktik keperawatan modern tidak hanya menuntut kecakapan klinis yang prima, tetapi juga pemahaman yang komprehensif mengenai landasan moral dan aspek hukum yang mengikat profesi. Buku Ajar Etik dan Hukum Keperawatan hadir sebagai panduan utama bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi keperawatan dalam menavigasi kompleksitas dilema moral serta batasan legal dalam tatanan pelayanan kesehatan.

Buku ini disusun secara sistematis mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan terkini, merangkum esensi perlindungan hukum dan integritas profesi melalui tujuh pembahasan utama. Pembaca akan diajak untuk memahami kekuatan dokumentasi keperawatan sebagai tameng hukum dan bentuk tanggung gugat profesi, serta bagaimana manajemen risiko dan pelaporan insiden menjadi pilar utama dalam membangun budaya keselamatan pasien.

Secara lebih tajam, buku ini membedah batas-batas krusial antara malpraktik, kelalaian (negligence), dan pelanggaran disiplin, lengkap dengan strategi pencegahannya. Kajian kemudian diperdalam dengan analisis isu-isu etik klinis yang kerap menjadi dilema di lapangan, mulai dari keputusan akhir hayat seperti Do Not Resuscitate (DNR), perawatan paliatif, hingga perlakuan etik pada populasi khusus dan rentan seperti anak, lansia, pasien dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Selain praktik klinis, buku ini juga memberikan rambu-rambu esensial dalam pelaksanaan penelitian keperawatan untuk memastikan perlindungan hak subjek penelitian.

Sebagai muara dari seluruh konsep teoritis, buku ini menyajikan kerangka analisis studi kasus etik-hukum yang aplikatif. Dilengkapi dengan panduan pengambilan keputusan klinis dan simulasi sidang etik, buku ini tidak hanya menjadi sumber literatur, tetapi juga sarana berlatih memecahkan kasus-kasus nyata.

Melalui pendekatan teoretis dan praktis, Buku Ajar Etik dan Hukum Keperawatan diharapkan mampu mencetak perawat profesional yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga tangguh secara moral, peka terhadap hak asasi pasien, dan taat pada koridor hukum yang berlaku.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-04-0 (PDF)



9

786347

927040

